EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA

REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

LEY DE CONECTIVIDAD UNIFICADA PARA REDES Y ASISTENCIA SANITARIA (C.U.R.A.)

"Infraestructura digital para la interoperabilidad sanitaria y la garantía operativa del derecho a la salud"

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- Objeto, Carácter de Orden Público, Principios Rectores y Competencia Federal Diferenciada

La presente ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional Unificado de Historia Clínica Digital, denominado "Conectividad Unificada para Redes y Asistencia Sanitaria – C.U.R.A.", como infraestructura digital sanitaria de carácter federal, estratégica y de interés nacional.

El Sistema C.U.R.A. constituye el mecanismo de implementación y funcionamiento del Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas (S.U.R.H.C.E.) establecido por la Ley Nacional N° 27.706, y tendrá como finalidad garantizar la interoperabilidad, portabilidad, trazabilidad y acceso seguro en tiempo real a la información clínica de todas las personas en el territorio nacional.

El Sistema C.U.R.A. constituye asimismo infraestructura pública estratégica de datos sanitarios de la República Argentina, destinada a garantizar la interoperabilidad, portabilidad, gobernanza y uso seguro de la información clínica para la atención sanitaria, la salud pública, la investigación científica y la innovación tecnológica en salud, contribuyendo al fortalecimiento de la soberanía sanitaria y tecnológica nacional y a la integración de la República Argentina en los ecosistemas internacionales de interoperabilidad sanitaria.

a) Declaración de Orden Público.

Decláranse de orden público, en todo el territorio de la República Argentina, las disposiciones de la presente ley relativas a:

1) El derecho del paciente a la portabilidad de su información clínica;
2) La interoperabilidad técnica y semántica de los datos sanitarios;

3) Los estándares mínimos de seguridad informática, identidad digital sanitaria y protección de datos personales de salud.

Esta declaración se funda en el interés público sanitario superior de garantizar la continuidad asistencial, prevenir riesgos derivados de la fragmentación informativa y proteger datos sensibles conforme los artículos 42, 43 y 75 incisos 18, 19 y 22 de la Constitución Nacional y la Ley 25.326.

b) Federalismo de Concertación.

La implementación operativa del Sistema C.U.R.A. en los subsistemas públicos provinciales y municipales se regirá por el principio de Federalismo de Concertación Sanitaria, entendido como un modelo de coordinación efectiva entre la Nación y las jurisdicciones mediante acuerdos de adhesión, estándares técnicos comunes, incentivos presupuestarios y mecanismos de cooperación, respetando plenamente las autonomías locales reconocidas por el artículo 121 de la Constitución Nacional.

c) Finalidad Específica.

El Sistema C.U.R.A. tiene por finalidad:

1) Garantizar la unificación, interoperabilidad federal, portabilidad y acceso seguro en tiempo real a la historia clínica digital.
2) Mejorar sustancialmente la calidad, seguridad y continuidad de la atención médica.
3) Optimizar los recursos del sistema de salud mediante la eliminación de duplicaciones, la gestión predictiva y la trazabilidad integral de procesos sanitarios.

d) Alcance Transformador.

El Sistema C.U.R.A. constituye una reforma estructural del sistema de salud argentino y comprenderá de manera integrada:

1) La Credencial Única de Salud Digital como llave de acceso unificada.
2) El Federalismo Digital Sanitario mediante arquitectura híbrida que respeta la soberanía jurisdiccional de datos.
3) La trazabilidad integral de actos médicos, accesos y dispensaciones.
4) La gestión unificada de turnos para el sistema adherente.
5) La integración prioritaria del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

6) Un esquema de financiamiento sostenible basado en eficiencia, reasignación estratégica de recursos y cooperación.
7) Un modelo de gobernanza federal permanente a través del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.
8) La proyección internacional como Hub de Interoperabilidad Sanitaria, conforme el Título correspondiente.
9) La Red Federal de Información de Farmacias de Turno.

e) Principios Rectores.

El Sistema se regirá por los siguientes principios:

1) Soberanía Sanitaria Digital.
2) Máxima eficiencia presupuestaria.
3) Interoperabilidad bajo estándares abiertos internacionales vigentes.
4) Privacidad y seguridad por diseño.
5) Equidad en el acceso.
6) Progresividad y no regresividad en la implementación de derechos digitales sanitarios.
7) Transparencia algorítmica y supervisión humana obligatoria en sistemas de Inteligencia Artificial.

f) Marco de Incorporación de Inteligencia Artificial.

El Sistema C.U.R.A. contará con una arquitectura modular, escalable y extensible que permita la incorporación progresiva de herramientas de Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes.

La incorporación de módulos de Inteligencia Artificial requerirá, como mínimo:

1) Validación técnica y clínica previa;
2) Evaluación de impacto ético y de sesgos;
3) Clasificación conforme el régimen de categorización por riesgo previsto en el Título X;
4) Aprobación del Comité Ético correspondiente;
5) Certificación expresa del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.;
6) Supervisión humana significativa, quedando prohibida la automatización sustitutiva

del juicio clínico profesional.

La implementación podrá realizarse mediante entornos piloto certificados con monitoreo reforzado y auditoría continua.

g) Cláusula de competencia federal diferenciada
Las disposiciones de la presente ley se dictan en ejercicio de las siguientes competencias constitucionales, diferenciadas según el régimen de aplicación:

1) Para el RÉGIMEN A: En ejercicio de las competencias exclusivas del Congreso sobre establecimientos y organismos bajo jurisdicción nacional (art. 75 inc. 30 CN), sobre el comercio y tráfico interprovincial de personas y datos que fluyen entre jurisdicciones (art. 75 inc. 13 CN), sobre las obras sociales nacionales y entidades de medicina prepaga sujetas a regulación federal (Leyes 23.660, 23.661 y 26.682) y en virtud de los poderes implícitos del art. 75 inc. 32 CN, en cuanto es necesario y conveniente para hacer efectivos los derechos establecidos por los tratados internacionales incorporados a la Constitución (art. 75 inc. 22 CN), en particular el derecho a la salud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2) Para el RÉGIMEN B: En ejercicio de las competencias concurrentes en materia de salud pública previstas en los artículos 125 y 126 de la Constitución Nacional, en cuanto la Nación fija estándares técnicos de referencia de coordinación interjurisdiccional —no presupuestos mínimos en sentido del art. 41 CN— que las jurisdicciones adherentes adoptan voluntariamente mediante el mecanismo del Artículo 4°. Las obligaciones del Régimen B solo son exigibles a jurisdicciones que hubieren adherido expresamente al Sistema C.U.R.A. conforme el Artículo 4°.

3) Para el RÉGIMEN C: En ejercicio del poder reglamentario de derechos fundamentales del paciente ya reconocidos por las Leyes 26.529 y 25.326 y por los tratados del art. 75 inc. 22 CN, cuyo alcance es universal por fundarse en derechos individuales exigibles ante cualquier efector, con independencia de la adhesión jurisdiccional.

RÉGIMEN A — APLICACIÓN DIRECTA E INMEDIATA:
Son de aplicación directa e inmediata, sin requerimiento de acto de adhesión, todas las disposiciones de esta ley respecto de:

1) Los organismos, establecimientos y programas de salud bajo dependencia del Estado Nacional.
2) El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

(INSSJP–PAMI).

3) Los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en las Leyes 23.660 y 23.661.
4) Las Entidades de Medicina Prepaga reguladas por la Ley 26.682.
5) Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) en lo relativo a prestaciones médicas bajo prestaciones del régimen federal.

RÉGIMEN B — ESTÁNDARES TÉCNICOS MÍNIMOS DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL:

Los estándares de interoperabilidad técnica, seguridad informática, identidad digital sanitaria y protección de datos establecidos en la presente ley constituyen estándares técnicos mínimos de coordinación interjurisdiccional, adoptados por las jurisdicciones adherentes mediante el Convenio de Adhesión Federal del Artículo 4°.

Las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran al sistema conforme el Artículo 4° quedan obligadas a respetar dichos estándares mínimos en sus efectores públicos, sin que ello implique delegación alguna de facultades de organización, administración o financiamiento de sus sistemas sanitarios locales.

Las jurisdicciones no adherentes no podrán ser sancionadas ni perder derechos preexistentes como consecuencia de su no adhesión. Las obligaciones aplicables a jurisdicciones no adherentes se limitan exclusivamente a garantizar la legibilidad y portabilidad del dato transjurisdiccional a solicitud del paciente titular conforme el Artículo 3° BIS, sin que ello exija la adopción de plataformas o infraestructuras específicas del Sistema C.U.R.A.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán dictar normas complementarias o más protectorias, sin desnaturalizar los estándares mínimos establecidos.

RÉGIMEN C — DERECHOS DEL CIUDADANO DE ALCANCE UNIVERSAL:
Los derechos del paciente reconocidos en el Artículo 19 y en el Artículo 32 de la presente ley son de alcance universal y no dependen de la adhesión jurisdiccional, en cuanto derivan directamente de los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y de la Ley 26.529.
Todo ciudadano podrá exigir el ejercicio de estos derechos ante cualquier efector del sistema de salud en el territorio nacional.

En ningún caso el ejercicio de derechos del Régimen C generará obligaciones financieras no presupuestadas para jurisdicciones no adherentes. El Estado Nacional asumirá los

costos de portabilidad cuando el efector provincial no adherente deba satisfacer un derecho del Régimen C

ARTÍCULO 2°.- Definiciones.

A los fines de la presente ley, entiéndase por:

a) Sistema C.U.R.A.: Plataforma nacional de información sanitaria digital, de carácter federal y de acceso restringido, que integra infraestructura tecnológica, repositorios de datos clínicos, servicios, aplicaciones, protocolos de interoperabilidad y mecanismos de gobernanza destinados a garantizar la interoperabilidad, portabilidad y acceso seguro a las historias clínicas digitales bajo estándares técnicos uniformes.

b) Credencial Única de Salud (C.U.S.): Documento digital y/o físico asociado al Identificador Único de Paciente (C.U.R.A.-ID), que permite el acceso seguro y autenticado a la información sanitaria del ciudadano, conforme lo establecido en la presente ley.

c) Usuario o Paciente: Toda persona física que reciba o haya recibido atención sanitaria en cualquier subsistema de salud y sea titular de los derechos reconocidos en la presente ley y en la Ley 26.529.

d) Prestador de Salud: Persona física o jurídica, pública o privada, que brinde servicios de salud, incluyendo profesionales individuales matriculados, establecimientos asistenciales de cualquier nivel de complejidad y entidades de la seguridad social.

e) Profesional de la Salud: Persona física legalmente habilitada para ejercer una profesión sanitaria, con matrícula vigente otorgada por autoridad competente.

f) Establecimiento de Salud: Todo efector público o privado donde se brinden servicios de salud, incluyendo hospitales, clínicas, sanatorios, centros de atención primaria, consultorios, laboratorios, centros de diagnóstico, farmacias y cualquier otro establecimiento habilitado para prestaciones sanitarias.

g) Autoridad de Aplicación: El Ministerio de Salud de la Nación o el organismo que en el futuro lo reemplace.

h) AAIP: La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de autoridad de control de la Ley 25.326.

i) Datos de Salud: Toda información relativa al estado de salud físico, mental o social de una persona, sus antecedentes clínicos, diagnósticos, tratamientos, estudios complementarios, prescripciones y cualquier otra información sanitaria, constituyendo datos personales sensibles en los términos del artículo 2° de la Ley 25.326.

j) Interoperabilidad: Capacidad técnica, semántica y organizacional de los sistemas de información sanitaria para intercambiar datos y permitir su utilización efectiva conforme estándares comunes.

k) Trazabilidad: Registro cronológico, íntegro e inalterable de los accesos, modificaciones y operaciones realizadas sobre los datos de salud, que permita identificar la identidad del usuario actuante, fecha, hora y tipo de acción realizada.

l) Consentimiento Informado Granular: Manifestación de voluntad libre, expresa, específica e informada del paciente que permite autorizar o restringir el acceso a categorías determinadas de información sanitaria conforme los mecanismos previstos en la presente ley.

m) Estudio Médico Digital: Todo resultado de laboratorio, imagen diagnóstica, informe médico o estudio complementario en formato estructurado o archivo digital que deba incorporarse a la historia clínica digital. La enumeración de ejemplos tales como análisis de laboratorio, tomografías, radiografías, resonancias, ecografías, informes de anatomía patológica u otros estudios tiene carácter meramente ejemplificativo y no taxativo.

n) Comisión Nacional de Bioética: Organismo creado por el Decreto N° 893/2025 o la normativa que en el futuro lo reemplace, modifique o sustituya en sus funciones rectoras de ética en salud.

ARTÍCULO 3°.- Ámbito de aplicación.

La presente ley establece el marco normativo, técnico y de derechos mínimos aplicable a todos los efectores de salud en el territorio nacional (públicos, privados y de la seguridad social), constituyendo el régimen técnico y operativo necesario para el cumplimiento de las Leyes N° 27.706 y N° 26.529.

Estándares y Derechos de Orden Público.

Los estándares técnicos mínimos de interoperabilidad, seguridad informática, privacidad por diseño y los derechos del paciente a la portabilidad de sus datos establecidos en la presente ley constituyen normas de orden público en los términos de los artículos 75 incisos 18, 19 y 22 de la Constitución Nacional, en cuanto configuran presupuestos mínimos federales destinados a garantizar la continuidad asistencial interjurisdiccional.

Dichos estándares deberán ser respetados por todos los efectores del sistema de salud (públicos, privados y de la seguridad social) en todo el territorio de la República Argentina.

Obligatoriedad Operativa Federal.

La adopción e integración plena a la plataforma operativa del Sistema C.U.R.A. será obligatoria para los efectores comprendidos en el Régimen A del inciso g) del Artículo 1° de la presente ley, conforme el cronograma establecido en el Artículo 14.

Para los efectores comprendidos en los subsistemas públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rige el Régimen B del inciso g) del Artículo 1°: la integración operativa al Sistema C.U.R.A. se producirá exclusivamente mediante adhesión voluntaria de la jurisdicción correspondiente, conforme el procedimiento previsto en el Artículo 4°.

Los Colegios Profesionales y entidades responsables de la administración de cronogramas de farmacia deberán proveer al Sistema C.U.R.A., exclusivamente en lo referido a la disponibilidad, ubicación y geolocalización en tiempo real de farmacias, los datos mínimos técnicos definidos por la Autoridad de Aplicación, cuando actúen en jurisdicciones que hubieren adherido al sistema conforme el Artículo 4°.

En ningún caso la no adhesión de una jurisdicción podrá:

a) Impedir a sus ciudadanos el ejercicio de los derechos del Régimen C.

b) Generar sanciones directas sobre los establecimientos de salud públicos provinciales o municipales.

c) Ser utilizada como condición para el acceso a fondos coparticipados u otras transferencias nacionales no vinculadas específicamente al Sistema C.U.R.A.

Adhesión de los Subsistemas Públicos Jurisdiccionales.

Para los establecimientos de salud dependientes de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, la integración operativa plena a la infraestructura y

aplicativos del Sistema C.U.R.A. se regirá por los Convenios de Adhesión Federal establecidos en el Artículo 4°.

Sin perjuicio de la adhesión, y exclusivamente en el marco de los presupuestos mínimos federales vinculados a la continuidad asistencial interjurisdiccional, las jurisdicciones deberán garantizar la interoperabilidad técnica bidireccional, segura y en tiempo real con el nodo nacional del Sistema C.U.R.A., conforme a los estándares federales definidos en la presente ley.

Dicha obligación:

a) Se limita estrictamente al intercambio técnico indispensable de información clínica necesaria para asegurar portabilidad, trazabilidad y continuidad asistencial entre jurisdicciones.
b) No implicará la adopción obligatoria de la plataforma operativa central.
c) No afectará la organización, administración, presupuesto, recursos humanos, gestión hospitalaria ni regulación sanitaria local, que permanecen bajo exclusiva competencia jurisdiccional conforme el artículo 121 de la Constitución Nacional.

El Estado Nacional proveerá, sin costo para las jurisdicciones no adherentes, la capa técnica mínima de interoperabilidad necesaria para el cumplimiento de la presente obligación, incluyendo herramientas, componentes de software, asistencia técnica y protocolos estandarizados, de modo que no resulte exigible el desarrollo de infraestructura propia adicional para garantizar la portabilidad interjurisdiccional.

Los datos relativos a los cronogramas de farmacias de turno establecidos por autoridades locales o colegios profesionales se consideran información sanitaria de interés público. Su integración técnica al nodo nacional del Sistema C.U.R.A. será obligatoria, bajo estándares de interoperabilidad definidos en la presente ley, exclusivamente a efectos de su visualización en el portal oficial del Sistema C.U.R.A., en la plataforma digital nacional "Mi Argentina" o en la interfaz ciudadana que en el futuro la reemplace.

La Autoridad de Aplicación establecerá un plazo de implementación progresiva no mayor a DOCE (12) meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, pudiendo disponer esquemas transitorios, mecanismos de carga manual asistida y soporte técnico específico para aquellas jurisdicciones o entidades que carezcan de sistemas digitales interoperables.

Régimen Unificado de Progresividad y Eximentes Técnicas.

La implementación de las obligaciones previstas en el presente artículo se realizará de manera progresiva, escalonada y conforme a la capacidad técnica efectiva de cada establecimiento o jurisdicción.

No constituirá incumplimiento sancionable la falta transitoria de interoperabilidad cuando derive de:

a) Fallas técnicas acreditadas.
b) Falta de conectividad o limitaciones estructurales de infraestructura.
c) Indisponibilidad de sistemas interoperables.
d) Caso fortuito o fuerza mayor.

En tales supuestos, no podrán aplicarse sanciones siempre que la causa no sea imputable a conducta dolosa o negligente grave del prestador o de la jurisdicción, debiendo la Autoridad de Aplicación prever mecanismos de contingencia, modalidades offline, asistencia técnica y esquemas de transición razonables.

ARTÍCULO 3° BIS.- Portabilidad interjurisdiccional de datos clínicos y continuidad asistencial.

El titular de los datos clínicos tiene derecho a la portabilidad de su información sanitaria desde cualquier efector de salud del territorio nacional. Este derecho es de alcance universal, inalienable e independiente de la dependencia jurisdiccional del efector o del régimen de aplicación previsto en el Artículo 1° inciso g) de la presente ley.

a) Contenido del derecho.

El derecho a la portabilidad comprende la facultad del titular de exigir, en cualquier momento y sin expresión de causa adicional, que sus datos clínicos sean accedidos, transferidos o puestos a disposición del profesional tratante que autorice, garantizando la continuidad de su atención sanitaria en todo el territorio nacional.

Ante solicitud del paciente o del profesional tratante debidamente autorizado, el efector deberá facilitar el acceso o la transferencia de la información clínica necesaria para la continuidad asistencial sin dilaciones indebidas. A los efectos de la presente ley, se considerarán referencias orientativas del plazo razonable las siguientes, sin que ello implique taxatividad ni rigidización del estándar:

En situaciones de urgencia o emergencia con riesgo vital verificable: de manera inmediata o en el plazo más breve que las condiciones técnicas permitan, no pudiendo exceder las DOS

(2) horas desde la solicitud;

En situaciones de continuidad asistencial programada o de seguimiento clínico: dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles desde la solicitud fehaciente;

En solicitudes de portabilidad ejercidas directamente por el titular sin urgencia clínica documentada: dentro de los CINCO (5) días hábiles.

La determinación de si una dilación resulta o no indebida en el caso concreto deberá ponderar la complejidad técnica del requerimiento, la situación clínica del paciente y las capacidades operativas efectivas del efector al momento de la solicitud. En ningún caso la complejidad técnica o la carga administrativa podrán invocarse para denegar la portabilidad ante situaciones de urgencia vital.

La transferencia se realizará utilizando formatos digitales estructurados y legibles conforme los estándares técnicos mínimos de interoperabilidad definidos por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., o estándares equivalentes que garanticen su legibilidad y utilización efectiva por sistemas adherentes.

b) Jurisdicciones adherentes al Sistema C.U.R.A.

En los efectores comprendidos en jurisdicciones adheridas conforme el Artículo 4°, la portabilidad se ejercerá en tiempo real mediante los mecanismos automatizados de la plataforma del Sistema C.U.R.A. El Resumen Clínico Federal establecido en el Artículo 3° TER deberá poder generarse y transferirse de manera automática sin intervención manual adicional del efector.

El incumplimiento de esta obligación por parte de efectores de jurisdicciones adherentes podrá dar lugar al régimen de medidas correctivas previsto en el Artículo 4° BIS.

c) Jurisdicciones no adherentes al Sistema C.U.R.A.

Respecto de los efectores pertenecientes a jurisdicciones no adheridas al Régimen B, el derecho a la portabilidad se garantizará conforme las siguientes reglas:

La obligación de portabilidad será plenamente exigible desde el momento en que el Estado Nacional haya puesto a disposición del efector, de manera gratuita y operativa, las herramientas tecnológicas mínimas necesarias para su cumplimiento, y haya transcurrido un plazo de adecuación no inferior a CIENTO OCHENTA (180) días corridos desde esa puesta a disposición, certificada por la Autoridad de Aplicación.

Hasta tanto se verifiquen las condiciones del numeral anterior, el efector deberá facilitar la

portabilidad mediante mecanismos alternativos razonables, incluyendo exportación de documentos clínicos en formato digital estandarizado, entrega en soporte físico o cualquier otro medio que permita al paciente ejercer efectivamente su derecho sin demoras que comprometan su atención. La imposibilidad técnica transitoria no podrá invocarse para denegar la información al paciente de manera absoluta.

La no adhesión de una jurisdicción al Régimen B no eximirá a sus efectores de garantizar al paciente, como mínimo, el conjunto de datos contenidos en el Resumen Clínico Federal del Artículo 3° TER por cualquier medio técnico disponible. La provisión del Resumen Clínico Federal conforme el Artículo 3° TER, o de un documento equivalente que contenga la totalidad de los campos allí previstos en formato legible y estructurado, satisfará la obligación mínima de portabilidad establecida en el presente artículo respecto de efectores de jurisdicciones no adherentes.

d) Principio de no imposición sin medios.

La presente disposición no implicará para las jurisdicciones no adherentes la obligación de adoptar la plataforma operativa del Sistema C.U.R.A., de desarrollar infraestructura tecnológica propia adicional, ni de asumir costos que el Estado Nacional no hubiere previamente cubierto mediante la provisión de los recursos técnicos indicados en el inciso c).

El Estado Nacional asumirá los costos técnicos de la portabilidad mínima cuando el efector de una jurisdicción no adherente deba satisfacer un derecho del Régimen C, conforme lo previsto en el Artículo 35 inciso g) de la presente ley.

e) Estándares técnicos y actualización.

La Autoridad de Aplicación publicará y mantendrá permanentemente actualizado el protocolo técnico mínimo que permita el cumplimiento de la portabilidad mediante mecanismos de exportación, transmisión o acceso digital seguro, garantizando la continuidad asistencial del paciente en todo el territorio nacional. Dicho protocolo será de acceso público y gratuito para todos los efectores del sistema.

f) Mecanismos de contingencia.

Cuando por razones técnicas verificables, falta de conectividad estructural o caso fortuito no fuera posible ejecutar la transferencia por medios digitales en el plazo ordinario, el efector deberá activar los mecanismos de contingencia previstos en el Artículo 22 de la presente ley y garantizar la provisión de la información por cualquier medio disponible dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes al restablecimiento de la conectividad, o en un plazo menor cuando la situación clínica del paciente así lo requiera.

En ningún caso la contingencia técnica podrá ser invocada para negar al paciente toda información sobre su estado de salud cuando su vida o integridad se encuentren comprometidas.

g) Consecuencias del incumplimiento.

La negativa injustificada, la demora que exceda los plazos orientativos del inciso a) sin causa técnica acreditada, o la provisión de información incompleta que impida la continuidad asistencial del paciente, constituirán incumplimiento de la obligación de portabilidad y serán calificadas como falta en los términos del régimen sancionatorio previsto en el Artículo 44 de la presente ley.

La calificación de la falta como leve, grave o gravísima se determinará conforme los criterios allí establecidos, ponderando especialmente el daño efectivo o potencial para la salud del paciente, la reiteración de la conducta y la existencia o no de causa técnica debidamente acreditada.

Respecto de los efectores pertenecientes a jurisdicciones no adherentes al Régimen B, la aplicación del régimen sancionatorio quedará condicionada a que se hubieren verificado previamente las condiciones de exigibilidad establecidas en el inciso c) numeral 1 del presente artículo. La potestad sancionatoria de la Autoridad de Aplicación nacional no desplazará ni interferirá con las facultades disciplinarias y de fiscalización propias de cada jurisdicción sobre sus efectores públicos, conforme los artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional.

h) Indisponibilidad del derecho.

El derecho reconocido en el presente artículo es irrenunciable. Ninguna cláusula contractual, reglamento institucional o norma jurisdiccional de rango inferior a la presente ley podrá restringirlo, condicionarlo a aranceles o imponer requisitos adicionales que obstaculicen su ejercicio efectivo.

ARTÍCULO 3° TER.- Resumen Clínico Federal de Continuidad Asistencial.

Con el exclusivo objeto de garantizar la continuidad asistencial interjurisdiccional y la seguridad del paciente en situaciones de atención fuera de su jurisdicción de origen, establécese el Resumen Clínico Federal de Continuidad Asistencial.

El Resumen Clínico Federal constituirá un conjunto mínimo, estructurado y estandarizado de datos sanitarios críticos, limitado estrictamente a la información indispensable para la atención médica segura e inmediata.

Su contenido se limitará a:

a) Identificador único del paciente (C.U.R.A.-ID).

b) Alergias activas registradas.

c) Medicación crónica vigente.

d) Diagnósticos activos de relevancia clínica inmediata.

e) Antecedentes críticos que impliquen riesgo vital.

f) Datos básicos del efector tratante habitual.

En ningún caso el Resumen Clínico Federal incluirá evoluciones médicas completas, estudios diagnósticos integrales, documentación administrativa ni información no vinculada directamente a la continuidad asistencial urgente.

Toda persona tendrá derecho a que los efectores de salud que registren su atención generen y mantengan actualizado dicho resumen mínimo conforme los estándares técnicos definidos por la Autoridad de Aplicación.

El cumplimiento de este derecho podrá realizarse mediante los mecanismos técnicos que cada jurisdicción determine o mediante las herramientas tecnológicas provistas por el Estado Nacional a tal efecto.

La provisión de dichas herramientas por parte del Estado Nacional no implicará obligación de integración plena a la plataforma operativa del Sistema C.U.R.A. para las jurisdicciones no adherentes.

El presente artículo se funda en los artículos 42, 43 y 75 incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto constituye un presupuesto mínimo federal destinado a proteger la vida, la salud y la continuidad asistencial de las personas en el territorio nacional.

ARTÍCULO 4º.- Régimen de adhesión federal, beneficios de acceso y titularidad de datos.

Invitación a Adherir y Régimen Federal de Implementación.

Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen operativo de la presente ley mediante el dictado de las normas locales correspondientes, en ejercicio de sus competencias concurrentes en materia de salud pública, con el objeto de integrar sus redes sanitarias públicas al Sistema C.U.R.A. y acceder a los beneficios de la federalización digital. La implementación del Sistema C.U.R.A. se efectuará con pleno respeto a las competencias propias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Nación establecerá estándares, lineamientos técnicos y protocolos mínimos de interoperabilidad, trazabilidad, credenciales e información sanitaria, sin intervenir en la administración cotidiana, organización interna, presupuesto, recursos humanos, compras, gestión operativa ni regulación local de los sistemas de salud provinciales. Cada jurisdicción mantendrá íntegramente su estructura sanitaria y sus políticas propias, limitándose la presente

ley a unificar criterios y lenguajes técnicos para garantizar continuidad asistencial, evitar duplicación de estudios, mejorar la seguridad del paciente y reducir los costos administrativos y operativos derivados de la fragmentación del sistema, permitiendo que la información clínica pueda ser utilizada en cualquier lugar del país.

La adhesión será siempre voluntaria y se formalizará mediante los convenios de cooperación previstos en esta ley, sin implicar delegación alguna de facultades no previstas en los artículos 121, 122 y 125 de la Constitución Nacional. Los órganos de coordinación previstos en esta ley, incluido el Consejo de Mayo, tendrán carácter consultivo y de articulación federal, sin facultades de supervisión, subordinación o mando sobre las jurisdicciones.

La voluntariedad de la adhesión no podrá verse desnaturalizada por la aplicación del régimen previsto en el Artículo 4° BIS, el cual se limitará exclusivamente a beneficios tecnológicos y programas específicos creados por la presente ley, sin afectar en ningún caso transferencias vinculadas a prestaciones esenciales de salud, programas obligatorios o financiamiento estructural del sistema sanitario provincial.

La selección de jurisdicciones para cada fase o tanda de implementación será determinada mediante resolución conjunta del Consejo Federal de Salud (COFESA) y la Autoridad de Aplicación conforme a lo establecido en el Artículo 14, en las Disposiciones Transitorias y en base a criterios técnicos y de capacidad operativa. Cada provincia deberá manifestar expresamente su aceptación para integrar la fase correspondiente, formalizada mediante el convenio de adhesión. Una vez aceptada su participación en una fase, la jurisdicción deberá cumplir íntegramente los requisitos, hitos, criterios técnicos de habilitación y protocolos obligatorios definidos para dicha etapa, sin que ello implique transferencia de la administración, regulación o gobierno de su sistema de salud.

En ningún supuesto esta ley podrá interpretarse como una centralización de competencias provinciales ni como una afectación a la autonomía jurisdiccional en materia sanitaria.

Ámbito Federal de Coordinación. El Consejo de Mayo, creado por los Decretos N.º 617/2024 y 382/2025, actuará como espacio consultivo y de articulación federal para promover la adhesión de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Sistema C.U.R.A. Podrá convocar a representantes jurisdiccionales, técnicos y sanitarios para facilitar acuerdos, coordinar la implementación progresiva, armonizar estrategias de integración y elevar recomendaciones de política pública a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Salud de la Nación. Sus conclusiones serán no vinculantes, pero servirán como base para los convenios de adhesión previstos en el presente artículo.

Beneficio de Acceso "Llave en Mano" (Modelo SaaS). Las jurisdicciones que suscriban el

Convenio de Adhesión accederán de forma inmediata y gratuita al uso irrestricto de la plataforma C.U.R.A., bajo la modalidad de "Software como Servicio Público", sin límite temporal predeterminado y sujeto a la vigencia del presente régimen legal y a la disponibilidad presupuestaria correspondiente. El Estado Nacional asume la totalidad de los costos de desarrollo, mantenimiento evolutivo, ciberseguridad centralizada y almacenamiento en la nube de ARSAT S.E., liberando a las jurisdicciones adherentes de la carga presupuestaria de desarrollar, licenciar, auditar o mantener sistemas informáticos propios.

Requisito de Infraestructura Mínima Preexistente. La adhesión implica que la jurisdicción asume la responsabilidad de garantizar que sus puntos de atención cuenten con la conectividad básica y los dispositivos terminales de acceso necesarios para operar el sistema vía web. Dichos dispositivos podrán ser computadoras de escritorio, portátiles, tabletas o teléfonos inteligentes estándar, permitiendo el aprovechamiento integral de la capacidad instalada existente sin requerir inversiones en hardware específico.

Incentivos al Recurso Humano. El personal de salud de las jurisdicciones que adhieran al sistema quedará automáticamente habilitado para acceder a los beneficios del Régimen de Equidad Territorial y al Bono por Zona Crítica Sanitaria establecido en la Disposición Transitoria vigésimaprimera, financiados mediante los ahorros sistémicos generados por la eficiencia operativa de la plataforma única.

Titularidad y Resguardo Federal. Ratifícase que las jurisdicciones provinciales conservan la plena titularidad administrativa y política de los registros sanitarios generados en los establecimientos de su dependencia. La Nación, a través del Sistema C.U.R.A., actuará exclusivamente en carácter de proveedor tecnológico y custodio de la seguridad, integridad y disponibilidad de la información, no pudiendo utilizar dichos datos para fines distintos a los sanitarios, estadísticos anonimizados, de auditoría federal o de emergencia.

ARTÍCULO 4 BIS.- Régimen de Incumplimiento Jurisdiccional, Medidas Correctivas y Debido Proceso Federal.

Las jurisdicciones que adhieran al Sistema C.U.R.A. y presenten incumplimientos relevantes de las obligaciones asumidas mediante el acto de adhesión podrán ser objeto de las medidas correctivas previstas en el presente artículo, aplicadas de forma gradual, proporcional y con pleno respeto al debido proceso y a la autonomía jurisdiccional.

a) Principios Rectores

Las medidas previstas en el presente artículo se regirán por los siguientes principios:

1) Federalismo de concertación: El régimen tiene carácter exclusivamente correctivo. Su finalidad es garantizar la efectiva implementación del Sistema C.U.R.A. sin comprometer la autonomía organizativa, administrativa ni financiera de las

jurisdicciones adherentes.

2) Gradualidad escalonada: Las medidas se aplicarán en forma progresiva, agotando obligatoriamente la etapa de advertencia y asistencia técnica antes de cualquier restricción de recursos.

3) Proporcionalidad funcional: Toda medida deberá guardar relación directa entre la entidad del incumplimiento, su impacto real sobre el sistema y la intensidad de la restricción propuesta.

4) No punitividad: Las restricciones previstas no tienen carácter sancionatorio penal ni generan antecedente disciplinario jurisdiccional. Cesarán automáticamente una vez subsanado el incumplimiento que las motivó.

5) Subsidiariedad: Las medidas restrictivas son el último recurso disponible. Solo proceden cuando la etapa de advertencia y asistencia técnica resulta agotada sin resultado.

b) Configuración del Incumplimiento Relevante

Se considerará configurado un incumplimiento relevante cuando concurran los siguientes elementos:

1) Elemento objetivo: La jurisdicción omite, dificulta o frustra de manera concreta la implementación de obligaciones expresamente asumidas en el instrumento de adhesión formalizado conforme el Artículo 4°.

2) Elemento funcional: El incumplimiento produce un impacto verificable sobre alguno de los siguientes aspectos del sistema:

i. la interoperabilidad técnica con el nodo nacional;
ii. la portabilidad de datos clínicos de pacientes;
iii. la trazabilidad de actos médicos o de dispensación;
iv. la continuidad asistencial interjurisdiccional de pacientes.

3) Elemento temporal: El incumplimiento persiste durante un plazo no inferior a TREINTA (30) días corridos desde la notificación de advertencia formal prevista en el inciso c), sin respuesta sustancial de la jurisdicción.

Criterio de relevancia: El incumplimiento será calificado como relevante cuando su impacto funcional afecte al menos al QUINCE POR CIENTO (15%) de los puntos de contacto operativos de la jurisdicción con el sistema, o cuando —con independencia de su alcance cuantitativo— comprometa la seguridad clínica de pacientes de forma acreditada. La Autoridad de Aplicación establecerá mediante resolución técnica los indicadores objetivos de medición del impacto funcional.

Eximentes: No configurarán incumplimiento relevante las demoras atribuibles a:

1. Fallas técnicas acreditadas de la plataforma nacional del Sistema C.U.R.A.
2. Falta de conectividad o limitaciones estructurales de infraestructura no imputables a la jurisdicción.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentados.
4. Insuficiencia en la provisión de herramientas técnicas por parte del Estado Nacional.
5. Procesos de adecuación normativa en curso con cronograma verificable presentado dentro de los plazos previstos en el presente artículo.

c) Etapa Previa Obligatoria: Advertencia Formal y Asistencia Técnica

Antes de iniciar cualquier procedimiento que pueda derivar en medidas restrictivas, la Autoridad de Aplicación deberá agotar obligatoriamente la siguiente etapa previa:

1. Advertencia formal: La Autoridad de Aplicación notificará fehacientemente a la máxima autoridad sanitaria de la jurisdicción con indicación de:

i. Los incumplimientos detectados, su calificación funcional y la evidencia técnica que los sustenta.
ii. El plazo de TREINTA (30) días corridos para que la jurisdicción presente respuesta, plan de adecuación o acredite eximentes.
iii. La oferta de asistencia técnica gratuita disponible.
iv. Las consecuencias posibles de la falta de respuesta sustancial.

2. Asistencia técnica: Simultáneamente con la advertencia formal, la Unidad Ejecutora del Sistema C.U.R.A. (UESC) deberá:

i. Designar un equipo de asistencia técnica para la jurisdicción dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación.
ii. Ofrecer diagnóstico técnico conjunto, identificación de obstáculos y propuesta de soluciones.
iii. Poner a disposición recursos tecnológicos, capacitación y soporte activo durante todo el plazo de la etapa previa.
iv. Elaborar informe de factibilidad técnica que determine si el incumplimiento es estructural, transitorio o imputable a la jurisdicción.

3. Respuesta jurisdiccional: Dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, la jurisdicción podrá:

i. Acreditar la subsanación del incumplimiento.
ii. Presentar un Plan de Adecuación Inicial con cronograma de hitos verificables, no superior a NOVENTA (90) días de duración.
iii. Invocar eximentes con documentación respaldatoria.
iv. Solicitar prórroga fundada de hasta QUINCE (15) días adicionales ante obstáculos técnicos acreditados.

4. Archivo de la etapa previa: Si la jurisdicción subsana el incumplimiento, presenta Plan de Adecuación Inicial aprobable o acredita eximentes suficientes, la Autoridad de Aplicación archivará las actuaciones sin más trámite. El archivo no tendrá valor de antecedente negativo para la jurisdicción.

La etapa previa no podrá ser omitida ni abreviada bajo ninguna circunstancia. Su incumplimiento por parte de la Autoridad de Aplicación acarreará la nulidad de cualquier medida restrictiva posterior.

d) Plan de Adecuación Obligatorio y Monitoreo Progresivo

Cuando la jurisdicción presente Plan de Adecuación Inicial conforme el inciso c), se activará el siguiente régimen:

1. Aprobación: La Autoridad de Aplicación evaluará el Plan dentro de los QUINCE (15) días hábiles de su recepción. Podrá:

i. Aprobarlo sin modificaciones.
ii. Aprobarlo con ajustes acordados con la jurisdicción.
iii. Rechazarlo fundadamente, con indicación precisa de las deficiencias a subsanar, otorgando un plazo de DIEZ (10) días hábiles para su reformulación.

El silencio de la Autoridad de Aplicación vencido el plazo de evaluación equivaldrá a aprobación tácita del Plan presentado.

2. Efectos de la aprobación: La aprobación del Plan suspende la apertura de cualquier procedimiento restrictivo durante toda la ejecución del cronograma acordado, siempre que se acredite cumplimiento sustancial de los hitos comprometidos.

3. Monitoreo progresivo: Durante la ejecución del Plan, la UESC realizará:

i. Verificación técnica de hitos al 25%, 50%, 75% y 100% del cronograma.
ii. Informe de avance al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. al completar cada etapa.
iii. Reuniones de seguimiento con autoridades jurisdiccionales con periodicidad no superior a QUINCE (15) días.

4. Incumplimiento del Plan aprobado: Si la jurisdicción incumple hitos verificables del Plan aprobado sin justificación acreditada y sin solicitar revisión del cronograma, la Autoridad de Aplicación podrá dar por agotada la etapa previa e iniciar el procedimiento del inciso e), con cómputo del tiempo transcurrido desde la advertencia original.

5. Revisión del Plan: La jurisdicción podrá solicitar revisión del cronograma por causas sobrevinientes acreditadas. La solicitud tendrá efecto suspensivo automático sobre los hitos pendientes durante su tramitación, que no podrá exceder de DIEZ (10) días hábiles.

e) Procedimiento Restrictivo: Notificación de Cargos

Agotada la etapa previa sin resultado suficiente, la Autoridad de Aplicación podrá iniciar el procedimiento restrictivo mediante notificación fehaciente que contenga:

1. Descripción detallada del incumplimiento relevante subsistente, con indicación del elemento objetivo, funcional y temporal verificados.
2. El resultado de la etapa previa y las razones por las cuales se considera insuficiente la respuesta jurisdiccional.
3. La medida restrictiva propuesta, con indicación precisa de los recursos afectados conforme el catálogo taxativo del inciso g), su monto, alcance y duración estimada.
4. El plazo de SESENTA (60) días corridos para ejercer el derecho de descargo previsto en el inciso f).

f) Derecho de Descargo Pleno

Dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos desde la notificación del inciso e), la jurisdicción podrá:

1. Presentar descargo fundado con argumentos técnicos, jurídicos y fácticos.
2. Ofrecer y producir prueba documental, pericial o técnica pertinente.
3. Solicitar audiencia presencial ante la Autoridad de Aplicación, que deberá realizarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la solicitud.
4. Presentar un Plan de Regularización Definitivo con cronograma verificable no superior a CIENTO VEINTE (120) días.
5. Invocar eximentes sobrevinientes no alegadas en la etapa previa.

La aprobación del Plan de Regularización Definitivo suspenderá la aplicación de la medida restrictiva durante toda su ejecución, sujeto al régimen de monitoreo del inciso d).

g) Recursos Susceptibles de Restricción

Las medidas correctivas solo podrán recaer exclusivamente sobre:

1. Aportes o financiamiento adicional destinado a módulos tecnológicos complementarios del Sistema C.U.R.A., de asignación condicionada y no coparticipable.
2. Programas voluntarios de modernización digital creados específicamente en el marco de la presente ley.
3. Beneficios operativos o tecnológicos no esenciales previstos para jurisdicciones adherentes, siempre que se trate de recursos de asignación condicionada específicamente creados en el marco del Sistema C.U.R.A.

La Autoridad de Aplicación publicará, mediante resolución conjunta con el Ministerio de Economía dentro de los NOVENTA (90) días de promulgada la presente ley, el catálogo taxativo de recursos susceptibles de restricción.

Quedan absolutamente excluidos de cualquier medida, sin excepción posible:

i. Fondos de la masa coparticipable federal.

ii. Recursos del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

iii. Transferencias vinculadas al Programa Médico Obligatorio.

iv. Partidas destinadas a atención primaria de la salud.

v. Recursos para programas materno-infantiles.

vi. Fondos para medicamentos esenciales.

vii. Partidas para emergencias sanitarias declaradas.

viii. Cualquier transferencia destinada a garantizar derechos fundamentales en materia de salud preexistentes a la presente ley.

h) Resolución Fundada

Vencido el plazo de descargo, la Autoridad de Aplicación dictará resolución fundada dentro de los TREINTA (30) días corridos, pudiendo:

1. Archivar las actuaciones, cuando el descargo, la subsanación o el Plan de Regularización sean suficientes.
2. Aprobar el Plan de Regularización Definitivo, con suspensión de la medida y activación del monitoreo progresivo del inciso d).
3. Aplicar la restricción en forma progresiva, solo cuando subsista el incumplimiento relevante y no exista plan aprobado en ejecución.

La resolución deberá pronunciarse expresamente sobre cada argumento y prueba aportados. La omisión de pronunciamiento sobre defensa sustancial acarreará la nulidad del acto.

i) Proporcionalidad y Límite Cuantitativo

La medida correctiva deberá ser proporcional al incumplimiento, fundada en evidencia técnica y limitada en el tiempo.

Presunción del 10%: Se presume *iuris tantum* que toda restricción que supere el DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos C.U.R.A.-específicos asignados a la jurisdicción afecta la prestación esencial. Para superar este umbral, la Autoridad de Aplicación deberá acreditar lo contrario mediante informe técnico del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. y audiencia previa con la jurisdicción.

Tope general del 20%: En ningún caso la restricción podrá exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) de los recursos C.U.R.A.-específicos de la jurisdicción.

Excepción técnicamente fundada al tope del 20%: De manera excepcional, la Autoridad de Aplicación podrá superar el tope del 20% exclusivamente cuando se acrediten conjuntamente los siguientes requisitos:

1. El incumplimiento es de carácter sistémico y compromete la interoperabilidad del sistema en más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los efectores de la jurisdicción.

2. Han transcurrido más de CIENTO OCHENTA (180) días desde la advertencia formal sin subsanación efectiva ni Plan aprobado en ejecución.
3. El Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. ha emitido dictamen técnico favorable a la excepción por mayoría de DOS TERCIOS (2/3) de sus miembros.
4. El COFESA ha sido notificado con QUINCE (15) días hábiles de antelación sin emitir objeción fundada.

En ningún caso la restricción podrá superar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de los recursos C.U.R.A.-específicos, aun verificándose los requisitos de excepción. La restricción excepcional operará por periodos de TREINTA (30) días renovables, sujeta a revisión periódica obligatoria.

j) Recurso de Reconsideración ante el COFESA

La jurisdicción podrá interponer recurso de reconsideración dentro de los QUINCE (15) días hábiles de notificada la resolución del inciso h).

El COFESA resolverá en composición extraordinaria paritaria, con abstención de los representantes de la jurisdicción recurrente, dentro de los TREINTA (30) días hábiles. Su decisión será vinculante para la Autoridad de Aplicación.

El vencimiento del plazo sin pronunciamiento expreso equivaldrá a resolución favorable a la jurisdicción, con archivo automático de las actuaciones y cese inmediato de toda medida aplicada.

k) Efecto Suspensivo Automático

La interposición del recurso del inciso j) suspende automáticamente toda medida restrictiva hasta su resolución definitiva.

El efecto suspensivo solo podrá levantarse excepcionalmente cuando exista riesgo sanitario grave acreditado, mediante resolución fundada de la Autoridad de Aplicación con dictamen técnico favorable del Consejo Nacional. Toda resolución que levante el efecto suspensivo será recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con efecto suspensivo sobre el levantamiento.

l) Continuidad Asistencial y Límites Absolutos

Las medidas previstas en el presente artículo no podrán en ningún caso:

1. Impedir a ciudadanos el ejercicio de los derechos del Régimen C de la presente ley.
2. Interrumpir o degradar la atención sanitaria efectiva prestada por efectores públicos.
3. Utilizarse como mecanismo de presión para la adhesión de jurisdicciones no adherentes.
4. Condicionarse al acceso a fondos coparticipados o transferencias no vinculadas específicamente al Sistema C.U.R.A.

m) Publicidad y Transparencia

Toda actuación del presente artículo —incluyendo advertencias, planes, resoluciones y medidas— será incorporada al Portal Federal de Transparencia del Sistema C.U.R.A. en formato abierto, con excepción de la información cuya reserva sea autorizada por resolución fundada del Consejo Nacional por razones de seguridad sanitaria.

ARTÍCULO 4° TER.- Régimen de corresponsabilidad en el tratamiento de datos sanitarios.

En el marco del Sistema C.U.R.A., el tratamiento de datos personales de carácter sensible se regirá por la Ley 25.326 y sus normas complementarias.

A los efectos de dicha normativa:

a) Las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios adherentes serán responsables del tratamiento respecto de los datos generados por sus propios establecimientos y profesionales de salud.

b) El Estado Nacional, a través de la Autoridad de Aplicación del Sistema C.U.R.A., actuará como encargado del tratamiento en lo relativo a la infraestructura tecnológica, almacenamiento, interoperabilidad y custodia técnica de la información.

c) Cuando existan procesos de interoperabilidad que involucren datos generados en múltiples jurisdicciones, se configurará un régimen de corresponsabilidad funcional, debiendo establecerse mediante convenios específicos la delimitación de obligaciones, medidas de seguridad y canales de respuesta ante incidentes.

d) La responsabilidad por el uso indebido, acceso no autorizado o tratamiento ilícito de datos será atribuible al sujeto que haya realizado la acción, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pudiera corresponder por deficiencias en las medidas de seguridad bajo la órbita del encargado del tratamiento.

e) La Autoridad de Aplicación deberá designar formalmente un Delegado de Protección de Datos con funciones específicas de supervisión, coordinación interjurisdiccional y enlace con la Agencia de Acceso a la Información Pública.

El convenio de corresponsabilidad previsto en el inciso c) deberá suscribirse como condición de habilitación operativa plena de la jurisdicción adherente, dentro del plazo máximo de NOVENTA (90) días corridos contados desde la formalización del convenio de adhesión

previsto en el Artículo 4°.

Hasta tanto dicho convenio sea suscripto, y a los efectos exclusivos de la determinación de responsabilidades frente a terceros y ante la autoridad de control competente, se presumirá que el Estado Nacional, en su carácter de encargado del tratamiento conforme el inciso b), asume transitoriamente el rol de responsable principal del tratamiento respecto de los procesos de interoperabilidad multijurisdiccionales, sin perjuicio de las acciones de repetición que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 5°.- Sustento jurídico e integración normativa.

Sustento Jurídico.

La presente ley se dicta en el marco y en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución Nacional y se integra con las siguientes normas, que constituyen su sustento jurídico complementario:

Ley N.º 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud y sus modificatorias.

Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales, su Decreto Reglamentario 1558/2001 y disposiciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Ley N.º 27.706 de Historia Clínica Electrónica.

Ley N.º 25.506 de Firma Digital y su normativa reglamentaria.

La presente ley constituye norma especial posterior en los aspectos específicamente regulados en materia de interoperabilidad, intercambio electrónico nacional de datos clínicos y funcionamiento del Sistema C.U.R.A.

Integración y Estándares Internacionales.

Sin perjuicio de la primacía de la legislación nacional, la plataforma tecnológica y los procesos de gestión de datos del Sistema C.U.R.A. deberán alinearse con los más altos estándares internacionales de seguridad, privacidad, trazabilidad e integridad, adoptando como referencia técnica:

a) Los principios de Privacidad desde el Diseño y Portabilidad del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.
b) Los estándares de confidencialidad y seguridad previstos en la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) de los Estados Unidos.
c) Los criterios de integridad de registros electrónicos, trazabilidad e inmutabilidad (Audit

Trail) establecidos en la norma FDA 21 CFR Parte 11.

d) El Anexo 11 (EMA Annex 11) sobre sistemas computarizados de la Agencia Europea de Medicamentos.

e) Las guías y buenas prácticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de salud digital y gobernanza de datos sanitarios.

Estos estándares internacionales servirán como guía técnica interpretativa y de mejora continua, sin que ello implique aplicación directa de normativa extranjera ni desplazamiento del ordenamiento jurídico argentino.

Prevalencia.

En caso de conflicto normativo, prevalecerán las disposiciones de la presente ley en cuanto al intercambio electrónico nacional de datos clínicos, la interoperabilidad y la arquitectura técnica del Sistema C.U.R.A., sin perjuicio de las garantías de confidencialidad y protección de datos personales establecidas por la legislación vigente.

Adecuación Normativa.

Toda norma de igual o menor jerarquía que se oponga a lo establecido en la presente ley deberá adecuarse a sus disposiciones dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos desde su entrada en vigencia.

Hasta tanto se produzca su adecuación o derogación expresa, las normas preexistentes mantendrán vigencia en todo aquello que no se oponga a la presente ley.

TÍTULO II - AUTORIDAD DE APLICACIÓN, GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

ARTÍCULO 6°.- Autoridad de aplicación, control y respuesta ágil.

Autoridad de Aplicación.

Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación, que ejercerá sus funciones en coordinación con el Consejo Federal de Salud (COFESA) y el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. establecido en el Artículo 7°.

Funciones Centrales de la Autoridad de Aplicación:

a) Canales de Denuncia:

Establecer y mantener canales gratuitos y accesibles para que los usuarios puedan reportar incumplimientos de la presente ley. Dichos canales incluirán, como mínimo:

1) Una línea telefónica nacional de acceso gratuito —que podrá ser una línea ya existente en la administración pública nacional—.
2) Una dirección de correo electrónico específica.
3) Un formulario web integrado en el portal oficial del Sistema C.U.R.A.

b) Sistema de Sugerencias de Mejora:

Implementar y mantener un formulario web integrado en el portal oficial para la recepción de sugerencias, con un sistema de clasificación, priorización automatizada y validación de identidad para sugerencias de profesionales o instituciones.

c) Autenticación y Verificación:

Implementar el Mecanismo Federal de Autenticación Profesional utilizando los proveedores de identidad del Estado (Mi Argentina, Mi AFIP o Mi ANSES) e integrar de forma automática y diaria los registros nacionales y provinciales de matrículas para verificar su vigencia.

d) Delegación de Funciones:

Podrá delegar funciones técnicas y operativas específicas en otros organismos de la Administración Pública Nacional (Secretaría de Innovación Pública, AAIP, ARSAT S.A.) en materia de infraestructura, interoperabilidad y seguridad, mediante resolución fundada.

En ningún caso podrán delegarse facultades sancionatorias, regulatorias, decisorias de carácter político ni atribuciones que impliquen ejercicio del poder de policía sanitario.

e) Unidad Ejecutora:

Crear y dirigir la Unidad Ejecutora del Sistema C.U.R.A. (UESC), de conformidad con lo establecido en el Artículo 9°, como órgano responsable de la ejecución operativa y el desarrollo técnico del sistema.

f) Protocolo de Urgencia Crítica y Equipo de Respuesta (CSIRT-C.U.R.A.)

1) Activación:
   Se establece un Protocolo de Urgencia Crítica para casos de vulnerabilidad de

seguridad, caída funcional crítica o errores masivos. El sistema automatizado categorizará estas incidencias como “Urgencia Crítica”.

2) Notificación Inmediata:
Al activarse el protocolo, el sistema notificará inmediatamente al coordinador del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. y al Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CSIRT-C.U.R.A.).

3) Composición:
El CSIRT-C.U.R.A. estará conformado con personal especializado de áreas preexistentes del Ministerio de Salud, la ONTI y la AAIP, sin generar nuevas estructuras burocráticas.

4) Plazos Obligatorios de Respuesta:
Evaluación (24 hs):El coordinador del Consejo Nacional evaluará la procedencia de la alerta. De confirmarse, se derivará al CSIRT-C.U.R.A. con instrucciones específicas.
Mitigación (72 hs): Dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles desde su derivación, el CSIRT-C.U.R.A. deberá implementar medidas de mitigación efectiva destinadas a contener, aislar o reducir el impacto del incidente, garantizando la continuidad operativa esencial del sistema.

Resolución Técnica Definitiva: La resolución técnica definitiva del incidente deberá producirse dentro del plazo máximo establecido conforme la clasificación de severidad prevista en el Protocolo CSIRT-C.U.R.A., el cual no podrá exceder los TREINTA (30) días corridos salvo supuestos de especial complejidad técnica debidamente fundada y documentada.

Clasificación de Severidad: El Protocolo CSIRT-C.U.R.A. establecerá una taxonomía de incidentes de seguridad según niveles de severidad (S1, S2, S3 y S4), determinando para cada categoría los plazos máximos de mitigación y resolución técnica definitiva, conforme estándares internacionales de gestión de incidentes de ciberseguridad.

El incumplimiento de los plazos previstos no generará responsabilidad administrativa automática cuando la Autoridad de Aplicación acredite la adopción diligente de medidas de mitigación, contención y recuperación acordes a la severidad del incidente, debiendo dichas actuaciones quedar debidamente documentadas y sujetas a auditoría.

En caso de imposibilidad técnica objetiva de cumplimiento de los plazos máximos establecidos, debidamente fundada y documentada, la Autoridad de Aplicación deberá activar un Protocolo de Transparencia Institucional, que incluirá:

i) Publicación de un informe técnico preliminar en el portal oficial dentro de las VEINTICUATRO (24) horas.

ii) Notificación formal al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. y al Consejo Federal de Salud (COFESA).

iii) Comunicación a la Comisión de Salud de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación cuando el incidente afecte de manera significativa la continuidad operativa del sistema.

b) Cierre: Una vez implementada la solución, el coordinador del Consejo Nacional notificará formalmente el cierre del incidente.

c) Condiciones de Activación de Alertas Críticas
El sistema automatizado activará el Protocolo de Urgencia Crítica cuando detecte, en un período de SETENTA Y DOS (72) horas, alguna de las siguientes condiciones:

1) Más del QUINCE POR CIENTO (15%) de sugerencias mensuales categorizadas como “URGENTE” o “ERROR CRÍTICO”.

2) Más de CIEN (100) reportes de un mismo problema técnico.

3) Cualquier vulneración de seguridad reportada por más de DIEZ (10) usuarios.

La Autoridad de Aplicación podrá ajustar estos parámetros en la reglamentación, manteniendo el principio de prontitud.

d) Vinculación con la Estructura de Gobernanza
Las funciones de mejora continua, evaluación de sugerencias en el proceso regular y auditoría funcional serán ejercidas por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. establecido en el Artículo 7°, en coordinación con los subcomités técnicos especializados del Artículo 8°.

e) Funcionamiento y Sesiones
El Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. se reunirá de forma virtual de manera trimestral. No obstante, se activará el Protocolo de Urgencia Crítica cuando el sistema automatizado detecte alguna de las condiciones de activación de alerta crítica establecidas precedentemente, conforme a los plazos y procedimientos aquí definidos.

La participación de la Agencia de Acceso a la Información Pública no afectará en ningún caso su carácter de autoridad de control independiente en los términos de la Ley 25.326.

ARTÍCULO 7°.- Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

a) Creación y Naturaleza

Créase el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. como el órgano máximo de gobierno, decisión y coordinación del sistema, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, de carácter federal, paritario y permanente, el cual ejercerá sus funciones conforme a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y respeto a las autonomías jurisdiccionales.

b) Composición

El Consejo estará integrado por:

1) El/la Ministro/a de Salud de la Nación o quien éste designe, quien lo presidirá.
2) Dos (2) representantes del Ministerio de Salud de la Nación.
3) Cinco (5) representantes del Consejo Federal de Salud (COFESA).
4) Un (1) representante de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
5) Un (1) representante de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI).

c) Mecanismos de Designación y Elección

1) Representantes del Ministerio de Salud: Serán designados por resolución ministerial.
2) Representantes de COFESA:
    i) Serán elegidos por votación entre todos los Ministros de Salud provinciales presentes en sesión formalmente convocada de COFESA.
    ii) Requerirán mayoría absoluta de los miembros presentes.
    iii) En caso de no alcanzarse dicha mayoría en primera votación, se realizará una segunda votación entre los dos candidatos más votados, resultando electo quien obtenga mayoría simple.
    iv) Deberá garantizarse representación regional equilibrada del país.
    v) Durarán DOS (2) años en sus funciones.
3) Representantes de AAIP y ONTI: Serán designados por las máximas autoridades de cada organismo.

Todos los cargos serán ad-honorem y no generarán remuneración adicional.

d) Atribuciones Exclusivas

El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

1) Aprobar, mantener y actualizar los estándares técnicos obligatorios del Sistema C.U.R.A., basados en normas internacionales abiertas como HL7 FHIR R4 (o superior), SNOMED CT y LOINC.
2) Definir y controlar los protocolos de interoperabilidad, seguridad, auditoría y trazabilidad.
3) Emitir dictámenes técnicos vinculantes sobre la certificación de sistemas informáticos de prestadores.
4) Establecer y revisar los criterios técnicos para el Índice Público de Interoperabilidad y Calidad (Índice C.U.R.A.).
5) Decidir el cronograma de implementación territorial y asignar recursos e incentivos dentro de los límites presupuestarios vigentes.
6) Designar a los coordinadores de los subcomités y supervisar su funcionamiento.
7) Resolver conflictos entre los subcomités técnicos especializados creados por el artículo 8° de la presente ley y aprobar los informes trimestrales de transparencia.

Las atribuciones precedentes deberán ejercerse dentro del marco de la presente ley y no podrán implicar regulación de materias reservadas a las autonomías provinciales conforme a los artículos 121 y concordantes de la Constitución Nacional.

Los estándares técnicos aprobados por el Consejo Nacional constituyen normas técnicas de carácter administrativo. Para adquirir fuerza obligatoria general respecto de efectores privados y de la seguridad social, deberán ser incorporados mediante resolución de la Autoridad de Aplicación, conforme el procedimiento previsto en la Ley 19.549 y previa consulta pública de TREINTA (30) días cuando impliquen nuevas obligaciones para los prestadores. Las resoluciones técnicas así dictadas serán remitidas a las comisiones competentes del Congreso Nacional dentro de los DIEZ (10) días de su publicación en el Boletín Oficial, sin perjuicio de su vigencia inmediata.

e) Mecanismo de Participación de Gobernadores

1) Derecho a Voz: Cualquier Gobernador de provincia adherente tendrá derecho a voz en las sesiones del Consejo Nacional.

2) Notificación Previa: Cuando se trate de decisiones que afecten directamente la implementación operativa, técnica o presupuestaria en una provincia no representada

en ese momento en el Consejo, deberá notificarse previamente a dicha jurisdicción con una antelación no inferior a DIEZ (10) días hábiles, a fin de que pueda formular observaciones.

3) Portal de Transparencia:
El Consejo mantendrá un portal público con:

i) Calendario anual de sesiones.

ii) Orden del día publicado con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación.

iii) Enlaces de acceso.

iv) Actas públicas.

4) Participación Directa:
Los Gobernadores podrán unirse a sesiones ordinarias o extraordinarias para plantear problemas u opinar sobre temas de su jurisdicción.

5) Mecanismo de Urgencia Provincial:
Para problemas críticos, los Gobernadores podrán solicitar intervención inmediata, con respuesta obligatoria del Consejo en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles.

6) Notificaciones Automáticas:
Los Gobernadores recibirán alertas automatizadas cuando:

i) Se detecten problemas técnicos o de interoperabilidad en su jurisdicción.

ii) Se traten temas de su interés específico en el orden del día.

f) Funcionamiento

El Consejo funcionará de manera predominantemente virtual a través de plataforma oficial segura.

Se reunirá:

1) Mensualmente de forma ordinaria.
2) De manera extraordinaria cuando lo convoque su Presidente o lo solicite la mayoría absoluta de sus miembros.

Las decisiones se tomarán por consenso preferente o mayoría simple de los miembros presentes. En caso de empate, el/la Presidente/a tendrá voto dirimente.
El Consejo no podrá sesionar válidamente sin la presencia de al menos CUATRO (4) representantes de COFESA.

Todas las sesiones tendrán acta digital que se publicará dentro de los CINCO (5) días hábiles, pudiendo extenderse excepcionalmente hasta DIEZ (10) días hábiles en casos de especial complejidad técnica o federal, debidamente fundados.

g) Subcomités Dependientes

El Consejo Nacional supervisará y coordinará los siguientes subcomités técnicos especializados que se establecerán en el Artículo 8° de la presente ley:

1) Subcomité de Estándares e Interoperabilidad.
2) Subcomité de Usabilidad Clínica.
3) Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial.
4) Subcomité de Seguridad y Protección de Datos.

h) Transparencia y Rendición de Cuentas

1) Todas las decisiones, estándares y documentación serán de acceso público.
2) Se publicarán informes trimestrales de gestión en el portal oficial.
3) El Consejo rendirá cuentas anualmente ante las Comisiones de Salud del Congreso.

La Autoridad de Aplicación ejercerá sus funciones en coordinación permanente con el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., garantizando la participación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la definición de estándares técnicos, políticas de interoperabilidad y estrategias de implementación del sistema.

El Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. actuará como órgano estratégico de definición técnica y coordinación federal del sistema. Sus decisiones en materia de estándares técnicos, interoperabilidad, arquitectura del sistema y certificación tecnológica tendrán carácter vinculante para la Autoridad de Aplicación en el ámbito técnico correspondiente, sin perjuicio de las competencias regulatorias, sancionatorias y de política sanitaria que corresponden al Ministerio de Salud de la Nación conforme la presente ley.

ARTÍCULO 8°.- Subcomités técnicos especializados

a) Naturaleza: Establécese los siguientes subcomités técnicos especializados, que dependerán del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. y actuarán como órganos asesores y ejecutores:

1) Subcomité de Estándares e Interoperabilidad:

Composición: ONTI (coordina), ARSAT, 2 técnicos de COFESA, 2 especialistas en interoperabilidad

Función: Desarrollar, proponer y actualizar permanentemente los estándares HL7 FHIR, SNOMED CT, LOINC y los protocolos de exposición de datos (APIs) de servicios esenciales de salud, asegurando la compatibilidad con las interfaces ciudadanas nacionales.

Periodicidad: Reuniones semanales virtuales

2) Subcomité de Usabilidad Clínica:

Composición: 2 representantes médicos, 2 de enfermería, 1 de pacientes, 2 de COFESA

Función: Aprobar interfaces, flujos clínicos, con poder de veto sobre carga burocrática

Periodicidad: Reuniones quincenales virtuales

3) Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial:

Composición: Entre SIETE (7) y ONCE (11) miembros. Deberá incluir obligatoriamente: Dos (2) bioeticistas con aval de la Comisión Nacional de Bioética. Al menos un (1) especialista en informática, ciencias de datos o inteligencia artificial. Un (1) profesional de la salud con experiencia clínica. Un (1) epidemiólogo o experto en salud pública. Un (1) representante de asociaciones de pacientes. Al menos un (1) representante técnico designado por COFESA.

La cantidad exacta de integrantes será determinada por resolución fundada del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., en función de la carga de trabajo, la criticidad de los sistemas a evaluar o la necesidad de conformar comisiones técnicas o salas de evaluación paralelas.

Función: Certificar y auditar algoritmos de IA según Artículo 23, alineando sus criterios con los principios rectores de la Comisión Nacional de Bioética

Periodicidad: Reuniones mensuales virtuales

4) Subcomité de Seguridad y Protección de Datos:

Composición: AAIP (coordina), 1 especialista en ciberseguridad, 1 de ONTI, 2 de COFESA

Función: Definir protocolos de seguridad, cifrado, auditoría

Periodicidad: Reuniones semanales virtuales

b) Mecanismos de Designación:

1) Representantes médicos: elegidos por el consejo directivo de la federación médica de mayor representatividad nacional
2) Representantes de enfermería: elegidos por el colegio de enfermería de mayor representatividad nacional
3) Representante de pacientes: designado por consenso de asociaciones de pacientes registradas
4) Bioeticistas: designados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de ternas propuestas por universidades nacionales
5) Especialistas técnicos: designados por el Ministerio de Salud sobre la base de antecedentes comprobables
6) Representantes de COFESA: técnicos designados por los Ministros de Salud provinciales que acrediten experiencia específica

c) Mecanismos de Decisión y Trabajo:

Operar por consenso preferente o mayoría simple, elevando al Consejo Nacional, creado por el artículo 7° de la presente ley, los desacuerdos irreconciliables.

Contarán con 24 horas para responder a alertas críticas, 72 horas para problemas altos

Presentarán informes mensuales al Consejo Nacional

d) Sistema de Alertas Automáticas a Gobernadores:

Los Gobernadores recibirán notificaciones automáticas cuando:

Se detecten problemas de interoperabilidad en su jurisdicción

Haya alertas de seguridad que afecten establecimientos de su provincia

Se programen sesiones que traten temas de su interés específico

Podrán designar un "Enlace Digital Provincial" que reciba todas las comunicaciones

ARTÍCULO 9°.- Unidad ejecutora del sistema C.U.R.A. (UESC).

a) Creación y Naturaleza. Créase la Unidad Ejecutora del Sistema C.U.R.A. (UESC), bajo la órbita del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., como el órgano responsable de la ejecución operativa, el desarrollo técnico y la gestión diaria del sistema.

b) Composición y Régimen de Personal. Estará integrada por un Director Ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Salud de la Nación, y equipos técnicos especializados en informática sanitaria, interoperabilidad, ciberseguridad y gestión de proyectos.
Dichos equipos se constituirán con personal de áreas preexistentes del Ministerio de Salud, ARSAT, ONTI y la SIGEN, mediante el régimen de comisión de servicios o adscripción. El personal asignado mantendrá su situación de revista y salarial en su organismo de origen, pero pasará a depender funcional y jerárquicamente de manera exclusiva del Director Ejecutivo de la UESC durante el período de su asignación, suspendiendo transitoriamente la subordinación con su organismo de origen a los fines de evitar la doble dependencia y garantizar la estricta unidad de mando operativa.

c) Facultades. La UESC tendrá la facultad de:

1) Solicitar Personal: Requerir a las autoridades de los organismos intervinientes la asignación en comisión de servicios del personal necesario.
2) Ejecución: Ejecutar las decisiones del Consejo Nacional y de los subcomités.
3) Contratos: Gestionar los contratos con proveedores previa autorización correspondiente.
4) Coordinación: Coordinar la implementación territorial con las provincias.
5) Contingencia: Activar de oficio los protocolos de contingencia y respuesta ágil.
6) Reportes: Presentar planes de trabajo y reportes de avance al Consejo Nacional.

d) Pirámide de Gobernanza. La gobernanza del Sistema C.U.R.A. se estructura en tres niveles:

1) Nivel Estratégico (Decisión): Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. (Art. 7°).
2) Nivel Técnico (Asesoramiento y Ejecución): Subcomités Especializados (Art. 8°).
3) Nivel Operativo (Ejecución): Unidad Ejecutora del Sistema C.U.R.A. (UESC).

e) Sujeción a Estándares. Todas las decisiones técnicas de la UESC y los desarrollos del sistema deberán ajustarse obligatoriamente a los estándares, protocolos de interoperabilidad y seguridad definidos por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A..

f) Principio de Agilidad y Descentralización Operativa. La UESC contará con autonomía

operativa y financiera para la ejecución de su presupuesto y la toma de decisiones técnicas de baja y mediana complejidad, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional.

ARTÍCULO 9° BIS.- Incompatibilidades, conflictos de interés y remoción.

Las disposiciones del presente artículo serán de aplicación a todas las autoridades, órganos, comisiones, consejos, comités, subcomités, unidades ejecutoras, órganos de control y demás instancias de gobernanza creadas por la presente ley, cualquiera sea su denominación, jerarquía o modalidad de integración.

a) Incompatibilidades

No podrán integrar los órganos mencionados:

1) Personas con condena penal firme por delitos dolosos.
2) Quienes ejerzan cargos directivos, gerenciales, de representación o de control en empresas contratistas, concesionarias o proveedoras del Estado Nacional o en entidades que desarrollen, comercialicen o provean tecnología sanitaria, software de gestión en salud o equipamiento médico vinculado al Sistema C.U.R.A.
3) Quienes mantengan participación accionaria significativa, directa o indirecta, superior al CINCO POR CIENTO (5 %) del capital social, en empresas comprendidas en el inciso anterior.
4) Quienes presten servicios de consultoría privada relacionados con sistemas de información sanitaria durante el ejercicio de sus funciones y hasta UN (1) año posterior a su cese.
5) Funcionarios judiciales en actividad.
6) Quienes se encuentren comprendidos en las incompatibilidades previstas en la Ley de Ética Pública y normas concordantes.
7) Quienes tengan interés económico directo o indirecto en decisiones que puedan afectar patrimonialmente a entidades con las que mantengan vínculos contractuales o societarios.

b) Remoción

Los integrantes de los órganos alcanzados por el presente artículo podrán ser removidos antes de la finalización de su mandato por:

1) Incumplimiento grave, reiterado o injustificado de sus funciones.

2) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente no subsanada dentro del plazo de TREINTA (30) días de notificada.
3) Falta reiterada e injustificada a reuniones o actividades obligatorias.
4) Violación a los principios de ética pública, integridad, transparencia o deber de confidencialidad.
5) Mal desempeño debidamente acreditado.
6) Configuración de alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso a).

b) Garantías del Debido Proceso

La remoción deberá ser dispuesta por la autoridad que hubiere efectuado la designación, mediante acto debidamente fundado.

El procedimiento deberá garantizar, como mínimo:

1) Notificación fehaciente y circunstanciada de los hechos imputados.
2) Plazo no inferior a QUINCE (15) días hábiles para efectuar descargo escrito y ofrecer prueba.
3) Derecho a producir prueba pertinente y útil.
4) Audiencia personal si el interesado la solicitare dentro del plazo de descargo.
5) Resolución motivada que se pronuncie expresamente sobre los argumentos y pruebas aportadas.
6) Posibilidad de interponer recurso de reconsideración ante el órgano que dispuso la remoción dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles.

La violación sustancial del debido proceso establecido en el presente artículo acarreará la nulidad absoluta del acto de remoción.

La reglamentación podrá ampliar estas garantías, pero en ningún caso restringirlas.

ARTÍCULO 10.- Módulo nacional de trazabilidad y auditoría

Créase el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría del Sistema C.U.R.A., bajo la órbita de la Autoridad de Aplicación, como componente central encargado del registro, monitoreo, control y auditoría de todos los accesos, modificaciones y operaciones realizadas dentro del sistema, en cumplimiento con los principios establecidos en la presente ley.

Alcance y finalidad:

El Módulo tendrá por objeto garantizar la transparencia, integridad y no repudio de toda acción efectuada en el Sistema C.U.R.A., permitiendo reconstruir en cualquier momento la trazabilidad completa de cada evento vinculado a la historia clínica digital, tanto de pacientes como de profesionales de la salud.

Características Técnicas y Conservación:

Todos los registros del Módulo deberán contar con firma digital y sello de tiempo, conforme a la Ley 25.506 de Firma Digital, garantizando su inalterabilidad y validez probatoria.

Los registros deberán conservarse por un período mínimo de DIEZ (10) años contados desde su generación, garantizando su integridad, inalterabilidad y validez probatoria conforme a la Ley 25.506. Transcurrido dicho plazo, podrán ser anonimizados o suprimidos conforme criterios técnicos definidos por la reglamentación, siempre que no exista obligación legal de conservación adicional derivada de procesos judiciales, auditorías en curso o investigaciones administrativas debidamente fundadas.

Auditoría y Control Proactivo:

El Módulo deberá implementar un sistema de alertas automáticas para detectar patrones anómalos de acceso, intentos de manipulación o actividades fuera del perfil autorizado.

La Autoridad de Aplicación deberá emitir informes públicos trimestrales de auditoría con indicadores de accesos, incidentes, sanciones aplicadas y cumplimiento de los principios de confidencialidad y seguridad establecidos en la presente ley.

Sistema Unificado de Detección y Notificación:

El Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría centralizará todas las alertas automáticas del sistema y las derivará según su naturaleza:

Alertas de Seguridad y Ciberseguridad → Subcomité de Seguridad y Protección de Datos y CSIRT-C.U.R.A. (24h)

Alertas de Usabilidad y Problemas Masivos → Subcomité de Usabilidad Clínica (72h)

Alertas de Interoperabilidad Técnica → Subcomité de Estándares e Interoperabilidad (48h)

Alertas Sanitarias y Epidemiológicas → Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (24h)

Alertas Éticas y de IA → Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial (7 días) Sanciones y responsabilidades:

El acceso indebido, manipulación no autorizada, falsificación o intento de eliminación de registros de trazabilidad constituirá falta gravísima, sujeta a las sanciones previstas en el Artículo 44, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

ARTÍCULO 10 BIS.- Emisión unificada y verificación de certificados médicos digitales mediante el Portal Profesional C.U.R.A.

Ventanilla única. El Sistema C.U.R.A. implementará un Portal Profesional único, de acceso seguro y autenticación robusta, que funcionará como ventanilla única nacional para la emisión, gestión y consulta de documentos clínicos digitales, incluyendo, como mínimo, los certificados médicos de reposo laboral, licencias médicas, aptitud e inaptitud, y constancias clínicas, sin perjuicio de otros documentos clínicos que se incorporen.

Interfaz única con sistemas subyacentes. La emisión de certificados desde el Portal Profesional C.U.R.A. se realizará mediante integración interoperable con los sistemas emisores habilitados preexistentes —públicos o privados, nacionales o jurisdiccionales— o, en su defecto, mediante el mecanismo de emisión de respaldo previsto en el inciso 4), sin requerir que el profesional utilice portales externos adicionales para completar el acto de emisión.

Registro mínimo y referencia en la Historia Clínica Digital. Todo certificado emitido desde el Portal Profesional C.U.R.A., cualquiera sea el sistema emisor subyacente, deberá:

a) quedar vinculado a la Historia Clínica Digital del paciente como documento clínico digital interoperable;

b) contar con identificación única, sello de tiempo y registro de trazabilidad;

c) incorporar metadatos mínimos obligatorios, al menos: profesional emisor y matrícula verificada, fecha y hora de emisión, período de reposo o vigencia, tipo de certificado y estado (vigente, vencido, rectificado o anulado);

d) sujetarse a los mecanismos de auditoría y control establecidos en la presente ley.

Emisión de respaldo. En los casos en que no exista integración operativa disponible con un sistema emisor habilitado, o cuando dicha integración se encuentre temporalmente indisponible por causas técnicas verificables, la Autoridad de Aplicación garantizará la emisión mediante un mecanismo de respaldo dentro del Sistema C.U.R.A., el cual deberá:

a) exigir verificación de identidad y matrícula profesional vigente;

b) requerir firma digital o mecanismo equivalente conforme normativa aplicable;

c) registrar trazabilidad completa, sello de tiempo y conservar evidencia técnica de

integridad;

d) permitir rectificación o anulación, dejando constancia inalterable del historial de estados.

Verificación externa sin exposición clínica. Todo certificado emitido desde el Portal Profesional C.U.R.A. deberá contar con un mecanismo de verificación pública o semipública mediante enlace y/o código QR, que permita corroborar su autenticidad y vigencia sin necesidad de impresión y sin revelar datos clínicos. La verificación exhibirá, como máximo, los siguientes datos: existencia del certificado, identidad del emisor (nombre y matrícula), fecha de emisión, período de reposo o vigencia, y estado (vigente, vencido, rectificado o anulado). Queda prohibida la exhibición del diagnóstico, historia clínica u otros datos sensibles en el canal de verificación.

Presentación y aceptación. La presentación del certificado ante empleadores, aseguradoras de riesgos del trabajo, organismos de seguridad social u otros destinatarios se considerará válidamente cumplida mediante el enlace y/o QR de verificación, sin perjuicio de que el paciente pueda descargar una representación imprimible si lo desea.

La Autoridad de Aplicación coordinará con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación la armonización normativa necesaria para garantizar la plena validez laboral del certificado digital emitido conforme al presente artículo, sin perjuicio de su eficacia jurídica inmediata como documento digital firmado conforme la Ley 25.506.

La reglamentación establecerá los criterios de acceso, registro de consultas y medidas antifraude.

Rectificación, anulación y trazabilidad. La rectificación o anulación de certificados deberá reflejarse de manera inmediata en el mecanismo de verificación, manteniéndose un registro inalterable de estados y eventos (emisión, modificación, rectificación, anulación y consulta), conforme al Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría y demás disposiciones aplicables de la presente ley.

La rectificación o anulación de un certificado que hubiere sido ya presentado y utilizado ante terceros producirá efectos hacia el futuro desde su registro en el sistema, sin perjuicio de las acciones judiciales o administrativas que pudieren corresponder. En tales casos, el sistema deberá permitir la notificación fehaciente al destinatario previamente verificado, cuando así lo determine la reglamentación.

No sustitución de regímenes vigentes. El presente artículo no deroga ni sustituye los

regímenes legales vigentes en materia de receta electrónica, firma digital, ejercicio profesional y documentación sanitaria, y se limita a establecer el acceso unificado, la integración interoperable, la trazabilidad y la verificación de certificados en el marco del Sistema C.U.R.A.

Valor probatorio y preservación forense.

Los certificados médicos digitales emitidos, verificados y trazados conforme al presente artículo, así como los registros técnicos asociados a su emisión, rectificación, anulación y verificación, gozarán de presunción de integridad, autenticidad e inalterabilidad, y constituirán instrumentos digitales válidos con pleno valor probatorio en sede administrativa, laboral, previsional y judicial, sin perjuicio de la posibilidad de impugnación mediante pericia técnica específica. A tales efectos, el Sistema C.U.R.A. deberá garantizar mecanismos de sellado temporal, hash criptográfico, registro inmutable de eventos, conservación íntegra de evidencias técnicas y cadena de custodia digital, conforme a los estándares que establezca la reglamentación, asegurando su admisibilidad forense y su verificabilidad independiente.

ARTÍCULO 10 TER.- Plazos de Conservación Diferenciados.

a) Historia Clínica Integral: conforme normativa sanitaria vigente y por un plazo no inferior a VEINTE (20) años.
b) Registros de trazabilidad y auditoría: DIEZ (10) años.
c) Logs técnicos de acceso y seguridad informática: CINCO (5) años.
d) Registros generados en modo contingencia: DIEZ (10) años.
e) Datos anonimizados para fines de investigación o análisis epidemiológico: mientras subsista imposibilidad razonable de re-identificación conforme estándares técnicos auditables.

ARTÍCULO 11.- Registro Nacional de Prestadores Habilitados del Sistema C.U.R.A.

Créase el Registro Nacional de Prestadores Habilitados del Sistema C.U.R.A., a cargo de la Autoridad de Aplicación, el cual listará a los efectores de salud y a los sistemas informáticos certificados en conformidad con los estándares de interoperabilidad, seguridad y calidad de datos definidos por la presente ley, su reglamentación y el Marco de Interoperabilidad Federal (MIF).

La inscripción en el Registro será requisito indispensable para:

a) Acceder al Sistema C.U.R.A. con permisos de escritura.

b) Cargar información clínica en la plataforma.

c) Emitir prescripciones electrónicas u otros documentos clínicos digitales integrados al sistema.

d) Acceder a historias clínicas digitales en los términos de la presente ley.

Requisitos de Inscripción

Podrán inscribirse en el Registro:

a) Profesionales de la salud que acrediten matrícula vigente otorgada por autoridad competente.

b) Establecimientos sanitarios que acrediten habilitación vigente emitida por la autoridad jurisdiccional correspondiente.

c) Prestadores o entidades cuyos sistemas informáticos hayan sido certificados en cuanto a su conformidad técnica con los estándares de interoperabilidad, seguridad, trazabilidad y disponibilidad establecidos por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

Vigencia, Auditorías y Estándares Técnicos

La vigencia de la habilitación estará sujeta a:

a) El mantenimiento permanente de la conformidad técnica con los estándares aprobados.

b) La superación de auditorías técnicas periódicas, con una frecuencia mínima anual, que verificarán:

    1) El cumplimiento de estándares de seguridad de la información.
    2) Los protocolos de acceso, autenticación y trazabilidad.
    3) La calidad, integridad y completitud de los datos cargados.
    4) La actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.
    5) El cumplimiento de los niveles de servicio (SLA/SLO) establecidos en el MIF.
    6) Procedimiento en Caso de No Conformidad

Si una auditoría detectare incumplimientos, se aplicará el siguiente procedimiento:

a) Notificación fehaciente al prestador, detallando las observaciones técnicas y otorgando un

plazo no inferior a TREINTA (30) días corridos para su subsanación, prorrogable según la complejidad del caso.

b) Plan de regularización: El prestador podrá presentar un plan de adecuación con cronograma técnico verificable. La Autoridad de Aplicación podrá aprobarlo, suspendiendo el proceso sancionatorio mientras se ejecute en tiempo y forma.

c) Re-auditoría: Vencido el plazo otorgado o finalizado el plan aprobado, se realizará una nueva evaluación técnica.

d) Suspensión preventiva: Cuando los incumplimientos generen riesgo grave para la seguridad de los datos, la continuidad asistencial o la integridad del sistema, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la suspensión preventiva de los permisos de escritura, garantizando mecanismos alternativos transitorios que aseguren la continuidad de la atención sanitaria.

e) Revocación: Solo procederá la revocación de la inscripción cuando, agotadas las instancias anteriores, subsista el incumplimiento, mediante resolución fundada y con garantía de debido proceso conforme el régimen sancionatorio previsto en la presente ley.

La suspensión o revocación de la inscripción no impedirá al prestador continuar prestando servicios de salud por vías alternativas, pero le impedirá operar dentro del Sistema C.U.R.A. hasta regularizar su situación.

ARTÍCULO 11 BIS.- Gestión Federal de Calidad de Datos e Índice C.U.R.A.

Todos los efectores de salud que integren el Sistema C.U.R.A. deberán cumplir los estándares mínimos de calidad de datos definidos por la Autoridad de Aplicación conforme el Marco de Interoperabilidad Federal (MIF) y los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

A tales efectos, el Sistema implementará mecanismos automatizados de evaluación continua de la calidad de los datos cargados, conforme, como mínimo, los siguientes criterios:

a) Completitud: porcentaje de campos obligatorios efectivamente cumplimentados.

b) Exactitud: coherencia interna y lógica de los datos registrados.

c) Consistencia: compatibilidad de la información con registros previos del paciente.

d) Actualidad: oportunidad temporal de la carga respecto del momento de la prestación.

e) Unicidad: ausencia de duplicación de registros clínicos.

f) Conformidad semántica: adecuación a los estándares terminológicos y codificaciones oficiales.

g) Trazabilidad y accesibilidad interoperable: disponibilidad técnica de la información para intercambio seguro y auditado.

Sistema de Indicadores

La Autoridad de Aplicación publicará trimestralmente el Índice C.U.R.A. de Calidad de Datos, el cual medirá el desempeño de cada prestador y jurisdicción conforme una escala estandarizada, objetiva y verificable.

El índice tendrá carácter técnico y comparativo, y su metodología deberá ser pública, transparente y auditable.

Los prestadores que obtengan una calificación inferior al sesenta por ciento (60/100) durante dos (2) trimestres consecutivos serán notificados fehacientemente para presentar un plan de mejora técnica con cronograma de adecuación.

Consecuencias del Incumplimiento Persistente

La persistencia de deficiencias en la calidad de datos, una vez agotadas las instancias de notificación y mejora, podrá dar lugar a:

a) Suspensión transitoria de los permisos de escritura en el Sistema C.U.R.A., previa sustanciación del procedimiento previsto en el artículo 11.

b) Derivación obligatoria al Subcomité Técnico de Usabilidad Clínica para asistencia técnica especializada.

c) Tipificación como falta grave conforme el régimen sancionatorio de la presente ley cuando la deficiencia obedezca a negligencia manifiesta o resistencia injustificada a cumplir estándares mínimos.

En todos los casos, el prestador conservará acceso de lectura a las historias clínicas de sus pacientes, garantizando la continuidad asistencial y el derecho a la salud.

El Índice C.U.R.A. será publicado de manera estratificada según el tipo de efector (alta, mediana y baja complejidad), tamaño de población atendida y contexto geográfico, a fin de garantizar comparabilidad significativa y evitar efectos estigmatizantes derivados de asimetrías estructurales. Para efectores rurales o ubicados en zonas de baja densidad poblacional, la metodología incluirá parámetros de corrección geográfica y ponderación contextual definidos reglamentariamente.

TÍTULO III - ARQUITECTURA, INFRAESTRUCTURA Y ESTÁNDARES TÉCNICOS

ARTÍCULO 12.- Infraestructura, arquitectura, colaboración estratégica y principio de máxima eficiencia presupuestaria

Infraestructura Pública y Eficiencia Presupuestaria. El desarrollo e implementación del Sistema C.U.R.A. se realizará bajo el Principio de Máxima Eficiencia Presupuestaria, utilizando prioritariamente la infraestructura tecnológica del Estado Nacional preexistente, en particular la de ARSAT S.A., con la cual se celebrará un convenio de mandato con precio de mercado auditado por la SIGEN. Cuando la infraestructura pública disponible resultare técnicamente insuficiente, o su utilización fuere antieconómica, la Autoridad de Aplicación podrá contratar con terceros conforme el régimen general del Decreto 1023/01 y sus modificatorias, debiendo fundar la insuficiencia mediante informe técnico de la UESC aprobado por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. Se priorizará el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros disponibles mediante la reasignación estratégica de partidas presupuestarias, con el objetivo de minimizar la generación de nuevas erogaciones para el Tesoro Nacional.

Alojamiento y Conectividad Federal. El sistema se alojará en los centros de datos de organismos nacionales y utilizará los recursos de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT S.E.), aprovechando la capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) para garantizar la conectividad troncal y la soberanía de los datos.

Arquitectura de "Cliente Liviano" (Hardware Cero). El sistema se implementará bajo una arquitectura web de "cliente liviano". Esto garantizará que el acceso completo a sus funcionalidades no requiera servidores locales ni hardware específico en las jurisdicciones, pudiendo operarse desde cualquier dispositivo estándar con navegador web (computadoras, tabletas o celulares), maximizando el uso de la capacidad instalada en los centros de salud.

Convenios de Colaboración Sin Transferencia de Fondos. Facúltase a la Autoridad de Aplicación a celebrar convenios de colaboración técnica con universidades públicas, institutos tecnológicos, organismos nacionales, provinciales o municipales y entidades del sistema científico estatal para el desarrollo y mejora del sistema. Dichos acuerdos se instrumentarán bajo la modalidad de cooperación técnica sin transferencia de fondos, aprovechando el capital intelectual del Estado.

Arquitectura Modular, Escalable y Extensible. El Sistema C.U.R.A. deberá concebirse y desarrollarse bajo una arquitectura modular, escalable y extensible, que permita la

incorporación progresiva de nuevas funcionalidades, módulos y servicios, sin necesidad de modificar la presente ley, conforme lo establezca la reglamentación y el Marco de Intercambio Federal.

ARTÍCULO 12 BIS.- Infraestructura Preparada para IA y Modernización de Legados.

La arquitectura técnica del Sistema C.U.R.A. deberá garantizar desde su diseño ('AI-Ready') la capacidad de incorporar módulos de Inteligencia Artificial de forma posterior, mediante APIs estandarizadas y contenedores softwares independientes.

Modernización de Sistemas Legados: La Autoridad de Aplicación proveerá Soporte Técnico Federal e implementará herramientas de extracción, transformación y carga (ETL) asistidas por IA para la migración, limpieza, estandarización y mapeo semántico de datos provenientes de sistemas preexistentes, garantizando la interoperabilidad sin costos de licenciamiento para las jurisdicciones.

ARTÍCULO 12 TER.- Financiamiento de la infraestructura digital sanitaria y adecuación del Fondo del Servicio Universal.

a) Financiamiento Complementario.

Sin perjuicio del régimen general de financiamiento del Sistema C.U.R.A., la infraestructura de conectividad sanitaria necesaria para su funcionamiento podrá financiarse, en lo estrictamente referido a redes y transporte de datos, mediante recursos provenientes del Fondo del Servicio Universal (FSU), creado por la Ley N° 27.078, con carácter complementario y específico.

b) Incorporación de finalidad específica al Fondo del Servicio Universal.

Incorpórase como último párrafo del artículo 25 de la Ley N° 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

“Asimismo, podrá destinarse hasta un máximo del VEINTE POR CIENTO (20%) anual de los recursos efectivamente recaudados por el Fondo del Servicio Universal al financiamiento de infraestructura de conectividad sanitaria vinculada al Sistema C.U.R.A., exclusivamente para el despliegue de redes, transporte de datos e infraestructura física necesaria para garantizar interoperabilidad y acceso digital en establecimientos públicos de salud.

La aplicación anual de este destino estará condicionada a la emisión previa de un informe técnico de evaluación de impacto suscripto por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que deberá certificar que la afectación prevista para el ejercicio no reducirá de

manera sustancial la ejecución de los programas tradicionales de conectividad universal.

La aplicación de este destino tendrá carácter complementario y no sustitutivo de los programas tradicionales de conectividad universal, y estará sujeta a evaluación anual de impacto técnico y presupuestario.

La presente afectación tendrá carácter transitorio por un plazo de CINCO (5) años desde la entrada en vigencia de la ley que la disponga, debiendo el Poder Ejecutivo remitir al Honorable Congreso de la Nación un informe anual de evaluación de resultados y continuidad como condición para su eventual renovación.”

c) Principio de Complementariedad.

La utilización de recursos del Fondo del Servicio Universal en el marco del Sistema C.U.R.A.:

1) Tendrá carácter estrictamente complementario y no sustitutivo de las partidas presupuestarias sanitarias;
2) No podrá implicar reducción de créditos presupuestarios asignados a políticas públicas de salud digital;
3) Deberá justificarse en términos de conectividad estructural y no de gasto operativo sanitario.

d) Control y Transparencia.

La aplicación de recursos del Fondo del Servicio Universal destinados a infraestructura de conectividad sanitaria estará sujeta a:

1) Auditoría anual por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN);
2) Control externo de la Auditoría General de la Nación (AGN);
3) Publicación anual de un informe técnico conjunto entre el ENACOM y el Ministerio de Salud de la Nación.

El informe deberá detallar:

a) El monto total recaudado por el Fondo en el ejercicio;
b) El porcentaje y monto específico afectado a infraestructura sanitaria;

c) La localización territorial de los proyectos financiados;

d) El estado de ejecución y grado de avance;

e) La justificación técnica de la complementariedad de la inversión.

Dicho informe será remitido a las Comisiones competentes en materia de Salud y Comunicaciones de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 13.- Arquitectura híbrida, capa de intercambio federada y repositorios nacionales.

El Sistema C.U.R.A. adoptará una arquitectura híbrida compuesta por repositorios nacionales para los datos críticos y repositorios jurisdiccionales o institucionales para el almacenamiento de historias clínicas completas, interconectados mediante una Capa de Intercambio Federada (CIF) basada en estándares internacionales de interoperabilidad.

La Capa de Intercambio Federada asegurará la comunicación entre los sistemas provinciales, municipales y privados mediante interfaces API seguras, autenticadas bajo protocolo OAuth 2.0, con cifrado extremo a extremo y registro de todas las transacciones en auditorías selladas digitalmente.

Los repositorios nacionales deberán incluir, como mínimo:

a) El Resumen Clínico de Urgencias (alergias, medicamentos activos, diagnósticos crónicos, cirugías y antecedentes relevantes).

b) El Registro Nacional de Receta Electrónica y Tratamientos Activos.

c) El Registro Federal de Vacunación e Inmunizaciones.

d) El Identificador Único de Paciente (C.U.R.A.-ID), que garantice la trazabilidad y unicidad de la información sanitaria en todo el territorio nacional.

e) Cualquier otro conjunto de datos que la Autoridad de Aplicación determine como crítico para la continuidad asistencial y la seguridad del paciente.

Las jurisdicciones y prestadores adheridos deberán implementar repositorios propios o integraciones que permitan el acceso federado conforme las especificaciones técnicas del Marco de Intercambio Federal (MIF), manteniendo la soberanía sobre la información originada en su ámbito.

La Autoridad de Aplicación aprobará y publicará las guías técnicas basadas en los estándares

internacionales de interoperabilidad clínica y semántica vigentes, tales como HL7 FHIR, SNOMED CT y LOINC o los que en el futuro los reemplacen, garantizando la compatibilidad semántica y técnica de los sistemas adheridos.

El Sistema C.U.R.A. deberá garantizar la redundancia geográfica de sus repositorios nacionales dentro del territorio argentino, contar con un Plan Nacional de Recuperación ante Desastres (DRP) y realizar pruebas semestrales de restauración y continuidad de servicio.

Toda transmisión o consulta de información deberá estar sujeta a autenticación fuerte, cifrado en tránsito y en reposo, y registro de auditoría accesible para la Autoridad de Aplicación y los titulares de los datos.

La implementación del presente artículo se ajustará al principio de máxima eficiencia presupuestaria para el Estado Nacional, conforme lo establecido en el Artículo 35 de la presente ley, utilizando la infraestructura tecnológica disponible de ARSAT S.E., la Red Federal de Fibra Óptica y demás recursos públicos interoperables.

La incorporación de datos al repositorio nacional del Resumen Clínico de Urgencias por parte de efectores pertenecientes a jurisdicciones no adherentes al Régimen B se regirá exclusivamente por el protocolo de portabilidad interjurisdiccional previsto en el Artículo 3° BIS, sin que ello implique adhesión operativa plena al Sistema C.U.R.A., integración estructural a su plataforma ni corresponsabilidad jurisdiccional automática en los términos del Artículo 4° TER.

ARTÍCULO 14.- Estrategia de implementación escalonada por módulos de valor e hitos.

La Autoridad de Aplicación, en acuerdo con el Ministerio de Economía y previa consulta con el Consejo Federal de Salud (COFESA), implementará el Sistema C.U.R.A. bajo una estrategia escalonada por módulos de valor. Esta vía prioriza el despliegue progresivo por funcionalidades críticas, maximizando el beneficio sanitario y minimizando el riesgo fiscal, con un avance sujeto al estricto cumplimiento de hitos técnicos de habilitación.
La implementación completa hasta la culminación de la Fase 3 no podrá exceder el plazo máximo de SIETE (7) años contados desde la promulgación de la presente ley.

La secuencia funcional obligatoria de implementación será la siguiente:

FASE 1 (Sistema Base - Años 1-2): Despliegue de los componentes fundacionales del sistema, incluyendo la Historia Clínica Electrónica Federal, el Sistema Federal de Gestión de

Turnos con capacidad para modalidad presencial y virtual, la Trazabilidad Digital de Medicamentos y la Interoperabilidad básica (FHIR), sin activación de módulos de IA clínica compleja.

Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos desde la promulgación de la presente ley, la Autoridad de Aplicación deberá presentar ante el Honorable Congreso de la Nación un Plan Federal de Implementación detallado que establezca cronograma operativo, metas cuantificables y criterios verificables de avance.

FASE 2 (IA de Bajo Riesgo - Años 2-3): Incorporación de módulos de optimización logística, limpieza y estandarización automática de datos, la implementación obligatoria de la videoconsulta integrada para las condiciones establecidas en el Artículo 19 QUINQUIES, accesibilidad digital asistida y herramientas administrativas inteligentes.

FASE 3 (IA de Riesgo Moderado - Años 3-5): Implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica predictiva, soporte a la codificación clínica y herramientas de asistencia administrativa avanzada.

FASE 4 (IA de Alto Impacto - Año 5+): Evaluación y despliegue de sistemas de soporte a decisiones clínicas, personalización de tratamientos y predictores de riesgo individual, bajo estricta supervisión humana.

FASE 5 (Proyección Global - Año 5+): Implementación del Hub de Interoperabilidad Sanitaria Global y el Resumen Internacional del Paciente (IPS), habilitando la conexión transfronteriza y la exportación de servicios, una vez consolidada la cobertura nacional.

Los hitos técnicos de implementación deberán garantizar un avance progresivo, verificable y medible del Sistema C.U.R.A., debiendo cumplirse como mínimo las siguientes condiciones:

a) Dentro de los VEINTICUATRO (24) meses desde la promulgación de la presente ley deberá encontrarse operativa la Fase 1 en al menos una jurisdicción piloto y haberse iniciado el despliegue en efectores adicionales del Régimen A.

b) Dentro de los CUARENTA Y OCHO (48) meses deberá verificarse la implementación operativa del sistema base en una proporción significativa de efectores alcanzados por el Régimen A.

c) Dentro del plazo máximo de SIETE (7) años previsto en el presente artículo deberá haberse

alcanzado la cobertura nacional funcional del sistema conforme los estándares técnicos establecidos.

La Auditoría General de la Nación (AGN) auditará anualmente el cumplimiento de estos hitos y publicará un informe público de avance.

La Autoridad de Aplicación podrá ajustar el cronograma operativo territorial o técnico siempre que no se altere el plazo máximo de implementación ni los principios de progresividad, eficiencia presupuestaria y cobertura nacional establecidos por la presente ley.

La implementación territorial de cada fase se realizará conforme al protocolo de implementación por tandas provinciales sucesivas y a los hitos de salida establecidos en las Disposiciones Transitorias de la presente ley. El avance a la fase funcional siguiente a nivel nacional estará supeditado al cumplimiento de los Criterios Técnicos de Habilitación definidos para la fase anterior, los cuales serán certificados por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A..
La verificación del cumplimiento de los hitos de transición entre fases será auditada por la Auditoría General de la Nación (AGN), que emitirá informe público anual sobre el estado de avance del sistema.
Si transcurridos VEINTICUATRO (24) meses desde la promulgación no se hubiera iniciado operativamente la Fase 1 en al menos una jurisdicción piloto, cualquier ciudadano o asociación vinculada a la defensa del derecho a la salud podrá presentar reclamo ante el Defensor del Pueblo de la Nación, quien evaluará la razonabilidad de la demora e instará, en su caso, a la Autoridad de Aplicación a adoptar medidas correctivas.

ARTÍCULO 15.- Estándares de interoperabilidad.

El Sistema C.U.R.A. integrará mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs) seguras y estándares internacionales de interoperabilidad a todos los subsistemas de salud. Es obligatorio para todo prestador garantizar la compatibilidad técnica de sus agendas con el Sistema Federal de Gestión de Turnos creado por el Artículo 19 bis, asegurando la sincronización en tiempo real

ARTÍCULO 16.- Conjunto mínimo básico de datos y expansión semántica.

La Autoridad de Aplicación deberá publicar, en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la reglamentación, el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) obligatorio. Este documento establecerá la lista prioritaria y acotada de los códigos SNOMED CT y LOINC para los diagnósticos, procedimientos, alergias, medicación y resultados de laboratorio de mayor

prevalencia, criticidad y uso en emergencias, a ser utilizados obligatoriamente por los prestadores.

El objetivo es acelerar la integración y asegurar la interoperabilidad semántica perfecta en los datos críticos.

Finalizado el plazo de implementación de la Vía de Implementación adoptada (Art. 14), la Autoridad de Aplicación establece un cronograma de expansión progresiva y obligatoria para el resto de las terminologías SNOMED CT y LOINC. Dicha expansión se realizará por módulos o ámbitos temáticos (ej. especialidades, procedimientos complejos) y tendrá como objetivo alcanzar la plena cobertura de los términos clínicos y de laboratorio en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) meses desde la reglamentación de la presente ley, asegurando la integración gradual sin generar disrupciones operativas o costos desmedidos de adaptación simultánea.

TÍTULO IV - DERECHOS DEL PACIENTE, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y GESTIÓN INTELIGENTE DE LA DEMANDA

ARTÍCULO 17.- Identificador Único de Paciente (C.U.R.A.-ID), Trazabilidad y Credenciales.

Créase el Identificador Único de Paciente (C.U.R.A.-ID), de carácter nacional, único, intransferible y permanente, asignado a toda persona registrada en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), conforme el procedimiento de activación establecido en el presente artículo.

El C.U.R.A.-ID constituye la clave técnica unívoca de vinculación de la información sanitaria de cada persona en el Sistema C.U.R.A., garantizando la integridad, continuidad asistencial, interoperabilidad y trazabilidad de su historia clínica digital.

El C.U.R.A.-ID constituye infraestructura pública sanitaria esencial y no podrá ser eliminado del registro de infraestructura del sistema ni suprimido de la base de identificación central, sin perjuicio del derecho de restricción del tratamiento activo reconocido en el inciso f) BIS del presente artículo y de la opción de exclusión prevista en el inciso e).

a) Creación y Naturaleza.

El C.U.R.A.-ID constituye un identificador sanitario de carácter nacional, único e intransferible, vinculado al titular desde su generación. No constituye documento de identidad civil ni podrá ser utilizado como sustituto del DNI, CUIL, CUIT u otros identificadores generales, quedando restringido exclusivamente al ámbito sanitario.

b) Generación técnica previa, activación y base jurídica del tratamiento.

1. Generación técnica previa (estado inactivo).

El C.U.R.A.-ID será generado de forma automática como identificador técnico de reserva para toda persona inscripta en el RENAPER. Dicha generación no implicará, por sí misma, tratamiento activo de datos personales ni sanitarios en los términos de la Ley N.° 25.326, ni habilitará acceso, vinculación o circulación de información clínica, manteniéndose en estado inactivo hasta su activación conforme lo dispuesto en el presente artículo.

2. Activación del identificador.

El C.U.R.A.-ID adquirirá estado activo únicamente cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

a) Activación por relación asistencial: Cuando la persona sea objeto de una prestación efectiva de salud en cualquier efector público o privado. En este supuesto, el efector deberá informar al titular, con antelación suficiente y como paso previo separado del inicio del acto asistencial, de manera clara, comprensible y accesible, sobre la creación, funcionamiento, efectos y derechos vinculados al identificador, conforme el artículo 6° de la Ley N.° 25.326. La información deberá quedar registrada en el sistema. La falta de información previa invalidará la activación del C.U.R.A.-ID para esa prestación, sin que ello impida la atención sanitaria del paciente.

b) Activación voluntaria anticipada: Cuando el titular active el identificador por iniciativa propia mediante plataformas digitales oficiales del Estado Nacional que acrediten identidad, incluyendo sistemas de identidad digital interoperables (Mi Argentina u otros que los reemplacen o complementen).

En ambos casos, la activación habilitará el uso del identificador exclusivamente para fines sanitarios, en los términos de la presente ley.

3. Base jurídica del tratamiento.

El tratamiento de los datos clínicos asociados al C.U.R.A.-ID, una vez activado, se fundamenta en:

a) la relación asistencial entre paciente y sistema de salud, conforme el artículo 7°, párrafo 4°, de la Ley N.° 25.326;

b) el interés público en materia sanitaria, la continuidad asistencial interjurisdiccional y el cumplimiento de obligaciones legales en materia de historia clínica digital, constituyendo excepción legal al consentimiento previo conforme artículo 7°, cuarto párrafo, de la Ley 25.326;

c) el consentimiento informado del titular en los casos que corresponda.

El tratamiento se regirá por los principios de: (1) Legalidad; (2) Finalidad; (3) Proporcionalidad; (4) Minimización; (5) Seguridad por diseño; (6) Responsabilidad proactiva.

Todo lo anterior conforme los artículos 42, 43 y 75 incisos 18, 19 y 22 de la Constitución

Nacional, la Ley 25.326, la Ley 26.529 y la Ley 27.706.

c) Generación Automática e Interoperabilidad.

El C.U.R.A.-ID se generará automáticamente a partir de los datos validados por el RENAPER y será interoperable con los sistemas de identidad digital del Estado Nacional. Los recién nacidos, personas que adquieran la nacionalidad o residencia y quienes se inscriban con posterioridad recibirán el C.U.R.A.-ID en forma automática, quedando en estado inactivo hasta su activación conforme el inciso b) del presente artículo.

d) Instrumentación y Credenciales.

Todo habitante tendrá acceso gratuito a su credencial digital a través de la plataforma digital oficial del Estado Nacional 'Mi Argentina', o la que en el futuro la reemplace o complemente.

La credencial digital contendrá:

1. Código QR estático asociado de manera unívoca al C.U.R.A.-ID del titular.

2. Token de autenticación dinámico, personal, renovable y de validez temporal limitada, destinado a la validación reforzada de identidad en farmacias, hospitales y demás establecimientos sanitarios habilitados.

3. Datos personales básicos visibles, conforme el principio de minimización de datos.

4. Elementos de seguridad criptográfica y mecanismos de integridad definidos por la reglamentación.

5. El código QR constituirá un mecanismo de identificación sanitaria que permitirá la verificación segura del C.U.R.A.-ID dentro del Sistema C.U.R.A.

Los niveles de acceso a la información sanitaria estarán determinados exclusivamente por:

1. El perfil autenticado del profesional o institución interviniente.

2. Las reglas de autorización y consentimiento del titular.

3. Los protocolos de emergencia previstos en la presente ley y su reglamentación.

Tipos de credenciales:

1. Credencial Física Opcional (Arancelada).

El titular podrá solicitar la emisión de una credencial física inteligente vinculada a su C.U.R.A.-ID, la cual contendrá:

i) Nombre y apellido del titular.

ii) Número de Documento Nacional de Identidad.

iii) Código QR impreso asociado de manera unívoca al C.U.R.A.-ID del titular, ubicado en el

reverso.

iv) Tecnología NFC o equivalente para validación por proximidad en entornos sanitarios habilitados.

v) Datos Vitales Críticos visibles de emergencia, exclusivamente en los términos y con los alcances previstos en el Artículo 17 TER de la presente ley.

La emisión de la credencial física será arancelada conforme los costos de producción y distribución, salvo los supuestos de gratuidad que establezca la reglamentación para grupos vulnerables definidos mediante criterios objetivos. La credencial física no almacenará información clínica adicional en soporte físico, limitándose a exhibir únicamente los Datos Vitales Críticos expresamente autorizados y validados conforme el Artículo 17 TER.

2. Formato Digital Imprimible (Gratuito).

El Sistema C.U.R.A. permitirá la descarga gratuita de un formato digital imprimible que contendrá:

i) Nombre y apellido del titular.

ii) Número de Documento Nacional de Identidad.

iii) Código QR vinculado al C.U.R.A.-ID.

iv) Los Datos Vitales Críticos previstos y regulados en el Artículo 17 TER.

Este formato tendrá idéntica funcionalidad identificatoria que la credencial física, con excepción de la tecnología NFC. Servirá como mecanismo de respaldo para identificación sanitaria básica y garantizará igualdad de acceso a la credencial física para personas que no cuenten con dispositivos digitales o recursos suficientes.

e) Régimen de Trazabilidad Integral.

Toda acción realizada en el Sistema C.U.R.A. quedará registrada en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría.

Deberá consignarse como mínimo:

1. Identidad digital y matrícula o CUIT del profesional actuante.

2. Fecha y hora exactas del acceso.

3. Identificador de paciente (C.U.R.A.-ID).

4. Tipo de acción realizada.

5. Establecimiento y terminal de acceso.

6. Dirección IP o identificación técnica del dispositivo cuando corresponda.

f) Derechos del Titular — Limitación y Control.

Sin perjuicio del carácter permanente del C.U.R.A.-ID como elemento de infraestructura, el titular podrá:

1. Consultar en tiempo real el historial completo de accesos.

2. Activar alertas de acceso.

3. Limitar la visualización de categorías específicas de datos sensibles, salvo en situaciones de emergencia debidamente registradas bajo protocolo 'break-glass'.

4. Oponerse al uso de sus datos para fines secundarios no asistenciales cuando no exista obligación legal expresa.

5. Solicitar rectificación de datos inexactos conforme la Ley 25.326.

6. Solicitar la activación del MODO RESTRINGIDO conforme el inciso f) BIS del presente artículo.

7. Solicitar la desactivación del identificador (opt-out), lo que implicará la suspensión del uso del C.U.R.A.-ID para nuevos tratamientos, sin afectar la validez legal de las prestaciones previamente registradas ni los plazos legales de conservación de historia clínica.

En ningún caso el ejercicio de estos derechos podrá afectar: (1) la conservación legal obligatoria de la historia clínica; (2) la trazabilidad integral del sistema; (3) el acceso a prestaciones sanitarias esenciales ni generar trato discriminatorio.

f) BIS. Modo Restringido del C.U.R.A.-ID.

En ejercicio del derecho de restricción del tratamiento previsto en el artículo 16 de la Ley 25.326, el titular podrá solicitar que su C.U.R.A.-ID sea colocado en MODO RESTRINGIDO.

La activación del MODO RESTRINGIDO producirá los siguientes efectos:

1. El C.U.R.A.-ID se conservará en el registro de infraestructura del sistema con valor pseudonimizado, a efectos de preservar la continuidad asistencial archivística y el cumplimiento de los plazos legales de conservación de historia clínica.

2. No podrá utilizarse para nuevos intercambios activos de información clínica entre efectores, salvo los supuestos de emergencia previstos en el inciso siguiente.

3. El acceso a los datos clínicos históricos vinculados quedará restringido, limitándose a: (i) los datos del Resumen Clínico Federal del Artículo 3° TER necesarios para la continuidad asistencial urgente; y (ii) los datos accesibles mediante el protocolo 'break-glass' del Artículo 17 BIS en situaciones de riesgo vital.

4. El MODO RESTRINGIDO es reversible a solicitud del titular en cualquier momento, con efecto inmediato.

El MODO RESTRINGIDO no produce los efectos de la supresión de datos: los registros clínicos existentes se conservan conforme los plazos legales de historia clínica y son accesibles al titular.

La solicitud de activación del MODO RESTRINGIDO deberá canalizarse a través del portal oficial del Sistema C.U.R.A. o de los centros de atención ciudadana habilitados, mediante procedimiento gratuito, simple y accesible que establecerá la reglamentación. La resolución deberá producirse dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida la solicitud.

El tratamiento de datos del titular en MODO RESTRINGIDO para fines de salud pública, vigilancia epidemiológica o investigación científica sólo procederá en formato correctamente anonimizado conforme los estándares del Artículo 67 BIS.

g) Accesos Indebidos y Sanciones.

El acceso indebido, manipulación no autorizada, suplantación de identidad o alteración de registros de trazabilidad constituirá falta gravísima conforme el artículo 44, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

h) Conservación de la Información.

La información clínica vinculada al C.U.R.A.-ID se conservará conforme los plazos legales vigentes en materia de historia clínica. Vencidos los plazos legales, los datos podrán:

1. Ser anonimizados con técnicas que garanticen razonablemente la imposibilidad de reidentificación, o

2. Ser eliminados cuando la anonimización no resulte técnicamente viable.

i) Interfaz de Usuario y Transparencia.

A los fines prácticos y de accesibilidad, el titular de los datos no requerirá memorizar, dictar ni ingresar manualmente su C.U.R.A.-ID. Toda interacción del paciente con efectores de salud, farmacias o plataformas digitales se realizará exhibiendo su Código QR dinámico o indicando su Documento Nacional de Identidad (DNI), encargándose la plataforma oficial de realizar la vinculación unívoca y encriptada en segundo plano.

j) Tratamiento de datos con posterioridad al fallecimiento del titular.

Con posterioridad al fallecimiento del titular, el C.U.R.A.-ID pasará automáticamente a estado de Modo Restringido conforme lo previsto en el inciso f) BIS del presente artículo.

El acceso a los datos clínicos vinculados podrá ser autorizado, de manera total o parcial, a:

a) herederos con declaratoria de herederos o testamento debidamente acreditados;

b) representantes legales debidamente constituidos;

c) terceros con interés legítimo documentado, conforme lo determine la reglamentación, limitándose en todo caso a la información estrictamente necesaria para la finalidad invocada.

Todo acceso en virtud del presente inciso quedará registrado en el Módulo Nacional de

Trazabilidad y Auditoría con trazabilidad reforzada.

El titular podrá, en vida, establecer restricciones o directivas respecto del acceso a su información sanitaria con posterioridad a su fallecimiento, mediante declaración registrada en el Portal del Sistema C.U.R.A. Dichas directivas serán vinculantes para la Autoridad de Aplicación, salvo que su cumplimiento implicara grave perjuicio para derechos de terceros o interés público sanitario debidamente acreditado.

Los datos del titular fallecido no podrán utilizarse con fines comerciales ni para perfilamiento de terceros, quedando su uso restringido a las finalidades asistenciales, de investigación debidamente autorizada y de interés público sanitario previstas en la presente ley.

k) Naturaleza Criptográfica del C.U.R.A.-ID y Protección de Identidad.

El Identificador Único de Paciente (C.U.R.A.-ID) será implementado mediante un mecanismo de seudonimización criptográfica que garantice:

1. Que el C.U.R.A.-ID sea un token generado mediante función criptográfica unidireccional (hash con sal — 'salt' — aleatoria institucional), de modo que no sea posible derivar la identidad civil del titular a partir del identificador sin acceso exclusivo a la clave de seudonimización.

2. Que el C.U.R.A.-ID no sea idéntico ni derivable directamente del DNI, CUIL, CUIT ni de ningún otro identificador civil preexistente.

3. Que la clave de seudonimización (sal institucional) se encuentre bajo custodia exclusiva del organismo designado como Autoridad de Custodia Criptográfica, con separación técnica y orgánica de los responsables del tratamiento de datos clínicos.

4. Que el proceso de re-identificación —necesario únicamente para la atención médica directa y para el ejercicio de derechos del titular— requiera acceso autenticado al módulo de correspondencia identitaria, con trazabilidad completa de cada consulta.

Queda expresamente prohibido:

1. El acceso al módulo de correspondencia identitaria con finalidad distinta a la atención médica directa, la continuidad asistencial o el ejercicio de derechos del titular.

2. La vinculación del C.U.R.A.-ID con bases de datos externas al Sistema C.U.R.A. que permitan inferir la identidad civil del titular a partir del identificador.

3. La construcción de perfiles individuales de salud con finalidad distinta a la atención médica, la investigación con datos anonimizados o la salud pública agregada.

l) Fundamento de Interés Público y Limitación de Finalidad.

La creación e implementación del C.U.R.A.-ID se fundamenta en razones de interés público sanitario estratégico, continuidad asistencial, seguridad del paciente y eficiencia del sistema de salud.

El C.U.R.A.-ID no podrá ser utilizado con fines comerciales, crediticios, laborales, de perfilamiento social ni para decisiones automatizadas ajenas a la finalidad sanitaria.

El ejercicio del derecho de oposición, restricción o baja no afectará el acceso a prestaciones sanitarias esenciales ni generará trato discriminatorio alguno.

m) Reglamentación.

La Autoridad de Aplicación establecerá los mecanismos técnicos, operativos y de seguridad para la generación, activación, gestión y eventual desactivación del C.U.R.A.-ID, garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales. La reglamentación no podrá reducir los estándares de protección establecidos en el presente artículo ni establecer bases jurídicas de tratamiento distintas a las expresamente enumeradas en el inciso b).

ARTÍCULO 17 BIS.- Consentimiento por episodio asistencial y duración del acceso.

a) Principio General.

El acceso a la información clínica del paciente a través del Sistema C.U.R.A. será otorgado por episodio asistencial, deberá ser limitado, proporcional, temporal y trazable, y se regirá por el tipo de atención brindada, conforme a los mecanismos de autenticación, identificación y trazabilidad establecidos en la presente ley.

El acceso ordinario a la información clínica requerirá consentimiento informado del paciente, salvo cuando el tratamiento de datos resulte necesario para la atención médica directa, la continuidad asistencial o situaciones de urgencia conforme la base jurídica prevista en el Artículo 17 inciso b).

b) Gestión Institucional del Consentimiento.

En caso de ingreso o admisión institucional para internación, la institución de salud, en su carácter de responsable del tratamiento de los datos personales conforme la Ley 25.326, deberá gestionar la obtención del consentimiento del paciente para el acceso a su información clínica por parte del equipo de salud interviniente.

El proceso podrá ser iniciado por personal habilitado que intervenga en funciones de admisión, recepción o atención, sin que ello implique facultades decisorias individuales sobre el alcance o condiciones del acceso.

La responsabilidad final de verificar la identidad del paciente y la validez del consentimiento recae en el profesional de la salud que accede efectivamente a la historia clínica.

c) Alcance del Consentimiento en Internación.

El consentimiento otorgado al momento de la admisión habilitará acceso continuo y vigente a la información clínica pertinente del paciente durante toda la estadía hospitalaria.

El acceso caducará automáticamente:

1) Al momento del alta médica definitiva; o
2) Al egreso físico efectivo del paciente del establecimiento, lo que ocurra último.

Si existiere alta administrativa pero el paciente permaneciera en observación, tránsito o espera de traslado, el acceso se mantendrá activo hasta el egreso físico certificado por profesional responsable.

El acceso quedará limitado a la institución y al equipo de salud autorizado.

d) Atención Ambulatoria, Consultorio Externo y Guardia.

En los casos de atención ambulatoria, consulta externa, prácticas diagnósticas o atención en guardia sin internación:

1) El acceso requerirá consentimiento del paciente.
2) Será temporal y limitado al acto asistencial en curso.
3) Tendrá vigencia limitada al episodio asistencial registrado, sin extenderse automáticamente a atenciones posteriores, salvo que exista continuidad diagnóstica o terapéutica debidamente documentada.

Si existieren estudios complementarios en proceso cuyo resultado deba integrarse a la historia clínica, el plazo podrá extenderse automáticamente hasta VEINTICUATRO (24) horas desde el consentimiento inicial o hasta la carga de los resultados pendientes, lo que ocurra primero.

e) Paciente Inconsciente o Imposibilitado de Consentir – Protocolo de Emergencia ("Break-Glass").
Cuando el paciente se encuentre inconsciente, incapacitado o imposibilitado de otorgar consentimiento, el acceso podrá habilitarse mediante el mecanismo de emergencia exclusivamente cuando resulte necesario para la protección de la vida o la salud del

paciente.
Se considerarán supuestos habilitantes:

1) Inconsciencia o alteración del estado de conciencia que impida comprender la solicitud.
2) Riesgo vital inminente que no admita demora.
3) Emergencia médica certificada.
4) Imposibilidad comunicacional transitoria en contexto de urgencia.

No constituirán supuestos habilitantes:

1) Negativa expresa del paciente consciente y capaz.
2) Mera ausencia del paciente cuando pueda contactárselo razonablemente.
3) Conveniencia o facilidad administrativa.

Todo acceso efectuado bajo esta modalidad deberá quedar debidamente registrado, justificado y sujeto a auditoría posterior conforme el régimen de trazabilidad.

b) Renovación del Consentimiento.
Para atenciones posteriores se requerirá nuevo consentimiento por cada episodio asistencial, salvo que se trate de:

1) Tratamientos crónicos bajo seguimiento regular del mismo profesional, en cuyo caso podrá otorgarse consentimiento válido por hasta SEIS (6) meses renovables.
2) Tratamientos de alta complejidad continua, en cuyo caso podrá extenderse durante todo el ciclo terapéutico definido clínicamente.

c) Revocación y Control por Parte del Paciente.

El paciente consciente podrá revocar o limitar el consentimiento otorgado en cualquier momento, salvo en los supuestos de riesgo vital o internación en curso.
La revocación producirá efectos hacia el futuro y quedará registrada en el sistema.

d) Trazabilidad del Consentimiento.
El Sistema C.U.R.A. registrará automáticamente:

1) Fecha y hora del otorgamiento del consentimiento.
2) Identidad del paciente verificada.

3) Personal que gestionó el consentimiento.
4) Modalidad de otorgamiento.
5) Duración y alcance autorizado.
6) Revocación si la hubiere.

ARTÍCULO 17 TER.- Datos Vitales Críticos, Régimen de Carga, Validación e Incentivo

a) Naturaleza Voluntaria.

La incorporación de Datos Vitales Críticos al perfil del C.U.R.A.-ID será voluntaria para el titular, sin que su omisión implique restricción alguna en el acceso al sistema sanitario ni en el ejercicio de derechos reconocidos por la presente ley.

b) Oferta Obligatoria en Primera Consulta.

En la primera consulta médica posterior a la entrada en vigencia de la presente ley, o en la primera consulta posterior a la creación del C.U.R.A.-ID en el caso de nuevos titulares, el profesional de la salud deberá ofrecer expresamente al paciente la posibilidad de:

1) Cargar datos vitales críticos.
2) Validar información previamente ingresada.
3) Actualizar registros existentes.

La negativa del paciente deberá quedar registrada en el sistema sin generar consecuencia alguna.

c) Definición de Datos Vitales Críticos.

Se entenderá por Datos Vitales Críticos, a título enunciativo:

1) Grupo sanguíneo y factor RH.
2) Alergias severas o reacciones adversas medicamentosas.
3) Medicación crónica activa.
4) Implantes, dispositivos médicos permanentes o terapias implantables (incluidos sistemas de liberación de fármacos).
5) Patologías de riesgo vital inmediato.
6) Hasta DOS (2) contactos de emergencia.

7) Fecha de nacimiento y localidad de residencia.

La reglamentación podrá ampliar o actualizar esta enumeración conforme evidencia científica.

d) Validación Profesional Obligatoria.

Todo dato vital crítico incorporado por el titular deberá ser validado electrónicamente por un profesional de la salud con matrícula vigente, quedando registrado el acto de validación en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría.

Hasta tanto no se produzca dicha validación, el dato no podrá visualizarse en el perfil paramédico o médico de emergencia.

e) Activación del Perfil de Emergencia.

La carga y validación de los Datos Vitales Críticos habilitará automáticamente el perfil de acceso escalonado para emergencias, permitiendo:

1) Visualización pública restringida exclusivamente a contactos de emergencia.
2) Visualización paramédica de datos vitales críticos.
3) Activación de protocolos médicos conforme la presente ley.

f) Advertencia Informativa.

El sistema deberá informar de manera clara al titular que la ausencia de carga de datos vitales críticos puede limitar la disponibilidad de información relevante en situaciones de emergencia médica.

g) Campañas de Concientización.

La Autoridad de Aplicación deberá implementar campañas permanentes de concientización pública sobre la importancia de registrar y validar datos vitales críticos para la seguridad sanitaria en emergencias.

ARTÍCULO 17 QUATER.- Fundamento de Interés Público y Limitación de Finalidad.

La creación e implementación del C.U.R.A.-ID se fundamenta en razones de interés público sanitario estratégico, continuidad asistencial, seguridad del paciente y eficiencia del sistema de salud.

El C.U.R.A.-ID no podrá ser utilizado con fines comerciales, crediticios, laborales, de perfilamiento social ni para decisiones automatizadas ajenas a la finalidad sanitaria.

El ejercicio del derecho de oposición o baja no afectará el acceso a prestaciones sanitarias esenciales ni generará trato discriminatorio alguno.

ARTÍCULO 17 QUINQUIES.- Naturaleza criptográfica del CURA-ID y protección de identidad.

a) Seudonimización obligatoria.
El Identificador Único de Paciente (CURA-ID) creado por el Artículo 17 será implementado mediante un mecanismo de seudonimización criptográfica que garantice:

   1) Que el CURA-ID sea un token generado mediante función criptográfica unidireccional (hash con sal —'salt'— aleatoria institucional), de modo que no sea posible derivar la identidad civil del titular a partir del identificador sin acceso exclusivo a la clave de seudonimización.

   2) Que el CURA-ID no sea idéntico ni derivable directamente del DNI, CUIL, CUIT ni de ningún otro identificador civil preexistente.

   3) Que la clave de seudonimización (sal institucional) se encuentre bajo custodia exclusiva del organismo designado como Autoridad de Custodia Criptográfica conforme el Artículo 12 de la presente ley, con separación técnica y orgánica de los responsables del tratamiento de datos clínicos.

   4) Que el proceso de re-identificación —necesario únicamente para la atención médica directa y para el ejercicio de derechos del titular— requiera acceso autenticado al módulo de correspondencia identitaria, con trazabilidad completa de cada consulta conforme el Artículo 10.

b) Prohibición de re-identificación no autorizada.
Queda expresamente prohibido:

   1) El acceso al módulo de correspondencia identitaria con finalidad distinta a la atención médica directa, la continuidad asistencial o el ejercicio de derechos del titular.

   2) La vinculación del CURA-ID con bases de datos externas al Sistema C.U.R.A. que permitan inferir la identidad civil del titular a partir del identificador.

   3) La construcción de perfiles individuales de salud con finalidad distinta a la atención médica, la investigación con datos anonimizados o la salud pública agregada.

c) Generación y asignación.
El CURA-ID se generará automáticamente por el Sistema C.U.R.A. al producirse la

primera carga de datos clínicos del titular, previa verificación de identidad conforme el Artículo 29. La asignación automática del CURA-ID no requerirá consentimiento autónomo por constituir un mecanismo técnico de seudonimización. El tratamiento posterior de datos clínicos vinculados al identificador se regirá por la base jurídica establecida en el Artículo 17 inciso b) y por el régimen de consentimiento previsto en el Artículo 17 BIS.

ARTÍCULO 18.- Resumen internacional del paciente (IPS) y acceso internacional.

a) Creación y Objeto.
Impleméntese en el Sistema C.U.R.A. el Resumen Internacional del Paciente (IPS), consistente en un extracto digital, normalizado, dinámico y de acceso restringido de los datos clínicos esenciales del titular, destinado a facilitar la continuidad asistencial en contextos de:

1) Atención sanitaria en el extranjero.
2) Emergencias médicas no planificadas fuera del territorio nacional.
3) Traslados interjurisdiccionales o internacionales para tratamientos especializados.

b) Estándar Técnico Obligatorio.
El IPS se generará conforme al estándar internacional HL7 FHIR International Patient Summary (IPS), garantizando interoperabilidad semántica y técnica a nivel global.
La Autoridad de Aplicación publicará y mantendrá la guía de implementación correspondiente.

c) Contenido Mínimo.
El IPS contendrá exclusivamente información clínica esencial, siempre que se encuentre disponible en el sistema y conforme la configuración de privacidad del titular:

1) Datos de identificación básicos (nombre, fecha de nacimiento y C.U.R.A.-ID).
2) Problemas de salud activos y antecedentes relevantes.
3) Medicación habitual o crítica.
4) Alergias e intolerancias.
5) Vacunaciones relevantes.
6) Intervenciones quirúrgicas significativas.
7) Implantes o dispositivos médicos relevantes.
8) Grupo sanguíneo y factor Rh.
9) Contactos de emergencia designados por el titular.

d) Control Granular de Privacidad.
El titular ejercerá control granular sobre la inclusión de categorías de datos en su IPS a través del Panel de Privacidad y Consentimiento previsto en el artículo 27.
Las siguientes categorías se encontrarán deshabilitadas por defecto y requerirán habilitación expresa del titular:

1) Información de salud mental.
2) Diagnósticos o tratamientos vinculados a VIH.
3) Información de salud sexual y reproductiva.
4) Historial de consumo de sustancias psicoactivas y tratamientos asociados.

El titular podrá en cualquier momento habilitar, deshabilitar o modificar dichas preferencias.

e) Generación y Acceso Nacional.
El IPS se generará de forma automática y dinámica a partir de la historia clínica digital, aplicando las preferencias configuradas por el titular.
El titular podrá:

1) Visualizar su IPS.
2) Descargarlo en formato PDF de lectura humana con código QR verificable.
3) Obtenerlo en formato estructurado interoperable (XML o JSON).
4) Deshabilitar completamente la funcionalidad IPS.

Todo acceso o descarga será registrado en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría.

f) Acceso Internacional por Invitación del Paciente.

El titular podrá generar, a través del portal oficial o de la plataforma “Mi Argentina” o la que la reemplace, un código de acceso temporal para compartir su IPS con un profesional extranjero.
El código:

1) Tendrá validez máxima de VEINTICUATRO (24) horas.
2) Será de un solo uso, salvo configuración expresa del titular.
3) Podrá ser revocado en cualquier momento antes de su utilización.

El profesional extranjero no requerirá registro previo en el Sistema C.U.R.A., debiendo:

1) Ingresar el código en el portal específico de “Atención Internacional”.
2) Aceptar términos de confidencialidad y limitación de uso.
3) Acceder exclusivamente en modalidad de visualización remota y temporal.

g) Naturaleza Jurídica del Acceso Remoto.
El acceso visual remoto al IPS no constituirá transferencia internacional de datos personales en los términos del artículo 12 de la Ley 25.326, en tanto:

1) No exista exportación, duplicación ni almacenamiento fuera de la infraestructura nacional.
2) El acceso sea exclusivamente temporal y en línea.

Sin perjuicio de ello, el acceso transfronterizo quedará sujeto a:

1) Limitación temporal estricta.
2) Limitación de finalidad exclusiva para atención médica individual.
3) Prohibición de reproducción, almacenamiento o reutilización de la información.
4) Trazabilidad reforzada.

h) Seguridad y Prevención de Captura.
El sistema incorporará mecanismos técnicos activos de prevención de copia, incluyendo:

1) Deshabilitación de impresión y descarga.
2) Restricciones técnicas sobre captura de pantalla.
3) Marca de agua digital dinámica con identificación de sesión, fecha y ámbito geográfico.
4) Registro de intentos de extracción o comportamiento anómalo.

Tales mecanismos constituirán medidas de disuasión técnica, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder ante uso indebido.

i) Interoperabilidad y Convenios Internacionales.
La Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios de reciprocidad digital sanitaria con otros Estados o bloques regionales.
Dichos convenios deberán:

1) Garantizar niveles de protección de datos equivalentes a los establecidos en la presente ley.
2) Asegurar reciprocidad para ciudadanos argentinos.

3) Contar con aprobación del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

j) Régimen de transferencia internacional del IPS.

La transmisión del Resumen Internacional del Paciente a sistemas de salud extranjeros solo podrá realizarse cuando se verifique al menos una de las siguientes condiciones:

1) El país receptor figure en la lista de países con nivel adecuado de protección de datos de salud, elaborada y actualizada anualmente mediante resolución conjunta del Ministerio de Justicia y la AAIP.

   La lista de países con nivel adecuado de protección de datos deberá ser elaborada dentro de los NOVENTA (90) días corridos desde la reglamentación de la presente ley, tomando como referencia técnica inmediata la lista vigente de países con nivel adecuado publicada por la Agencia de Acceso a la Información Pública y la lista del Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) u organismo equivalente.

   Hasta tanto dicha lista sea formalmente aprobada, se considerarán países con nivel adecuado aquellos reconocidos como tales por la Agencia de Acceso a la Información Pública o por el Comité Europeo de Protección de Datos en sus listados vigentes al momento de la transferencia.

2) Exista consentimiento específico, previo e informado del titular para la transferencia a ese país o sistema receptor.

3) La transferencia sea estrictamente necesaria para salvaguardar la vida o la integridad del titular en situación de urgencia vital documentada, debiendo transmitirse exclusivamente los datos clínicos mínimos necesarios para la atención inmediata, con notificación al titular o su representante en el plazo más breve posible.

En ningún caso la transferencia internacional del IPS podrá incluir datos de salud mental, salud sexual y reproductiva, o diagnósticos de enfermedades estigmatizantes sin consentimiento explícito adicional del titular.

ARTÍCULO 18 BIS.- Sistema Federal de Vigilancia Epidemiológica Asistida por Inteligencia Artificial.

a) Creación y Objeto.

Créase el Sistema Federal de Vigilancia Epidemiológica Asistida por Inteligencia Artificial, integrado al Sistema C.U.R.A., destinado a la detección temprana de brotes, anomalías sanitarias y eventos de interés epidemiológico mediante el análisis automatizado y en tiempo real de datos estructurados y no estructurados provenientes del sistema.

El sistema tendrá como finalidad exclusiva fortalecer la capacidad preventiva del Estado en materia de salud pública, optimizando la detección precoz y la respuesta sanitaria coordinada.

b) Fuentes de Información.

El sistema podrá integrar información proveniente de:

1) Efectores de salud públicos, privados y de la seguridad social.
2) Laboratorios y centros de diagnóstico.
3) Servicios de urgencias y emergencias.
4) Registros epidemiológicos oficiales.
5) Datos agregados de movilidad poblacional cuando resulten relevantes para la vigilancia sanitaria.

b) Protección de Datos y Anonimización.

El análisis automatizado se realizará sobre datos previamente anonimizados o seudonimizados, conforme a los siguientes principios:

1) Eliminación de identificadores directos.
2) Minimización de datos personales.
3) Sustitución de datos individualizantes por rangos o categorías cuando corresponda.
4) Aplicación de técnicas técnicas adecuadas que reduzcan razonablemente el riesgo de reidentificación.

El análisis de datos no estructurados, incluyendo texto libre de evoluciones clínicas o informes, requerirá mecanismos adicionales de anonimización previa antes de su procesamiento automatizado.

En ningún caso el sistema tendrá por finalidad la identificación individual de pacientes, salvo cuando la autoridad epidemiológica competente, mediante acto fundado, requiera la

trazabilidad individual para la gestión de un evento sanitario confirmado conforme a la normativa vigente.

c) Generación de Alertas y Validación Humana.

El sistema podrá generar alertas automatizadas cuando detecte patrones estadísticos anómalos, agrupamientos geográficos o incrementos significativos de eventos sanitarios.

Toda alerta generada automáticamente deberá ser validada por la autoridad epidemiológica competente, nacional o provincial según corresponda, antes de:

1) Activar investigaciones epidemiológicas.
2) Emitir comunicaciones oficiales.
3) Adoptar medidas sanitarias.

No podrán adoptarse medidas restrictivas de derechos individuales o colectivos basadas exclusivamente en decisiones automatizadas sin validación humana expresa.

d) Certificación Ética y Técnica.
Previo a su puesta en funcionamiento en entorno productivo, los modelos algorítmicos utilizados deberán ser evaluados y certificados por el Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial en Salud previsto en la presente ley.

La certificación deberá verificar, como mínimo:

1) Proporcionalidad entre el alcance del análisis y el beneficio sanitario esperado.
2) Suficiencia de las medidas de anonimización implementadas.
3) Ausencia de sesgos discriminatorios manifiestos.
4) Existencia de mecanismos de supervisión humana.
5) Transparencia suficiente sobre los criterios generales de detección utilizados.

La certificación tendrá vigencia anual y podrá ser suspendida o revocada ante incumplimientos técnicos o éticos.

e) Coordinación Federal.
El sistema operará en coordinación con las autoridades epidemiológicas provinciales, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud y los organismos sanitarios competentes, garantizando acceso a tableros agregados y anonimizados para monitoreo federal en tiempo real.

ARTÍCULO 19.- Derechos del Paciente

Sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley 26.529 y demás normativa aplicable, el paciente tendrá derecho a:

a) Acceso a Prescripciones.

b) Acceder desde su perfil digital a todas sus prescripciones electrónicas vigentes y recientes.

c) Visualizar medicamento, dosis, frecuencia, duración del tratamiento, profesional prescriptor e indicación clínica.

d) Consultar el historial de medicación dispensada cuando se encuentre integrado al sistema.

e) Recordatorios Terapéuticos y Sanitarios.

f) Activar y configurar recordatorios terapéuticos vinculados a sus prescripciones.

g) Recibir notificaciones sobre:

    1) Confirmaciones de turno.

    2) Avisos de preparación de estudios.

    3) Vencimiento de recetas o derivaciones.

    4) Controles periódicos o vacunaciones pendientes.

h) Configurar el canal de notificación (SMS, correo electrónico, notificación digital u otros que establezca la reglamentación).

i) Gestión de Turnos. Acceder de forma clara y unificada al historial de turnos solicitados, otorgados, cumplidos y cancelados.

j) Utilizar el Sistema Federal de Gestión de Turnos conforme el artículo 19 BIS, cuando se encuentre disponible en su jurisdicción.

k) Visor de Farmacias. Consultar, mediante el visor integrado del sistema:

    1) Farmacias cercanas a su ubicación.

    2) Farmacias de turno según los listados oficiales de cada jurisdicción.

    3) Información de stock declarada voluntariamente por las farmacias, cuando se encuentre disponible.

l) Control de Geolocalización.
Controlar en todo momento las funciones que utilicen su geolocalización, pudiendo activarlas o desactivarlas libremente, sin que ello afecte el acceso a prestaciones esenciales, conforme los principios de privacidad, minimización y consentimiento establecidos en la presente ley.

m) Control de Privacidad y Datos Sensibles.
Acceder al Panel de Privacidad del Sistema.
Ejercer control granular sobre categorías de datos sensibles conforme el artículo 27.

n) Configurar la inclusión de información en el Resumen Internacional del Paciente (IPS) conforme el artículo 18.

o) Consultar el historial completo de accesos a su historia clínica, incluyendo:

1) Identidad del profesional o institución.

2) Fecha y hora del acceso.

3) Tipo de acción realizada.

p) Denunciar accesos indebidos conforme el régimen previsto en la presente ley.

q) Información sobre Inteligencia Artificial.

1) Ser informado cuando un sistema de inteligencia artificial haya intervenido de manera asistida en una recomendación o proceso clínico que lo afecte.

2) Conocer la identificación del profesional responsable de la validación humana.

3) Solicitar revisión humana de decisiones asistidas por inteligencia artificial, sin costo adicional.

r) Credenciales Sanitarias.

1) Acceder gratuitamente a la credencial digital conforme el artículo 17.

2) Solicitar credencial física opcional o descargar formato imprimible, en los términos allí establecidos.

s) Ejercicio de Derechos
El ejercicio de los derechos previstos en el presente artículo será gratuito.
Podrá realizarse:

1) Preferentemente en línea, a través del Portal del Paciente.

2) Mediante canales alternativos para garantizar accesibilidad universal, incluyendo:

t) Línea telefónica gratuita.
Atención presencial en establecimientos de salud habilitados.

u) Oficinas u organismos públicos que determine la reglamentación.

El sistema deberá garantizar:

1) Interfaces compatibles con tecnologías de asistencia.

2) Lenguaje claro y comprensible.

3) Mecanismos de apoyo para adultos mayores y personas con discapacidad.

4) Canales de Reclamo

En caso de vulneración de los derechos establecidos en el presente artículo, el paciente podrá:

a) Presentar reclamo ante la mesa de ayuda del Sistema C.U.R.A.

b) Presentar denuncia ante la Autoridad de Aplicación conforme el artículo 6.

c) Interponer acción de amparo o hábeas data conforme el artículo 43 de la Constitución Nacional.

d) Formular denuncia ante la Agencia de Acceso a la Información Pública cuando se afecten derechos vinculados a protección de datos personales.

Los reclamos deberán ser registrados y respondidos dentro de los plazos que establezca la reglamentación, garantizando trazabilidad y transparencia del trámite.

ARTÍCULO 19 BIS.- Sistema Federal de Gestión de Turnos

Créase el Sistema Federal de Gestión de Turnos como componente gratuito e integrado del Sistema C.U.R.A., destinado a centralizar la gestión de agendas médicas de los efectores

adherentes.

a) Objeto.
El sistema permitirá a los usuarios:

1) Buscar profesionales y establecimientos por especialidad, cobertura y ubicación.
2) Consultar disponibilidad horaria en tiempo real.
3) Solicitar, confirmar, cancelar y reprogramar turnos.
4) Visualizar de manera unificada todos los turnos futuros y pasados.
5) Recibir recordatorios automáticos.

b) Alcance.

Será obligatorio para los organismos y prestadores comprendidos en el artículo 3 inciso b).

Será obligatorio para las jurisdicciones provinciales y municipales que adhieran al régimen operativo conforme el artículo 4.

La implementación se realizará de manera progresiva, priorizando el sector público.

c) Configuración y Carga de Información.

La Autoridad de Aplicación desarrollará y mantendrá la plataforma, que incluirá:

1) Registro de establecimientos.
2) Gestión de staff profesional.
3) Configuración de agendas.
4) Asignación y seguimiento de turnos.

b) Todo prestador adherente deberá:

1) Cargar y mantener actualizada la información de su staff.
2) Mantener actualizadas sus agendas conforme los estándares del presente artículo.

c) Modalidades de Integración.
Los prestadores podrán optar por:

1) Integración vía API, mediante sincronización automática bidireccional con sus sistemas propios.
2) Utilización directa del portal web oficial del Sistema C.U.R.A.

En ambos casos deberán cumplirse los estándares de interoperabilidad y calidad de datos establecidos por la Autoridad de Aplicación.

d) Verificación de Cobertura y Advertencia al Usuario.
El sistema implementará mecanismos de verificación automática de cobertura de salud mediante interoperabilidad con:

1) Obras sociales nacionales.
2) Empresas de medicina prepaga.
3) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
4) Obras sociales provinciales adherentes.

Las entidades mencionadas deberán proveer mecanismos técnicos de consulta de afiliación vigente y plan de cobertura dentro del plazo que establezca la reglamentación.

Al momento de confirmar un turno bajo cobertura, el sistema deberá exhibir advertencia informativa destacada al paciente conforme la Ley 26.682, sin modificar las obligaciones legales vigentes de los prestadores y financiadores.

e) Notificaciones.

El sistema enviará automáticamente:

1) Confirmación inmediata del turno.
2) Recordatorios previos.
3) Avisos de cancelación o modificación por parte del prestador.

f) Gestión de Cancelaciones.

El paciente podrá cancelar el turno dentro del plazo que establezca la reglamentación.

El sistema liberará automáticamente el horario cancelado.

Podrán implementarse mecanismos de verificación adicional en casos de inasistencias reiteradas injustificadas.

g) Actualización de Agendas.

Los prestadores deberán mantener sus agendas actualizadas:

En tiempo real cuando sea técnicamente posible.

Con una latencia máxima razonable determinada por la reglamentación según complejidad y condiciones de conectividad.

La asignación reiterada de turnos inexistentes o no disponibles por negligencia del prestador constituirá falta grave conforme el artículo 44, sin perjuicio de las exclusiones por caso fortuito debidamente acreditado.

La reglamentación establecerá:

1) Parámetros objetivos para considerar reiteración.
2) Mecanismos de monitoreo automático.
3) Procedimiento de advertencia previa antes de la aplicación de sanciones.

h) Optimización Inteligente.

El funcionamiento del sistema podrá integrarse con herramientas de análisis predictivo de demanda sanitaria conforme el artículo 19 TER, con el objetivo de reducir tiempos de espera y mejorar la distribución de recursos.

ARTÍCULO 19 TER.- Motor Predictivo de Demanda Sanitaria.

Créase el Motor Predictivo de Demanda Sanitaria como módulo de inteligencia artificial integrado al Sistema C.U.R.A., destinado a mejorar la planificación operativa y la gestión de la demanda asistencial.

a) Objeto.

El Motor Predictivo tendrá por finalidad:

1) Estimar la demanda de servicios de salud por especialidad, zona geográfica y franja horaria.
2) Detectar tendencias de saturación en guardias, consultorios, internación o servicios críticos.
3) Generar alertas tempranas ante riesgo de congestión o colapso operativo.
4) Formular recomendaciones de optimización de agendas y distribución de turnos dentro del sistema adherente.

b) Naturaleza de las Recomendaciones.

El sistema generará alertas y sugerencias automáticas basadas en análisis estadísticos y modelos predictivos.

Las recomendaciones podrán incluir:

1) Refuerzo de horarios o ampliación de agendas.
2) Reorganización interna de turnos.
3) Sugerencia de derivación a efectores alternativos dentro del sistema adherente.

En ningún caso el sistema podrá ejecutar redistribuciones automáticas ni modificar agendas sin validación humana.

c) Supervisión Humana Obligatoria.

Toda decisión operativa derivada de las alertas del Motor Predictivo deberá ser:

1) Evaluada por el responsable del establecimiento correspondiente; y

2) Validada, cuando corresponda, por la autoridad sanitaria jurisdiccional competente.

Las recomendaciones del sistema no serán vinculantes ni sustituirán la potestad organizativa de las autoridades sanitarias.

d) Certificación Ética y Técnica Previa.

El algoritmo predictivo deberá ser certificado por el Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial en Salud, previo a su implementación en entorno productivo.

La certificación evaluará como mínimo:

1) Exactitud y validación con datos históricos.
2) Ausencia de sesgos discriminatorios.
3) Transparencia mínima del modelo respecto de las variables utilizadas.
4) Impacto en la equidad de acceso a la atención sanitaria.

La certificación deberá renovarse periódicamente conforme establezca la reglamentación.

e) Principio de Equidad.

La optimización de la demanda no podrá generar:

1) Discriminación indirecta por condición socioeconómica.
2) Postergación sistemática de poblaciones vulnerables.
3) Concentración injustificada de recursos en determinadas zonas en detrimento de otras.

f) Protección de Datos.

El funcionamiento del Motor Predictivo deberá basarse prioritariamente en datos agregados y seudonimizados, respetando los principios de minimización y proporcionalidad establecidos en la presente ley.

ARTÍCULO 19 QUATER.- Prescripciones, seguimiento terapéutico y apoyo farmacológico.

Prescripciones, seguimiento terapéutico y módulo federal de disponibilidad farmacéutica.

a) Integración automática de prescripciones.

El Sistema C.U.R.A. integrará en el perfil del paciente todas las prescripciones electrónicas activas y recientes emitidas por profesionales habilitados, provenientes de la Historia Clínica Electrónica Interoperable.

El paciente podrá visualizar:

1) Prescripciones vigentes.
2) Historial completo de prescripciones anteriores.
3) Registro de dispensación efectiva total o parcial cuando haya sido informada por farmacia habilitada, incluyendo fecha, cantidad dispensada y saldo pendiente en caso de prescripciones con esquema de dispensación fraccionada.
4) Alertas de vencimiento de tratamientos crónicos.

b) Contenido mínimo de la prescripción electrónica.
Cada prescripción deberá exhibir:

1) Medicamento indicado conforme Denominación Común Internacional (DCI).
2) Dosis, frecuencia, vía de administración y duración del tratamiento.
3) Profesional prescriptor, matrícula e institución.
4) Indicación clínica.
5) Fecha de emisión y vencimiento.

El sistema pondrá a disposición campos estructurados opcionales para especificaciones terapéuticas adicionales sin generar carga administrativa innecesaria.

En caso de prescripciones electrónicas extendidas con esquema de dispensación programada conforme el Artículo 19 QUINQUIES, el sistema deberá reflejar el cronograma de dispensaciones autorizadas, los límites temporales de retiro y el saldo disponible, impidiendo la duplicación o retiro anticipado no autorizado.

c) Recordatorios terapéuticos.

El paciente podrá activar recordatorios automáticos basados en la información estructurada de su prescripción, conforme su configuración personal.

d) Visor Federal de Farmacias.

El Sistema integrará un visor geolocalizado que mostrará:

1) Farmacias cercanas.
2) Farmacias de turno conforme información oficial de cada jurisdicción.
3) Horarios declarados de atención.

La información sobre turnos será provista por las autoridades competentes o Colegios Profesionales Farmacéuticos provinciales, actuando el Sistema C.U.R.A. como integrador y visualizador sin sustituir facultades regulatorias locales.

e) Disponibilidad orientativa de medicamentos.

1) Fase Inicial Voluntaria.
Durante los primeros VEINTICUATRO (24) meses desde la entrada en vigencia de la ley, la carga de información sobre disponibilidad orientativa de medicamentos será voluntaria para las farmacias.

La Autoridad de Aplicación deberá:

i) Proveer APIs estandarizadas.
ii) Ofrecer asistencia técnica gratuita.
iii) Habilitar mecanismos simplificados de carga manual.
iv) Establecer incentivos de visibilidad institucional.

2) Fase de Integración Obligatoria Progresiva.
Transcurrido el plazo indicado en el punto anterior, la Autoridad de Aplicación podrá establecer un calendario progresivo de integración obligatoria para categorías

específicas de medicamentos, priorizando:

i) Medicamentos esenciales del Programa Médico Obligatorio.
ii) Medicación de urgencia y alta rotación.
iii) Medicamentos sujetos a trazabilidad nacional.
iv) Tratamientos críticos o de alto impacto sanitario.

La implementación deberá ser:

i) Escalonada por categorías.
ii) Proporcional a la capacidad operativa del establecimiento.
iii) Coordinada con autoridades sanitarias provinciales.
iv) Precedida de notificación con un plazo mínimo de SEIS (6) meses de adecuación.

2) Régimen de cumplimiento.
Una vez declarada obligatoria la carga para determinada categoría de medicamentos:

i) Se otorgará apercibimiento con plazo de TREINTA (30) días para regularización.
ii) Se ofrecerá asistencia técnica personalizada.

Solo ante incumplimiento persistente e injustificado podrá aplicarse el régimen sancionatorio del Artículo 44.

No constituirá incumplimiento sancionable:

i) Imposibilidad técnica debidamente acreditada.
ii) Falta de conectividad estructural en zonas rurales.
iii) Caso fortuito o fuerza mayor.

b) Principio de privacidad.

Las funcionalidades previstas en el presente artículo se regirán por los principios de

minimización, finalidad y consentimiento establecidos en esta ley.

El paciente podrá activar o desactivar funciones basadas en geolocalización o recordatorios sin afectar el acceso a prestaciones esenciales.

ARTÍCULO 19 QUINQUIES.- Videoconsulta obligatoria, agenda integrada y prescripción electrónica extendida para pacientes con condiciones crónicas.

a) Agenda profesional integrada.

El Sistema C.U.R.A. deberá garantizar a los profesionales de la salud el acceso unificado a su agenda, turnos y operaciones asistenciales, tanto en modalidad presencial como virtual, permitiendo la gestión integral de la atención dentro de una única plataforma, conforme a las capacidades desplegadas en la FASE 1 del Artículo 14.

b) Videoconsulta como modalidad complementaria obligatoria.

Los prestadores comprendidos en el presente artículo deberán ofrecer, como mínimo, la modalidad de videoconsulta como complemento de la atención presencial para:

1) Seguimiento de pacientes con condiciones crónicas priorizadas.
2) Controles evolutivos de patologías estabilizadas.
3) Renovación de tratamientos de mantenimiento.

La modalidad virtual no sustituye la consulta presencial, y el paciente conservará en todo momento el derecho a optar por atención presencial.

c) Definición de paciente crónico prioritario.

A los efectos de la presente ley, se considera paciente crónico prioritario a toda persona que:

1) Posea condición crónica registrada en su Historia Clínica Digital.
2) Requiera tratamiento farmacológico continuo.
3) Necesite controles periódicos y seguimiento longitudinal.

La Autoridad de Aplicación, en coordinación con sociedades científicas, podrá establecer listado orientativo de patologías priorizadas.

d) Autonomía profesional.

El profesional tratante conserva plena autonomía clínica para:

1) Determinar si la atención puede realizarse por videoconsulta.

2) Requerir evaluación presencial cuando lo considere clínicamente necesario.

3) Alternar modalidades según evolución del paciente.

4) Suspender seguimiento virtual ante signos de descompensación.

Toda indicación de presencialidad deberá quedar documentada en la Historia Clínica Digital con fundamento clínico sumario.

e) Prescripción electrónica extendida.
Para los pacientes crónicos prioritarios, los prestadores deberán poder emitir prescripciones electrónicas extendidas conforme el siguiente régimen:

1) Prescripción trimestral: hasta NOVENTA (90) días de tratamiento por receta electrónica.

2) Prescripción semestral: hasta CIENTO OCHENTA (180) días de tratamiento mediante la emisión de una (1) prescripción electrónica única estructurada, con esquema de dispensación fraccionada programada, la cual podrá instrumentarse en una única videoconsulta o consulta presencial, sin obligación de nueva consulta durante dicho período, salvo indicación médica fundada o solicitud expresa del paciente.
La prescripción electrónica semestral deberá:

i) Determinar la duración total del tratamiento (hasta 180 días).

ii) Establecer la cantidad total autorizada conforme posología indicada.

iii) Incorporar un esquema obligatorio de dispensación fraccionada por períodos definidos (mensual u otro intervalo clínicamente adecuado).

iv) Impedir retiros anticipados, superposición de dispensaciones o duplicación en diferentes establecimientos farmacéuticos.

v) Registrar cada dispensación efectuada en el Sistema C.U.R.A. para fines de trazabilidad y seguimiento terapéutico.

f) Requisitos para prescripción extendida.
La prescripción por CIENTO OCHENTA (180) días procederá cuando concurran:

1) Patología crónica estabilizada.

2) Medicación de mantenimiento sin ajustes frecuentes.

3) Adherencia terapéutica adecuada.

4) Ausencia de eventos adversos relevantes.

5) Controles clínicos o de laboratorio dentro de parámetros aceptables cuando correspondan.

g) Garantías para el paciente.

Queda expresamente prohibido:

1) Negar atención presencial invocando disponibilidad de videoconsulta.
2) Condicionar la emisión de prescripción extendida exclusivamente a modalidad virtual.
3) Establecer copagos o aranceles diferenciados más gravosos para la consulta presencial cuando ambas modalidades estén cubiertas por el financiador.

h) Ámbito de aplicación obligatoria.
Las disposiciones del presente artículo serán de cumplimiento obligatorio para:

1) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI).
2) Agentes del Seguro de Salud comprendidos en las Leyes N° 23.660 y 23.661.
3) Entidades de Medicina Prepaga reguladas por la Ley N° 26.682.
4) Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en lo pertinente.
5) Los subsistemas provinciales y municipales podrán adherir conforme el régimen federal previsto en la presente ley.

i) Responsabilidad profesional.
El profesional que emita prescripción electrónica extendida asume responsabilidad por:

1) Evaluación adecuada del estado clínico.
2) Verificación de estabilidad terapéutica.
3) Control de interacciones o contraindicaciones.
4) Información al paciente sobre signos de alarma.

La emisión de prescripción por hasta CIENTO OCHENTA (180) días conforme las condiciones del presente artículo no constituirá por sí misma indicio automático de negligencia, mala praxis ni desviación del estándar de cuidado, siempre que el profesional haya cumplido con las obligaciones precedentemente enumeradas y dejado constancia fundada en la Historia Clínica Digital.

La presente disposición establece una presunción de adecuación profesional que admite prueba en contrario cuando se acreditare omisión, imprudencia, impericia o falta de seguimiento razonable conforme las circunstancias del caso concreto.

j) Implementación progresiva.

La obligatoriedad de ofrecer videoconsulta conforme el inciso b) se implementará a partir de la FASE 2 prevista en el Artículo 14.

La Autoridad de Aplicación establecerá los protocolos técnicos y clínicos correspondientes, en coordinación con el Consejo Federal de Salud (COFESA), las sociedades científicas reconocidas y la Superintendencia de Servicios de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias.

k) Principios de desarrollo.

El módulo de videoconsulta y prescripción extendida deberá ajustarse a los principios de:

1) Progresividad tecnológica.
2) Seguridad por diseño.
3) Interoperabilidad.
4) Validación técnica previa.

l) Motor Automático de Validación Clínica Preventiva.

1) Implementación.
   El Sistema C.U.R.A. implementará un Motor Automático de Validación Clínica Preventiva aplicable a toda prescripción electrónica emitida conforme el presente artículo.
2) Finalidad.
   El motor tendrá carácter exclusivamente preventivo y asistencial, con el objeto de:
   i) Detectar posibles errores de dosis, frecuencia o duración del tratamiento.
   ii) Identificar interacciones medicamentosas potencialmente relevantes.
   iii) Alertar sobre duplicaciones terapéuticas activas.
   iv) Verificar contraindicaciones basadas en alergias registradas o antecedentes clínicos relevantes.
   v) Advertir inconsistencias entre diagnóstico consignado y tratamiento prescripto cuando resulten estadísticamente significativas.
3) Naturaleza no sustitutiva.
   El motor no sustituye el juicio clínico del profesional tratante ni impide la emisión de la prescripción cuando el profesional, bajo su responsabilidad, confirme expresamente su decisión.

Las alertas generadas tendrán carácter informativo y deberán ser visualizadas antes de la firma digital de la receta, pudiendo el profesional:

i) Modificar la prescripción conforme la sugerencia.

ii) Confirmar la prescripción original dejando constancia digital de su validación clínica.

4) Registro de validación.
Toda alerta generada y su resolución quedarán registradas en el Sistema C.U.R.A. con sello de tiempo, sin constituir por sí mismas antecedente sancionatorio ni presunción de mala praxis.

5) Protección del profesional.
La emisión de una prescripción luego de visualizar y validar una alerta no constituirá, por sí misma, indicio de negligencia, imprudencia ni desviación del estándar de cuidado, siempre que se encuentre debidamente fundamentada en la historia clínica digital.

6) Auditoría técnica.
El Motor Automático de Validación Clínica Preventiva será auditado periódicamente por el Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial conforme el Artículo 66, a fin de verificar:

i) Exactitud técnica.

ii) Ausencia de sesgos indebidos.

iii) Actualización conforme evidencia científica vigente.

iv) Tasa razonable de falsos positivos.

En ningún caso el motor podrá configurarse para bloquear automáticamente la prescripción sin intervención humana.

ARTÍCULO 19 SEXIES.- Optimización de Asignación de turnos en Salud Mental y Psiquiatría.

Establécese un modelo de gestión de la demanda para los servicios de salud mental y psiquiatría orientado a la optimización de los recursos físicos y tecnológicos, garantizando en todo momento el respeto por la autonomía del paciente, la accesibilidad efectiva y el criterio profesional.

a) Garantía de disponibilidad presencial.

Los efectores de salud deberán garantizar disponibilidad suficiente de turnos presenciales en consultorio físico para:

1) Personas que carezcan de conectividad o dispositivos tecnológicos aptos.
2) Personas mayores de SESENTA Y CINCO (65) años o que manifiesten dificultades significativas en el uso de tecnologías digitales.
3) Pacientes cuya condición clínica, conforme criterio profesional debidamente fundado, requiera evaluación presencial.

Los efectores deberán garantizar disponibilidad razonable y suficiente de turnos presenciales, de modo tal que ningún paciente que solicite atención presencial quede privado de ella por razones organizativas o de priorización tecnológica.

La priorización prevista en el presente inciso tendrá carácter de garantía de acceso y no podrá interpretarse como limitación del derecho de elección de otros pacientes.

b) Disponibilidad de teleconsulta.

Para la población que cuente con acceso tecnológico adecuado y competencias digitales suficientes, el Sistema C.U.R.A. ofrecerá la opción de atención mediante teleconsulta para:

1) Primeras entrevistas diagnósticas en psicología y psiquiatría.
2) Psicoterapia de seguimiento.
3) Consultas psiquiátricas no urgentes.

La utilización de la modalidad de teleconsulta para primera entrevista o inicio de tratamiento quedará sujeta al criterio clínico del profesional interviniente, quien podrá requerir atención presencial cuando lo considere necesario y dejar constancia fundada en la Historia Clínica Digital.

Podrán asignarse turnos con profesionales habilitados de cualquier jurisdicción que cuenten con disponibilidad inmediata, conforme el régimen federal previsto en la presente ley.

c) Derecho de elección.
El paciente conserva en todo momento el derecho a elegir entre modalidad presencial o

teleconsulta, cuando ambas se encuentren disponibles y resulten clínicamente apropiadas. El profesional interviniente podrá indicar la necesidad de atención presencial cuando lo considere clínicamente necesario, debiendo dejar constancia fundada en la Historia Clínica Digital.

d) Prohibición de imposición.
En ningún caso podrá:

1) Imponerse la modalidad de teleconsulta a pacientes que prefieran atención presencial.

2) Imponerse atención presencial obligatoria cuando el paciente prefiera teleconsulta y no exista contraindicación clínica fundada.

3) Establecerse una modalidad incompatible con la preferencia del paciente, su condición clínica, su contexto personal o el criterio profesional debidamente fundamentado.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente inciso constituirá falta grave conforme el Artículo 44.

ARTÍCULO 19 SEPTIES.- Prestación interjurisdiccional mediante teleconsulta a través del Sistema C.U.R.A. Facilitación tecnológica y articulación federal.

El Sistema C.U.R.A. habilitará mecanismos de teleconsulta que permitan la interacción remota entre profesionales de la salud y pacientes ubicados en distintas jurisdicciones del territorio nacional, con el objeto de mejorar el acceso, la equidad territorial y la continuidad del cuidado sanitario. El presente régimen constituye un servicio de intermediación tecnológica dentro de una red federal interoperable, asentado en la competencia federal en materia de telecomunicaciones conforme el artículo 75 inciso 13 de la Constitución Nacional, y no implica en ningún caso la habilitación automática para el ejercicio profesional en jurisdicción distinta a aquella en la que el profesional se encuentra matriculado.

ARTÍCULO 19 OCTIES.- Criterio de Holgura Prestacional.

La atención presencial para pacientes aptos digitalmente quedará supeditada a la existencia de capacidad ociosa comprobada en el efector local, garantizando en todo momento que dicha asignación no afecte el acceso de los grupos prioritarios definidos en el Artículo 19 SEXIES.

ARTÍCULO 20.- Trazabilidad digital de medicamentos

La obligación de adherir troqueles físicos en recetas o comprobantes de dispensación quedará reemplazada por el Registro Digital de Dispensación Trazable del Sistema C.U.R.A. y vinculado en tiempo real con el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos administrado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Dicho registro tendrá el mismo valor legal, probatorio y auditor que el sistema basado en troqueles, en cumplimiento de lo establecido por las Disposiciones ANMAT N.º 3683/2011, 6301/2015 y 10564/2016, o las normas que en el futuro las sustituyan, modifiquen o actualicen, sin necesidad de modificación legislativa expresa.

Implementación por Hitos y Plazos: La obligatoriedad del Registro Digital se implementará en cada jurisdicción de conformidad con la secuencia de hitos, plazos y certificaciones establecida en la Disposición Transitoria Undécima, la cual regula de manera integral la implementación de la Trazabilidad Digital de Medicamentos. Los hitos técnicos detallados de sustitución del troquel físico se establecerán conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria correspondiente.

Período de Transición: En cada jurisdicción, se establece un período de convivencia de DOCE (12) meses a partir de la certificación mencionada. Durante este plazo, serán válidos tanto el troquel físico como el Registro Digital. Cumplido este período, el Registro Digital será el único mecanismo válido con fuerza liberatoria.

Contenido Mínimo del Registro: El Registro Digital de Dispensación Trazable deberá contener, como mínimo:

a) Código unívoco del medicamento (GTIN), número de serie, lote y fecha de vencimiento.
b) Identificador C.U.R.A.-ID del paciente titular.
c) Identificación de la farmacia o entidad dispensadora.
d) Identificación digital del profesional farmacéutico interviniente (firma digital y matrícula).
e) Fecha, hora y localización geográfica de la dispensación.
f) Código de la receta electrónica asociada.
g) La localización geográfica será obligatoria únicamente en modalidades de dispensación no presenciales (entrega a domicilio, envío postal u otras modalidades digitales). En la dispensación presencial en farmacia habilitada con domicilio declarado, bastará la

identificación del establecimiento, sin requerirse geolocalización adicional.

La verificación fehaciente de la identidad del paciente al momento de la dispensación se realizará mediante los mecanismos establecidos en el Artículo 29, cumpliendo con ello el requisito de individualización del titular.

Validez Probatoria y Liberatoria: La carga de esta información en el Sistema C.U.R.A. tendrá efecto liberatorio respecto de la obligación de pegar troqueles físicos y constituirá prueba suficiente y preferente de la entrega del medicamento al paciente. Las obras sociales, entidades de medicina prepaga, aseguradoras de riesgos del trabajo y demás financiadores no podrán exigir la presentación de troqueles físicos, comprobantes en soporte papel ni documentación adicional cuando la dispensación se encuentre debidamente registrada, validada y certificada en el Registro Digital de Dispensación Trazable conforme la presente ley.

Reglamentación: La Autoridad de Aplicación, en acuerdo con la ANMAT y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), será la encargada de reglamentar los protocolos de interoperabilidad, seguridad, autenticación y auditoría para la implementación del presente artículo.

La verificación y auditoría del Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT) serán realizadas de manera conjunta por:

a) La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

b) La Autoridad de Aplicación de la presente ley.

c) Las obras sociales, entidades de medicina prepaga y aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), en el ámbito de sus respectivas competencias.

En caso de divergencia de criterio entre los organismos intervinientes:

En aspectos técnico-sanitarios vinculados a la legalidad de la dispensación, trazabilidad de lote, número de serie o condiciones farmacológicas, prevalecerá el criterio técnico de la ANMAT.

En aspectos vinculados exclusivamente a cobertura prestacional o condiciones contractuales de financiamiento, prevalecerá el criterio del organismo competente en materia de seguridad social o financiamiento sanitario.

Cuando la cuestión involucre simultáneamente aspectos sanitarios y prestacionales, se constituirá una mesa técnica conjunta que deberá expedirse en un plazo máximo de QUINCE (15) días.

Integración con el Módulo Nacional de Trazabilidad: El RDDT constituirá una base de datos federada, integrada al Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría previsto en el Artículo 10. Toda transacción generará un registro con firma digital y sello de tiempo, garantizando su inalterabilidad, autenticidad, integridad y valor probatorio.

Mecanismo de Verificación Automática (MVAD): La ANMAT, en coordinación con la Autoridad de Aplicación, implementará un Mecanismo de Verificación Automática de Dispensas (MVAD) que, de forma inmediata a la carga en el sistema, realizará las siguientes validaciones:

La correspondencia entre el medicamento dispensado y la receta electrónica asociada.

La validez del número de serie y lote contra el Sistema Nacional de Trazabilidad de ANMAT.

El registro automático del consumo en el stock de la farmacia dispensadora.

La habilitación de consultas auditoras por parte de obras sociales y prepagas, preservando la confidencialidad de los datos personales del paciente mediante seudonimización o técnicas equivalentes.

Validez Legal de la Auditoría Digital: Toda auditoría basada en el RDDT y el MVAD podrá realizarse en forma remota y digital, sin requerir documentación física adicional, y tendrá el mismo valor legal que la verificación presencial.

Plazos de Conservación y Notificación de Incidencias: Los registros de auditoría del MVAD deberán conservarse por un plazo mínimo de DIEZ (10) años. Cualquier inconsistencia, omisión o duplicación detectada será notificada de forma inmediata y automática al establecimiento involucrado, a la ANMAT y al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., pudiendo derivar en las sanciones previstas en el Título VIII.

Aspectos técnicos: Los estándares de interoperabilidad, códigos de identificación (GTIN/Serie), protocolos de seguridad y el listado de normas derogadas se regirán por lo establecido en el ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMATIVAS Y DE RIESGO de la presente ley.

La implementación del presente artículo se realizará conforme al principio de máxima eficiencia presupuestaria establecido en el Artículo 35, utilizando la infraestructura

tecnológica del Sistema C.U.R.A.

ARTÍCULO 21.- Registro federal de ensayos clínicos y farmacovigilancia.

Créase el Registro Federal de Ensayos Clínicos y Farmacovigilancia, integrado al Sistema C.U.R.A. e interoperable con los sistemas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), conforme la normativa vigente o las normas que en el futuro la sustituyan o actualicen, sin necesidad de modificación legislativa expresa, con el objeto de centralizar y hacer pública la información sobre investigación y seguridad de medicamentos en el territorio nacional.

Contenido Mínimo Obligatorio:

El Registro deberá contener, de manera obligatoria y actualizada:

Ensayos Clínicos:

Todos los ensayos clínicos autorizados por la ANMAT, incluyendo protocolo, centros participantes, criterios de inclusión y estado de reclutamiento.

Uso Compasivo y Acceso Expandido:

Los tratamientos autorizados bajo estas figuras, asociados al paciente (C.U.R.A.-ID) y al profesional tratante.

Farmacovigilancia:

Los reportes de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) y de Eventos Adversos a Medicamentos (EA), generados automáticamente desde la historia clínica digital o reportados por profesionales.

Validación Profesional Obligatoria:

Las alertas automáticas generadas por el Sistema C.U.R.A. en materia de ESAVI o Eventos Adversos a Medicamentos deberán ser validadas por el profesional actuante antes de su notificación formal al Sistema Nacional de Farmacovigilancia de la ANMAT.

El profesional deberá evaluar la relación temporal entre la administración del medicamento o vacuna y el evento reportado, la plausibilidad clínica, la gravedad del evento y su necesidad de notificación conforme la normativa sanitaria vigente.

Calidad y Ética Internacional:

La participación de pacientes en ensayos clínicos y el manejo de sus datos para tales fines se

regirá bajo el estricto cumplimiento de los estándares internacionales de Buenas Prácticas Clínicas de la Conferencia Internacional sobre Armonización (ICH-GCP).

Principios de Funcionamiento:

Transparencia:

La información agregada y anonimizada del registro será de acceso público para ciudadanos, investigadores y profesionales.

La Autoridad de Aplicación publicará informes estadísticos semestrales con datos agregados y anonimizados sobre ensayos clínicos en curso, resultados disponibles y tendencias de farmacovigilancia.

Interoperabilidad:

Se integrará con el Sistema Nacional de Farmacovigilancia de la ANMAT y con estándares internacionales (ej: WHO ICDRA, E2B).

Consentimiento Informado:

La participación de un paciente en un ensayo clínico deberá quedar registrada en su historia clínica digital mediante un consentimiento informado digital específico y revocable.

Protección de Datos:

Los datos de pacientes participantes en ensayos clínicos y de pacientes que experimenten eventos adversos serán considerados datos sensibles de máxima protección conforme la Ley 25.326 y la presente ley.

Su acceso estará restringido a autoridades sanitarias competentes e investigadores autorizados.

Toda publicación o difusión pública deberá realizarse exclusivamente en forma agregada y anonimizada de manera irreversible.

Finalidad:

Para la Salud Pública:

Mejorar la seguridad de los pacientes y la vigilancia de la eficacia de los tratamientos.

Para la Investigación:

Evitar la duplicación de esfuerzos, promover el reclutamiento de pacientes y posicionar a la Argentina como un hub regional para investigación clínica.

Para el Paciente:

Dar acceso transparente a opciones de tratamiento innovadoras y a la evidencia de seguridad de sus medicamentos.

ARTÍCULO 21 BIS.- Accesibilidad Digital Asistida por Inteligencia Artificial.

El Sistema C.U.R.A. deberá proveer mecanismos de accesibilidad basados en IA, incluyendo asistentes virtuales 24/7, lectura de pantalla, conversión voz-texto, simplificación automática de lenguaje, interfaces adaptativas y herramientas destinadas a personas con discapacidades visuales, auditivas, cognitivas o de alfabetización digital limitada. La accesibilidad será considerada un componente esencial del servicio de salud digital.

ARTÍCULO 22.- Funcionalidad de operación con conectividad intermitente.

Objetivo. El Sistema C.U.R.A. deberá proveer un mecanismo que permita a los profesionales la consulta y registro de atenciones en situaciones de falta temporal de conectividad, garantizando la integridad de los datos ingresados y su posterior sincronización segura y

auditada con el sistema central.

Principio "Offline-First" y Persistencia de Datos.

El sistema implementará un modelo de diseño "Offline-First" en su interfaz web, donde los datos ingresados por el profesional se persistirán de forma automática y

continua en el almacenamiento local del dispositivo durante su ingreso, impidiendo su pérdida ante interrupciones de conectividad.

Este guardado automático funcionará como un respaldo integral, protegiendo el trabajo en curso ante cualquier interrupción, incluyendo el cierre inesperado de la pestaña del navegador, la caída del sistema o el cierre automático de sesión por inactividad.

La interfaz deberá proporcionar retroalimentación clara al usuario sobre el estado de la conexión y el éxito del guardado local.

Sincronización y Eliminación Segura.

Al restablecerse la conectividad, el sistema procederá de forma automática a la sincronización segura de todos los registros pendientes con el servidor central.

Una vez obtenida la confirmación fehaciente del servidor central del procesamiento exitoso de los datos, el sistema deberá proceder a la eliminación automática e irreversible de dichos datos del almacenamiento local del dispositivo.

Verificación de Identidad en Entornos Sin Conectividad.

Para Pacientes en Base Local: La verificación de identidad se realizará mediante el cotejo visual de la persona con la fotografía oficial previamente descargada en la base local.

Para Pacientes No Identificados en Base Local: La verificación de identidad se

realizará de forma obligatoria mediante la carga manual del número de DNI y del número de trámite del Documento Nacional de Identidad físico, y la captura de

una fotografía de dicho documento. Todos los registros creados bajo este protocolo quedarán automáticamente marcados con el estatus "Validación Identity Pendiente".

Validación Posterior: Al restablecerse la conectividad, el sistema central validará de forma prioritaria y automática los registros marcados como "pendientes"

contra el RENAPER. La repetida validación fallida de identidades será considerada una falta grave sujeta a las sanciones del Artículo 44.

Mecanismos de Seguridad.

Toda la información almacenada localmente estará cifrada.

El sistema implementará protocolos para el borrado remoto seguro de la base local en casos de pérdida o robo del dispositivo.

Todas las acciones realizadas sin conectividad, así como los procesos de sincronización y validación, quedarán registradas en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría.

ARTÍCULO 23.- Sistema de Asistencia Clínica Inteligente. Funcionamiento, ética, responsabilidad y ciclo de vida.

Los sistemas de asistencia clínica inteligente integrados al Sistema C.U.R.A. tendrán carácter de apoyo a la decisión profesional, debiendo garantizar en todo momento la supervisión humana efectiva y el respeto irrestricto de los derechos del paciente. Su implementación se realizará de manera progresiva, bajo estrictos controles técnicos, éticos y jurídicos, conforme el presente artículo.

a) Condición de activación progresiva.

La activación del Sistema de Asistencia Clínica Inteligente se realizará en forma escalonada y coordinada con el cronograma de fases del Artículo 14 y la clasificación de riesgo del Título X:

1. Fase Piloto: Podrá activarse en módulos clínicos específicos y establecimientos certificados cuando se verifique un nivel de completitud y calidad de datos igual o superior al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) promedio trimestral, conforme métricas definidas por el Consejo Nacional.

2. Implementación General: La expansión nacional requerirá un nivel de calidad igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90%) promedio trimestral.

3. Verificación Independiente: Los indicadores de calidad deberán ser certificados por auditor externo independiente designado mediante procedimiento público, sin que la verificación pueda recaer exclusivamente sobre la Unidad Ejecutora del Sistema C.U.R.A.

La activación de módulos de asistencia clínica inteligente no podrá producirse con anterioridad a la fase del Artículo 14 correspondiente al nivel de riesgo del módulo conforme la clasificación del Título X. La reglamentación podrá autorizar implementaciones progresivas mediante entornos piloto controlados y certificados, previo dictamen favorable del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial en Salud.

b) Objeto.

El Sistema tendrá por objeto apoyar a los profesionales de la salud en el proceso diagnóstico y terapéutico mediante el análisis en tiempo real de datos clínicos estructurados y no estructurados, la sugerencia de diagnósticos diferenciales, alertas de seguridad y recomendaciones basadas en evidencia científica validada.

c) Características técnicas y entrenamiento.

El sistema deberá:

1. Analizar en tiempo real los síntomas, signos y resultados de estudios ingresados por el profesional.
2. Sugerir diagnósticos diferenciales ordenados por probabilidad, indicando el nivel de confianza y la evidencia científica que sustenta cada sugerencia.
3. Entrenarse prioritariamente con datos anonimizados del Repositorio de Investigación del Artículo 67 BIS, garantizando su adaptación a la epidemiología argentina. Cuando razones técnicas debidamente fundadas requieran el uso complementario de otras fuentes de datos, estas deberán satisfacer los mismos estándares de protección, anonimización y soberanía establecidos en la presente ley, con dictamen previo del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial en Salud.
4. Funcionar prioritariamente en infraestructura soberana nacional. Cuando circunstancias técnicas debidamente acreditadas por la Unidad Ejecutora del Sistema C.U.R.A. hagan inviable dicho funcionamiento en una etapa o módulo determinado, podrá recurrirse a infraestructura complementaria, siempre que se garantice el almacenamiento y procesamiento de datos en territorio de la República Argentina o

bajo soberanía jurídica argentina, conforme lo dispuesto en el Artículo 71, y previa aprobación del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

5. Actualizarse periódicamente conforme la evolución de la literatura médica y la evidencia científica validada.
6. Emitir alertas de seguridad clínica ante interacciones medicamentosas graves, contraindicaciones críticas o valores clínicamente peligrosos, requiriendo confirmación expresa del profesional en alertas de alto riesgo.
7. Clasificar sus intervenciones en niveles de información pasiva, sugerencia activa y alerta crítica, conforme estándares definidos por la reglamentación y el Título X.

d) Principios éticos irrenunciables.

1. Carácter asistencial no decisorio: Las sugerencias tendrán carácter exclusivamente informativo y en ningún caso vinculante.
2. Validación profesional obligatoria: Todo diagnóstico deberá ser confirmado explícitamente por el profesional matriculado actuante.
3. Transparencia algorítmica: El profesional podrá consultar la lógica, variables relevantes y evidencia científica detrás de cada sugerencia, conforme estándares técnicos definidos por la reglamentación.
4. Registro de auditoría: Quedará registrado cada uso del sistema, las sugerencias mostradas y la decisión final del profesional, con sello de tiempo.
5. Prohibición de automatización sustitutiva: Ningún módulo podrá sustituir el juicio clínico profesional ni generar decisiones automáticas sin intervención humana significativa.
6. Prohibición de coerción algorítmica: Ningún profesional podrá ser evaluado, sancionado, incentivado o condicionado laboralmente por aceptar o rechazar recomendaciones del sistema, siempre que su decisión esté debidamente fundamentada en criterio clínico.
7. Responsabilidad del acto médico e indelegabilidad: El sistema constituye exclusivamente una herramienta tecnológica de soporte. La responsabilidad civil, penal y disciplinaria derivada del acto médico recae de manera primaria e indelegable sobre el profesional de la salud matriculado actuante, sin perjuicio de las responsabilidades concurrentes que pudieren corresponder al Estado, al prestador o al proveedor tecnológico conforme el inciso f) del presente artículo. En ningún caso la sugerencia, omisión o alerta del sistema eximirá al profesional de su deber de cuidado, de la revisión crítica de la información y de la estricta aplicación de su lex artis y sano juicio clínico.

e) Estándar de actuación profesional y presunción de diligencia.

Se considerará cumplido el deber de diligencia del profesional cuando:

1. Utilice sistemas debidamente autorizados e inscritos en el RENIA-Salud conforme la presente ley.

2. Evalúe razonablemente la recomendación recibida en el contexto clínico específico del paciente.
3. Registre su decisión —con o sin apartamiento de la sugerencia algorítmica— en la Historia Clínica Digital.

Se presume que el profesional ha actuado conforme al estándar de cuidado cuando el sistema opere dentro de los parámetros para los cuales fue certificado. Dicha presunción admite prueba en contrario únicamente cuando se acreditare omisión, imprudencia o impericia manifiesta en el análisis de la recomendación algorítmica, o uso indebido o no autorizado del sistema. La emisión de una prescripción luego de visualizar y validar una alerta no constituirá, por sí misma, indicio de negligencia, imprudencia ni desviación del estándar de cuidado, siempre que se encuentre debidamente fundamentada en la Historia Clínica Digital.

f) Régimen de responsabilidad diferenciada.

1. Responsabilidad del Estado Nacional.

El Estado Nacional responde objetivamente, conforme el Artículo 3° de la Ley 26.944 y normativa complementaria, por los daños causados al paciente cuando el módulo de IA clínica fue:

i. habilitado sin cumplir los requisitos del Artículo 67 (RENIA-Salud); o
ii. autorizado contra dictamen técnico desfavorable del Subcomité del Artículo 66.

La responsabilidad del Estado es concurrente con la del profesional cuando el error sea imputable tanto al diseño del sistema como a la supervisión individual. El Estado no responde cuando el profesional actuó prescindiendo por completo del sistema o cuando su actuación fue manifiestamente contraria al protocolo establecido.

2. Responsabilidad del prestador.

El prestador de salud responde solidariamente cuando implemente un módulo sin verificar su inscripción vigente en el RENIA-Salud o en violación de las condiciones de su certificación.

3. Responsabilidad del proveedor tecnológico.

El desarrollador o proveedor del sistema responde conforme los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación cuando el daño sea causalmente imputable a un defecto intrínseco del modelo, falla técnica, incumplimiento de estándares de calidad o seguridad, o divergencias respecto de las condiciones bajo las cuales fue certificado, con independencia de la certificación obtenida.

4. Responsabilidad del profesional.

El profesional será responsable en caso de:

i. apartamiento manifiestamente injustificado de las buenas prácticas clínicas;
ii. uso indebido o no autorizado del sistema;
iii. omisión de evaluación razonable ante situaciones de evidente error del sistema detectables por un profesional diligente.

La responsabilidad del profesional se evaluará conforme el estándar de diligencia del inciso e) del presente artículo y es compatible con la responsabilidad concurrente del Estado, del

prestador y del proveedor tecnológico según los incisos f.1), f.2) y f.3), sin que la atribución a uno de los sujetos excluya automáticamente la de los restantes conforme el régimen general del Código Civil y Comercial de la Nación.

g) Seguro obligatorio y cobertura de riesgos.

Los proveedores de módulos Nivel II y Nivel III conforme la clasificación del Artículo 65 BIS deberán contratar y mantener vigente seguro de responsabilidad civil por daños derivados del funcionamiento de sus sistemas, con cobertura mínima determinada por la Autoridad de Aplicación. Esta obligación constituye condición de mantenimiento de la inscripción en el RENIA-Salud.

En tanto no exista oferta suficiente en el mercado asegurador para la cobertura de dichos riesgos, el Estado Nacional garantizará un esquema transitorio de cobertura a través de fondos específicos u otros instrumentos adecuados, sin que ello releve al proveedor de su responsabilidad objetiva conforme el inciso f.3) del presente artículo. La implementación de estos mecanismos no podrá generar costos directos para los profesionales de la salud ni constituir una barrera de acceso al sistema.

h) Valor probatorio de los registros del sistema.

Los registros del sistema —incluyendo recomendaciones emitidas, alertas generadas, decisiones adoptadas por el profesional y validaciones realizadas— constituirán prueba relevante para la determinación de responsabilidades, con pleno valor probatorio conforme la Ley N.° 25.506 de Firma Digital. La ausencia de registro de validación profesional de una alerta de alto riesgo generará presunción simple de incumplimiento del deber de revisión.

i) Clasificación de riesgo y supervisión reforzada.

El Sistema de Asistencia Clínica Inteligente será clasificado conforme el régimen del Título X. En función de dicha clasificación podrán exigirse:

1. Validaciones clínicas adicionales.
2. Implementación progresiva en entornos piloto certificados.
3. Evaluación de impacto algorítmico previa a la puesta en producción.
4. Monitoreo reforzado post-implementación.
5. Auditorías periódicas obligatorias con métricas de precisión, sensibilidad, especificidad y tasa de aceptación profesional.
6. Monitoreo continuo de desempeño, seguridad clínica y potenciales sesgos algorítmicos durante todo el ciclo de vida operativo.

j) Revisión periódica y retiro (Sunset Clause).

Todo módulo de asistencia clínica inteligente deberá someterse a revisión técnica, ética y de desempeño con una periodicidad no mayor a VEINTICUATRO (24) meses.

Cuando se verifiquen riesgos para la seguridad del paciente, pérdida de utilidad clínica, obsolescencia técnica, sesgos no corregibles, degradación significativa del desempeño o

incumplimiento de los estándares establecidos, la Autoridad de Aplicación, previo dictamen del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial, podrá disponer:

1. La suspensión temporal del módulo.
2. Su recalibración obligatoria.
3. Su retiro definitivo del entorno productivo.

La revisión deberá evaluar precisión, sensibilidad, especificidad, tasa de aceptación profesional y potenciales sesgos poblacionales. Las decisiones deberán ser fundadas, auditables y registradas en el RENIA-Salud. En casos de urgencia, la suspensión preventiva inmediata procederá mediante resolución técnica fundada del Subcomité, con notificación fehaciente al desarrollador con antelación mínima de VEINTICUATRO (24) horas, salvo riesgo de daño grave e irreversible. La medida deberá ser revisada por el Consejo Nacional en el plazo máximo de QUINCE (15) días.

k) Principio de sustentabilidad técnica y soberanía tecnológica.

La implementación del Sistema de Asistencia Clínica Inteligente se ejecutará mediante:

1. Infraestructura existente: Utilización de capacidad ociosa de ARSAT S.E. y centros de datos nacionales.
2. Datos anonimizados: Entrenamiento prioritario con el Repositorio de Investigación del Artículo 67 BIS, conforme lo establecido en el inciso c) del presente artículo.
3. Recursos humanos: Desarrollo por equipos de universidades nacionales y sistema científico-tecnológico estatal.
4. Modelos abiertos: Adaptación de algoritmos de código abierto y estándares internacionales.
5. Validación colaborativa: Pruebas y validación en hospitales públicos existentes de distintos niveles de complejidad y regiones del país.

l) Responsabilidad por fallos sistémicos.

Cuando se acredite la existencia de un error sistemático del algoritmo que haya sido determinante en la producción de un daño y que no hubiera podido ser razonablemente detectado por el profesional actuante, la responsabilidad del Estado Nacional se regirá por la Ley 26.944 y normativa complementaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan contra el proveedor tecnológico conforme el inciso f.3) del presente artículo y la responsabilidad individual que pudiere corresponder.

ARTÍCULO 23 BIS.- Módulos avanzados de asistencia operativa y gestión de capacidad.

En el marco de la arquitectura modular, escalable y extensible del Sistema C.U.R.A., el Sistema de asistencia clínica inteligente establecido en el artículo 23 permitirá la incorporación progresiva de módulos avanzados de asistencia operativa, sin requerir modificación de la presente ley, conforme lo establezca la reglamentación y el Marco de

Intercambio Federal.

Entre los módulos avanzados que podrán incorporarse, sin carácter limitativo, se incluyen:

Sistemas de gestión y visualización de la capacidad hospitalaria, incluyendo la disponibilidad de camas por establecimiento, servicio y nivel de complejidad.

Tableros visuales interactivos de lectura inmediata, con representación gráfica del estado operativo (disponible, ocupado, reservado, fuera de servicio), destinados a apoyar la toma de decisiones clínicas y organizativas.

Herramientas de optimización de derivaciones, admisiones y flujos asistenciales, integradas a la historia clínica digital y a los sistemas institucionales existentes.

Los módulos previstos en el presente artículo se implementarán de manera progresiva y optativa, mediante proyectos piloto y esquemas de adhesión voluntaria por parte de los establecimientos de salud, conforme los criterios técnicos, de interoperabilidad y de seguridad definidos por la Autoridad de Aplicación.

La estandarización funcional y visual de los módulos avanzados deberá garantizar:

Interfaces claras, intuitivas y accesibles para los equipos de salud.

Interoperabilidad con los sistemas de información hospitalarios y jurisdiccionales.

Adaptabilidad a las particularidades organizativas y operativas de cada establecimiento, sin perjuicio del cumplimiento de los estándares mínimos definidos a nivel federal.

ARTÍCULO 23 TER.- Responsabilidad complementaria del Estado, el prestador y el proveedor tecnológico en el Sistema de Asistencia Clínica Inteligente.

a) Responsabilidad del Estado Nacional.

El Estado Nacional responde objetivamente, conforme el Artículo 3° de la Ley 26.944, por los daños causados al paciente cuando el módulo de IA clínica fue:

1) Habilitado sin cumplir los requisitos del Art. 67 (RENIA-Salud); o

2) Autorizado contra dictamen técnico desfavorable del Subcomité del Art. 66.
La responsabilidad del Estado es concurrente con la del profesional cuando el error sea imputable tanto al diseño del sistema como a la supervisión individual. El Estado no responde cuando el profesional actuó prescindiendo por completo del sistema.

b) Responsabilidad del prestador.

El prestador de salud responde solidariamente cuando implemente un módulo sin verificar su inscripción vigente en el RENIA-Salud (Art. 67) o en violación de las condiciones de su certificación.

c) Responsabilidad del proveedor tecnológico.

El proveedor del modelo responde conforme los arts. 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación cuando el daño sea causalmente imputable a un defecto intrínseco del modelo, con independencia de su certificación.

d) Seguro obligatorio.

Los proveedores de módulos Nivel II y Nivel III (Art. 65 BIS) deberán contratar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil por daños derivados del funcionamiento de sus sistemas, con cobertura mínima determinada por la Autoridad de Aplicación. Esta obligación es condición de mantenimiento de la inscripción en el RENIA-Salud

ARTÍCULO 24.- Sistema nacional de indicadores predictivos.

Créase el Sistema Nacional de Indicadores Predictivos, que utilizará exclusivamente datos anonimizados, agregados e irreversibles del Sistema C.U.R.A., provenientes del Repositorio de Datos para Investigación y Salud Pública previsto en el Artículo 67 BIS, para generar modelos predictivos y alertas tempranas destinados a optimizar la gestión de los recursos sanitarios a nivel nacional, provincial y local.

Carácter complementario.

El Sistema Nacional de Indicadores Predictivos tiene carácter prospectivo, estratégico y de planificación sanitaria, diferenciándose del Sistema Federal de Vigilancia Epidemiológica Asistida por Inteligencia Artificial previsto en el Artículo 18 BIS, el cual opera con fines de detección temprana de eventos sanitarios en tiempo real.

El presente sistema no sustituye ni interfiere con los mecanismos de vigilancia epidemiológica activa, sino que los complementa mediante análisis predictivos basados en datos agregados y anonimizados destinados a la planificación macro-sanitaria.

Finalidad: El sistema tendrá por objeto:

Predecir Demanda: Anticipar picos de demanda en guardias, hospitalizaciones y consultas por patologías estacionales.

Optimizar Recursos: Estimar necesidades de stock de medicamentos e insumos críticos.

Vigilancia Proactiva: Detectar precozmente potenciales brotes epidemiológicos o cambios en los patrones de morbilidad.

Principios de Funcionamiento:

Privacidad por Diseño: Los modelos se entrenarán y ejecutarán exclusivamente con datos anonimizados e irreversibles, mediante técnicas de anonimización robusta tales como privacidad diferencial, k-anonimato u otras metodologías equivalentes que garanticen razonablemente la imposibilidad de reidentificación individual, conforme estándares técnicos que establezca la reglamentación.

Transparencia Algorítmica: Los modelos predictivos utilizados serán auditados por el Comité de Ética e IA (Art. 8) para evitar sesgos y garantizar la equidad.

La auditoría deberá evaluar la exactitud de las predicciones, la ausencia de sesgos discriminatorios y la relevancia sanitaria de las variables utilizadas, pudiendo recomendar recalibración o suspensión del modelo cuando se detecten desvíos significativos.

Resultados Públicos: Los informes y alertas generados serán de acceso público para garantizar la transparencia y permitir la planificación conjunta. La publicación se realizará en formato agregado y anonimizado, incluyendo indicadores metodológicos básicos que permitan evaluar la confiabilidad del sistema sin comprometer la seguridad informática.

Validación Periódica: El desempeño de los modelos predictivos será evaluado trimestralmente mediante la comparación entre demanda proyectada y demanda real observada, así como entre alertas epidemiológicas generadas y eventos efectivamente ocurridos.

Cuando se detecte un error sistemático grave que comprometa la utilidad sanitaria del modelo, la Autoridad de Aplicación, previo dictamen del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial, podrá disponer su recalibración obligatoria o suspensión temporal.

Destinatarios y Uso: La información generada será puesta a disposición de:

La Autoridad de Aplicación y las autoridades sanitarias jurisdiccionales.

Los hospitales y redes de salud públicas.

El Sistema Federal de Emergencias (SIFEM).

La información generada tendrá carácter orientativo y estratégico, no pudiendo ser utilizada como fundamento exclusivo para la adopción de medidas restrictivas de derechos sin validación epidemiológica humana.

ARTÍCULO 24 BIS.- Módulo Nacional de Detección de Duplicaciones, Sobreactuación e Inconsistencias Prestacionales

Créase el Módulo Nacional de Detección de Duplicaciones, Sobreactuación e Inconsistencias Prestacionales del Sistema C.U.R.A., aplicable a todos los prestadores, financiadores y subsistemas comprendidos en la presente ley.

a) Finalidad.

El módulo tendrá carácter preventivo, analítico y de apoyo a la auditoría humana, con el objeto de:

1) Detectar duplicación de estudios, prácticas o prestaciones realizadas en períodos clínicamente incompatibles.
2) Identificar sobreactuación en dispensación de medicamentos o prestaciones facturadas.
3) Analizar patrones anómalos de utilización estadísticamente atípicos.
4) Detectar inconsistencias temporales o geográficas en registros asistenciales.
5) Contribuir a la prevención de fraude y uso indebido de recursos sanitarios.

b) Naturaleza no sancionatoria automática.
El módulo no podrá:

1) Rechazar automáticamente prestaciones.
2) Denegar coberturas.
3) Aplicar sanciones.
4) Bloquear pagos de manera automática.

Toda alerta generada deberá ser evaluada por auditor humano competente antes de adoptarse cualquier medida administrativa, contractual o sancionatoria.

c) Procedimiento ante alerta.

Cuando una alerta derive en cuestionamiento de prestación:

1) El prestador o financiador involucrado será notificado fehacientemente.
2) Se otorgará un plazo mínimo de QUINCE (15) días hábiles para presentar justificación clínica o administrativa.

La evaluación deberá ser realizada por auditor profesional humano debidamente identificado.

De persistir el cuestionamiento, se sustanciará el procedimiento correspondiente conforme el Artículo 44 y la normativa aplicable.

d) Protección contra automatización decisoria.

Queda expresamente prohibida la adopción de decisiones exclusivamente automatizadas que produzcan efectos jurídicos adversos para prestadores, profesionales o pacientes sin intervención humana significativa.

e) Auditoría técnica del algoritmo.

El módulo será auditado anualmente por el Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial conforme el Artículo 66, debiendo verificarse:

1) Exactitud técnica.
2) Tasa razonable de falsos positivos.
3) Ausencia de sesgos discriminatorios territoriales, económicos o profesionales.
4) Transparencia mínima sobre variables utilizadas para generación de alertas.

Si la tasa de falsos positivos supera parámetros razonables definidos en la reglamentación, el módulo deberá recalibrarse o suspenderse preventivamente.

f) Protección de datos.

El análisis automatizado se realizará mediante técnicas de seudonimización, minimización y segmentación de datos, garantizando el cumplimiento de la Ley 25.326 y del Artículo 25 de la presente ley.

g) Alcance federal.

El módulo será aplicable a:

1) INSSJP–PAMI.
2) Agentes del Seguro de Salud (Leyes 23.660 y 23.661).
3) Entidades de Medicina Prepaga (Ley 26.682).
4) Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en lo pertinente.

5) Prestadores públicos y privados adheridos al Sistema C.U.R.A.

TÍTULO V - PROTECCIÓN DE DATOS, PRIVACIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

ARTÍCULO 25.- Protección y trazabilidad de datos personales.

a) Los datos contenidos en el Sistema C.U.R.A. se consideran datos sensibles conforme la Ley 25.326 y sus modificatorias.

b) La Autoridad de Aplicación y los Prestadores son responsables de la guarda y custodia de esta información, debiendo aplicar los mecanismos de seguridad y acceso restringido exigidos por la Ley N° 27.706 y su reglamentación.

c) El acceso, almacenamiento y tratamiento se realizarán bajo estrictos protocolos de seguridad, garantizando los principios de licitud, consentimiento informado, finalidad, acceso, rectificación y supresión.

d) Toda consulta o acceso quedará registrada con identificación del profesional o entidad interviniente, fecha, hora y motivo, y podrá ser auditada por el titular de los datos, la Autoridad de Aplicación y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

e) El usuario podrá revocar su consentimiento y solicitar la baja del sistema en cualquier momento mediante:

1) El Portal oficial del Sistema C.U.R.A.;
2) La línea telefónica gratuita prevista en el Artículo 6° inciso a);
3) Presentación presencial ante autoridad sanitaria jurisdiccional o en puntos de atención designados por la Autoridad de Aplicación.

La Autoridad de Aplicación y las jurisdicciones adherentes deberán garantizar mecanismos accesibles, simples y gratuitos para el ejercicio efectivo de este derecho, conforme los principios de accesibilidad universal y no discriminación, asegurando al menos un canal presencial por jurisdicción a través de autoridad sanitaria competente o puntos de atención oficialmente designados para la recepción y gestión de la solicitud.

Una vez formalizada la solicitud de baja, los datos personales sensibles serán bloqueados para uso asistencial y seudonimizados, conservándose únicamente durante los plazos exigidos por la normativa sanitaria y legal vigente. Cumplidos dichos plazos, se procederá a la anonimización conforme estándares técnicos de privacidad diferencial y reducción de riesgo de re-identificación establecidos en la reglamentación.

En aquellos casos excepcionales en los que, conforme dictamen técnico fundado del Comité de Ética y Protección de Datos, la anonimización no garantice razonablemente la imposibilidad de re-identificación, se procederá a la eliminación completa y definitiva de los datos personales sensibles, dejando constancia fehaciente del proceso.

f) Régimen de responsabilidad.

A los efectos de la Ley 25.326:

Cada Prestador será Responsable del Tratamiento respecto de los datos personales que genere o incorpore al Sistema C.U.R.A., en cuanto a su legalidad, finalidad, exactitud y licitud de obtención del consentimiento cuando corresponda.

El Ministerio de Salud de la Nación actuará como Corresponsable del Tratamiento respecto de la plataforma nacional, su infraestructura tecnológica, almacenamiento, seguridad, integridad, disponibilidad, control de accesos y gestión de incidentes de seguridad.

Las provincias adherentes actuarán como corresponsables respecto de los datos generados en sus jurisdicciones conforme los convenios de adhesión y corresponsabilidad que se celebren.

g) Transferencias de datos.

Las transferencias de datos personales dentro del territorio nacional entre prestadores, financiadores y autoridades sanitarias, cuando se realicen para fines asistenciales, continuidad de atención, fiscalización sanitaria, control prestacional o cumplimiento de obligaciones legales, no requerirán consentimiento adicional al previsto en el artículo 17 BIS, siempre que se mantenga la finalidad sanitaria legítima.

Las transferencias internacionales o accesos transfronterizos se regirán por lo dispuesto en el artículo 18 y por la Ley 25.326, requiriendo nivel adecuado de protección o instrumento jurídico habilitante conforme la normativa vigente.

Notificación de incidentes de seguridad.

En caso de violación de seguridad que comprometa datos personales de salud:

La Autoridad de Aplicación deberá notificar a la Agencia de Acceso a la Información Pública

dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de detectado el incidente.

Cuando la brecha suponga un riesgo alto para los derechos del titular, éste deberá ser notificado dentro de las NOVENTA Y SEIS (96) horas, indicando:

1) La naturaleza del incidente.
2) Los datos potencialmente afectados.
3) Las medidas de contención adoptadas.
4) Las recomendaciones pertinentes para mitigar riesgos.

h) Registro Público de Responsables y Encargados.

Créase el Registro Público de Responsables y Corresponsables del Sistema C.U.R.A., administrado por la Autoridad de Aplicación, que identificará a cada Prestador, su rol, domicilio, base legal de tratamiento y datos de contacto del Delegado de Protección de Datos. El Registro será de acceso público y en línea.

Las tareas y desarrollos previstos en el presente artículo se ejecutarán conforme los Artículos 12° y 17°, sin generar nuevas erogaciones presupuestarias.

ARTÍCULO 26.- Corresponsabilidad, acuerdos de intercambio y auditoría federal.

Acuerdos Marco. La Autoridad de Aplicación, junto al Consejo Federal de Salud (COFESA) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), establecerán los acuerdos marco de intercambio de información sanitaria entre jurisdicciones y sectores público-privados.

Dichos acuerdos deberán respetar en todo momento los principios de especialidad, finalidad, minimización y blindaje sanitario establecidos en la presente ley, y no podrán habilitar accesos nominales a organismos excluidos por el Artículo 26 BIS.

Acuerdo de Corresponsabilidad. Cada provincia, obra social o prestador privado que se adhiera al Sistema C.U.R.A. deberá suscribir un acuerdo de corresponsabilidad, garantizando de manera obligatoria:

Cumplimiento de Estándares: La adhesión estricta a los protocolos de seguridad, privacidad e interoperabilidad definidos por la Autoridad de Aplicación.

Reserva de Titularidad: El mantenimiento de la titularidad de los datos originados dentro de

su jurisdicción o institución, conforme a lo establecido en el Artículo 4°, sin que ello implique limitación a la interoperabilidad federal prevista en la presente ley.

Limitación de Finalidad: El acceso a los datos estará limitado exclusivamente a finalidades asistenciales, sanitarias o epidemiológicas, quedando expresamente prohibidas las transferencias masivas de datos o su uso comercial.

Auditoría Cruzada: La sujeción a mecanismos de auditoría cruzada con el Módulo Nacional de Trazabilidad establecido en el Artículo 10.

Régimen de Corresponsabilidad. Las jurisdicciones adherentes asumirán corresponsabilidad respecto del tratamiento de los datos generados en su ámbito territorial, conforme el régimen establecido en el Artículo 25, sin perjuicio de la responsabilidad primaria del prestador que origine la información.

Fiscalización y Revocación. Toda adhesión implicará la aceptación de los estándares técnicos obligatorios y la fiscalización periódica por parte de la Autoridad de Aplicación y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La Autoridad de Aplicación podrá revocar la interoperabilidad y suspender los beneficios del sistema en caso de incumplimiento grave de las condiciones establecidas, previa intimación formal y otorgamiento de plazo razonable para subsanar el incumplimiento.

En caso de controversias entre jurisdicciones respecto de interpretación o alcance de los acuerdos de corresponsabilidad, el Consejo Federal de Salud (COFESA) actuará como instancia de coordinación y armonización federal, sin afectar las competencias constitucionales provinciales.

ARTÍCULO 26 BIS.- Principio de Especialidad, Inmunidad Administrativa y Blindaje Sanitario.

En cumplimiento de la justificación ética de los sistemas de información nominales y para garantizar que el Sistema C.U.R.A. sea una herramienta de inclusión universal, establécese:

Prohibición de Uso Extra-Sanitario:

Queda expresamente prohibida la transferencia, cesión o el acceso a los datos nominales y sensibles del Sistema C.U.R.A. por parte de autoridades de control migratorio, fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia o entes recaudadores de impuestos. Los acuerdos marco referidos en el Artículo 26 no podrán, bajo ninguna circunstancia, incluir a dichos organismos como receptores de información nominal.

Inmunidad Administrativa del Beneficiario:

El registro de un paciente en el Sistema C.U.R.A. y la información clínica derivada no podrán ser utilizados como prueba de infracción a leyes migratorias o de cualquier otra índole administrativa ajena a la salud. El sistema garantiza la atención y documentación sanitaria sin que esto suponga un riesgo de exposición para personas en situación de irregularidad administrativa o vulnerabilidad social.

Limitación a la Excepción Judicial:

Solo se admitirá el acceso a datos nominales por autoridades extra-sanitarias mediante orden judicial específica en el marco de investigaciones por delitos de extrema gravedad expresamente enumerados en el presente inciso.

A los fines de esta ley, se considerarán delitos de extrema gravedad exclusivamente los siguientes:

1) Homicidio doloso en cualquiera de sus modalidades previstas en los artículos 79 a 84 del Código Penal.
2) Secuestro extorsivo previsto en el artículo 170 del Código Penal.
3) Trata de personas conforme Ley 26.842.
4) Delitos contra la integridad sexual de menores de edad previstos en los artículos 119, 120, 124, 125 y concordantes del Código Penal cuando la víctima fuere menor de DIECIOCHO (18) años.
5) Delitos previstos en los artículos 200 a 208 del Código Penal cuando exista riesgo concreto para la salud pública.
6) Delitos previstos en los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 23.737 cuando se trate de organización criminal o tráfico a gran escala debidamente calificado en la resolución judicial.

Queda excluida toda interpretación extensiva, analógica o por equiparación de escalas penales. La enumeración precedente tiene carácter taxativo.

La orden judicial deberá ser específica, expresa y debidamente fundada, y deberá especificar con precisión:

a) Los datos concretos cuya revelación se autoriza.
b) La estricta necesidad y proporcionalidad del acceso en relación con la investigación.

c) Las garantías de confidencialidad y resguardo de la información.

d) El plazo máximo de conservación y utilización de los datos autorizados.

e) La acreditación de que la prueba no puede obtenerse por medios menos intrusivos.

El juez interviniente deberá disponer la notificación al titular de los datos una vez concluida la medida, salvo que dicha notificación pudiera frustrar de manera concreta y fundada la investigación, circunstancia que deberá ser expresamente motivada en la resolución.

La postergación de la notificación no podrá exceder de SEIS (6) meses, renovables mediante resolución fundada.

Prohibición de Vigilancia Masiva:

Queda prohibido el uso de los repositorios de C.U.R.A. para realizar tareas de inteligencia preventiva, búsqueda masiva de personas (data mining) o cualquier otra acción de vigilancia estatal no sanitaria.

La prohibición precedente no obsta a investigaciones judiciales específicas respecto de personas determinadas en causas penales concretas, siempre que se cumplan estrictamente los requisitos establecidos en el presente artículo.

Registro y Auditoría:

La Autoridad de Aplicación llevará un registro reservado y auditado de todas las órdenes judiciales que habiliten el acceso excepcional a datos en los términos del presente artículo, consignando como mínimo la autoridad requirente, el tipo de delito investigado conforme el inciso c), el alcance del acceso autorizado y su duración.

Dicho registro será auditado semestralmente por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y por la Defensoría del Pueblo de la Nación, quienes deberán publicar un informe estadístico anual que preserve la confidencialidad de las investigaciones en curso, indicando cantidad de solicitudes, categorías de delitos invocados y resultado de las auditorías.

Consecuencias por Violación:

El acceso o utilización de datos del Sistema C.U.R.A. en violación de las disposiciones del presente artículo constituirá falta grave y podrá dar lugar a:

Responsabilidad administrativa del funcionario interviniente.

Responsabilidad civil del Estado conforme Ley 26.944.

Las acciones penales que pudieren corresponder conforme el Código Penal.

ARTÍCULO 27.- Consentimiento informado, segmentación y panel de control de privacidad.

El paciente podrá gestionar sus consentimientos de forma granular a través del Panel de Privacidad y Consentimiento del Sistema C.U.R.A., estableciendo qué profesionales o instituciones pueden acceder a sus datos, por cuánto tiempo y con qué finalidad.

El Sistema C.U.R.A. permitirá autorizar accesos temporales o permanentes mediante el ingreso de matrícula profesional o identificación institucional, con fecha de expiración y motivo clínico, registrándose todo en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría.

a) Panel de Control de Privacidad y Consentimiento Granular.

El Sistema proveerá al titular un Panel de Control de Privacidad donde podrá:

1. Establecer la visibilidad por defecto para cada categoría de dato sensible.
2. Otorgar o revocar permisos de acceso temporales o permanentes a profesionales o instituciones específicas.
3. Visualizar el historial completo de accesos, autorizaciones y revocaciones.
4. Gestionar permisos vinculados a categorías específicas de datos sensibles.
5. Ejercer los derechos previstos en la Ley 25.326 conforme lo dispuesto en el Artículo 25 de la presente ley.

b) Configuración por Defecto.

1. La configuración inicial del Panel de Control mantendrá ocultas todas las categorías de datos sensibles, requiriendo acción explícita del titular para su habilitación.
2. Se considerarán categorías de datos sensibles, a título enunciativo:
3. Salud mental y tratamientos psicológicos o psiquiátricos.
4. Diagnósticos o tratamientos vinculados a VIH.
5. Información de salud sexual y reproductiva.
6. Historial de consumo de sustancias psicoactivas y tratamientos de adicciones.

c) Segmentación Criptográfica y Protocolo de Custodia y Recuperación de Claves.

El Sistema garantizará la segmentación criptográfica de las categorías sensibles mediante cifrado con claves independientes por categoría, de modo que:

1. Cada categoría posea clave criptográfica diferenciada.
2. Ni administradores del sistema ni profesionales con acceso general puedan visualizar datos segmentados sin consentimiento específico del titular.

3. Solo puedan accederse mediante consentimiento válido o activación del mecanismo de emergencia previsto en el Artículo 28 (Break-Glass).
4. Todo acceso quede sujeto a trazabilidad reforzada.

A fin de garantizar el derecho de acceso del titular a sus propios datos reconocido en el artículo 14 de la Ley 25.326 y prevenir la pérdida irreversible de información clínica por causas técnicas, el Sistema C.U.R.A. implementará un Protocolo de Custodia Distribuida y Recuperación de Claves Criptográficas que deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:

1. Custodia distribuida obligatoria. Cada clave criptográfica de categoría sensible será custodiada mediante un esquema de umbral criptográfico con un mínimo de TRES (3) custodios independientes: la Autoridad de Aplicación del Sistema C.U.R.A., la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y el propio titular del dato a través de un mecanismo seguro de recuperación personal. Ningún custodio individual podrá reconstruir la clave sin la participación de al menos DOS (2) de los restantes.
2. Mecanismo de recuperación por el titular. El Sistema deberá proveer al titular, al momento de la configuración de cada categoría segmentada, un mecanismo seguro y documentado de recuperación de su fracción de clave, que podrá consistir en frase de recuperación cifrada, código de recuperación personal o dispositivo criptográfico equivalente, conforme los estándares técnicos que establezca la Autoridad de Aplicación. La provisión de este mecanismo es condición técnica previa a la activación de la segmentación.
3. Procedimiento de recuperación ante pérdida. Ante la pérdida de acceso del titular a sus datos segmentados por causas técnicas no imputables a su conducta, el Sistema C.U.R.A. deberá garantizar un procedimiento de recuperación asistida que preserve en todo momento la confidencialidad de los datos, con intervención obligatoria de al menos DOS (2) custodios y notificación a la AAIP. Dicho procedimiento no podrá implicar acceso al contenido de los datos por parte de los custodios intervinientes.
4. Actualización y rotación de claves. Todo proceso de actualización, migración o rotación de claves criptográficas deberá garantizar la continuidad del acceso del titular a sus datos segmentados sin solución de continuidad. Queda prohibida toda actualización técnica que implique riesgo de pérdida o inaccesibilidad definitiva de datos segmentados.
5. Auditabilidad del protocolo. El protocolo de custodia y recuperación será auditado anualmente por la AAIP, debiendo publicarse el resultado de dicha auditoría en el portal oficial del Sistema C.U.R.A. dentro de los QUINCE (15) días hábiles de su conclusión.

La Autoridad de Aplicación reglamentará las especificaciones técnicas del protocolo dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley, debiendo obtener conformidad previa de la AAIP respecto de los aspectos vinculados a la protección de datos personales.

En caso de que el titular no configure mecanismo personal de recuperación, el sistema

aplicará un esquema supletorio de custodia segura que garantice el ejercicio del derecho de segmentación.

d) Información al Titular sobre Segmentación.

1. Al momento de ocultar una categoría sensible, el Sistema deberá mostrar al titular un mensaje informativo claro, comprensible y redactado en lenguaje no alarmista, con el siguiente contenido mínimo: i. La información de esta categoría no será visible para los profesionales de la salud que lo atiendan a través del Sistema C.U.R.A., salvo que usted lo autorice expresamente o se active el mecanismo de emergencia previsto en la ley. ii. Si lo considera conveniente para su atención, puede informar verbalmente a su profesional tratante sobre esta información en cualquier momento, sin necesidad de habilitarla en el sistema. iii. Usted podrá habilitar el acceso a esta categoría en cualquier momento, de forma total o parcial, temporal o permanente, desde este mismo panel. iv. Esta configuración no afecta su derecho a recibir atención médica. Ningún prestador puede negarle atención por mantener esta categoría segmentada.
2. El mensaje informativo no podrá contener referencias directas a riesgos de diagnóstico incorrecto, prescripción contraindicada ni consecuencias clínicas adversas derivadas de la segmentación. Dichas consideraciones clínicas son de incumbencia del profesional tratante en el marco de la relación asistencial y no constituyen información que deba ser transmitida por el sistema en el momento de ejercer un derecho de privacidad.
3. El titular deberá confirmar que ha leído la información antes de aplicar la segmentación. Dicha confirmación no implica renuncia a ningún derecho ni puede ser interpretada como asunción de responsabilidad clínica por la configuración elegida.

e) Inclusión en el Resumen Internacional del Paciente (IPS).

1. La incorporación de categorías sensibles en el Resumen Internacional del Paciente (Artículo 18) estará deshabilitada por defecto.
2. El Panel de Control deberá permitir la habilitación granular y explícita de cada categoría para su inclusión en el IPS.

f) Eximición de carga obligatoria para estudios anónimos.

1. Los test rápidos anónimos de VIH, sífilis u otras infecciones transmisibles realizados fuera del ámbito hospitalario en campañas comunitarias o programas públicos quedarán eximidos de la carga obligatoria al Sistema.
2. El titular podrá solicitar voluntariamente la incorporación del resultado a su historia clínica, siempre que: i. Se verifique identidad fehaciente. ii. Exista consentimiento expreso. iii. La carga sea efectuada exclusivamente por profesional matriculado. iv. El Sistema no permitirá auto-carga directa por parte de usuarios para evitar adulteraciones o documentación fraudulenta.

g) Validación y Trazabilidad.

1. Cada acceso, modificación o carga de datos clínicos deberá quedar firmado digitalmente, consignando: i. Identidad profesional. ii. Matrícula. iii. Institución. iv. Fecha y hora. v. Acción realizada.
2. El paciente podrá visualizar en su Panel el historial completo de accesos y autorizaciones.
3. Los cambios en configuración de privacidad tendrán efecto inmediato para nuevos accesos, sin afectar accesos válidamente iniciados bajo consentimiento vigente por episodio asistencial conforme el Artículo 17 BIS.

h) Transparencia y Control.

1. El Sistema deberá notificar al paciente por medios electrónicos cada vez que un profesional acceda a su historia clínica o a información sensible bajo consentimiento.
2. La Autoridad de Aplicación publicará informes semestrales de auditoría sobre: i. Cantidad de accesos. ii. Revocaciones de consentimiento. iii. Incidentes o vulneraciones detectadas. iv. Uso del mecanismo de emergencia.

i) Principio de No Discriminación.

Ningún prestador público o privado podrá negar atención, limitar servicios o establecer diferencias de trato por la negativa del paciente a compartir datos sensibles.

El profesional interviniente podrá informar al paciente, en el marco de la relación asistencial y con criterio clínico, cuando considere que la disponibilidad de determinada información podría ser relevante para la atención que está brindando, invitando al paciente a habilitarla si lo estima conveniente para ese episodio.

La decisión final corresponderá exclusivamente al paciente debidamente informado.

ARTÍCULO 27 BIS.- Evaluación de Impacto y Gestión de Incidentes.

Previo a la puesta en funcionamiento de cada módulo crítico que implique tratamiento masivo de datos personales o incorporación de sistemas de inteligencia artificial, deberá realizarse una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD).

Toda brecha de seguridad que comprometa datos personales deberá ser notificada a la autoridad competente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas desde su detección, conforme reglamentación.

ARTÍCULO 27 TER.- Base jurídica expresa del tratamiento de datos de salud en el Sistema C.U.R.A. y consentimiento dinámico.

a) Base jurídica del tratamiento.
El tratamiento de datos personales de salud en el Sistema C.U.R.A. se funda en las

siguientes bases jurídicas, en los términos del Artículo 7° de la Ley 25.326 y del bloque de derechos sanitarios de la Constitución Nacional (arts. 42 y 75, inc. 22):

BASE A — Ejecución de la relación asistencial (art. 7°, inc. 3°, Ley 25.326):
El tratamiento de datos de salud por prestadores habilitados con motivo de la atención médica efectiva constituye tratamiento necesario para el ejercicio de la práctica médica, conforme el artículo 7°, tercer párrafo, de la Ley 25.326.
Este tratamiento es lícito sin consentimiento autónomo adicional, dado que el paciente que concurre a un efector de salud presta consentimiento implícito a la atención médica y al registro de los actos que la componen.

BASE B — Interés público en salud pública y continuidad asistencial (art. 7°, inc. 4°, Ley 25.326):
La integración al Sistema C.U.R.A. de los datos clínicos generados en el marco de la relación asistencial, a los efectos de garantizar la interoperabilidad federal y la continuidad asistencial interjurisdiccional, constituye tratamiento con finalidad de interés público sanitario, fundado en la presente ley como norma que expresamente lo habilita conforme el artículo 7°, cuarto párrafo, Ley 25.326.

b) Información previa obligatoria.
Con independencia de la base jurídica aplicable, el prestador deberá informar al paciente, en el momento del primer contacto asistencial, de forma clara y accesible:

1) Que sus datos clínicos serán incorporados al Sistema C.U.R.A.
2) La finalidad del tratamiento y los derechos que le asisten (art. 32 de la ley).
3) Cómo ejercer la segmentación de acceso a través del Panel de Privacidad.
4) El plazo de conservación de sus datos conforme el Artículo 27 TER.

Esta información deberá constar en el registro de la primera consulta y ser accesible desde el Portal del Sistema C.U.R.A. en todo momento.

c) Consentimiento específico para usos secundarios.
Los tratamientos de datos de salud con finalidad distinta a la atención médica directa —incluyendo investigación científica, estadística sanitaria, modelos predictivos agregados y cualquier uso secundario— requerirán consentimiento específico, previo, libre, informado y revocable del titular, otorgado de forma autónoma e independiente del consentimiento asistencial.
El Panel de Privacidad del Artículo 27 deberá distinguir con claridad los consentimientos de uso primario (asistencial) de los de uso secundario.

d) Modelo de granularidad y ejercicio efectivo.

El Sistema C.U.R.A. garantizará que el Panel de Privacidad del Artículo 27 permita al titular:

1) Visualizar en todo momento qué bases jurídicas amparan el tratamiento de cada categoría de sus datos.

2) Ejercer la oposición al tratamiento fundado en el interés público (Base B) cuando existan razones legítimas derivadas de su situación particular, sin que ello afecte el acceso a la atención médica.

3) Otorgar, modificar y revocar consentimientos de uso secundario (Base C) en cualquier momento, con efecto desde la revocación, sin perjuicio de los tratamientos ya realizados.

ARTÍCULO 27 QUATER.- Evaluación de Impacto en Protección de Datos (DPIA) y política de retención y eliminación de datos.

a) Evaluación de Impacto en Protección de Datos (DPIA) previa obligatoria.

1) Antes de la puesta en producción de cualquier módulo del Sistema C.U.R.A. que implique tratamiento masivo de datos de salud identificables o seudónimos, la Autoridad de Aplicación deberá realizar y publicar una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (DPIA), conforme los estándares del Artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 (GDPR), adaptados al ordenamiento jurídico argentino.

2) La DPIA deberá:

i) Describir sistemáticamente el tratamiento y sus finalidades.

ii) Evaluar la necesidad y proporcionalidad de los tratamientos.

iii) Identificar y evaluar los riesgos para los derechos y libertades de los titulares de datos.

iv) Establecer las medidas previstas para mitigar dichos riesgos.

v) Incluir un análisis de alternativas técnicas menos intrusivas.

3) La DPIA será sometida a consulta previa de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que dispondrá de NOVENTA (90) días para emitir dictamen no vinculante. La Autoridad de Aplicación deberá publicar su respuesta motivada a las observaciones de la AAIP.

4) Cualquier módulo que sea objeto de modificaciones sustanciales —incluyendo cambios en la finalidad, en el volumen de datos tratados, en los sistemas de acceso o en los módulos de Inteligencia Artificial— requerirá DPIA complementaria antes de su despliegue.

b) Política de retención y eliminación de datos.
La Autoridad de Aplicación, en coordinación con la AAIP, establecerá mediante resolución fundada —dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de reglamentada la presente ley— la política de retención y eliminación de datos del Sistema C.U.R.A.,

conforme los siguientes criterios mínimos:

1) Plazos máximos de retención por categoría de dato:
   i) Datos de la historia clínica activa: durante toda la relación asistencial activa y por un plazo mínimo de DIEZ (10) años desde la última atención documentada, conforme la Ley 26.529 y el Código Civil y Comercial.
   ii) Datos de prescripción y dispensación: CINCO (5) años desde la prescripción, salvo tratamientos crónicos.
   iii) Registros de acceso y trazabilidad (logs): CINCO (5) años desde el acceso, con posibilidad de extensión ante investigación en curso.
   iv) Datos de uso secundario (investigación): el plazo específico del proyecto de investigación aprobado, con destrucción certificada al vencimiento.
2) Eliminación segura.
   Vencido el plazo de retención, los datos serán eliminados de forma segura e irreversible conforme estándares técnicos certificados, o anonimizados de forma irreversible para su eventual conservación con fines estadísticos.
3) Derecho al olvido sanitario.
   El titular de los datos podrá solicitar la eliminación anticipada de datos no sujetos a obligación legal de conservación. La solicitud será resuelta por la Autoridad de Aplicación en un plazo no mayor a TREINTA (30) días.

ARTÍCULO 28.- Acceso de emergencia ("break-glass").

En situaciones de emergencia médica que impliquen riesgo cierto e inminente para la vida o la salud del paciente y cuando éste se encuentre imposibilitado de otorgar consentimiento, el profesional de la salud actuante podrá acceder temporalmente a la información clínica protegida del Sistema C.U.R.A. sin autorización previa del titular, conforme las siguientes condiciones:

a) Requisitos de procedencia.
   El acceso de emergencia procederá únicamente cuando concurran simultáneamente:
   1) Existencia de emergencia médica certificable que requiera intervención urgente.
   2) Imposibilidad material del paciente para prestar consentimiento válido.
   3) Necesidad clínica razonable del acceso a la historia clínica para la adecuada atención.

No procederá el mecanismo cuando exista negativa expresa del paciente consciente y capaz.

b) Alcance del acceso.

El acceso de emergencia habilitará la visualización integral de la historia clínica del paciente, incluyendo categorías sensibles segmentadas o protegidas conforme el artículo 27, cuando ello resulte necesario para la preservación de la vida o la salud.

En tales supuestos, la protección de la vida y la integridad física prevalecerá sobre las configuraciones de privacidad previamente establecidas por el titular.

c) Procedimiento de activación.

Para activar el mecanismo de acceso de emergencia, el profesional deberá:

1) Encontrarse previamente autenticado en el Sistema C.U.R.A. mediante sus credenciales personales habilitadas.

2) Identificar de manera inequívoca al paciente mediante:

i) Escaneo de la credencial digital o código QR vinculado al C.U.R.A.-ID; o

ii) Ingreso manual del Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro identificador biométrico validado por el sistema, el cual resolverá internamente la correspondencia con el C.U.R.A.-ID del titular.

3) Seleccionar el motivo clínico de urgencia de un listado predefinido o consignarlo fundadamente.

4) Confirmar expresamente que se cumplen los requisitos del inciso a), bajo declaración de responsabilidad profesional.

El sistema otorgará acceso temporal limitado exclusivamente al episodio de emergencia, el cual caducará automáticamente una vez finalizada la atención urgente o vencido el plazo técnico que establezca la reglamentación.

d) Notificación obligatoria y control ex post.

Todo acceso activado bajo el protocolo break-glass deberá:

1) Ser registrado automáticamente e inmediatamente por el Módulo Nacional de Trazabilidad (Art. 10), con indicación del profesional actuante, el establecimiento, la fecha y hora, los datos consultados y la causa de la emergencia declarada.

2) Generar una notificación automática al titular del dato —o a su representante legal o gestor delegado— dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el acceso, con indicación del profesional que accedió, la información consultada y la causal invocada.

3) La notificación se efectuará por el canal preferido registrado en el perfil del Sistema C.U.R.A. del titular; si no hubiere canal disponible, mediante mensaje en el Portal del Sistema.

4) El titular podrá impugnar ante la Autoridad de Aplicación todo acceso break-glass que considere injustificado, dentro de los TREINTA (30) días de la notificación.

La Autoridad deberá verificar la concurrencia de los requisitos de procedencia, la proporcionalidad del acceso y la correspondencia con los registros clínicos del episodio. Si se

comprobare uso indebido, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 44, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales.

e) Uso indebido.

Constituye uso indebido del mecanismo:

1) Invocar emergencia inexistente.
2) Acceder por interés personal o ajeno a la atención sanitaria.
3) Utilizar la información obtenida para fines distintos del tratamiento del paciente.
4) Emplear el mecanismo para eludir el consentimiento en situaciones ordinarias.

El uso indebido será considerado falta gravísima.

f) Auditoría proactiva.

La Autoridad de Aplicación realizará auditorías periódicas, al menos trimestrales, sobre una muestra representativa de accesos “break-glass”, verificando:

1) Correspondencia entre la emergencia declarada y los registros clínicos posteriores.
2) Razonabilidad de la duración del acceso.
3) Ausencia de patrones sistemáticos de abuso.

Si se detectaran irregularidades, se iniciará investigación de oficio conforme el régimen sancionatorio vigente.

g) Responsabilidad institucional.

Los establecimientos de salud deberán:

1) Capacitar a su personal sobre el uso correcto del mecanismo.
2) Monitorear accesos de emergencia.
3) Informar a la Autoridad de Aplicación posibles irregularidades.

h) Implementación presupuestaria.

La implementación del presente artículo se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 35, sin generar nuevas estructuras administrativas permanentes.

ARTÍCULO 29.- Verificación de identidad y consentimiento presencial.

Los mecanismos de verificación fehaciente establecidos en el presente artículo serán de aplicación obligatoria para todo acceso a datos clínicos o prescripciones dentro del Sistema C.U.R.A., incluyendo, pero no limitándose a, la consulta por parte de profesionales médicos, la dispensación de medicamentos en farmacias y la realización de estudios en laboratorios.

a) Métodos de Verificación Fehaciente Habilitantes.

Se deberá acreditar la identidad y consentimiento del titular mediante uno de los siguientes métodos:

1) Autenticación con DNI y Token de Mi Argentina.
   El ingreso por parte del profesional del número de DNI y del token o código de acceso temporal generado por la aplicación "Mi Argentina" habilitará el acceso de manera inmediata.
   Este método se considerará el de más alto nivel de seguridad.

2) Credencial C.U.R.A.
   El escaneo del código QR vinculado al C.U.R.A.-ID por parte del profesional y la validación mediante token o código de acceso temporal generado por la aplicación oficial habilitarán el acceso de manera inmediata.

3) Documento Nacional de Identidad Físico.
   Presentado el DNI físico y vigente, el ingreso del número de trámite por parte del profesional habilitará el acceso de manera inmediata, previa verificación visual razonable de correspondencia entre el documento y la persona presente.

4) Verificación Biométrica o Autenticación Fuerte Alternativa.
   Cuando la jurisdicción disponga de servicios de validación biométrica interoperables con RENAPER u otros sistemas oficiales de identidad digital del Estado Nacional, podrá utilizarse autenticación biométrica facial o equivalente como método habilitante

   En ausencia de disponibilidad biométrica, y únicamente en contextos de atención urgente con paciente consciente, podrá utilizarse un mecanismo subsidiario excepcional de verificación mediante preguntas múltiples de seguridad,

requiriéndose un mínimo de CINCO (5) preguntas independientes y el acierto total de las respuestas.

Todo acceso habilitado bajo este mecanismo subsidiario deberá quedar sujeto a trazabilidad reforzada y auditoría automática posterior.

b) Protocolo excepcional de atención para pacientes no identificables, conforme lo establecido en el artículo 29 BIS.

Cuando ninguno de los métodos previstos en el inciso a) resulte aplicable o viable —incluyendo supuestos de pacientes extranjeros sin documentación argentina, personas indocumentadas, documentación extraviada o imposibilidad material de validación técnica— el establecimiento deberá:

1) Crear un identificador provisorio de atención de emergencia generado automáticamente por el sistema.
2) Registrar datos mínimos disponibles, tales como sexo, edad estimada, descripción básica y circunstancias del ingreso.
3) Garantizar la atención médica inmediata sin que la falta de identificación fehaciente constituya obstáculo o demora.
4) Registrar con trazabilidad reforzada la identidad del profesional interviniente, establecimiento, fecha, hora y motivo de imposibilidad de validación.
5) Intentar la verificación fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores, vinculando el registro provisorio al C.U.R.A.-ID definitivo en caso de lograrse identificación.

Si la identificación no pudiera completarse, el registro permanecerá separado con acceso restringido y será objeto de revisión y eventual anonimización conforme reglamentación.

La creación, gestión, contraste y eventual integración del identificador provisorio se regirá por lo dispuesto en el Artículo 29 BIS.

c) Prohibición de negativa de atención.

Ningún prestador de salud podrá negar, demorar o condicionar la atención médica necesaria basándose en:

1) Falta de Documento Nacional de Identidad.

2) Imposibilidad de validación digital inmediata.

3) Ausencia de credencial C.U.R.A.

4) Falta de conectividad o fallas técnicas del sistema.

En tales supuestos deberá aplicarse el protocolo excepcional previsto en el inciso b), garantizando el derecho a la atención sanitaria.

d) Responsabilidad por suplantación de identidad.

La suplantación de identidad para acceder a datos clínicos, prescripciones o prestaciones sanitarias constituirá infracción grave y podrá dar lugar a responsabilidad penal conforme la legislación vigente.

El profesional o establecimiento que detecte intento de suplantación deberá:

1) Denegar el acceso irregular.

2) Registrar el incidente en el sistema.

3) Informar a la Autoridad de Aplicación cuando corresponda.

ARTÍCULO 29 BIS.- Protocolo Nacional para Pacientes No Identificados

Creación de Identificador Temporal.

Todo establecimiento de salud deberá generar un Identificador Temporal (C.U.R.A.-TEMP) para toda persona que requiera atención urgente y no pueda ser identificada fehacientemente al momento del ingreso.

Registro de Datos Iniciales.

Se capturará fotografía actual del rostro del paciente, junto con descripción física detallada y signos distintivos visibles.

Dicha información quedará asociada exclusivamente al perfil C.U.R.A.-TEMP, con acceso restringido.

Historia Clínica Anónima Unificada.

Los eventos clínicos posteriores se acumularán en el perfil temporal hasta tanto se determine

la identidad del paciente, garantizando continuidad asistencial.

Base Cerrada de Perfiles Hospitalarios NN.

El Sistema C.U.R.A. mantendrá una base cerrada compuesta únicamente por los perfiles C.U.R.A.-TEMP generados en establecimientos de salud del país.

Mecanismo de contraste humanitario.

Los organismos oficiales de búsqueda de personas podrán cargar la fotografía de una persona denunciada como desaparecida para contrastarla exclusivamente contra la base cerrada de perfiles C.U.R.A.-TEMP generados en establecimientos de salud.

El sistema podrá utilizar herramientas de análisis automatizado de similitud facial con las siguientes garantías:

a) El procesamiento tendrá carácter exclusivamente asistido y no decisorio.
b) Solo se sugerirán coincidencias con umbral alto de similitud definido reglamentariamente.
c) La verificación final será siempre humana y manual.
d) Toda búsqueda quedará registrada con trazabilidad completa.

Este mecanismo no constituye identificación biométrica masiva ni vigilancia poblacional, sino un procedimiento puntual y humanitario de contraste individual ante denuncia concreta.

Validación Judicial Obligatoria

Toda coincidencia considerada positiva deberá ser elevada a autoridad judicial competente, quien ordenará las medidas de verificación necesarias (cotejo documental, ADN u otras pericias).

Solo mediante resolución judicial se autorizará la fusión definitiva del perfil C.U.R.A.-TEMP con el C.U.R.A.-ID correspondiente.

Protección de Datos

Las fotografías y datos de perfiles temporales solo podrán utilizarse para fines asistenciales y de búsqueda de personas.

Una vez confirmada la identidad, el perfil temporal será fusionado y la fotografía será retirada de la base de contraste.

Los perfiles temporales no identificados serán conservados por el plazo que determine la reglamentación conforme principios de necesidad y proporcionalidad.

ARTÍCULO 30.- Seguridad informática, cifrado y arquitectura de Cero Confianza (Zero Trust).

El Sistema C.U.R.A. garantizará la máxima protección tecnológica, criptográfica y operativa de la información clínica nacional, adoptando políticas de seguridad alineadas con las normas ISO/IEC 27001, 27701 y 22301, o aquellas que en el futuro las sustituyan o actualicen, conforme estándares internacionales vigentes.

Cifrado y autenticación.

Toda información almacenada y transmitida deberá cifrarse utilizando estándares criptográficos simétricos y de protección de datos en tránsito vigentes y recomendados por organismos técnicos de referencia internacional, incluyendo el National Institute of Standards and Technology (NIST), la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) y organismos equivalentes.

Los algoritmos y protocolos específicos deberán actualizarse mediante resolución del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. cuando los organismos técnicos de referencia declaren su obsolescencia, vulnerabilidad significativa o necesidad de migración tecnológica, sin requerir modificación legislativa.
El acceso de usuarios profesionales requerirá autenticación multifactor, la cual se considerará cumplida mediante la autenticación previa en los sistemas de identidad digital del Estado Nacional (Mi Argentina, Mi AFIP, Mi ANSES). Los estándares de seguridad para las aplicaciones y componentes web del Sistema C.U.R.A., incluyendo el uso de Web Application Firewalls (WAF), serán al menos equivalentes a los utilizados por dichos sistemas de identidad digital

Segmentación y control de acceso.

El sistema aplicará el principio de mínimo privilegio, limitando cada perfil a la información estrictamente necesaria para su función.

Todo intento de acceso indebido generará bloqueo automático, registro de auditoría y notificación a la Autoridad de Aplicación.

Infraestructura y almacenamiento.

El Sistema C.U.R.A. se alojará exclusivamente en centros de datos nacionales de ARSAT S.E. o equivalentes designados por la Autoridad de Aplicación, con redundancia geográfica

mínima en tres (3) nodos ubicados en macro-regiones federales diferenciadas.

A los efectos del presente artículo, se entenderá por macro-regiones federales las siguientes:

1) Noroeste Argentino (NOA)
2) Noreste Argentino (NEA)
3) Cuyo
4) Patagonia
5) Región Centro
6) Área Metropolitana de Buenos Aires

Los nodos deberán encontrarse físicamente separados, en infraestructuras independientes y en distintas áreas metropolitanas o provincias. No se considerará cumplimiento válido la localización de múltiples nodos dentro de un mismo centro de datos o complejo edilicio.

Los respaldos diarios cifrados se conservarán durante un mínimo de diez (10) años, con verificación mensual de integridad.

Plan Nacional de Contingencia y Respuesta a Incidentes.

Créase el CSIRT-C.U.R.A. (Computer Security Incident Response Team), conformado por especialistas del Ministerio de Salud de la Nación, la ONTI y la AAIP, responsable de la prevención, detección y mitigación de incidentes de ciberseguridad.

Ante una vulnerabilidad o ataque confirmado, el CSIRT-C.U.R.A. deberá iniciar la investigación en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas hábiles e iniciar medidas de contención dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles, debiendo documentar el plan de remediación y recuperación conforme la criticidad del incidente.

Toda brecha de seguridad será comunicada a la Autoridad de Aplicación, al establecimiento involucrado y, en caso de corresponder, al titular de los datos afectados.

Supervisión y auditoría.

El sistema será objeto de auditorías técnicas y de seguridad informática anuales, a cargo de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Los resultados serán publicados en formato abierto en el portal oficial del Estado Nacional, preservando el anonimato de los datos personales.

Principio de Cero Confianza (Zero Trust).

El Sistema C.U.R.A. se diseñará, implementará y operará bajo un modelo de seguridad de Cero Confianza, el cual se regirá por los siguientes principios y componentes obligatorios:

Verificación Explícita: Toda solicitud de acceso, sin importar su origen, será autenticada, autorizada y cifrada de forma estricta antes de conceder cualquier acceso.

Acceso con Mínimo Privilegio: Los usuarios, dispositivos y flujos de trabajo solo tendrán acceso a los datos y sistemas estrictamente necesarios para cumplir una función específica y por el tiempo limitado que esta requiera.

Microsegmentación: La red y los repositorios de datos del Sistema C.U.R.A. serán divididos en segmentos de seguridad pequeños y aislados para limitar la capacidad de movimiento lateral.

Monitoreo Continuo y Análisis Comportamental: El sistema implementará una plataforma de Detección y Respuesta Extendidas (XDR) para el monitoreo en tiempo real del comportamiento de usuarios y dispositivos, con el fin de identificar actividades anómalas.

Microsegmentación, Cifrado y Políticas Granulares de Acceso.

Toda información de salud sensible definida en el Artículo 27 deberá ser etiquetada obligatoriamente mediante un conjunto cerrado de categorías, tales como salud mental, VIH, salud sexual y reproductiva y consumo de sustancias. Este etiquetado será automático y podrá basarse en la especialidad del profesional interviniente, en los códigos SNOMED CT o LOINC utilizados, y en reglas semánticas definidas por la Autoridad de Aplicación.

El acceso a estos datos etiquetados estará gobernado por un motor de políticas que cruzará la especialidad, institución y contexto del profesional con las etiquetas de los datos.

Queda estrictamente prohibido que la autorización para un tipo de dato sensible implique la autorización para otro. Un profesional solo podrá visualizar las categorías de datos sensibles explícitamente permitidas para su perfil, independientemente de su acceso a la historia clínica general.

La Autoridad de Aplicación, en conjunto con el Comité de Gobernanza Técnica, definirá y actualizará la matriz de especialidades médicas y las categorías de datos sensibles a las que cada una puede acceder.

ARTÍCULO 31- Protocolo de Contingencia Sanitaria Nacional (Modo de Adversidad). Activación, arquitectura operativa y control constitucional.

El presente artículo establece el régimen excepcional que transforma al Sistema C.U.R.A. en herramienta de apoyo a la gestión sanitaria y logística durante emergencias o catástrofes que afecten a la población, con estricta sujeción al control jurisdiccional y a la protección de los derechos fundamentales.

DEFINICIÓN OBJETIVA DE EMERGENCIA SANITARIA

A los efectos del presente artículo, se entenderá por emergencia sanitaria toda situación excepcional que concurra con al menos DOS (2) de los siguientes criterios objetivos:

a) Declaración formal de emergencia sanitaria por autoridad nacional o jurisdiccional competente;

b) Existencia de evidencia epidemiológica verificable de transmisión activa entre personas de un agente de riesgo cierto, acreditada por autoridad sanitaria competente;

c) Superación del umbral de alerta del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud integrado al Sistema C.U.R.A.;

d) Riesgo inminente de colapso de la capacidad asistencial en la jurisdicción afectada, acreditado mediante informe técnico del Ministerio de Salud de la Nación.

a) Activación ministerial inicial

El Ministro de Salud de la Nación podrá activar el Protocolo de Contingencia mediante resolución fundada cuando se verifiquen, de forma concurrente:

1) La configuración de una emergencia sanitaria conforme la definición objetiva establecida en el presente artículo;

2) La necesidad técnicamente acreditada de acceso ampliado o coordinado a datos clínicos para la gestión de la emergencia, con determinación expresa de los tipos de datos accesibles, los sujetos autorizados y el ámbito geográfico de aplicación;

3) La imposibilidad de obtener consentimiento individual en el plazo requerido por las circunstancias de la emergencia.

b) Declaración del Modo de Adversidad

La resolución ministerial que activa el Protocolo de Contingencia importa la declaración formal del Modo de Adversidad del Sistema C.U.R.A., estado operativo excepcional que habilita las funcionalidades previstas en el inciso 6 del presente artículo, exclusivamente en los términos y con los controles constitucionales aquí establecidos.

Desde el momento de su activación y hasta la obtención de habilitación judicial conforme el inciso 3, el Modo de Adversidad habilitará únicamente:

1) El despliegue del Módulo de Triage y Carga Rápida previsto en el inciso 6.b);

2) El Módulo Logístico de Interoperabilidad de Emergencia previsto en el inciso 6.c), limitado exclusivamente a datos operativos agregados sin identificadores clínicos individuales;

3) El acceso a datos agregados y anonimizados del Sistema C.U.R.A. para planificación sanitaria de la respuesta.

El acceso a datos clínicos individualizados requerirá habilitación judicial expresa conforme el inciso 3, sin excepción.

c) Control judicial previo habilitante

La activación del Protocolo no habilitará por sí sola el acceso ampliado a datos clínicos individualizados. Dicho acceso requerirá autorización judicial expresa, conforme el siguiente procedimiento:

1) La Autoridad de Aplicación deberá comunicar la activación al juzgado federal con competencia en lo contencioso-administrativo del lugar de la emergencia dentro de las SEIS (6) horas de dictada la resolución ministerial, solicitando habilitación del acceso ampliado e indicando con precisión: los tipos de datos requeridos, los sujetos autorizados a acceder y el ámbito territorial de aplicación;

2) El juez deberá expedirse dentro de las DOCE (12) horas de recibida la comunicación, pudiendo de oficio o a petición de parte revisar la proporcionalidad y alcance de la activación y ordenar su modificación o cese. La resolución judicial deberá ser fundada;

3) Hasta tanto se produzca la habilitación judicial expresa, el acceso a datos clínicos individualizados permanecerá suspendido. Esta restricción no afectará las acciones de respuesta sanitaria de emergencia que no requieran acceso a datos clínicos nominales;

4) Si el juez no se expidiere en el plazo establecido, la Autoridad de Aplicación podrá habilitar el acceso ampliado exclusivamente a datos agregados y anonimizados, quedando el acceso a datos individualizados suspendido hasta pronunciamiento judicial expreso;

5) El juez interviniente podrá, en cualquier momento durante la vigencia del Protocolo, ordenar la modificación, restricción o cese de las medidas de acceso ampliado, si verificare que han cesado las condiciones que las justificaron o que se han excedido los límites establecidos.

d) Ratificación legislativa

Si la activación del Protocolo superare las SETENTA Y DOS (72) horas, el Poder Ejecutivo deberá solicitar ratificación política dentro de ese plazo, conforme el siguiente mecanismo diferenciado según el estado de funcionamiento del Honorable Congreso de la Nación:

1) Congreso en período de sesiones ordinarias o extraordinarias: La solicitud de ratificación se dirigirá a las comisiones competentes en materia de salud de ambas Cámaras, las que deberán expedirse dentro de los SIETE (7) días corridos desde la activación. La falta de ratificación dentro de ese plazo determinará la cesación automática del Modo de Adversidad;

2) Congreso en receso parlamentario: La solicitud de ratificación se dirigirá a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Sistema C.U.R.A. prevista en el Artículo 72 BIS de la presente ley, la que deberá reunirse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la comunicación y expedirse mediante dictamen fundado dentro de los SIETE (7) días corridos desde la activación. El dictamen favorable de la Comisión Bicameral tendrá carácter de ratificación provisoria, válida hasta la reanudación del período legislativo ordinario o extraordinario, momento en el cual el Poder Ejecutivo deberá requerir ratificación definitiva de las comisiones competentes dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de iniciado el período. La falta de ratificación definitiva dentro de ese plazo determinará la cesación del Modo de Adversidad;

3) En ambos supuestos, la ratificación habilitará la continuidad del Modo de Adversidad exclusivamente por el período y con el alcance expresamente aprobado. Cualquier ampliación del ámbito geográfico, de los tipos de datos accesibles o de los sujetos autorizados requerirá nueva ratificación conforme el procedimiento establecido en el presente inciso;

4) Sin perjuicio del mecanismo de ratificación, la activación del Protocolo deberá ser comunicada de forma inmediata y simultánea al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Agencia de Acceso a la Información Pública, a los efectos del ejercicio de sus competencias de control.

e) Prohibiciones absolutas durante la activación

En ningún caso el Protocolo de Contingencia podrá habilitar:

1) El acceso a datos de salud con fines de seguridad pública, control social, identificación de individuos o seguimiento de conductas ajenas a la respuesta sanitaria;

2) La transferencia, comunicación o cesión de datos clínicos individualizados a organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad o cualquier organismo con competencias ajenas a la respuesta sanitaria directa;

3) La elaboración de perfiles individuales fuera del estricto marco de la atención médica de emergencia;

4) La aplicación de las funcionalidades del Modo de Adversidad sobre áreas geográficas, poblaciones o tipos de datos no comprendidos en la delimitación expresa de la resolución de activación;

5) Cualquier uso de la información obtenida para fines distintos de la respuesta sanitaria y logística de la emergencia declarada, tanto durante su vigencia como con posterioridad.

f) Medidas operativas excepcionales

Al momento de la activación, con los alcances diferenciados establecidos en el inciso 2 y conforme el control judicial del inciso 3, el Sistema C.U.R.A. implementará de forma automática y temporal las siguientes funcionalidades:

1) Acceso Sanitario de Emergencia.

Previa habilitación judicial expresa del acceso a datos individualizados, se habilitará un nivel

de Acceso Sanitario de Emergencia que permita a los profesionales de la salud debidamente autenticados en el Sistema C.U.R.A. acceder a información clínica crítica de los pacientes en la zona geográfica afectada, bajo protocolo de autenticación reforzado y de estricta auditoría. El Acceso Sanitario de Emergencia se limitará estrictamente:

i. A la zona geográfica afectada delimitada en la resolución de activación, sin habilitar acceso masivo nacional salvo emergencia de alcance nacional debidamente acreditada y judicialmente habilitada;

ii. A los datos del Resumen Clínico Federal establecido en el Artículo 3° TER —alergias activas, medicación crónica vigente, diagnósticos activos de relevancia clínica inmediata y antecedentes críticos con riesgo vital—, salvo que la habilitación judicial autorice expresamente el acceso a categorías adicionales por requerimientos específicos de la emergencia;

iii. Al período de duración del Protocolo vigente;

iv. Todo acceso realizado bajo esta modalidad deberá quedar registrado inmediatamente con indicación del profesional actuante, establecimiento, fecha, hora, tipo de dato consultado y causal de emergencia declarada, conforme el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría.

2) Módulo de Triage y Carga Rápida.

Se desplegará un módulo específico que permita el registro rápido de pacientes en contextos de adversidad, con un conjunto mínimo de datos de triaje, priorizando la atención asistencial sin subordinar el socorro a la completitud del registro. Los datos ingresados bajo este módulo:

i. Quedarán identificados con marcador de contexto de emergencia;

ii. Se incorporarán a la historia clínica digital del paciente una vez identificado fehacientemente;

iii. Quedarán sujetos a los mismos regímenes de protección, trazabilidad y auditoría que el resto del sistema;

iv. Podrán cargarse en modalidad offline conforme el Artículo 22, con sincronización obligatoria al restablecerse la conectividad.

3) Interoperabilidad de Emergencia — Módulo Logístico Exclusivo.

Se establecerán de forma temporal y acotada interfaces de programación de aplicaciones (APIs) con los sistemas de organismos de respuesta a emergencias intervinientes —fuerzas de seguridad, bomberos, defensa civil y Sistema Federal de Emergencias (SIFEM)—, bajo las siguientes condiciones y limitaciones absolutas:

i. Las interfaces habilitadas se limitarán estrictamente a datos logísticos y de capacidad operativa: geolocalización de zonas de atención activa, capacidad de camas disponibles por establecimiento y servicio, disponibilidad de insumos críticos, estado de rutas de traslado y distribución geográfica de recursos sanitarios. En ningún caso incluirán acceso a historias clínicas individuales, diagnósticos, tratamientos, medicación, ni categorías sensibles de datos personales de salud;

ii. Los organismos intervinientes recibirán exclusivamente información agregada, anonimizada y orientada a la coordinación logística, sin capacidad técnica de identificación de pacientes individuales. Las interfaces deberán diseñarse técnicamente

para imposibilitar el acceso a datos no autorizados;

iii. Las interfaces tendrán carácter estrictamente temporal y se desactivarán automáticamente a las SETENTA Y DOS (72) horas de su activación inicial, salvo ratificación expresa del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. mediante resolución fundada que acredite la persistencia objetiva de la emergencia y la proporcionalidad de su continuidad;

iv. Cada prórroga de las interfaces deberá ser fundada, proporcional y sujeta a auditoría reforzada. El Consejo Nacional comunicará toda prórroga al juzgado federal interviniente dentro de las DOCE (12) horas de dispuesta;

v. Al cesar el Modo de Adversidad, las interfaces se desactivarán automáticamente. Los organismos receptores de información deberán eliminar la totalidad de los datos recibidos durante la vigencia del Protocolo en un plazo máximo de SETENTA Y DOS (72) horas desde el cese, mediante procedimiento técnico de borrado seguro e irreversible conforme estándares internacionales reconocidos. El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse mediante certificación formal suscripta por la máxima autoridad del organismo receptor y por su responsable técnico de sistemas, con indicación de la metodología de eliminación utilizada, la fecha y hora de ejecución y el volumen de datos eliminados. Dicha certificación deberá ser remitida a la Autoridad de Aplicación del Sistema C.U.R.A., a la Agencia de Acceso a la Información Pública y al juzgado federal interviniente dentro del mismo plazo de SETENTA Y DOS (72) horas. La Autoridad de Aplicación realizará verificación técnica independiente del cumplimiento efectivo de la eliminación mediante auditoría de los sistemas de los organismos receptores dentro de los TREINTA (30) días posteriores al cese del Protocolo. La omisión de la certificación, su falsedad o el incumplimiento de la eliminación efectiva constituirán falta gravísima conforme el régimen sancionatorio aplicable al organismo responsable, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieren corresponder.

g) Control institucional concurrente

Simultáneamente a la activación del Protocolo y durante toda su vigencia, se constituirá un órgano de supervisión integrado por:

1) Un representante del Ministerio Público Fiscal;

2) Un representante de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP);

3) Un comité técnico sanitario designado por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

Este órgano deberá monitorear en tiempo real el uso de los datos, la proporcionalidad de las medidas adoptadas y el cumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad y finalidad exclusivamente sanitaria. Tendrá facultades para requerir información a la Autoridad de Aplicación, disponer restricciones adicionales de acceso y elevar observaciones fundadas al juzgado interviniente en cualquier momento de la vigencia del Protocolo.

h) Trazabilidad y auditoría durante la emergencia

Todo acceso a datos en el marco del Protocolo deberá:

1) Quedar registrado en forma íntegra, inmediata e inalterable en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría, con identificación del profesional actuante, establecimiento, fecha, hora, tipo de dato consultado y causal de emergencia declarada;
2) Ser susceptible de auditoría permanente y en tiempo real por el órgano de supervisión concurrente;
3) El titular del dato —o su representante legal o gestor delegado— deberá ser notificado sobre el acceso producido a su información clínica durante la emergencia, con indicación del profesional que accedió, la información consultada y la causal invocada. La notificación se realizará de forma progresiva conforme las condiciones operativas de la emergencia lo permitan, respetando el siguiente orden de prioridad: primero, cuando el titular se encuentre en condiciones de recibirla durante el curso de la atención; en su defecto, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del cese del impedimento operativo o clínico que la hubiere diferido; y en todos los casos, dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días contados desde la fecha del acceso, aun cuando la emergencia se encontrare aún vigente. La Autoridad de Aplicación implementará mecanismos automatizados de notificación masiva que permitan cumplir progresivamente esta obligación sin subordinar la continuidad de la respuesta sanitaria. El diferimiento de la notificación individual deberá quedar registrado con indicación de la causa específica que lo motivó, quedando sujeto a verificación en la auditoría ex post prevista en el inciso 10.

i) Duración del Modo de Adversidad

El Modo de Adversidad caducará automáticamente en los siguientes supuestos, lo que ocurra primero:

1) A los NOVENTA (90) días corridos desde su activación, salvo prórroga expresa ratificada por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. mediante resolución fundada que acredite la subsistencia objetiva de la emergencia, comunicada al juzgado interviniente;
2) A los SIETE (7) días corridos desde su activación, si no se hubiere obtenido ratificación legislativa o de la Comisión Bicameral conforme el inciso 4;
3) Por orden judicial fundada en cualquier momento;
4) Por decisión del Ministro de Salud de la Nación, cuando hubieren cesado las condiciones objetivas que motivaron la activación.

Al producirse la caducidad, el sistema retornará automáticamente a su modo de operación normal, las APIs de emergencia se desactivarán, y los permisos de acceso ampliado quedarán revocados sin posibilidad de reactivación salvo nueva activación conforme el presente artículo.

j) Auditoría ex post exhaustiva

Finalizada la emergencia o vencido el Modo de Adversidad, el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. realizará una auditoría exhaustiva de todas las acciones realizadas bajo este

Protocolo, que comprenderá:

1) Accesos realizados a datos individualizados, su fundamento clínico y la información consultada;
2) Uso de las interfaces logísticas de emergencia, organismos destinatarios y datos compartidos;
3) Cumplimiento de las prohibiciones absolutas establecidas en el inciso 5;
4) Funcionamiento del órgano de supervisión concurrente y observaciones formuladas;
5) Verificación del cumplimiento efectivo de las certificaciones de eliminación de datos por parte de los organismos receptores, conforme el inciso 6.c.v, incluyendo los resultados de la auditoría técnica independiente;
6) Eventuales desvíos, usos no autorizados o excesos detectados.

El informe de auditoría será publicado dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores al cese de la emergencia, preservando la privacidad de los pacientes mediante anonimización de la información individual. Será remitido simultáneamente a las Comisiones de Salud de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, a la Agencia de Acceso a la Información Pública y al juzgado federal interviniente.

k) Protección de derechos y consecuencias por uso indebido

El uso indebido del Modo de Adversidad para fines de inteligencia, seguridad interior, control migratorio, perfilamiento social o cualquier propósito ajeno a la estricta respuesta sanitaria y logística de la emergencia declarada, constituirá falta gravísima conforme al régimen sancionatorio de la presente ley, sin perjuicio de:

1) Las responsabilidades civiles del Estado Nacional conforme la Ley N° 26.944;
2) Las responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes;
3) Las acciones penales que pudieren corresponder conforme el Código Penal de la Nación.

La activación del Modo de Adversidad sin que concurran los criterios objetivos establecidos en la definición inicial del presente artículo, o su mantenimiento más allá de los plazos autorizados, constituirán agravantes de la responsabilidad prevista en el presente inciso.

TÍTULO VI - DERECHOS DE LOS USUARIOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES

ARTÍCULO 32.- Derechos del usuario.

Toda persona titular de datos en el Sistema C.U.R.A. tendrá los siguientes derechos:

Acceso gratuito y permanente. Acceder en cualquier momento, de manera gratuita, a su historia clínica digital completa, incluyendo resultados, estudios, prescripciones y registros

históricos.

Credencial C.U.R.A. y portabilidad. Obtener sin costo su Credencial Digital y/o el formato de respaldo imprimible con código QR “llavero”. Asimismo, tendrá derecho a solicitar la Credencial Física Inteligente con tecnología NFC, para facilitar el acceso a sus datos en situaciones de urgencia mediante lectura por proximidad, abonando los costos correspondientes.

Acceso y Gestión Unificada de Turnos. Acceder a un sistema unificado de búsqueda, gestión y asignación de turnos médicos en todo el sistema de salud adherente a través del portal C.U.R.A. y la aplicación "Mi Argentina", que garantice:

La búsqueda inteligente de profesionales y establecimientos por especialidad, nombre, ubicación geográfica y disponibilidad.

La búsqueda inteligente de profesionales y establecimientos filtrando por las obras sociales y prepagas con las que estos tienen convenio, garantizando que el turno solicitado será atendido bajo dicha cobertura.

La visualización de la disponibilidad en tiempo real.

La autogestión para solicitar, confirmar, cancelar o reprogramar turnos de forma autónoma, con validación inmediata que impida la doble asignación.

La consulta centralizada de todos sus turnos futuros, sin importar el prestador o el canal de asignación.

Consentimiento y privacidad. Gestionar sus consentimientos informados, segmentar la visibilidad de su información sensible y autorizar o revocar accesos a profesionales e instituciones, a través del Panel de Privacidad y Consentimiento previsto en el Artículo 27, con efecto inmediato.

Revocación y baja del sistema. Revocar en cualquier momento los consentimientos otorgados o solicitar la baja total del Sistema C.U.R.A., mediante un trámite digital simple, gratuito y autenticado a través de cualquiera de las plataformas oficiales de identidad digital del Estado Nacional.

Trazabilidad y transparencia. Consultar en tiempo real el historial completo de accesos a su información, con identificación del profesional, establecimiento, fecha, hora y motivo de cada acceso, conforme al Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría del Artículo 10.

Comprensión plena de la información. Acceder a un glosario interactivo y un mecanismo de simplificación de lenguaje que garantice la comprensión de los términos técnicos, diagnósticos y medicamentos, asegurando que el derecho de acceso implique también el derecho a entender su información clínica.

Actualización autónoma de datos de contacto. Actualizar, en cualquier momento, sus datos de contacto, domicilio y teléfonos de emergencia desde la interfaz digital, sin intervención de terceros.

Notificaciones automáticas. Recibir notificaciones electrónicas o alertas dentro del portal o aplicación cuando un profesional autorizado acceda a su historia clínica o cargue nueva información en su perfil.

Denuncias y reclamos. Denunciar incumplimientos de la presente ley por parte de cualquier prestador público o privado, obra social o institución, a través de los canales gratuitos que establecerá la Autoridad de Aplicación, incluyendo una línea telefónica nacional, correo electrónico y formulario web específico. La Autoridad de Aplicación deberá dar respuesta fundada en un plazo máximo de TREINTA (30) días.

Sugerencias de mejora. Sugerir mejoras al sistema mediante el Panel de Sugerencias y Revisión disponible en el portal oficial, cuyas observaciones deberán ser analizadas por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A (Artículo 6°).

Información sobre IA. Derecho a ser informado de manera clara y comprensible cuando se utilicen herramientas de Inteligencia Artificial en sus procesos de diagnóstico, tratamiento o gestión administrativa conforme los principios y salvaguardas establecidos en el Artículo 23.

Revisión Humana. Derecho a solicitar la intervención y revisión humana de cualquier recomendación, triaje o decisión administrativa generada o asistida por sistemas automatizados, garantizando que ninguna decisión médica relevante sea tomada exclusivamente por un algoritmo. El ejercicio de este derecho no suspenderá medidas urgentes necesarias para la protección de la salud del paciente.

Transparencia de Capacidades. Derecho a conocer los límites, riesgos y el grado de autonomía

de los sistemas de IA utilizados en su atención.

La Autoridad de Aplicación deberá garantizar que el ejercicio de los derechos enumerados sea totalmente gratuito, accesible y disponible mediante interfaz digital 100 % en línea, con mecanismos de accesibilidad universal y atención prioritaria a personas con discapacidad o adultos mayores.

ARTÍCULO 33.- Obligaciones de los prestadores de salud.

Todos los prestadores del sistema de salud quedan obligados a:

a) Cargar en el Sistema C.U.R.A. los datos clínicos de toda persona atendida, según el conjunto mínimo que determine la Autoridad de Aplicación, priorizando la información crítica para la continuidad de cuidados y situaciones de emergencia, conforme el cronograma de implementación progresiva que dicha Autoridad establezca por reglamentación. La carga de datos al Sistema C.U.R.A. no requerirá consentimiento autónomo adicional del paciente cuando se funde en las Bases A o B del Artículo 27 BIS. El prestador deberá, en todos los casos, cumplir con la obligación de información previa establecida en el inciso b) del Artículo 27 BIS.
La carga de datos vinculados a usos secundarios solo procederá mediando consentimiento específico conforme el inciso c) del Artículo 27 BIS.

b) Asociar cada carga de datos a la identificación del profesional y del establecimiento interviniente.

c) Informar al paciente, al momento de la atención, sobre la existencia del sistema, sus derechos y la posibilidad de gestionar su cuenta digital.

d) Cumplir con los protocolos de seguridad y niveles de acceso definidos por la autoridad competente.

e) Capacitación Obligatoria y Certificación en Alfabetización Digital Sanitaria: Garantizar la capacitación obligatoria, con evaluación y certificación de aprobación, para todo el personal que interactúe con el sistema. La Autoridad de Aplicación, en coordinación con el Consejo Federal de Salud (COFESA) y las entidades profesionales nacionales, desarrollará un Sistema Federal de Capacitación Digital, de conformidad con lo establecido en el Artículo 34, que cumplirá con los siguientes principios:

Especificidad por Rol: Los contenidos y evaluaciones serán específicos para cada perfil profesional (médicos, enfermeros, administrativos, etc.).

Modalidad Escalonada y en Cascada: Se implementará a través de una red de "Facilitadores

Digitales" certificados en cada jurisdicción y establecimiento.

Gamificación e Incentivos: El sistema de capacitación incorporará mecanismos de gamificación (insignias digitales, rankings) y otorgará beneficios no monetarios, tales como acceso a certificaciones de posgrado virtual, bibliotecas especializadas y puntaje para la recertificación de matrículas profesionales, en acuerdo con los colegios y consejos profesionales.

Actualización Permanente: La capacitación será un proceso continuo, actualizándose ante cada nueva funcionalidad o protocolo de seguridad relevante.

Ser responsables de la verificación fehaciente de la identidad de los usuarios al momento de la atención. El proceso de verificación deberá incluir, como mínimo, la validación del número de DNI contra las bases oficiales del Registro Nacional de las Personas y el cotejo visual de la persona con la fotografía oficial obtenida de dicha fuente. La Autoridad de Aplicación podrá habilitar excepciones a este mecanismo únicamente para situaciones de emergencia que impidan su realización o imposibilidad técnica debidamente registrada en el sistema, estableciendo los protocolos correspondientes.

Los prestadores que cuenten con sistemas de información propios (HIS/EMR) deberán integrarlos mediante las APIs seguras del Sistema C.U.R.A. (Vía de Integración Nativa). A falta de dicha integración, o mientras la misma se encuentra en desarrollo, el prestador deberá utilizar obligatoriamente la interfaz web oficial para la consulta y carga de toda la información asistencial obligatoria establecida en el Conjunto Mínimo Básico de Datos. La elección de la vía no exime del cumplimiento de los plazos y estándares de calidad de la información.

Reportar sugerencias de mejora y dificultades técnicas a través del formulario web específico disponible en el portal oficial del Sistema C.U.R.A.

Incorporar el uso del Sistema C.U.R.A. como parte de los protocolos obligatorios de atención y de los procesos de auditoría interna de calidad.

Garantizar que sus profesionales de la salud puedan acceder individualmente al sistema de sugerencias del Sistema C.U.R.A con sus credenciales profesionales, sin requerir intermediación institucional que obstaculice la participación directa.

Verificación Previa a la Carga: El Sistema C.U.R.A. deberá presentar al profesional, previo a la confirmación definitiva, un resumen de los datos clínicos, diagnósticos y tratamientos que serán incorporados a la historia clínica digital, requiriendo la revisión y confirmación expresa mediante acción afirmativa del profesional (checkbox o mecanismo equivalente) antes de

proceder a la carga definitiva. La ausencia de confirmación activa impedirá la incorporación de la información al sistema.

Ventana de Corrección: El profesional que haya cargado información dispondrá de un plazo de UNA (1) hora para modificar dicha carga sin necesidad de justificación adicional.

Toda modificación realizada dentro de este plazo será notificada automáticamente al paciente a través de los canales oficiales del sistema y quedará registrada en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría, sin constituir falta sancionable.

Vencido dicho plazo, las modificaciones posteriores deberán realizarse mediante justificación fundada del profesional interviniente, quedando igualmente registradas en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría, sin que ello implique presunción de irregularidad cuando respondan a la dinámica propia del acto médico.

Los laboratorios, centros de diagnóstico por imágenes y todos los establecimientos que realicen estudios médicos deberán cargar en el Sistema C.U.R.A., dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles, los resultados de todos los estudios realizados, incluyendo informes, imágenes y datos crudos cuando corresponda, mediante integración por APIs seguras o mediante la interfaz web del sistema salvo imposibilidad técnica debidamente registrada en el sistema..

Fomentar la capacitación de su personal en el uso del Sistema C.U.R.A a través de los tutoriales interactivos y evaluaciones interactivas integradas en la plataforma. El sistema otorgará insignias digitales y beneficios no monetarios (como acceso a congresos virtuales, bibliotecas digitales especializadas o certificaciones de capacitación) a los profesionales que completen dichas formaciones, promoviendo una adopción efectiva sin costos adicionales.

ARTÍCULO 34.- Sistema Federal de Capacitación Digital y Cambio Cultural.

Creación, Objeto y Financiamiento. Créase el Sistema Federal de Capacitación Digital del Sistema C.U.R.A., con el objeto de garantizar la adopción efectiva, segura y competente del sistema por parte de todos los usuarios. La capacitación será completamente gratuita y se realizará mediante una plataforma virtual federal provista por el Estado Nacional, utilizando la infraestructura tecnológica pública existente y los recursos reasignados conforme al principio de máxima eficiencia presupuestaria establecido en el Artículo 35. Se priorizará el uso de herramientas de código abierto y la producción de contenidos en colaboración con universidades públicas e institutos de formación técnica.

Principios Rectores. Su implementación se regirá por:

Especificidad por Rol: Los contenidos, duración y evaluaciones serán específicos para cada perfil (médicos, enfermeros, técnicos, administrativos).

Federalismo en Cascada: Se implementará a través de una red de "Facilitadores Digitales" certificados en cada jurisdicción.

Acreditación Habilitante: La aprobación de la capacitación básica será requisito indispensable para el acceso al sistema con permisos de escritura y carga de datos, sin que ello implique modificación del vínculo laboral ni afectación de derechos adquiridos, constituyendo un requisito técnico-operativo para el uso de la plataforma.

Accesibilidad: Se ofrecerá en modalidad virtual auto asistida, con tutorías virtuales e instancias presenciales focalizadas para zonas con conectividad limitada.

Componentes del Sistema. La plataforma online integrada al portal C.U.R.A. alojará:

a) Cursos interactivos por rol, incluyendo fundamentos de Inteligencia Artificial aplicada a la salud.
b) Simuladores del sistema para práctica sin riesgo.
c) Evaluaciones de acreditación.
d) Biblioteca de recursos (videotutoriales, guías rápidas, manuales).
e) Red de Facilitadores Digitales. Cada jurisdicción designará al menos un Facilitador Digital por establecimiento de salud de mediana y alta complejidad, y uno por región para establecimientos de baja complejidad. Estos recibirán capacitación intensiva y certificación por la Autoridad de Aplicación, siendo responsables del soporte de primera línea y la réplica de conocimientos en su ámbito.

Cronograma de Capacitación Obligatoria.

Fase 1 (0-6 meses): Capacitación y certificación de la Red Nacional de Facilitadores Digitales.

Fase 2 (6-18 meses): Acreditación del 80% del personal sanitario en las provincias de la primera tanda piloto.

Fase 3 (18-36 meses): Extensión al 100% del personal nacional y administrativo.

Mecanismos de Incentivo y Reconocimiento.

Gamificación: Insignias digitales, rankings y certificados de especialización.

Beneficios No Monetarios: La aprobación podrá otorgar puntaje para la recertificación de matrículas profesionales, previa suscripción de convenios con los Colegios y Consejos profesionales competentes, acceso a certificaciones de posgrado virtual avaladas por universidades nacionales y acceso preferencial a bibliotecas digitales especializadas.

Régimen de Capacitación Continua y Vinculación Operativa. Establécese la obligatoriedad de

acreditar una carga horaria mínima anual de capacitación en temas de interoperabilidad, seguridad de datos, ética digital en salud e IA. La falta de acreditación anual dará lugar a la suspensión temporal de las funcionalidades de firma digital y prescripción, previa notificación e intimación al profesional para regularizar la situación dentro del plazo que establezca la reglamentación. El sistema emitirá certificados automáticos registrados en el Módulo de

Trazabilidad.

Evaluación de Impacto. La Autoridad de Aplicación medirá anualmente la tasa de finalización, nivel de satisfacción, correlación entre capacitación y reducción de errores de carga, y la brecha digital entre jurisdicciones.

ARTÍCULO 34 BIS.- Plan Federal de Actualización Tecnológica Continua.

La Autoridad de Aplicación establecerá un plan de actualización tecnológica a diez (10) años para garantizar la sostenibilidad del Sistema C.U.R.A., incluyendo renovación de infraestructura, recertificación anual de módulos, evaluación de nuevas tecnologías, mecanismos de financiamiento mixto y espacios de innovación regulatoria ('sandboxes').

TÍTULO VII - FINANCIAMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

CAPÍTULO 1 - Financiamiento y Cooperación Internacional

ARTÍCULO 35.- Financiamiento, sostenibilidad y principio de máxima eficiencia presupuestaria.

a. Principio Rector.

El desarrollo, implementación y sostenibilidad del Sistema C.U.R.A. se regirá por el Principio de Máxima Eficiencia Presupuestaria con Infraestructura Pública Preexistente, priorizando la reasignación estratégica de recursos sobre la generación de nueva erogación, y fundamentándose en el ahorro futuro que la unificación digital generará para el Sistema de Salud Nacional, sin perjuicio del régimen específico y restrictivo establecido en el artículo 12 TER para el financiamiento de la infraestructura de conectividad sanitaria.

b. Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD).

Créase el Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD), que se integrará exclusivamente mediante los siguientes recursos, sin afectar las funciones esenciales del sistema de salud:

b.1. Reasignación por Eficiencia y Optimización.

Se destinará un porcentaje no mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos asignados anualmente a programas de salud digital e informática de la Jurisdicción 70 — Ministerio de Salud de la Nación, específicamente de las partidas correspondientes a la Ley N° 27.553 de Telemedicina, al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y a los ítems "Fortalecimiento del Sistema de Salud" e "Informática Sanitaria". La reasignación se fundamenta en la absorción y superación funcional de dichas partidas por el Sistema C.U.R.A. una vez que las funcionalidades correspondientes se encuentren operativas y certificadas en la jurisdicción del efector.

La reasignación se aplicará de forma escalonada y proporcional al grado de implementación efectiva del Sistema C.U.R.A. en cada jurisdicción, conforme el siguiente esquema: (i) hasta el TRES POR CIENTO (3%) durante el primer ejercicio fiscal posterior a la promulgación, sin requerir certificación de operatividad completa, a efectos de financiar las actividades preparatorias de la UESC; (ii) hasta el SEIS POR CIENTO (6%) a partir del segundo ejercicio, una vez certificada la operatividad de la Fase 1 en al menos una jurisdicción piloto; (iii) hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) pleno a partir del tercer ejercicio, previa certificación de la UESC sobre la absorción efectiva de las funcionalidades correspondientes. Los porcentajes de cada tramo son topes máximos y no importan obligación de afectación total.

La reasignación se realizará mediante resolución conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía, dictada dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la promulgación de la presente ley para el primer tramo, previo informe técnico de la UESC que acredite: (a) que la función correspondiente del Sistema C.U.R.A. se encuentra operativa y certificada en la jurisdicción afectada en el grado que corresponda al tramo aplicable; y (b) que la reasignación no comprometerá funciones esenciales de los programas de origen. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) auditará anualmente el cumplimiento de ambas condiciones.

Si vencido el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días la resolución conjunta no hubiere sido dictada por causas no imputables a la UESC, el Ministerio de Salud podrá disponer, mediante resolución fundada, la afectación provisional del primer tramo (hasta el TRES POR CIENTO) con cargo a créditos presupuestarios disponibles de la propia jurisdicción, a fin de garantizar la continuidad de las actividades preparatorias. Dicha afectación provisional deberá ser ratificada por la resolución conjunta dentro de los SESENTA (60) días hábiles posteriores, sin cuyo pronunciamiento caducará automáticamente, siendo los importes utilizados reintegrados a su partida de origen.

Quedan excluidos de toda reasignación, y gozan de intangibilidad presupuestaria absoluta, los programas que registren una población beneficiaria activa superior a CINCUENTA MIL (50.000) personas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, certificada por el Ministerio de Salud. Esta exclusión no podrá ser dejada sin efecto por resolución conjunta ni por decreto del Poder Ejecutivo Nacional; su modificación requiere ley del Honorable Congreso de la Nación.

La resolución conjunta de reasignación deberá incluir un plan de transición con cronograma verificable que garantice la continuidad operativa de cada función crítica de los programas afectados hasta tanto sea absorbida íntegramente por el Sistema C.U.R.A., sin interrupciones en la prestación de servicios sanitarios. La SIGEN auditará trimestralmente el cumplimiento

del plan de transición durante los VEINTICUATRO (24) meses siguientes a cada reasignación.

b.2. Aprovechamiento de Infraestructura Pública Preexistente.

El desarrollo e implementación utilizará de manera obligatoria y sin costo adicional la infraestructura tecnológica, centros de datos y capacidad humana de ARSAT S.E. (Red Federal de Fibra Óptica — REFEFO y satélites), la Secretaría de Innovación Pública (estándares e identidad digital) y la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (auditoría y certificación), cuyos costos operativos ya se encuentran contemplados en sus respectivos presupuestos.

Sin perjuicio de la utilización prioritaria de ARSAT S.E., cuando la UESC certifique, mediante informe técnico aprobado por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., que la capacidad técnica disponible de ARSAT S.E. resulta insuficiente para garantizar los niveles de disponibilidad, seguridad y latencia requeridos por el Sistema C.U.R.A. en una fase o módulo determinado, la Autoridad de Aplicación podrá contratar capacidad complementaria de infraestructura cloud bajo las siguientes condiciones acumulativas: (1) proveedores que garanticen el almacenamiento y procesamiento de datos exclusivamente en territorio de la República Argentina o en infraestructura bajo soberanía jurídica argentina; (2) proceso de selección conforme el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorias; (3) dictamen previo de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) sobre las condiciones técnicas de soberanía de datos; (4) publicación íntegra del contrato en el portal oficial del Sistema C.U.R.A. La insuficiencia de ARSAT S.E. deberá ser verificada anualmente por la SIGEN.

b.3. Financiamiento Internacional y Proyección Global.

Autorícese al Poder Ejecutivo a gestionar financiamiento específico con organismos internacionales de crédito para proyectos de salud digital y para la proyección del Sistema C.U.R.A. como Hub Global, el cual será destinado al FIISD y, en su caso, a la Subcuenta de Proyección Internacional creada por el Artículo 42 de la presente ley.

b.4. Contribución Solidaria para la Interoperabilidad Sanitaria (CIES).

Créase la Contribución Solidaria para la Interoperabilidad Sanitaria (CIES), destinada al financiamiento, sostenimiento y evolución de la infraestructura pública digital del Sistema C.U.R.A., en el marco del principio de solidaridad que rige el sistema de salud y seguridad social conforme el artículo 14 BIS de la Constitución Nacional.

i. Naturaleza jurídica.

La CIES tiene carácter de contribución solidaria de afectación específica, vinculada al sostenimiento de un sistema público esencial para la garantía del derecho a la salud, fundada en el principio de solidaridad del sistema de seguridad social establecido en el artículo 14 BIS de la Constitución Nacional. No constituye tasa retributiva de servicios ni impuesto general.

La exigibilidad de la CIES nace con la disponibilidad efectiva y certificada de los servicios de interoperabilidad, portabilidad, trazabilidad clínica y autenticación federal del Sistema C.U.R.A. para el sujeto obligado en su jurisdicción de operación, conforme la certificación que emita la Autoridad de Aplicación en los términos del Artículo 35 TER. Hasta tanto dicha

certificación no sea emitida respecto del sujeto obligado, la obligación de contribuir no será exigible, sin que ello genere mora ni intereses. Esta vinculación entre disponibilidad efectiva y exigibilidad de la contribución constituye el nexo funcional que distingue a la CIES de un impuesto general de financiamiento, al corresponder su cuantificación al costo real de los servicios efectivamente disponibles para cada categoría de sujeto obligado.

ii. Sujetos alcanzados.

Se encuentran alcanzados por la presente contribución los agentes del sistema de salud que operen en el ámbito del Régimen A, incluyendo las Obras Sociales Nacionales comprendidas en las Leyes N° 23.660 y N° 23.661, y las Entidades de Medicina Prepaga reguladas por la Ley N° 26.682, así como los demás financiadores del sistema, en los términos que establezca la reglamentación. No son sujetos de la CIES las obras sociales provinciales ni los efectores dependientes de provincias, salvo adhesión voluntaria expresa.

iii. Base de cálculo.

La contribución se determinará sobre el gasto anual en prestaciones de salud o sobre la cantidad de beneficiarios activos, conforme criterios objetivos, proporcionales y no discriminatorios definidos en la presente ley. El criterio de determinación de la alícuota distribuirá la base de cálculo entre los sujetos obligados en proporción a la cantidad de afiliados o beneficiarios activos de cada uno, certificada ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) o la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) según corresponda.

A los efectos de la determinación de la base de cálculo, la reglamentación podrá establecer categorías de sujetos obligados diferenciadas según el grado de utilización efectiva de los servicios de interoperabilidad del Sistema C.U.R.A., de modo que la contribución guarde proporcionalidad con el beneficio recibido por cada categoría. Los sujetos que acrediten utilización nula o marginal del sistema en un ejercicio, por causas ajenas a su voluntad y debidamente certificadas, podrán solicitar la reducción proporcional de la contribución correspondiente a dicho ejercicio, conforme el procedimiento que establezca la reglamentación.

iv. Alícuota.

La alícuota de la contribución no podrá ser inferior al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) ni superior al CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del gasto anual en prestaciones médicas de la entidad, o su equivalente técnico según la base de cálculo adoptada. La reglamentación deberá establecer la alícuota aplicable dentro de dichos límites, conforme criterios de razonabilidad, equidad y sostenibilidad del sistema.

Los límites de alícuota establecidos en el presente inciso podrán ser actualizados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto fundado, exclusivamente cuando la SIGEN certifique una variación verificada del costo real de prestación de los servicios de interoperabilidad superior al TREINTA POR CIENTO (30%) respecto del costo que sirvió de base para la determinación vigente, siempre que la alícuota resultante de la actualización no exceda el UNO POR CIENTO (1%) del gasto anual en prestaciones médicas. Toda actualización deberá ser comunicada a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema C.U.R.A. dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial, con el informe técnico que la fundamente.

v. Tope individual.

El monto del CIES no podrá exceder, para ningún sujeto obligado, el costo real y verificado de los servicios de interoperabilidad efectivamente prestados a ese sujeto en el ejercicio. La SIGEN verificará el cumplimiento de este tope con carácter previo a la emisión de la resolución conjunta de cuantificación.

vi. Principios de aplicación.

La contribución deberá: (a) respetar la proporcionalidad económica de los sujetos alcanzados; (b) evitar efectos confiscatorios o distorsivos; (c) garantizar la sustentabilidad del sistema sin afectar la continuidad de las prestaciones; (d) mantener criterios de transparencia y trazabilidad en su utilización.

vii. Cláusula de no traslado.

El CIES no podrá ser utilizado, invocado ni incorporado como fundamento en solicitudes de aumento de cuotas, copagos, coseguros ni aranceles de ninguna naturaleza ante los organismos de control competentes. Toda solicitud de modificación de cuotas o aranceles deberá acompañar declaración jurada de la entidad, firmada por su máxima autoridad, indicando que el CIES no integra los fundamentos del aumento requerido. La falsedad de la declaración jurada habilita: (a) la revocación de la autorización de aumento; (b) la devolución de los importes cobrados de más a los afiliados o tomadores, con actualización por el Índice de Precios al Consumidor del INDEC; y (c) la aplicación de las sanciones previstas en el régimen sancionatorio de la SSS o SSN según corresponda.

viii. Afectación específica y destino.

Los fondos recaudados en concepto de CIES se acreditarán directamente al FIISD y no podrán ser reasignados a otro destino por acto del Poder Ejecutivo ni por resolución de organismo alguno.

ix. Cuantificación técnica.

La cuantificación técnica del CIES para cada ejercicio será fijada mediante resolución conjunta de la SSS y de la SSN, emitida dentro de los NOVENTA (90) días corridos de la promulgación de la presente ley para el primer ejercicio y con CIENTO OCHENTA (180) días de anticipación para cada ejercicio posterior. La resolución conjunta opera exclusivamente como mecanismo de cuantificación técnica dentro de los parámetros fijados en la presente ley y no constituye ejercicio de potestad tributaria autónoma. Toda modificación de la base de cálculo deberá fundarse en variación documentada del costo real de prestación, acreditada mediante informe técnico de la UESC y dictamen de la SIGEN.

Si vencido el plazo aplicable la resolución conjunta no hubiere sido dictada, regirá con carácter provisorio la alícuota del ejercicio anterior, ajustada por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC correspondiente al período. Esta aplicación provisoria no generará mora ni intereses a cargo de los sujetos obligados, debiendo regularizarse la diferencia que corresponda, sin accesorios, dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la publicación de la resolución conjunta definitiva.

x. Reglamentación.

La Autoridad de Aplicación, en coordinación con los organismos competentes en materia de seguridad social y financiamiento sanitario, establecerá los mecanismos operativos de liquidación, percepción, control y fiscalización de la contribución. La determinación de la alícuota aplicable deberá fundarse en criterios objetivos, verificables y públicos, incluyendo: (a) el costo efectivo de sostenimiento y operación del Sistema C.U.R.A.; (b) la proporcionalidad respecto de la capacidad económica de los sujetos alcanzados; (c) el impacto sobre la sostenibilidad de las prestaciones de salud. La Autoridad de Aplicación deberá publicar anualmente un informe técnico que justifique la alícuota vigente, incluyendo estructura de costos, proyecciones y criterios utilizados para su determinación.

xi. Recursos administrativos.

Los sujetos obligados podrán impugnar la cuantificación del CIES ante la SSS o SSN según corresponda, mediante recurso de reconsideración con efecto suspensivo exclusivamente sobre la porción impugnada. El organismo competente deberá resolver el recurso dentro de los SESENTA (60) días hábiles. El silencio administrativo vencido dicho plazo equivale a resolución denegatoria, habilitando la acción contencioso-administrativa.

c. Mecanismo de Autofinanciamiento y Reinversión.

Una vez implementado el Sistema C.U.R.A. conforme el cronograma del Artículo 14, la SIGEN certificará anualmente los ahorros netos del sistema. La certificación se realizará mediante dictamen técnico conjunto de la SIGEN, la AGN y la Autoridad de Aplicación, conforme la metodología aprobada según el procedimiento establecido en el presente apartado.

c.1. Metodología de cuantificación previa.

Dentro de los NOVENTA (90) días corridos de la promulgación de la presente ley, la SIGEN, la AGN y la Autoridad de Aplicación aprobarán, con participación de al menos DOS (2) universidades nacionales con acreditada experiencia en economía de la salud designadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la metodología técnica de cuantificación de ahorros sistémicos. La metodología deberá contemplar: (i) criterios objetivos, verificables y auditables; (ii) atribución causal entre digitalización y reducción de costos; (iii) diferenciación entre ahorros directos cuantificables y ahorros indirectos estimados; (iv) factores de prudencia no inferiores al QUINCE POR CIENTO (15%) sobre los ahorros proyectados. La metodología aprobada será publicada en el Boletín Oficial. Hasta tanto no sea aprobada dicha metodología, no podrá disponerse la afectación de recursos bajo el concepto de ahorros reinvertibles ni asumirse compromisos de gasto con cargo a dicho concepto.

Si vencido el plazo de NOVENTA (90) días la metodología no hubiere sido aprobada por falta de acuerdo entre los organismos intervinientes, la SIGEN, en su carácter de organismo de control interno con competencia técnica en auditoría de gestión, establecerá, mediante resolución fundada, una metodología provisional aplicable al primer ejercicio, debiendo comunicarla a las demás partes y a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema C.U.R.A. La metodología provisional no vincula a los ejercicios posteriores y será sustituida por la definitiva una vez aprobada. Su aplicación en ningún caso constituirá habilitación para asumir compromisos de gasto que excedan los créditos presupuestarios vigentes.

El factor de prudencia establecido en el punto (iv) del presente inciso, fijado en el QUINCE POR CIENTO (15%) como mínimo, podrá ser aumentado por la SIGEN mediante resolución fundada cuando las condiciones macroeconómicas del ejercicio generen incertidumbre significativa sobre la materialización de los ahorros proyectados. Dicha resolución deberá publicarse junto con la metodología y ser comunicada a la Comisión Bicameral dentro de los CINCO (5) días hábiles de su emisión. En ningún caso el factor de prudencia podrá ser reducido por debajo del mínimo legal sin ley expresa del Honorable Congreso de la Nación.

c.2. Condición de certificación previa.

La aplicación de la fórmula de reinversión prevista en el presente apartado quedará condicionada, en todo caso, a la previa emisión por la SIGEN de dictamen fundado que certifique la existencia y cuantificación de los ahorros netos del ejercicio. Sin dictamen previo de la SIGEN, no podrán asumirse compromisos de gasto, celebrarse contratos ni disponerse transferencias con cargo a ahorros sistémicos.

La SIGEN deberá emitir el dictamen de certificación de ahorros dentro de los NOVENTA (90) días del cierre del ejercicio fiscal. Si vencido dicho plazo el dictamen no hubiere sido emitido por causas no imputables a la Autoridad de Aplicación, ésta podrá solicitar al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. la habilitación de un crédito provisional de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los ahorros estimados conforme la metodología vigente, destinado exclusivamente a gastos de ciberseguridad y mantenimiento crítico del sistema conforme el inciso h), puntos 1) a 3). Dicho crédito provisional quedará sujeto a regularización dentro de los TREINTA (30) días hábiles posteriores a la emisión del dictamen definitivo, sin que su eventual exceso genere responsabilidad administrativa cuando hubiere mediado buena fe y criterio técnico razonable en la estimación.

c.3. Distribución.

Un porcentaje no menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los ahorros netos anuales certificados por la SIGEN deberá destinarse prioritariamente a los siguientes fines:

— CUARENTA POR CIENTO (40%) para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, Mejora de la Conectividad, Mantenimiento y Actualizaciones Críticas.

— SESENTA POR CIENTO (60%) para el Fondo Federal de Equidad Sanitaria establecido en la Disposición Transitoria Vigesimoprimera.

En el caso del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI), la aplicación de la presente reinversión se realizará conforme lo dispuesto específicamente en el apartado (d) del presente artículo.

c.4. Cláusula de escape presupuestaria.

Cuando los ahorros netos certificados por la SIGEN en un ejercicio resultaren insuficientes para cubrir las asignaciones del inciso c), o cuando la SIGEN no pudiere certificar ahorros netos positivos, el Poder Ejecutivo Nacional deberá incluir en el proyecto de Ley de Presupuesto del ejercicio siguiente una partida destinada a cubrir dichas asignaciones, no inferior al monto necesario para mantener operativos los módulos de ciberseguridad y el Fondo Federal de Equidad Sanitaria en su nivel de ejecución del ejercicio anterior. La SIGEN

deberá informar al Congreso, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de presentado el proyecto de presupuesto, el cumplimiento o incumplimiento de esta obligación, con indicación del monto de la eventual omisión.

La ejecución de las afectaciones específicas previstas en el presente artículo se realizará conforme al régimen de administración financiera del Estado Nacional establecido por la Ley 24.156 y quedará sujeta a la inclusión de los créditos correspondientes en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio, sin que ello implique la alteración del principio de reinversión aquí establecido.

d. Ahorro Operativo Estructural del INSSJP–PAMI.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) deberá cuantificar anualmente los ahorros derivados de la digitalización integral de sus procesos en el marco del Sistema C.U.R.A., incluyendo:

Eliminación de papelería, sobres y recetas impresas.

Eliminación de autorizaciones presenciales y trámites manuales.

Eliminación del troquel físico mediante el Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT).

Reducción de auditorías manuales, reclamos y reprocesamientos.

Disminución de pérdidas económicas por fraude asociado al troquel físico.

Optimización de recursos humanos reconvertidos.

Convenio de cooperación.

El INSSJP–PAMI y el Ministerio de Salud de la Nación suscribirán un convenio de cooperación que regule la cuantificación y transferencia de ahorros al FIISD. El convenio deberá suscribirse dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la promulgación de la presente ley y utilizará como metodología de cuantificación la aprobada conforme el inciso c.1 del presente artículo, adaptada a las particularidades operativas del INSSJP–PAMI.

Si vencido el plazo el convenio no hubiera sido suscripto sin causa justificada, el Ministerio de Salud elevará informe al Poder Ejecutivo Nacional, quien deberá requerir al Directorio del INSSJP–PAMI la suscripción dentro de los TREINTA (30) días siguientes. La no suscripción injustificada vencidos ambos plazos habilitará al Ministerio de Salud a implementar la cuantificación unilateral mediante la metodología aprobada, a los efectos del reconocimiento contable del ahorro, sin que ello impida la posterior suscripción del convenio y su aplicación prospectiva.

Transferencia condicionada.

Un porcentaje no menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los ahorros netos anuales podrá ser transferido al FIISD, previo dictamen de la SIGEN que certifique: (i) la existencia y cuantificación de los ahorros netos atribuibles a la digitalización; (ii) que la transferencia no compromete la sostenibilidad financiera del Instituto ni la calidad de las prestaciones a sus afiliados; (iii) que los indicadores de calidad de prestaciones a afiliados del ejercicio en curso

no son inferiores a los del ejercicio anterior conforme los estándares que establezca la SSS. La SIGEN emitirá el dictamen dentro de los NOVENTA (90) días del cierre del ejercicio fiscal. Sin dictamen previo favorable de la SIGEN, no podrá disponerse transferencia alguna.

El porcentaje de transferencia al FIISD establecido en el presente inciso como mínimo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) podrá ser reducido transitoriamente por el Directorio del INSSJP–PAMI, con aprobación de la SSS, cuando el dictamen de la SIGEN acredite que los indicadores de sostenibilidad financiera del Instituto o de calidad prestacional registran deterioro respecto del ejercicio anterior. La reducción no podrá exceder el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del mínimo legal y tendrá vigencia máxima de UN (1) ejercicio fiscal, debiendo regularizarse en el ejercicio siguiente.

En ningún caso la digitalización implicará reducción de personal, garantizándose la reconversión de funciones conforme a la presente ley. El convenio deberá contemplar un Plan de Reconversión de Funciones, elaborado con participación de las organizaciones gremiales representativas del personal del INSSJP, con cronograma de capacitación y reasignación de tareas. El incumplimiento del Plan de Reconversión suspende automáticamente la obligación de transferencia al FIISD hasta su regularización.

e. Asignación Específica para Inteligencia Artificial.

Del total de los recursos del Fondo de Inversión Inicial (FIISD), se destinará una partida específica y protegida para el financiamiento operativo del Registro Nacional de Módulos de IA (RENIA-Salud), el funcionamiento del Comité Ético Nacional y la auditoría continua de algoritmos, garantizando que la supervisión tecnológica cuente con recursos independientes.

El Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., a propuesta del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial, podrá actualizar mediante resolución fundada los estándares técnicos aplicables a los módulos de IA financiados con recursos del FIISD, cuando la evolución del estado del arte así lo requiera, sin necesidad de modificación de la presente ley, siempre que los estándares actualizados garanticen un nivel de protección del paciente equivalente o superior al vigente. Toda actualización deberá ser comunicada a la Comisión Bicameral de Seguimiento dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su publicación.

f. Mecanismos de Sostén para Prestadores.

Para garantizar la inclusión digital, se instruirá a la banca pública nacional a crear líneas de crédito específicas y accesibles para la adquisición de software certificado y hardware necesario. La Autoridad de Aplicación proveerá asistencia técnica no monetaria para minimizar estos costos.

g. Subcuenta de Compensación por Interoperabilidad Mínima.

Créase dentro del Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD) una Subcuenta de Compensación por Interoperabilidad Mínima, destinada exclusivamente a:

Cubrir los costos técnicos derivados del cumplimiento de la obligación de portabilidad establecida en el Artículo 3° BIS respecto de jurisdicciones no adherentes al Régimen B.

Financiar la provisión gratuita de herramientas de interoperabilidad, componentes de software, asistencia técnica y servicios de implementación mínima necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en el Régimen C.

La utilización de esta subcuenta no implicará transferencia automática de recursos a las jurisdicciones no adherentes, sino cobertura directa de los costos técnicos mediante provisión federal de soluciones tecnológicas, soporte y servicios. La afectación de recursos a esta subcuenta se realizará conforme la disponibilidad presupuestaria anual y sin afectar recursos coparticipables.

h. Orden de Prelación entre Fuentes del FIISD.

En caso de insuficiencia del FIISD para cubrir la totalidad de las obligaciones del ejercicio, la Autoridad de Aplicación aplicará los recursos disponibles conforme el siguiente orden de prelación:

Obligaciones de la Subcuenta de Compensación por Interoperabilidad Mínima.

Gastos operativos esenciales de la UESC y del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

Partida específica para RENIA-Salud, Comité Ético Nacional y auditoría de algoritmos.

Financiamiento de efectores en cronograma activo del ejercicio (fórmula Artículo 35 TER inciso b).

Ciberseguridad, mantenimiento y actualizaciones críticas.

Aportaciones al Fondo Federal de Equidad Sanitaria (FFES).

Equipamiento y conectividad adicional fuera del cronograma activo.

El incumplimiento del orden de prelación por parte de la Autoridad de Aplicación habilitará la intervención de la SIGEN y la comunicación a las Comisiones competentes del Congreso de la Nación dentro de los CINCO (5) días hábiles.

Cuando los recursos disponibles del FIISD resulten insuficientes para atender simultáneamente todas las obligaciones del orden de prelación, la Autoridad de Aplicación podrá, mediante resolución fundada comunicada al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. y a la SIGEN, aplicar los recursos disponibles cubriendo íntegramente las obligaciones de los puntos 1) a 3) y distribuyendo proporcionalmente los recursos remanentes entre las obligaciones de los puntos 4) a 7), respetando el orden jerárquico entre ellas. Esta asignación proporcional no constituirá incumplimiento de la presente ley cuando se acredite la insuficiencia objetiva de recursos y se comunique con la debida antelación a los organismos de control y a los afectados.

i. Transparencia.

La Autoridad de Aplicación publicará trimestralmente en el portal oficial el detalle de la ejecución del FIISD, las métricas de ahorro y el cumplimiento del principio de máxima

eficiencia presupuestaria. La información deberá estar disponible en formatos abiertos, reutilizables y con desagregación por fuente de financiamiento, destino, ejecución presupuestaria y resultados obtenidos. Dicha información estará sujeta a auditoría anual por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y control externo de la Auditoría General de la Nación (AGN).

ARTÍCULO 35 BIS.- Ejecución Presupuestaria Progresiva y Responsabilidad Fiscal.

Las obligaciones de carácter financiero, tecnológico, de asistencia técnica, equipamiento o subsidio previstas en la presente ley se ejecutarán de manera progresiva y conforme:

a) La disponibilidad presupuestaria anual asignada al Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD).
b) Las partidas aprobadas en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.
c) El cronograma federal de implementación aprobado por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

La presente ley no generará derecho subjetivo automático a transferencias económicas individuales ni a financiamiento inmediato fuera de las fases certificadas y habilitadas conforme el régimen de implementación progresiva establecido.

La ejecución financiera deberá respetar el principio de sostenibilidad fiscal, sin comprometer la continuidad de las funciones esenciales del sistema de salud.

En caso de conflicto interpretativo entre el presente artículo y disposiciones específicas de esta ley que establezcan derechos concretos con determinación suficiente de requisitos, alcance y condiciones de percepción —incluyendo, en su caso, lo previsto en el Artículo 43 QUINQUIES— prevalecerá la norma específica.

La limitación referida a la inexistencia de derecho subjetivo automático establecida en el presente artículo será aplicable exclusivamente a beneficios programáticos, subsidios, asistencias o transferencias cuya cuantía, condiciones de acceso o cronograma dependan de reglamentación, disponibilidad presupuestaria o certificación de fases de implementación.

ARTÍCULO 35 TER.- Condición de operatividad presupuestaria y garantía de asignación mínima.

a) Condición de exigibilidad de obligaciones y sanciones.

Las obligaciones de integración, carga de datos y adecuación tecnológica impuestas a los prestadores de salud por la presente ley, así como las sanciones previstas en el Artículo 44 por incumplimiento de dichas obligaciones, solo serán exigibles respecto de un efector determinado cuando se verifiquen conjuntamente las siguientes condiciones:

1) Condición presupuestaria: que el Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD) cuente con crédito presupuestario aprobado en la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, o que exista reasignación presupuestaria efectivamente ejecutada conforme el Artículo 35.

2) Condición infraestructural: que la Autoridad de Aplicación haya certificado, mediante resolución fundada y publicada en el Boletín Oficial, que la infraestructura técnica del Sistema C.U.R.A. se encuentra operativa y disponible en la jurisdicción del efector obligado, con conectividad suficiente, plataforma de carga habilitada y soporte técnico activo.

3) Condición de capacitación: que el efector haya tenido acceso efectivo al programa de capacitación previsto en el Artículo 34 con una antelación mínima de NOVENTA (90) días corridos al inicio del período de exigibilidad.

La Autoridad de Aplicación publicará, con actualización trimestral, un mapa federal de operatividad que identifique, por efector y por jurisdicción, el estado de cumplimiento de las condiciones precedentes.

b) Garantía de asignación mínima en la Ley de Presupuesto.
El Poder Ejecutivo Nacional deberá incluir en el Proyecto de Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal siguiente a la promulgación de la presente ley, y en cada ejercicio fiscal subsiguiente hasta la implementación completa del sistema conforme el cronograma del Artículo 14, una asignación específica destinada al FIISD que no podrá ser inferior al monto resultante de la fórmula:

Asignación mínima = [Número de efectores en cronograma del ejercicio]
x [Costo estándar por efector certificado por la UESC]

El costo estándar por efector será determinado por la UESC dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de reglamentada la presente ley, con metodología auditada por la SIGEN, y actualizado anualmente conforme el índice de precios de tecnología del INDEC o el que lo reemplace.

c) Consecuencias del incumplimiento presupuestario del Estado.
Si la asignación presupuestaria del FIISD resultare inferior al mínimo calculado conforme el inciso b):

1) La Autoridad de Aplicación deberá ajustar el cronograma de implementación del

Artículo 14 a los efectores efectivamente financiados, comunicando la modificación al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. y al Congreso de la Nación dentro de los TREINTA (30) días.

2) Las sanciones del Artículo 44 quedan automáticamente suspendidas respecto de los efectores excluidos del cronograma ajustado.

3) El déficit presupuestario no exime al Estado Nacional de su obligación de implementar el sistema: la omisión habilita a los prestadores y a los ciudadanos a exigir judicialmente el cumplimiento de las obligaciones estatales previstas en la presente ley.

d) Compatibilidad con la Ley 24.156.
Las disposiciones de la presente ley no habilitan compromisos de gasto que excedan los créditos presupuestarios vigentes. Todo contrato, convenio o compromiso que implique erogaciones con cargo al FIISD será nulo si al momento de su celebración no existiere crédito presupuestario disponible y suficiente conforme los Artículos 15 y 34 de la Ley 24.156.

ARTÍCULO 35 QUATER.- Fuentes complementarias de financiamiento de base nacional.

a) Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), en el marco de la Ley N° 23.877, lanzarán, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la promulgación, convocatorias específicas denominadas 'Módulos C.U.R.A. — Innovación Sanitaria Digital' destinadas a financiar mediante Aportes No Reembolsables (ANR) y créditos a tasa subsidiada el desarrollo de módulos tecnológicos del Sistema C.U.R.A. que hayan sido identificados como prioritarios en el cronograma oficial. Las convocatorias serán diseñadas en coordinación entre la Autoridad de Aplicación, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Todo módulo financiado bajo esta modalidad deberá cumplir las condiciones de licencia estatal perpetua, no exclusiva e irrevocable establecidas en el Artículo 37 inciso d) numeral 3) de la presente ley. Los recursos correspondientes a contratos de servicios o bienes que el sistema reciba en el marco de estas convocatorias se integrarán al FIISD. No implican transferencia de datos personales de salud y no constituyen tributo ni carga financiera para los participantes.

b) Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

La Autoridad de Aplicación, en coordinación con el Ministerio de Economía, habilitará, mediante resolución conjunta dictada dentro de los NOVENTA (90) días corridos de la promulgación, la calificación de los desarrollos de módulos del Sistema C.U.R.A. como actividad elegible a los efectos del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento

(Ley N° 27.635) para las empresas del sector de tecnología sanitaria que soliciten inscripción o mantenimiento en el Registro Nacional de Beneficiarios. La habilitación requerirá validación técnica del Subcomité de Estándares e Interoperabilidad del Sistema C.U.R.A. sobre la conformidad del módulo con los estándares HL7 FHIR R4, SNOMED CT y LOINC adoptados por el sistema. Esta habilitación no modifica el universo de actividades elegibles de la Ley N° 27.635 ni crea obligación de gasto adicional para el Estado.

c) Fondos de Modernización del Estado y Transformación Digital.

El Ministerio de Salud, en coordinación con la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, podrá celebrar convenios de cooperación interministerial para la reasignación de partidas presupuestarias correspondientes a programas de modernización del Estado y transformación digital de organismos nacionales cuyas funcionalidades sean absorbidas y superadas por el Sistema C.U.R.A., conforme el régimen del Artículo 37 de la Ley N° 24.156. Los convenios deberán: (i) indicar específicamente las funcionalidades absorbidas y la fecha de absorción certificada por la UESC; (ii) ser notificados a las Comisiones de Salud y de Presupuesto de ambas Cámaras del Congreso dentro de los TREINTA (30) días de su suscripción; (iii) no afectar funciones esenciales cuya población beneficiaria supere CINCUENTA MIL (50.000) personas.

d) Instrumentos de Financiamiento Tecnológico — Mercado de Capitales.

La Autoridad de Aplicación, con dictamen previo del Ministerio de Economía, podrá emitir Títulos de Inversión en Salud Digital (TISD), valores negociables en el mercado de capitales regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), con las siguientes características: (i) plazo de hasta DIEZ (10) años; (ii) rendimiento vinculado a indicadores auditados de ahorro sistémico certificado por la SIGEN; (iii) afectación de los fondos captados exclusivamente al FIISD; (iv) garantía subordinada del Tesoro Nacional limitada al crédito presupuestario específicamente autorizado en la Ley de Presupuesto del ejercicio de emisión, sin que la garantía pueda exceder dicho crédito. La emisión requiere: autorización en la Ley de Presupuesto correspondiente; dictamen técnico-financiero de la Secretaría de Finanzas; y aprobación del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. No generan deuda soberana garantizada por el Estado en sentido pleno; la garantía subordinada opera solo si la SIGEN certifica ahorros netos insuficientes para el pago del servicio de deuda en el ejercicio. La CNV reglamentará el régimen de emisión dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la promulgación.

ARTÍCULO 35 QUINQUIES.- Cooperación técnica internacional no reembolsable.

La Autoridad de Aplicación, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, queda específicamente autorizada para celebrar acuerdos de cooperación técnica no reembolsable con los siguientes organismos internacionales y agencias, en el marco

de los programas vigentes de cada institución:

1) Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en el marco del Plan de Acción de Salud Digital para las Américas CD57/10 y los planes que lo sucedan.
2) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Área de Práctica de Gobierno Digital y del Acelerador de ODS.
3) Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el marco del programa de salud digital y conectividad sanitaria.
4) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) — División de Salud, para asistencia técnica no reembolsable y proyectos de preparación (profiling) de operaciones.
5) Corporación Andina de Fomento (CAF) — Programa de Transformación Digital.
6) Agencias de cooperación bilateral (AECID, GIZ, USAID, JICA, France Coopération) con programas activos de salud digital o gobierno electrónico.

Los acuerdos de cooperación técnica podrán incluir: (a) asistencia técnica para el diseño e implementación de estándares de interoperabilidad y ciberseguridad; (b) financiamiento de proyectos piloto territoriales de salud digital; (c) capacitación de recursos humanos especializados en el exterior; (d) validación y certificación de módulos del sistema por organismos de referencia internacional; (e) participación en redes internacionales de innovación en salud digital.

Los acuerdos de cooperación técnica no generan deuda soberana, no implican transferencia de datos personales identificables de pacientes ni de profesionales, y no crean obligaciones tributarias para los organismos cooperantes. Los recursos obtenidos en especie, software o capacidades técnicas se reflejarán contablemente en el FIISD como activos intangibles o donaciones en especie, conforme las normas de contabilidad gubernamental vigentes. Los recursos en dinero se acreditarán directamente al FIISD conforme el régimen de la Ley N° 24.156. Todos los acuerdos deberán publicarse íntegramente en el portal oficial del Sistema C.U.R.A. dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su suscripción.

ARTÍCULO 35 SEXIES.- Aportes privados complementarios no distorsivos.

a) Donaciones de entidades sin fines de lucro y fundaciones institucionales.

Las fundaciones, asociaciones civiles y organismos internacionales con fines de desarrollo podrán realizar donaciones al FIISD o al FFES, en dinero o en especie, conforme el régimen de la Ley N° 24.156 y las normas de control de lavado de activos vigentes. Previo a la aceptación de toda donación de valor superior al equivalente de QUINIENTAS (500) Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), la Autoridad de Aplicación deberá: (i) publicar las condiciones ofrecidas por el donante en el portal oficial; (ii) obtener dictamen de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) sobre la compatibilidad de las condiciones de la donación con la Ley N° 25.326 y las disposiciones de soberanía de datos de la presente ley; (iii) verificar que las condiciones no impliquen, directa ni indirectamente, acceso, uso,

análisis, monetización ni comercialización de datos de salud identificados, identificables o anonimizados.

Las donaciones cuyas condiciones no superen el examen del inciso precedente serán rechazadas. Las donaciones que superen el examen no implican ningún derecho del donante sobre el sistema, sus datos, sus módulos ni sus desarrollos.

b) Aportes de universidades nacionales y centros de investigación públicos.

Las universidades nacionales y los organismos del sistema científico y tecnológico nacional (CONICET, INTA, INTI y equivalentes) podrán realizar aportes en especie al Sistema C.U.R.A. mediante: (i) provisión de recursos humanos especializados por períodos de hasta DOS (2) años, mediante comisión de servicios o acuerdo de cooperación sin transferencia de fondos conforme el Artículo 12; (ii) desarrollo de módulos tecnológicos no críticos en el marco de contratos de investigación y desarrollo sin explotación exclusiva; (iii) validación clínica y técnica de algoritmos de inteligencia artificial, con publicación de los informes de validación. Los aportes en especie se contabilizarán en el FIISD conforme las normas de contabilidad gubernamental. No crean obligaciones salariales adicionales para la UESC.

c) Instrumentos excluidos.

No son admisibles como fuentes de financiamiento del Sistema C.U.R.A., en ninguna modalidad ni denominación: (1) cualquier mecanismo que implique la entrega, licencia, cesión, acceso controlado, análisis o monetización de datos de salud individuales o de bases de datos anonimizadas como contraprestación o condición de financiamiento; (2) Bonos de Impacto Social (Social Impact Bonds — SIBs) cuyas métricas de resultado involucren datos individuales de pacientes identificables o identificables; (3) contratos de préstamo, patrocinio o cooperación que incluyan cláusulas de exclusividad tecnológica, renuncia a estándares abiertos o dependencia tecnológica permanente de un proveedor. Los actos que violen estas exclusiones son nulos de nulidad absoluta.

ARTÍCULO 36.- Registro y validación continua de profesionales.

Alta inicial.

El profesional de la salud se registrará en el Sistema C.U.R.A. mediante autenticación con Mi Argentina, Mi AFIP o Mi ANSES, vinculando su CUIT/CUIL y su matrícula profesional con los registros nacionales y/o provinciales correspondientes.

Revalidación automática diaria.

El Sistema C.U.R.A. ejecutará, al menos una vez cada veinticuatro (24) horas, una verificación automática de la vigencia de la matrícula y habilitación profesional ante los registros competentes.

Esta verificación se realizará de manera silenciosa y sin requerir acción del usuario, garantizando la continuidad del servicio y la integridad del registro.

Bloqueo preventivo.

Si la verificación indicare vencimiento, suspensión o inhabilitación, el sistema procederá a un bloqueo preventivo automático del acceso de carga del profesional, dejando constancia en el registro de auditoría e informando de manera simultánea al titular de la cuenta y al establecimiento sanitario de pertenencia.

El profesional contará con un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas corridas para acreditar ante el sistema la regularidad de su matrícula mediante constancia digital emitida por la autoridad competente.

Durante dicho plazo, conservará acceso en modo lectura al sistema y podrá visualizar su actividad registrada, sin facultad de carga o firma digital.

Transcurrido dicho plazo sin acreditación suficiente, el bloqueo adquirirá carácter definitivo hasta regularización.

Cierre de sesión forzoso.

Toda sesión profesional tendrá un tiempo máximo de vida de veinticuatro (24)

horas y un cierre automático por inactividad de diez (10) minutos, requiriéndose nueva autenticación para continuar.

La Autoridad de Aplicación podrá establecer, por resolución fundada, plazos menores en entornos de alto riesgo o en terminales de acceso compartido.

Gestión Inteligente de la Sesión.

Toda sesión profesional tendrá un cierre automático por inactividad superior a diez(10) minutos. No obstante, el sistema implementará un mecanismo de "Cierre de Sesión Inteligente" que:

Pausará el temporizador de inactividad durante la interacción activa del usuario, como la edición de campos de texto.

Emitirá una advertencia visual no intrusiva antes del cierre, permitiendo al usuario extender la sesión.

En coordinación con la funcionalidad de operación con conectividad intermitente, garantizará que el trabajo en curso quede guardado

automáticamente antes de cualquier cierre de sesión, pudiendo ser recuperado por el usuario al re-autenticarse.

Trazabilidad.

Toda acción relacionada con el acceso profesional ---alta, validación, bloqueo, reactivación o cierre--- quedará registrada automáticamente con fecha, hora, identificadores de sistema y fuente del padrón consultada, conforme lo dispuesto por el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría (Artículo 10).

Reclamo y reactivación.

El profesional podrá iniciar un trámite digital de revisión adjuntando la constancia de regularización ante la entidad competente.

Verificada la vigencia de la matrícula, el sistema reactivará automáticamente el acceso y dejará constancia en el registro de auditoría.

Desbloqueo excepcional en contexto asistencial crítico.

Cuando el bloqueo preventivo se produzca durante el ejercicio efectivo de funciones asistenciales en guardia, emergencia o prestación crítica, el establecimiento sanitario podrá solicitar habilitación temporal extraordinaria por un plazo máximo de DOCE (12) horas, mediante procedimiento digital simplificado con validación institucional.

Dicha habilitación excepcional no exime al profesional de acreditar la vigencia de su matrícula dentro del plazo general establecido, y quedará sujeta a auditoría posterior obligatoria por parte de la Autoridad de Aplicación.

Alcance.

La autenticación y validación previstas en este artículo serán requisito indispensable para cargar, firmar o acceder a información clínica bajo perfil profesional.

ARTÍCULO 37.- Régimen de mecenazgo, inversión privada y alianzas estratégicas.

a) Objeto.
   Créase el "Régimen de Fomento a la Inversión Privada en Salud Digital", con el objeto de canalizar recursos del sector privado hacia el desarrollo, infraestructura, innovación tecnológica y sostenibilidad del Sistema C.U.R.A., mediante mecanismos de patrocinio, mecenazgo, alianzas estratégicas y desarrollo de módulos tecnológicos. El presente régimen se fundamenta en razones de interés público sanitario estratégico, fortalecimiento del sistema de salud y desarrollo científico-tecnológico nacional.

b) Programa de Padrinazgo Tecnológico.
   Facúltase a la Autoridad de Aplicación a crear el Programa de Padrinazgo, mediante el cual personas jurídicas privadas podrán financiar la actualización tecnológica,

conectividad o equipamiento de establecimientos de salud públicos específicos.

A cambio, obtendrán:

1) Beneficios Fiscales: El monto efectivamente erogado en el marco del Programa de Padrinazgo Tecnológico será deducible del Impuesto a las Ganancias conforme el régimen del Artículo 81 bis de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificatorias, incorporado por la presente ley en el artículo 37 TER. Los límites, condiciones, cupo fiscal, procedimiento de certificación y restricciones aplicables son los establecidos en dicho artículo, cuya reglamentación estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en coordinación con la Autoridad de Aplicación del Sistema C.U.R.A.

2) Reconocimiento Institucional: El derecho a la mención pública, colocación de placas en el establecimiento beneficiado y uso del sello "Empresa Protectora de la Salud Pública" en sus comunicaciones corporativas, conforme lineamientos que establezca la reglamentación.

c) Integración de Salud Corporativa

Las empresas que posean servicios médicos laborales propios podrán solicitar la integración de sus sistemas de gestión al Sistema C.U.R.A. exclusivamente para la validación digital automática de certificados y licencias médicas emitidos conforme normativa vigente.

Dicha integración estará sujeta al pago de una contraprestación económica de naturaleza contractual administrativa por los servicios tecnológicos efectivamente prestados, la cual no tendrá carácter tributario ni constituirá tasa, impuesto o contribución, sino precio público por servicio específico de validación digital.

La integración se limitará estrictamente a:

1) Validación de autenticidad del certificado médico.
2) Verificación de vigencia de la matrícula profesional emisora.
3) Constatación de existencia formal del documento.

En ningún caso implicará acceso a diagnósticos, antecedentes clínicos, historia médica completa ni categorías de datos sensibles del trabajador.

Los recursos provenientes de dicha contraprestación se acreditarán al Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD).

d) Alianzas de Investigación y Desarrollo (I+D). La Autoridad de Aplicación podrá celebrar Acuerdos de Alianza Estratégica con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, exclusivamente para el desarrollo, entrenamiento, validación, mejora o implementación de módulos tecnológicos del Sistema C.U.R.A.

1) Serán elegibles:

   i) Módulos expresamente previstos en el cronograma oficial conforme Disposición Transitoria Vigésimo Quinta y Artículo 23.

   ii) Módulos adicionales no previstos en el cronograma, siempre que:demuestren utilidad sanitaria estratégica; no generen incompatibilidad con la arquitectura adicional; no impliquen obligación de financiamiento estatal adicional; y cumplan con las condiciones de integración, licencia estatal y auditoria previstas en el presente artículo.
   Los módulos prioritarios definidos en el cronograma oficial tendrán preferencia en la asignación de cupo fiscal y evaluación de elegibilidad.

2) Acceso a datos anonimizados
   El acceso al Repositorio Nacional previsto en el Artículo 67 BIS:

   i) No implicará cesión de titularidad ni derechos exclusivos sobre los datos.

   ii) Se realizará únicamente en entornos controlados y auditables.

   iii) No podrá dar lugar a extracción masiva de bases completas.

   iv) No generará derecho preferencial de acceso futuro por el solo hecho del aporte económico.

3) Condiciones obligatorias de desarrollo
   Todo módulo desarrollado en el marco del presente régimen deberá:

   i) Integrarse obligatoriamente al Sistema C.U.R.A. una vez validado técnicamente.

   ii) Otorgar al Estado argentino licencia gratuita, perpetua, irrevocable y no exclusiva para su uso en el territorio nacional.

   iii) Garantizar prioridad operativa y mantenimiento para el sistema sanitario argentino.

   iv) Permitir auditoría técnica completa del código y modelos por el Subcomité Técnico de Ética e Inteligencia Artificial en Salud.

   v) No impedir la interoperabilidad ni la evolución futura del sistema.

   vi) No generar dependencia tecnológica exclusiva.

Ningún módulo crítico del Sistema C.U.R.A. podrá implementarse bajo condiciones contractuales o técnicas que impidan su sustitución razonable por otro proveedor interoperable, debiendo garantizarse arquitectura abierta y documentación técnica suficiente para su eventual reemplazo.

4) Explotación internacional
Los desarrolladores podrán explotar comercialmente versiones derivadas fuera del territorio nacional, siempre que:

i) No impliquen transferencia de datos argentinos.

ii) No reproduzcan datasets anonimizados originales.

iii) No restrinjan el uso gratuito y permanente en la República Argentina.

5) Categoría "Socio Tecnológico Fundador"
Créase la categoría de "Socio Tecnológico Fundador" para entidades que realicen aportes estratégicos dentro de los primeros VEINTICUATRO (24) meses desde la entrada en vigencia del régimen.

Dicha condición otorgará:

i) Participación en instancias consultivas técnicas no decisorias.

ii) Derecho preferente a presentar propuestas en convocatorias iniciales.

iii) Acceso prioritario al Sandbox Nacional de IA en Salud.

iv) Posibilidad de celebrar acuerdos marco plurianuales.

La condición no implicará exclusividad ni derechos exclusivos sobre datos o módulos.

6) Naturaleza contractual y estabilidad regulatoria
Los acuerdos estratégicos celebrados en el marco del presente artículo tendrán naturaleza contractual administrativa. No podrán ser modificados unilateralmente en sus condiciones esenciales sin causa debidamente fundada ni sin respetar el equilibrio económico del acuerdo. Las modificaciones normativas posteriores no afectarán derechos adquiridos conforme contratos vigentes, salvo normas de orden público sanitario o protección de datos. Las condiciones esenciales de acceso a datos anonimizados, licenciamiento, integración y beneficios fiscales no podrán alterarse con efecto retroactivo respecto de proyectos aprobados durante un plazo mínimo de CINCO (5) años.

7) Gobernanza técnica
El Subcomité Técnico de Ética e Inteligencia Artificial en Salud ejercerá sus funciones con independencia técnica y publicará criterios objetivos de evaluación, garantizando transparencia y previsibilidad regulatoria.

8) Calidad de datos
La Autoridad de Aplicación implementará un Programa Nacional de Calidad de Datos Sanitarios con métricas públicas, auditoría periódica y publicación semestral de indicadores de completitud, consistencia e interoperabilidad.

e) Destino de los Recursos: Los recursos provenientes de estas alianzas se destinarán con prioridad al Fondo de Inversión Inicial (FIISD) del Artículo 35 y a programas específicos de formación de talento en bioinformática e IA en salud.

f) Condiciones Irrenunciables: Estos acuerdos se celebrarán bajo el estricto cumplimiento de

todas las condiciones de soberanía de datos, propiedad intelectual estatal y prohibición de re-identificación establecidas en el Artículo 67 BIS.

g) Transparencia. La Autoridad de Aplicación publicará anualmente en el portal oficial un informe detallado que incluya:

1) Monto total de inversión captada mediante los mecanismos del presente artículo (Padrinazgo, Cánones y Alianzas I+D);
2) Proyectos específicos financiados;
3) Beneficiarios institucionales;
4) Estado de ejecución y auditorías realizadas.

La información deberá presentarse en formato abierto y accesible, garantizando la transparencia integral de la gestión.

ARTÍCULO 37 BIS.- Sandbox Nacional de Inteligencia Artificial en Salud

Créase el Sandbox Nacional de Inteligencia Artificial en Salud como entorno regulado, controlado, auditado y de acceso competitivo destinado al desarrollo, entrenamiento, validación y prueba de módulos tecnológicos aplicables al Sistema C.U.R.A..

El presente régimen y el tratamiento de datos anonimizados en su marco se fundan en razones de interés público sanitario estratégico, desarrollo científico nacional, mejora estructural del sistema de salud y protección colectiva de la población, conforme los artículos 42 y 75 inciso 18 de la Constitución Nacional y la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

El Sandbox tendrá carácter estratégico, de infraestructura sanitaria digital crítica y competitividad internacional, orientado a fomentar la inversión privada y la innovación tecnológica bajo principios de soberanía digital inteligente, seguridad jurídica y arquitectura abierta.

Asimismo, el Estado promoverá la integración del Sandbox con redes internacionales de innovación en salud digital, favoreciendo la validación cruzada y la proyección global de los desarrollos generados, sin comprometer la soberanía de datos.

a) Principios Rectores
El funcionamiento del Sandbox se regirá por los siguientes principios:

1) Soberanía de datos.
Los datos anonimizados utilizados permanecerán bajo jurisdicción argentina y no

podrán ser descargados, transferidos ni reproducidos fuera del entorno técnico autorizado.

2) Bien público no transferible.
Los datasets anonimizados constituyen activo estratégico del Estado y no podrán ser objeto de cesión, venta, transferencia de titularidad ni exclusividad contractual.

3) Definición técnica de anonimización.
A los efectos del presente artículo, se entenderá por datos anonimizados aquellos registros clínicos estructurados que hayan sido sometidos a procesos técnicos irreversibles de supresión, disociación o transformación que eliminen identificadores directos y reduzcan el riesgo de re-identificación por medios razonables.
Se considerarán identificadores directos, entre otros: nombre y apellido, número de documento, CUIL, domicilio exacto, teléfono, correo electrónico, número de afiliado, identificadores biométricos y cualquier otro dato que permita la identificación directa de la persona.
Podrán conservarse variables clínicas, demográficas y territoriales agregadas o generalizadas —incluyendo localidad o región sanitaria— siempre que no permitan la identificación individual razonable conforme evaluación técnica periódica.
La anonimización deberá aplicarse mediante metodologías combinadas que incluyan, cuando corresponda, técnicas de supresión de identificadores directos, generalización de variables sensibles, agregación territorial proporcional al riesgo, mecanismos de k-anonymity, diversidad de atributos sensibles, privacidad diferencial u otras metodologías equivalentes reconocidas internacionalmente, asegurando la reducción razonable y verificable del riesgo de re-identificación.La conservación de variables territoriales deberá realizarse bajo criterios de minimización de riesgo, pudiendo aplicarse agrupación por región sanitaria cuando el tamaño poblacional o la singularidad del evento clínico así lo requieran.

Una vez aplicados los procesos técnicos de anonimización irreversibles previstos en el presente artículo y evaluado el riesgo residual conforme estándares técnicos auditables, los datos podrán ser utilizados bajo el presente régimen en tanto no resulte razonablemente posible la re-identificación por medios técnicos disponibles al momento de su evaluación, conforme la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

4) Acceso controlado y auditado.
El acceso se otorgará exclusivamente por proyecto aprobado, bajo entornos seguros, con registro integral de accesos, trazabilidad técnica y monitoreo permanente.

5) Evaluación de riesgo de re-identificación.
Todo acceso estará sujeto a evaluación previa de riesgo de re-identificación y monitoreo continuo. El intento de re-identificación implicará rescisión inmediata del acuerdo, inhabilitación permanente para participar del régimen y las sanciones administrativas y penales correspondientes.

6) Prohibición de uso discriminatorio.
Queda expresamente prohibido el uso de datos anonimizados del Sandbox, así como de modelos entrenados en dicho entorno, para el desarrollo de sistemas de scoring individual sanitario, fijación de primas de seguros de salud o vida, evaluación actuarial individual, segmentación discriminatoria de cobertura, o cualquier mecanismo que implique discriminación basada en condiciones de salud, dentro o fuera del territorio nacional.

7) Auditoria independiente del proceso de anonimización.
El proceso de anonimización y evaluación de riesgo será auditado periódicamente por organismo técnico independiente o por la autoridad nacional de protección de datos cuando corresponda.
Cuando el acceso al Sandbox tenga fines comerciales o implique explotación económica posterior de los desarrollos obtenidos, la aprobación del proyecto requerirá dictamen técnico previo y vinculante de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) respecto del proceso de anonimización aplicado y de la evaluación de riesgo de re-identificación, conforme la Ley N° 25.326 y normativa complementaria.

8) No exclusividad.
La participación en el Sandbox no generará derecho exclusivo ni preferente sobre datos futuros ni sobre otros desarrollos del sistema.

9) Interoperabilidad obligatoria.
Todo desarrollo deberá cumplir estándares abiertos, documentar interfaces y permitir integración modular sin dependencia tecnológica exclusiva.

10) Arquitectura sustituible.
Ningún módulo crítico del Sistema C.U.R.A. podrá implementarse bajo condiciones que impidan su reemplazo razonable por otra solución interoperable.

11) Licencia estatal perpetua.
Todo módulo validado otorgará al Estado argentino licencia gratuita, perpetua, irrevocable y no exclusiva para su uso en el territorio nacional.

12) Estabilidad regulatoria mínima.

Las condiciones esenciales de acceso, licencia estatal y explotación internacional establecidas en el presente artículo no podrán ser alteradas con efecto retroactivo respecto de proyectos ya aprobados.

Los datasets incorporados al Sandbox deberán cumplir estándares mínimos de calidad, completitud y normalización semántica conforme los estándares HL7 FHIR, SNOMED CT y demás nomenclaturas oficiales adoptadas por el Sistema C.U.R.A., con auditoría técnica periódica.

b) Procedimiento Acelerado de Evaluación
La Autoridad de Aplicación deberá resolver la admisión o rechazo de proyectos presentados al Sandbox en un plazo máximo de NOVENTA (90) días corridos desde la presentación formal completa.

El silencio administrativo vencido dicho plazo se considerará rechazo fundado por razones técnicas no subsanadas.

El procedimiento acelerado no implicará reducción de exigencias éticas, técnicas ni de seguridad.

Los desarrolladores que validen módulos prioritarios durante los primeros VEINTICUATRO (24) meses desde la entrada en vigencia del Sandbox podrán acceder a entornos ampliados de entrenamiento supervisado y evaluación clínica avanzada antes de la apertura general del módulo al resto del mercado.

Asimismo, los desarrolladores estratégicos que participen desde la fase inicial del Sandbox y mantengan cumplimiento sostenido de estándares técnicos y éticos podrán acceder de manera progresiva a los datasets anonimizados que se incorporen al Sistema C.U.R.A., conforme su disponibilidad efectiva y validación técnica.

c) Igualdad de Acceso
El acceso al Sandbox y a los proyectos de I+D se realizará mediante convocatorias públicas, criterios objetivos y evaluación técnica fundada, garantizando igualdad de oportunidades entre los interesados y evitando cualquier forma de favoritismo o asignación discrecional.

d) Convocatorias Temáticas y Roadmap Tecnológico
La Autoridad de Aplicación publicará anualmente:

1) Convocatorias temáticas estratégicas.
2) Prioridades tecnológicas sanitarias.
3) Desafíos específicos del sistema.
4) Módulos prioritarios conforme el cronograma oficial.
5) Requerimientos técnicos mínimos.

Asimismo, deberá publicar y actualizar el Roadmap Oficial de Desarrollo Tecnológico del Sistema C.U.R.A., otorgando previsibilidad regulatoria y horizonte de planificación para inversores.
Los módulos prioritarios desarrollados y validados en el marco del Sandbox podrán ser considerados para implementación piloto preferente dentro del cronograma oficial del Sistema C.U.R.A

El Estado garantizará que los datasets anonimizados generados conforme el cronograma de implementación territorial y tecnológica del Sistema C.U.R.A., una vez superados los hitos previstos en la presente ley, serán incorporados progresivamente al entorno del Sandbox bajo criterios técnicos objetivos, auditables y no discriminatorios.

e) Incentivos Estratégicos
Las entidades que desarrollen proyectos en el marco del Sandbox podrán acceder a:

1) Beneficio fiscal conforme el Artículo 37, sujeto a cupo anual aprobado por la Ley de Presupuesto y límites individuales.
2) Condición de “Socio Tecnológico Fundador” para quienes inviertan dentro de los primeros VEINTICUATRO (24) meses desde la puesta en funcionamiento del Sandbox.
3) Derecho preferente a presentar propuestas en convocatorias futuras durante TRES (3) años, sin afectar el principio de igualdad de acceso.
4) Acceso prioritario a entornos ampliados de prueba clínica validada.
5) Posibilidad de celebrar acuerdos marco plurianuales.
6) Prioridad técnica progresiva en la asignación de entornos ampliados de entrenamiento cuando el volumen de datos anonimizados supere los umbrales técnicos definidos por la Autoridad de Aplicación, aplicable exclusivamente a quienes hayan adquirido la condición de “Socio Tecnológico Fundador”.

Los incentivos fiscales no generarán obligación automática de gasto público, crédito fiscal transferible ni reintegro, y estarán sujetos al cupo anual aprobado por la Ley de

Presupuesto.

Durante los primeros DOS (2) ejercicios presupuestarios desde la habilitación del Sandbox, el cupo anual de incentivos podrá priorizar proyectos presentados dentro de los primeros DOCE (12) meses.

f) Acuerdos Marco Plurianuales
La Autoridad de Aplicación podrá celebrar acuerdos marco de colaboración tecnológica por plazos de hasta CINCO (5) años con desarrolladores estratégicos que:

1) Hayan validado exitosamente módulos prioritarios.
2) Cumplan estándares éticos, técnicos y de seguridad.
3) Demuestren capacidad sostenida de innovación.

Los acuerdos deberán:

i) Respetar la licencia estatal perpetua.
ii) Garantizar interoperabilidad y sustituibilidad.
iii) No generar dependencia tecnológica exclusiva.
iv) Publicarse íntegramente en el portal oficial.

Los acuerdos celebrados en el marco del Sandbox tendrán naturaleza contractual administrativa con estabilidad mínima de CINCO (5) años respecto de sus condiciones esenciales, salvo razones de orden público sanitario debidamente fundadas.

Los desarrolladores estratégicos podrán participar en mesas técnicas de definición de estándares de estructuración, codificación y calidad de datos, sin que ello implique acceso anticipado a información sensible ni privilegios exclusivos.

g) Explotación Internacional Permitida
Las entidades desarrolladoras podrán explotar comercialmente versiones derivadas fuera del territorio nacional, siempre que:

1) No impliquen transferencia de datos argentinos.
2) No restrinjan el uso gratuito y permanente del módulo en la República Argentina.
3) No reproduzcan datasets anonimizados originales.

El Estado argentino podrá emitir certificación oficial de validación tecnológica del Sistema C.U.R.A. para módulos desarrollados y auditados exitosamente en el Sandbox, a efectos de su proyección internacional.

La licencia estatal perpetua prevista en el presente artículo incluirá el derecho del Estado argentino a requerir auditoría técnica fundada de modelos derivados exportados cuando existan indicios razonables de utilización contraria a los principios de soberanía sanitaria, no discriminación o protección de datos establecidos en la presente ley. El incumplimiento habilitará la revocación de certificaciones oficiales y la rescisión de acuerdos marco vigentes

h) Control Legislativo y Transparencia
La suspensión total del Sandbox o del régimen de alianzas estratégicas requerirá acto administrativo fundado y comunicación inmediata a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema C.U.R.A.

La Autoridad de Aplicación publicará anualmente informe detallado de:

i) Proyectos aprobados.

ii) Inversiones captadas.

iii) Estado de ejecución.

iv) Auditorías realizadas.

v) Resultados obtenidos.

El Estado Nacional responderá conforme el régimen establecido en la Ley N° 26.944 cuando una eventual re-identificación resulte imputable a deficiencias técnicas del proceso de anonimización bajo su control directo. La responsabilidad no se extenderá a conductas dolosas o fraudulentas de terceros que violen las condiciones técnicas y contractuales del Sandbox.

ARTÍCULO 37 TER.- Modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Incorpórase como Artículo 81 bis de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificatorias, el siguiente:

“Artículo 81 bis.- Deducción especial por inversión en el Programa de Padrinazgo Tecnológico del Sistema C.U.R.A.

Los contribuyentes de todas las categorías podrán deducir de la ganancia neta del ejercicio —determinada conforme las disposiciones de la presente ley con anterioridad al cómputo de la presente deducción— el monto efectivamente erogado en concepto de inversiones realizadas en el marco del Programa de Padrinazgo Tecnológico del Sistema C.U.R.A., creado por la ley que instituye el Sistema Federal de Historia Clínica Digital Unificada.

La deducción prevista en el presente artículo tiene carácter de deducción especial autónoma, adicional e independiente de las deducciones admitidas en los Artículos 81 y 87 de la presente ley. Una misma erogación no podrá computarse simultáneamente al amparo del presente artículo y del inciso c) del Artículo 81.

La deducción podrá computarse hasta el CIEN POR CIENTO (100%) del monto efectivamente invertido en el ejercicio fiscal correspondiente. No obstante, el monto total a deducir en cada ejercicio no podrá exceder el CINCO POR CIENTO (5%) de la ganancia neta del ejercicio del contribuyente, calculada con anterioridad al cómputo de la presente deducción y de las deducciones previstas en el inciso c) del Artículo 81.

El beneficio establecido en el presente artículo queda sujeto a las siguientes condiciones:

a) Será aplicable exclusivamente sobre montos efectivamente invertidos y certificados mediante constancia emitida por la Autoridad de Aplicación del Sistema C.U.R.A., en la que conste el establecimiento de salud público beneficiado, la naturaleza de la inversión y el monto certificado. La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento de certificación dentro de los NOVENTA (90) días corridos de la promulgación de la ley que instituye el Sistema C.U.R.A.

b) No generará saldo a favor, crédito fiscal transferible ni reintegro. El excedente no deducido en un ejercicio no es trasladable a ejercicios futuros.

c) Estará sujeto al cupo fiscal anual que establezca la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para cada ejercicio. Para el primer ejercicio fiscal de vigencia, y hasta tanto la Ley de Presupuesto fije el cupo definitivo, regirá un cupo fiscal transitorio equivalente al CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) de la recaudación total del Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal inmediato anterior, conforme la liquidación definitiva publicada por la AFIP. Las solicitudes de certificación se procesarán por estricto orden cronológico de presentación ante la Autoridad de Aplicación del Sistema C.U.R.A. Se reservará el TREINTA POR CIENTO (30%) del cupo para contribuyentes que revistan la condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas conforme la Ley N° 25.300 y sus modificatorias. El cupo no utilizado en cada ejercicio no será acumulable al ejercicio siguiente.

d) No implicará obligación automática de gasto público ni habilitará acción judicial o administrativa por parte del contribuyente ante el agotamiento del cupo fiscal.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) verificará la correcta aplicación fiscal del beneficio conforme la certificación emitida por la Autoridad de Aplicación del Sistema C.U.R.A. y reglamentará los aspectos formales y procedimentales del presente régimen dentro de los NOVENTA (90) días de la promulgación de la ley que instituye el Sistema C.U.R.A., incluyendo la forma de computar la deducción en la declaración jurada anual.”

ARTÍCULO 38.- Cooperación internacional y exportación de conocimiento sanitario digital.

a) Facultades de cooperación internacional.
La Autoridad de Aplicación, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, queda facultada para celebrar convenios de cooperación, asistencia técnica, financiamiento o transferencia tecnológica con:

1) Organismos multilaterales de crédito;
2) Agencias de cooperación internacional;
3) Gobiernos extranjeros;
4) Entidades públicas o privadas con fines de desarrollo;

A los efectos de su encuadre constitucional, los convenios previstos en el presente artículo se clasificarán en:

1) Acuerdos Ejecutivos de Cooperación Técnica, que no impliquen transferencia internacional de datos personales identificables ni compromisos financieros plurianuales a cargo del Estado Nacional, y cuya ejecución podrá realizarse por el Poder Ejecutivo Nacional conforme sus competencias administrativas.

2) Tratados o Acuerdos Internacionales con Compromisos Financieros o Transferencia de Datos, que impliquen obligaciones económicas plurianuales, transferencia tecnológica estructural, cesión de licencias estratégicas del sistema o cualquier forma de circulación internacional de datos personales. En tales casos, requerirán aprobación del Honorable Congreso de la Nación conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional antes de su entrada en vigor.

con el objeto de:

1) Promover la replicación y adaptación del modelo C.U.R.A. en otros países;
2) Obtener financiamiento externo para la ampliación, innovación o mantenimiento del Sistema C.U.R.A.;
3) Exportar servicios de consultoría y asistencia técnica especializada en salud digital.

b) Lineamientos estratégicos.
A los efectos de esta ley, se tendrán especialmente en consideración los lineamientos y

oportunidades de financiamiento detallados en el ANEXO II – "Cooperación Internacional y Financiamiento Externo" de la presente ley.

La celebración de convenios deberá respetar en todo momento:

1) La soberanía nacional sobre los datos sanitarios;
2) La prohibición de transferencia internacional de datos personales identificables, salvo cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de protección de datos;
3) La titularidad estatal sobre los desarrollos estratégicos del Sistema C.U.R.A., salvo acuerdos específicos que no comprometan su control público.
4) La certificación previa por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) respecto de la existencia de nivel adecuado de protección de datos personales en el país receptor, conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 25.326, cuando el convenio prevea cualquier forma de tratamiento o circulación internacional de datos sanitarios.

c) Integración de recursos.
Los ingresos, fondos o bienes resultantes de estos convenios se integrarán:

1) Al Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD);
2) Al Fondo de Autofinanciamiento y Reinversión establecidos en el Artículo 35;

destinándose de manera prioritaria a:

1) Innovación tecnológica;
2) Fortalecimiento de capacidades provinciales;
3) Mantenimiento y actualización del sistema;
4) Desarrollo de infraestructura crítica y ciberseguridad.

b) Transparencia y control parlamentario.
El Poder Ejecutivo informará anualmente al Honorable Congreso de la Nación sobre:

1) Los convenios suscritos;
2) Los aportes financieros captados;

3) Los bienes o servicios recibidos;

4) Los resultados concretos de la cooperación internacional en el marco del Sistema C.U.R.A.

El informe deberá publicarse asimismo en el portal oficial del Sistema C.U.R.A., garantizando acceso público y formato abierto.

Los Acuerdos Ejecutivos de Cooperación Técnica no podrán comprometer erogaciones plurianuales superiores al crédito presupuestario vigente ni generar endeudamiento externo indirecto. Toda obligación financiera que exceda el ejercicio presupuestario en curso requerirá autorización legislativa expresa.

ARTÍCULO 38 BIS.- Perfil de proyecto para organismos multilaterales y gestión activa de créditos.

a) Perfil de proyecto multilateral. Dentro de los SESENTA (60) días corridos de la promulgación de la presente ley, la UESC elaborará un perfil de proyecto técnico del Sistema C.U.R.A. conforme los formatos requeridos por el BID, la CAF y el Banco Mundial para su presentación a las respectivas Divisiones de Salud o de Transformación Digital. El perfil deberá incluir: (i) descripción técnica del sistema, fases y cronograma; (ii) estimación de costos por fase con metodología auditada por la SIGEN; (iii) indicadores de resultado verificables, incluidas metas de cobertura, reducción de duplicaciones y ahorro sistémico; (iv) estructura de gobernanza del sistema; (v) análisis de riesgos técnicos, institucionales y financieros; y (vi) propuesta de contraparte local. El perfil deberá ser aprobado por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. antes de su presentación.

b) Gestión activa. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Economía y la Cancillería, gestionará activamente la obtención del financiamiento multilateral conforme el siguiente cronograma mínimo: (i) presentación formal del perfil ante BID, CAF y BM: dentro de los SESENTA (60) días de la promulgación; (ii) presentación de Documento de Proyecto (DP) completo ante CAF (organismo con proceso más ágil): dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días; (iii) presentación de DP completo ante BID: dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días. El incumplimiento de estos plazos deberá ser informado al Congreso por la SIGEN dentro de los QUINCE (15) días hábiles del vencimiento, con indicación del organismo en mora y las causas.

c) Régimen de los fondos obtenidos. Los fondos obtenidos mediante préstamos multilaterales se incorporarán al FIISD y se administrarán conforme el régimen de la Ley N° 24.156, estando sujetos a: (i) auditoría de la AGN; (ii) control externo del organismo prestamista conforme el

convenio de préstamo; (iii) publicación trimestral de ejecución en el portal oficial del Sistema C.U.R.A. Los contratos de préstamo establecerán, como condición de desembolso, la acreditación de la puesta en operación de la infraestructura ARSAT correspondiente y la certificación del cronograma de implementación por el Consejo Nacional.

d) Fuente de contraparte. La contraparte local de los préstamos multilaterales se financiará con los recursos de reasignación presupuestaria ejecutados conforme el inciso a) del Artículo 35 y con los ingresos del CIES del ejercicio correspondiente, de modo tal que la contraparte no requiera nueva partida presupuestaria del Tesoro Nacional. Si la suma de ambas fuentes resultare insuficiente para cubrir la contraparte mínima exigida por el organismo prestamista, el Poder Ejecutivo deberá incluir la partida adicional necesaria en el proyecto de Ley de Presupuesto del ejercicio siguiente, con comunicación a las Comisiones de Presupuesto del Congreso.

CAPÍTULO 2 - Hub de Interoperabilidad Sanitaria Global

ARTÍCULO 39.- Declaración Estratégica y Modelo de Valor.

Declaración Estratégica: Declárase como política estratégica del Estado Nacional el posicionamiento del Sistema C.U.R.A. como Hub de Interoperabilidad Sanitaria Global, ofreciendo una plataforma segura, soberana y basada en estándares abiertos.

La implementación operativa de esta proyección se realizará conforme los convenios previstos en el Artículo 38.

Objeto Tridimensional del Hub Global: El Hub tiene por objeto:

Para el Interés Nacional de Argentina:

Generar un nuevo sector exportador de servicios de salud digital de alto valor. Posicionar al país como líder regional y global en soberanía digital sanitaria. Atraer inversiones y alianzas estratégicas en el ecosistema de tecnología sanitaria.

Para los Países Socios:

Ofrecer una solución llave en mano, de bajo costo y alta seguridad para naciones que buscan modernizar sus sistemas de salud.

Brindar interoperabilidad inmediata con una red global de sistemas de salud, evitando años de desarrollo y costos billonarios.

Facilitar la atención sanitaria segura de sus ciudadanos en el extranjero.

Para el Ciudadano Usuario:

Garantizar la continuidad de su cuidado clínico a nivel global.

Mantener el control pleno y granular, conforme los mecanismos establecidos, de su información sensible mediante los mecanismos establecidos en los Artículos 27 y 18 de la presente ley.

Modelo de Valor: Esta proyección internacional transforma al C.U.R.A. en una herramienta de política exterior y desarrollo económico, generando divisas por la exportación de servicios de consultoría, desarrollo tecnológico y gestión basados en el expertise adquirido, a la vez que se ofrece a los países socios una solución integral que reduce sus costos de desarrollo y acelera su modernización sanitaria.

ARTÍCULO 40.- Principios de replicabilidad y adaptación.

El Sistema C.U.R.A. constituye una infraestructura nacional de datos de salud diseñada para su interoperabilidad internacional y para la cooperación tecnológica en materia de salud digital, pudiendo servir como modelo de referencia para otros Estados que busquen desarrollar infraestructuras públicas interoperables de información sanitaria.

a) Framework Exportable.

El modelo C.U.R.A. se estructura como un framework replicable, cuyos principios de gobernanza, arquitectura técnica, estándares de interoperabilidad y mecanismos de implementación podrán ser adoptados por otros Estados, respetando los marcos normativos locales y los principios de soberanía digital establecidos en la presente ley.

b) Adaptación a Realidades Locales.

En los procesos de cooperación internacional, los componentes específicos del ecosistema argentino —incluyendo sistemas de identidad digital, registros civiles y organismos regulatorios sanitarios— deberán ser adaptados por cada país socio utilizando sus sistemas análogos preexistentes, sin transferencia de competencias soberanas.

c) Portafolio de Servicios Internacionales.

La Autoridad de Aplicación, en coordinación con ARSAT S.A. y el organismo nacional competente en materia de promoción de exportaciones, podrá ofrecer los siguientes servicios para posicionar a la República Argentina como exportador de infraestructura pública digital en salud:

1) C.U.R.A.-Asesoría: Servicios de consultoría para la adaptación del framework legal, técnico y operativo.
2) C.U.R.A.-Core: Licenciamiento del software base para implementaciones locales bajo control soberano del país receptor.
3) C.U.R.A.-Cloud: Servicios de hospedaje en infraestructura soberana argentina (ARSAT), garantizando que los datos pertenecientes a otros Estados permanezcan bajo titularidad y control jurídico del país contratante, conforme los acuerdos específicos suscriptos. El Estado Argentino actuará exclusivamente en calidad de encargado de tratamiento o proveedor de infraestructura, quedando exento de responsabilidad civil o penal por el contenido, licitud o uso que el Estado extranjero haga de dichos datos.
4) C.U.R.A.-Academy: Programas de certificación, capacitación y transferencia de conocimiento en salud digital.

d) Generación de Divisas e Ingreso al Tesoro Nacional.
Los recursos económicos, regalías o compensaciones financieras generadas por la exportación, licenciamiento o prestación de los servicios enumerados en el inciso c) ingresarán directamente al Tesoro Nacional (Rentas Generales), quedando a libre disposición del Estado Nacional para su asignación presupuestaria conforme las prioridades de gobierno, constituyendo un aporte genuino del sector salud a la balanza de pagos y la generación de divisas del país.

e) Marco de Implementación.
Las acciones previstas en el presente artículo se ejecutarán conforme los convenios internacionales previstos en el Artículo 38 y la estrategia definida en el Artículo 39.

ARTÍCULO 41.- Modelos de adhesión y garantías de protección.

a) Modelos de Conexión Internacional.

La Autoridad de Aplicación podrá establecer los siguientes esquemas de vinculación con otros Estados o bloques regionales:

1) Federación Bilateral: Intercambio recíproco del Resumen Internacional del Paciente (IPS) con países que acrediten estándares técnicos y jurídicos equivalentes en materia de interoperabilidad y protección de datos.
2) Adhesión a Bloque Regional: Integración como nodo asociado a infraestructuras sanitarias supranacionales que cumplan estándares equivalentes de protección de datos y soberanía digital.

3) Hub de Servicios: Implementación del modelo C.U.R.A. como plataforma base o puente de interoperabilidad para países que adopten el framework previsto en el Artículo 40.

b) Garantías de Protección de Datos.

Todo intercambio internacional de información clínica identificable deberá respetar las siguientes garantías mínimas:

1) Soberanía de Datos: Los datos clínicos primarios permanecerán bajo titularidad y control soberano del país de origen, sin transferencia permanente de bases nominales completas.
2) Control del Titular: Todo acceso internacional requerirá consentimiento previo, específico, granular y revocable del paciente, conforme los Artículos 18 y 27.
3) Principio de Minimización: Solo se compartirá el Resumen Internacional del Paciente (IPS) estrictamente necesario para el acto asistencial concreto.
4) Trazabilidad Transfronteriza: Todo acceso internacional quedará registrado en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría, indicando país receptor, institución, profesional interviniente, fecha, hora y motivo declarado.

c) Nivel Adecuado de Protección.

Cualquier transferencia internacional de datos personales identificables requerirá que el país receptor garantice un nivel adecuado de protección conforme el artículo 12 de la Ley 25.326 y las resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), o bien que existan:

1) Acuerdos bilaterales o multilaterales específicos;
2) Cláusulas contractuales tipo con garantías técnicas y organizativas suficientes; o
3) Instrumentos jurídicos equivalentes que aseguren estándares no inferiores a los reconocidos en el ordenamiento jurídico argentino.

En ningún caso se autorizarán transferencias que impliquen disminución del estándar de protección vigente en la República Argentina.

La Autoridad de Aplicación deberá requerir dictamen previo de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) antes de habilitar cualquier modalidad de interoperabilidad sanitaria internacional que implique transferencia de datos personales identificables.

La interpretación de las garantías de protección previstas en el presente artículo deberá realizarse de manera compatible con los principales estándares internacionales de protección de datos y gobernanza de datos sanitarios, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR), el Espacio Europeo de Datos de Salud (EHDS) y otros instrumentos internacionales equivalentes, siempre que ello no implique reducción del nivel de protección establecido por el ordenamiento jurídico argentino.

d) Armonización Normativa.

Las disposiciones del presente artículo se interpretarán en forma armónica con los Artículos 25, 26 BIS, 27 y 18 de la presente ley.

La interpretación de las garantías de protección previstas en el presente artículo deberá realizarse de manera compatible con los estándares internacionales de interoperabilidad sanitaria y con los regímenes de protección de datos aplicables en las jurisdicciones participantes, siempre que aseguren un nivel de protección equivalente o superior al reconocido por el ordenamiento jurídico argentino.

ARTÍCULO 42.- Financiamiento sustentable del Hub Global.

a) Uso de Infraestructura Existente.

El desarrollo y operación del Hub Global se realizará prioritariamente mediante la utilización de capacidad ociosa de la infraestructura tecnológica de ARSAT S.E., así como mediante la reasignación estratégica de recursos humanos especializados pertenecientes a organismos públicos preexistentes, sin creación de estructuras administrativas permanentes adicionales.

b) Subcuenta de Proyección Internacional del FIISD.

Créase dentro del Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD) la Subcuenta de Proyección Internacional, con afectación específica al desarrollo, mantenimiento y expansión internacional del modelo C.U.R.A.

Se integrará mediante:

1) El CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los ingresos netos efectivamente percibidos por exportación de servicios, licencias o asistencia técnica del Sistema C.U.R.A. El remanente ingresará al Tesoro Nacional (Rentas Generales) conforme lo dispuesto en el Artículo 40 inciso d)
2) Aportes provenientes de cooperación internacional y organismos multilaterales de crédito destinados específicamente al desarrollo de la dimensión internacional del sistema.
3) Contribuciones económicas de países socios en virtud de acuerdos de adhesión,

federación o implementación del modelo C.U.R.A., conforme los convenios del Artículo 38.

Principio de No Afectación del Sistema Nacional.

Los recursos de la Subcuenta no podrán comprometer ni disminuir las partidas destinadas al funcionamiento, mantenimiento y mejora del Sistema C.U.R.A. en el territorio nacional.

Su administración estará sujeta a las reglas de la Ley N° 24.156 y a la auditoría anual de la Auditoría General de la Nación.

c) Autofinanciamiento por Eficiencia.

El desarrollo incremental de capacidades internacionales podrá financiarse con una porción de los ahorros netos auditados conforme el Artículo 35, siempre que:

1) Dichos ahorros hayan sido previamente certificados por los organismos de control competentes;
2) Se garantice la cobertura prioritaria de las necesidades del sistema nacional; y
3) La afectación cuente con aprobación del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

ARTÍCULO 43.- Sistema Global de Alerta Temprana y Preparación ante Pandemias.

a) Objeto.

Créase el Sistema Global de Alerta Temprana del Hub C.U.R.A., destinado a la detección ultra-temprana de potenciales amenazas epidémicas o pandémicas mediante el análisis colaborativo de datos agregados y anonimizados provenientes de los países adherentes, con el fin de fortalecer la preparación y respuesta coordinada en materia de salud pública.

b) Fuente y Naturaleza de los Datos.

El sistema se alimentará exclusivamente de los Módulos Nacionales de Indicadores Predictivos de cada país adherente, equivalentes al previsto en el Artículo 24 de la presente ley.

Los datos compartidos deberán ser previamente anonimizados de manera irreversible conforme técnicas robustas, incluyendo privacidad diferencial, agregación regional mínima o síntesis de datos.

En ningún caso se transferirán datos personales identificables ni historias clínicas individuales.

c) Indicadores Epidemiológicos Agregados.

Podrán incluirse, entre otros, los siguientes indicadores, siempre en formato agregado y no identificable:

1) Tasa de síndromes gripales o respiratorios.
2) Variaciones inusuales en consultas por síntomas específicos.
3) Prescripciones atípicas de medicamentos antivirales o respiratorios.
4) Resultados de laboratorio con desvíos estadísticamente significativos.

d) Plataforma de Inteligencia Artificial Colaborativa (PAIVP-C.U.R.A.).

Créase la Plataforma de IA para Vigilancia Pandémica (PAIVP-C.U.R.A.), que operará sobre infraestructura soberana definida por la Autoridad de Aplicación.

El entrenamiento de modelos se realizará preferentemente bajo el paradigma de Aprendizaje Federado, donde los modelos se entrenan localmente en cada país y solo se comparten parámetros matemáticos agregados.

La plataforma analizará patrones geotemporales anómalos, desviaciones respecto de líneas base históricas y señales de propagación interestatal.

e) Protocolo de Alerta.

Cuando se superen umbrales técnicos predefinidos y auditables, el sistema generará una Alerta Técnica de Fase Inicial.

La alerta será comunicada de forma confidencial a los puntos focales sanitarios designados por cada país adherente.

El sistema no sustituye ni reemplaza los mecanismos formales de notificación previstos por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), ni implica declaración automática de emergencia internacional.

f) Gobernanza y Supervisión.

La PAIVP-C.U.R.A. será supervisada por un Comité Internacional de Vigilancia Epidemiológica con representación técnica de los países adherentes.

Dicho comité verificará la validez científica de los umbrales, la proporcionalidad de las

alertas y la ausencia de sesgos sistemáticos.

Toda metodología algorítmica será documentada y auditable.

g) Limitación de Responsabilidad.

El Sistema Global de Alerta constituye una herramienta de apoyo técnico y análisis predictivo. Las decisiones sanitarias, declaraciones de emergencia y medidas de respuesta corresponderán exclusivamente a las autoridades competentes de cada Estado y a los organismos internacionales pertinentes.

h) Beneficios para los Países Adherentes.

Acceso a alertas epidemiológicas tempranas generadas a partir del análisis agregado y colaborativo internacional, permitiendo anticipación en la preparación de capacidades sanitarias.

Integración a una red de inteligencia sanitaria colectiva que fortalezca la cooperación técnica y la diplomacia sanitaria entre Estados.

Participación en el Comité Internacional de Vigilancia Epidemiológica, con derecho a supervisión técnica y revisión metodológica de los modelos utilizados.

CAPÍTULO 3 – Régimen Federal de Equidad Territorial

ARTÍCULO 43 BIS.- Fondo Federal de Equidad Sanitaria.

a) Créase el Fondo Federal de Equidad Sanitaria (FFES) como instrumento de política sanitaria destinado a reducir asimetrías territoriales en el acceso a profesionales de la salud y servicios médicos especializados.

Fuentes de Financiamiento.

1) El SESENTA POR CIENTO (60%) de los ahorros netos anuales demostrados conforme el artículo 35, inciso e), destinados a equidad territorial.
2) Las partidas específicas que asigne la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio.
3) Aportes voluntarios de provincias adherentes;

4) Donaciones de organismos internacionales y mecenazgo privado destinado específicamente a programas de equidad territorial;

5) Todo otro recurso que se le asigne por ley.

b) Administración y Supervisión.

El Fondo será administrado por el Ministerio de Salud de la Nación bajo supervisión de la Comisión Federal de Equidad Sanitaria creada en el artículo siguiente, y estará sujeto a auditoría anual por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).

c) Afectación Específica.

Los recursos del Fondo tendrán afectación específica y no podrán ser reasignados a finalidades distintas de las establecidas en el presente capítulo. La afectación específica garantizará la continuidad de los programas de equidad territorial aun en contextos de restricción presupuestaria.

d) Aporte Inicial Garantizado.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso a), el Poder Ejecutivo Nacional deberá incluir en los Proyectos de Ley de Presupuesto correspondientes a los DOS (2) primeros ejercicios fiscales posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley una partida inicial destinada al FFES no inferior al monto resultante de la siguiente fórmula:

Aporte mínimo FFES = [N.° de Zonas Críticas Sanitarias identificadas conforme el Artículo 43 QUATER en el ejercicio correspondiente] × [VEINTE (20) Salarios Mínimos Vitales y Móviles anuales por zona]

El factor de 20 SMVM por zona representa el costo promedio estimado de financiar un proyecto piloto de reducción de brecha territorial de complejidad mínima. La SIGEN verificará el cumplimiento de esta obligación conforme el procedimiento del inciso e) del Artículo 35 TER.

El mapa de Zonas Críticas Sanitarias para el cálculo del primer ejercicio deberá ser elaborado por la Comisión Federal de Equidad Sanitaria dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la promulgación, utilizando los datos del INDEC, el SISA y el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud disponibles a la fecha de elaboración.

A partir del tercer ejercicio presupuestario, el Fondo operará primariamente con los recursos derivados de los ahorros certificados conforme el Artículo 35, complementados con las partidas que determine la Ley de Presupuesto.

e) Mecanismo de Contingencia Presupuestaria.

En caso de insuficiencia del FFES para atender compromisos de pago ya asumidos en ejercicios anteriores mediante actos administrativos firmes, el Poder Ejecutivo Nacional deberá incluir en el Proyecto de Ley de Presupuesto del ejercicio inmediato siguiente una partida específica de contingencia no inferior al monto de los compromisos pendientes de cancelación, sin que ello implique habilitación para asumir nuevos compromisos que excedan la disponibilidad efectiva del Fondo en dicho ejercicio.

ARTÍCULO 43 TER.- Comisión Federal de Equidad Sanitaria.

Créase en el ámbito del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. la Comisión Federal de Equidad Sanitaria, con las siguientes atribuciones:

a) Elaborar y actualizar anualmente el Mapa Federal de Zonas Críticas Sanitarias conforme los criterios del artículo 43 QUATER;

b) Diseñar, implementar y supervisar los programas, bonos e incentivos previstos en el artículo 43 QUINQUIES;

c) Proponer al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. la asignación presupuestaria anual del Fondo Federal de Equidad Sanitaria entre las distintas líneas de acción;

d) Evaluar el impacto de las políticas de equidad territorial mediante el Sistema Federal de Indicadores de Equidad, cuyos parámetros serán establecidos por la reglamentación;

e) Rendir cuentas anualmente ante el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., el Consejo Federal de Salud (COFESA) y las Comisiones de Salud de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación mediante el Informe Anual de Evaluación de Impacto del Régimen de Equidad Territorial.

Composición:

La Comisión estará integrada por:

a) CINCO (5) representantes del Consejo Federal de Salud (COFESA), designados por ese organismo con representación de las distintas regiones del país;

b) DOS (2) representantes del Ministerio de Salud de la Nación;

c) UN (1) representante de la Autoridad de Aplicación del Sistema C.U.R.A.;

d) UN (1) representante del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI);

e) UN (1) representante de las Universidades Nacionales con carreras de Ciencias de la Salud, designado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La Comisión será presidida por uno de los representantes de COFESA, elegido por mayoría simple entre sus miembros, con mandato de DOS (2) años renovable.

Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con carácter honorario, sin generar nuevas estructuras administrativas permanentes ni erogaciones adicionales, salvo las necesarias para su funcionamiento técnico básico.

ARTÍCULO 43 QUATER.- Zonas Críticas Sanitarias.

A los efectos de la presente ley, se entiende por Zonas Críticas Sanitarias aquellas áreas geográficas del territorio nacional que presenten déficit estructural de profesionales de la salud, servicios médicos especializados o acceso efectivo a atención sanitaria, conforme los siguientes criterios objetivos:

a) Densidad de profesionales de salud por habitante: inferior en al menos un CINCUENTA POR CIENTO (50%) respecto del promedio nacional vigente al momento de la evaluación;

b) Tiempo de acceso a centro de complejidad media o alta: superior a SESENTA (60) minutos en condiciones normales de transitabilidad;

c) Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): superior al promedio nacional;

d) Tasa de mortalidad infantil y materna: superior al promedio nacional en forma sostenida durante los últimos TRES (3) años;

e) Indicadores epidemiológicos específicos: según las particularidades regionales y los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud integrado al Sistema C.U.R.A.;

f) Otros criterios técnicos complementarios que establezca la reglamentación en función de evidencia epidemiológica y demográfica actualizada.

La Comisión Federal de Equidad Sanitaria elaborará y publicará anualmente el Mapa Federal de Zonas Críticas Sanitarias, con desagregación por provincia, departamento y localidad. El mapa será certificado por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. y publicado en el Portal Federal de Transparencia con formato de datos abiertos.

Las provincias podrán solicitar la inclusión o exclusión de áreas específicas mediante presentación fundada con datos epidemiológicos actualizados. La resolución deberá ser fundada en los criterios objetivos establecidos en el presente artículo y será recurrible ante el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

La metodología de cálculo de los indicadores establecidos en el presente artículo será definida por la reglamentación técnica con participación del INDEC, el Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo Federal de Salud (COFESA), garantizando criterios homogéneos y comparables entre jurisdicciones.

ARTÍCULO 43 QUINQUIES.- Instrumentos de Equidad Territorial y Régimen de Implementación Escalonada

El Régimen Federal de Equidad Territorial se implementará mediante los siguientes instrumentos, financiados exclusivamente con recursos del Fondo Federal de Equidad Sanitaria Digital (FFES) previsto en el Artículo 43 BIS, conforme el régimen de gradualidad y sostenibilidad establecido en el presente artículo.

a) Bonos de Radicación Profesional.

Créanse los Bonos de Radicación Profesional como suplementos económicos mensuales por función diferenciada en zona crítica, de carácter extraordinario y territorial, destinados a profesionales de la salud que se radiquen en Zonas Críticas Sanitarias por un período mínimo de DOS (2) años.

Naturaleza jurídica.

Los Bonos de Radicación Profesional constituyen un suplemento por función diferenciada de carácter no remunerativo, otorgado en razón de las condiciones especiales del puesto y la zona de desempeño, y no en retribución directa de los servicios ordinarios prestados. En consecuencia:

1) No integran el concepto de remuneración a ningún efecto legal, incluyendo el cálculo del sueldo anual complementario, indemnizaciones por desvinculación y adicionales por antigüedad.
2) Quedan expresamente excluidos de la base imponible previsional conforme el Artículo 6°, inciso j) de la Ley 24.241 y sus modificatorias.
3) No generan obligación de aportes ni contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ni a obras sociales, en tanto se mantenga el carácter extraordinario y territorial del suplemento.
4) No son incorporables al salario básico ni al sueldo de referencia de la especialidad.

La presente exclusión opera de pleno derecho desde la percepción del primer Bono y no requiere acto administrativo individual ulterior. La AFIP y la ANSES deberán considerar este suplemento excluido de la base imponible en cualquier proceso de fiscalización o determinación de deuda.

Graduación del monto.

El monto será graduado según:

1) Nivel de criticidad de la zona.

2) Especialidad requerida.

3) Tiempo de permanencia comprometido.

El monto podrá oscilar entre el TREINTA POR CIENTO (30%) y el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del salario promedio de la especialidad en centros urbanos de referencia, conforme determine la reglamentación.

Condiciones de percepción y cese.

La percepción del Bono estará condicionada a la permanencia efectiva en la Zona Crítica Sanitaria durante el período comprometido.

El profesional podrá cesar voluntariamente en cualquier momento, sin que ello implique restricción alguna a su libertad de trabajo o de residencia garantizadas por el Artículo 14 de la Constitución Nacional. El cese no dará lugar a sanción disciplinaria, inhabilitación ni restricción del ejercicio profesional.

Eximición del reintegro por causas justificadas.

Quedan eximidos del reintegro proporcional los casos de cese motivados en:

1) Enfermedad o accidente del profesional, o de un familiar a cargo conviviente, que impida objetivamente la continuidad de la prestación, debidamente certificada.

2) Traslado del cónyuge o conviviente en unión convivencial registrada, por razones laborales o de fuerza mayor debidamente acreditadas.

3) Cierre, fusión, reestructuración o desafectación del establecimiento sanitario de destino por decisión de la autoridad competente.

4) Cualquier otra causa ajena a la voluntad del profesional, valorada y aprobada por la Autoridad de Aplicación mediante resolución fundada en el plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la presentación.

Reintegro proporcional en caso de cese sin causa justificada.

En caso de cese voluntario antes del período mínimo comprometido, y siempre que no concurra ninguna de las causas de eximición previstas en el párrafo anterior, el profesional deberá reintegrar únicamente la porción proporcional del Bono correspondiente a los meses no cumplidos desde la fecha de cese hasta la finalización del período mínimo pactado.

La actualización del monto a reintegrar se calculará conforme el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), tomando como fecha de inicio del cómputo el primer día del mes en que opera el cese efectivo.

El reintegro no podrá exceder en ningún caso el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor nominal total percibido en concepto de Bono durante el período efectivamente cumplido, con independencia del monto que resulte de la actualización por CER. Si la actualización por CER arrojare un importe superior a dicho tope, el reintegro exigible quedará limitado al valor nominal del veinte por ciento (20%) sin ajuste adicional.

El reintegro se efectuará en DOCE (12) cuotas mensuales iguales, salvo acuerdo expreso del profesional para efectuarlo en menor plazo. No generará intereses punitorios ni moratorios durante el período de pago acordado.

b) Incentivos No Monetarios.

Podrán otorgarse, entre otros:

1) Puntaje adicional en concursos de residencias o cargos hospitalarios.
2) Prioridad en programas de formación de posgrado y especialización en universidades nacionales.
3) Acceso preferencial a programas de financiamiento de investigación y actualización profesional.
4) Programas de vivienda o subsidios habitacionales conforme inciso g).

c) Programas de Rotación Formativa.

Se promoverán períodos de rotación en Zonas Críticas Sanitarias como parte de los programas de formación de residentes y concurrentes en especialidades estratégicas. La rotación no constituirá requisito obligatorio para la certificación final de la especialidad, salvo que así lo dispongan las instituciones formadoras y sociedades científicas competentes en coordinación con las autoridades educativas nacionales y provinciales.

d) Telemedicina de Apoyo y Consultoría Especializada.

1) Provisión prioritaria de conectividad, equipamiento y acceso a plataformas de teleconsulta.
2) Acceso preferente a sistemas de segunda opinión con centros de referencia nacional.
3) Capacitación específica en salud digital para profesionales radicados en zonas críticas.

e) Soporte Logístico Integral.

1) Provisión prioritaria de insumos críticos.
2) Coordinación de derivaciones interjurisdiccionales.
3) Reducción de carga administrativa mediante asistencia técnica digital.

f) Sistemas de Reemplazo y Descanso.

El FFES financiará mecanismos de reemplazo temporal para profesionales únicos en su especialidad en zonas aisladas. Se garantizará la posibilidad de ausentarse hasta TREINTA (30) días corridos por año calendario, sin afectar la continuidad asistencial de la población. La organización operativa será coordinada por la Autoridad de Aplicación en conjunto con la jurisdicción provincial correspondiente.

g) Subsidio Habitacional y Traslado.

Cuando la radicación implique cambio efectivo de residencia, podrá otorgarse un subsidio habitacional mensual destinado a compensar costos adicionales de alquiler o vivienda. Podrán cubrirse gastos de traslado inicial y relocalización, conforme criterios objetivos establecidos por reglamentación. La asignación de este beneficio requerirá acreditación documentada del cambio de residencia.

h) Régimen de Implementación Escalonada y Sostenibilidad Fiscal.

Implementación Progresiva.

Durante los DOS (2) primeros ejercicios presupuestarios posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, el régimen se implementará exclusivamente en modalidad piloto, alcanzando un máximo inicial determinado por disponibilidad presupuestaria. La implementación plena comenzará a partir del TERCER ejercicio presupuestario posterior a la entrada en vigencia, una vez que existan ahorros netos demostrados conforme el Artículo 35.

Límite Presupuestario Anual.

La ejecución anual del régimen no podrá exceder los recursos efectivamente disponibles en el Fondo Federal de Equidad Sanitaria Digital. En ningún caso la implementación podrá generar déficit fiscal ni comprometer partidas destinadas a funciones sanitarias esenciales. Si los recursos disponibles resultaren insuficientes, la Autoridad de Aplicación deberá ajustar proporcionalmente la cantidad de nuevos beneficiarios, sin afectar compromisos ya asumidos mediante actos administrativos firmes en ejercicios anteriores. La cobertura de dichos compromisos previos quedará sujeta al mecanismo de contingencia establecido en el Artículo 43 BIS, inciso e).

Evaluación Anual de Sostenibilidad.

La Comisión Federal de Equidad Sanitaria deberá:

1) Evaluar anualmente el impacto fiscal del régimen.
2) Publicar informe de costo-beneficio y resultados sanitarios.
3) Recomendar ampliación, mantenimiento o reducción del alcance según disponibilidad financiera y resultados obtenidos.

Principio de No Desfinanciamiento.

La implementación del presente régimen no podrá:

1) Reducir prestaciones existentes en otras jurisdicciones.
2) Implicar disminución salarial de profesionales no alcanzados por el régimen.
3) Generar desplazamientos forzosos de personal sanitario.

i) Reglamentación.

La reglamentación establecerá:

1) Montos específicos dentro de las bandas establecidas en el inciso a).
2) Procedimientos de postulación, selección y formalización del compromiso de radicación.
3) Mecanismos de control y auditoría del cumplimiento de las condiciones de permanencia.
4) Condiciones de permanencia y procedimiento para la acreditación de causas de eximición del reintegro proporcional.
5) Procedimiento de liquidación y pago del reintegro en cuotas conforme lo establecido en el inciso a), garantizando en todo caso la proporcionalidad y el tope del veinte por ciento (20%) del valor nominal total percibido.

ARTÍCULO 43 SEXIES.- Evaluación, Transparencia y Rendición de Cuentas.

La Comisión Federal de Equidad Sanitaria elaborará y publicará anualmente el Informe de Evaluación de Impacto del Régimen de Equidad Territorial, el cual deberá contener como mínimo:

a) Métricas de redistribución profesional alcanzada: Variación interanual en densidad de profesionales por zona, especialidades incorporadas, tiempos de permanencia promedio;
b) Análisis de costo-efectividad: Relación entre recursos invertidos y mejora en indicadores sanitarios en Zonas Críticas;
c) Evaluación de impacto en salud pública: Evolución de mortalidad infantil y materna, tiempos de acceso a atención especializada, reducción de derivaciones de emergencia, mejora en cobertura de programas sanitarios prioritarios;
d) Rendición de cuentas del Fondo Federal de Equidad Sanitaria: Ejecución presupuestaria detallada por línea de acción, provincia beneficiaria e instrumento implementado;
e) Indicadores del Sistema Federal de Indicadores de Equidad: Conforme los parámetros técnicos establecidos en la reglamentación;
f) Recomendaciones de ajuste: Propuestas de modificación de criterios, instrumentos o asignaciones presupuestarias fundadas en evidencia empírica.
El Informe será remitido obligatoriamente a:

1) El Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.;
2) El Consejo Federal de Salud (COFESA);
3) Las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del

Honorable Congreso de la Nación;

4) La Auditoría General de la Nación (AGN);

5) La Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

g) Evaluación de sostenibilidad fiscal: Proyección de recursos disponibles del Fondo Federal de Equidad Sanitaria Digital para los próximos TRES (3) ejercicios presupuestarios, compatibilidad entre compromisos asumidos y recursos efectivamente disponibles, y recomendación fundada sobre ampliación, mantenimiento o reducción del alcance del régimen.

El Informe será publicado íntegramente en el Portal Federal de Transparencia del Sistema C.U.R.A. en formato de datos abiertos dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores a su aprobación por el Consejo Nacional.

TÍTULO VIII - RÉGIMEN SANCIONATORIO Y FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 44.- Régimen de Sanciones, Responsabilidades y Debido Proceso.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley dará lugar a la aplicación de sanciones graduadas conforme la gravedad de la falta, el perjuicio causado, la intencionalidad y la reincidencia, garantizando en todos los casos el debido proceso administrativo.

a) Principios del Régimen Sancionatorio
Legalidad y Tipicidad: Solo serán sancionables las conductas expresamente tipificadas en esta ley.

Razonabilidad y Proporcionalidad:

1) Las sanciones serán proporcionales a la gravedad de la falta.

2) Se evaluará la entidad del daño, la intencionalidad y los antecedentes del infractor.

Debido Proceso: Se garantizará el procedimiento conforme a la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y principios constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional).

Non bis in idem: No se sancionará dos veces por el mismo hecho.

Gradualidad: Se priorizará la prevención y subsanación sobre la sanción, salvo en casos

de gravedad extrema.

b) Clasificación de Faltas
Las conductas infractoras se clasifican de la siguiente manera:

1) Faltas Leves:

i) Demoras menores (hasta setenta y dos (72) horas) en la carga de datos clínicos no críticos sin perjuicio para el paciente.

ii) Incumplimiento no reiterado de estándares de calidad de datos (Índice C.U.R.A. inferior a 60/100 en un trimestre aislado).

iii) Omisión no intencional de actualización de agendas en el Sistema de Turnos dentro de la latencia permitida.

iv) Errores formales o administrativos sin impacto en la atención médica.

2) Faltas Graves:

i) Obstrucción activa o negligencia reiterada (tres (3) o más incumplimientos en noventa (90) días tras apercibimiento) que impida el cumplimiento de los Criterios Técnicos de Habilitación.

ii) Incumplimiento sistemático de obligaciones de carga de datos (más del treinta por ciento (30%) de datos obligatorios sin cargar durante sesenta (60) días).

iii) Asignación reiterada (tres (3) o más en treinta (30) días) de turnos inexistentes por negligencia del prestador.

iv) Negativa injustificada a interoperar tras apercibimiento y plazo de subsanación.

v) Incumplimiento de obligaciones de trazabilidad de medicamentos (RDDT) tras fase obligatoria y procedimiento previo.

vi) Violación no dolosa de principios de protección de datos.

vii) Negativa discriminatoria de atención basada en configuración de privacidad del paciente.

3) Faltas Gravísimas:

i) Acceder, intentar acceder o cargar información clínica careciendo de matrícula vigente, o hallándose la matrícula suspendida o inhabilitada por sanción disciplinaria.

ii) Uso indebido del mecanismo break-glass.

iii) Violación del blindaje sanitario establecido en la presente ley.

iv) Suplantación de identidad de paciente o profesional.

v) Manipulación, adulteración o falsificación de datos clínicos o registros de trazabilidad.

vi) Comercialización, cesión o venta de datos de salud.

vii) Violación grave del secreto profesional.

viii) Uso de información del Sistema para fines de discriminación.

ix) Activación indebida del Modo de Adversidad sin emergencia real.

x) Reincidencia en faltas graves (tres (3) o más sanciones firmes en veinticuatro (24) meses).

c) Unidad de Referencia y Actualización (UMSD)
A los fines de la presente ley, el valor de referencia para el cálculo de multas es la Unidad de Multa Sanitaria Digital (UMSD), equivalente al valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente al momento de la comisión de la infracción.
La Autoridad de Aplicación actualizará el valor de la UMSD dentro de los QUINCE (15) días de cada modificación del SMVM, publicando la tabla de conversión en el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación.
La determinación de la multa se realizará conforme los principios de legalidad, tipicidad y razonabilidad establecidos en el inciso a).

d) Escala de Sanciones para Efectores Privados y de la Seguridad Social
Las multas aplicables a los efectores del sector privado y de la seguridad social (obras sociales, entidades de medicina prepaga, ART y demás sujetos obligados que desarrollen actividad en el sector privado conforme el Régimen A del art. 1°(g) inc. 3 a 5) se ajustarán a la siguiente escala:

1) Falta Leve: Multa de CERO COMA CINCO (0,5) a DOS (2) UMSD por infracción. Máximo por ejercicio fiscal para el mismo infractor: DIEZ (10) UMSD.

2) Falta Grave: Multa de DOS (2) a VEINTE (20) UMSD por infracción. En caso de reincidencia dentro de los DOCE (12) meses: el rango aplicable se duplica. Máximo por ejercicio fiscal para el mismo infractor: CIEN (100) UMSD. Sanciones accesorias: Suspensión temporal de acceso al Sistema de treinta (30) a noventa (90) días; Inhabilitación temporal para emitir prescripciones electrónicas de treinta (30) a ciento ochenta (180) días; Publicación en el Portal de Transparencia.

3) Falta Gravísima: Multa de VEINTE (20) a DOSCIENTAS (200) UMSD por infracción. En caso de reincidencia dentro de los DOCE (12) meses: el rango aplicable se triplica. Máximo por ejercicio fiscal para el mismo infractor: QUINIENTAS (500) UMSD. Sanciones accesorias: Bloqueo o inhabilitación digital por dos (2) a cinco (5) años; Denuncia penal (si configura delito); Comunicación al colegio profesional; Inhabilitación para participar en programas del Sistema

C.U.R.A.

La Autoridad de Aplicación determinará la multa concreta dentro del rango aplicable, ponderando: (i) la gravedad de la falta; (ii) el perjuicio causado al paciente o al sistema; (iii) la intencionalidad; (iv) los antecedentes del infractor; (v) la subsanación voluntaria y oportuna.

Para personas físicas, profesionales independientes o establecimientos unipersonales, el rango máximo aplicable será equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del previsto para personas jurídicas de gran envergadura, conforme parámetros objetivos que establezca la reglamentación.
En ningún caso la multa impuesta podrá exceder el TREINTA POR CIENTO (30%) de la facturación mensual promedio del infractor correspondiente a los SEIS (6) meses anteriores a la comisión de la falta, debidamente acreditada.

e) Régimen para Efectores Públicos
A los efectores de salud bajo dependencia del Estado Nacional, los Gobiernos Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los Municipios, NO se les aplicarán multas dinerarias. En su lugar, y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que correspondan al personal responsable, se aplicarán las siguientes medidas correctivas:

1) Falta Leve: Apercibimiento formal con plan de subsanación obligatorio de QUINCE (15) a TREINTA (30) días. Asistencia técnica presencial obligatoria por la UESC.
2) Falta Grave: Plan de mejora obligatorio con supervisión mensual de la UESC. Suspensión preventiva del acceso a módulos no esenciales del sistema hasta la subsanación. Informe al organismo de control presupuestario jurisdiccional competente.
3) Falta Gravísima: Intervención técnica obligatoria de la UESC. Suspensión del acceso a módulos del sistema proporcional a la gravedad (excepto urgencias). Comunicación a la máxima autoridad jurisdiccional sanitaria. Publicación en el Registro de Incumplimientos.

   Las medidas correctivas aplicadas a efectores públicos no podrán implicar retención automática de fondos coparticipables ni afectar transferencias nacionales no vinculadas específicamente al Sistema C.U.R.A.

   En todos los casos, las medidas correctivas aplicadas a efectores públicos deberán respetar la continuidad de la atención a los pacientes.

   La diferencia de tratamiento sancionatorio entre efectores públicos y privados se fundamenta en la distinta naturaleza jurídica de los sujetos obligados y en la

imposibilidad de aplicar sanciones pecuniarias al propio Estado, sin que ello implique exención de responsabilidad funcional o disciplinaria del personal interviniente ni trato desigual ante la ley.

f) Coordinación con el Artículo 45 y Prohibición de Non Bis In Idem

Los incumplimientos vinculados específicamente al Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT) previsto en el Artículo 20 se regirán por el régimen sancionatorio especial establecido en el Artículo 45.

Las restantes infracciones relativas al acceso, tratamiento, seguridad, integridad, confidencialidad o uso indebido de datos clínicos dentro del Sistema C.U.R.A. se regirán por el presente artículo.

En ningún caso podrá aplicarse más de una sanción administrativa por el mismo hecho material, aun cuando la conducta pudiera encuadrar formalmente en disposiciones de ambos artículos.

En caso de duda sobre la norma aplicable, prevalecerá la disposición especial que regule de manera más directa la conducta infractora, debiendo la Autoridad de Aplicación fundar expresamente dicha calificación en el acto administrativo sancionatorio.

g) Atenuantes y Agravantes

1) Atenuantes: i) Reconocimiento espontáneo antes de detección. ii) Colaboración activa. iii) Falta de antecedentes. iv) Adopción inmediata de medidas correctivas. v) Pequeña magnitud del prestador.

2) Agravantes: i) Reiteración tras sanción previa. ii) Ocultamiento u obstrucción. iii) Perjuicio concreto a pacientes. iv) Gran magnitud del prestador. v) Intencionalidad dolosa acreditada.

h) Destino de las Multas

El producido de las multas aplicadas conforme el inciso d) de este artículo se destinará con exclusividad al Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD) previsto en el Artículo 35, no pudiendo ser reasignado a finalidades distintas por el Poder Ejecutivo.

i) Procedimiento Sancionatorio

1) Notificación de cargos: Detallando hechos, calificación y sanción propuesta.

2) Plazo de descargo: Mínimo quince (15) días hábiles, prorrogables por otros quince

(15).

3) Audiencia: Si el presunto infractor lo solicita.

4) Producción de prueba: Documental, pericial, testimonial o inspecciones.

5) Resolución fundada: Dentro de treinta (30) días, analizando pruebas y fundamentos.

6) Recursos administrativos: Reconsideración (10 días) y Jerárquico (15 días).

7) Recurso judicial: Conforme artículo 23 de la Ley 19.549.

j) Suspensión de Ejecución

La interposición de recursos no suspende automáticamente la ejecución de la sanción. Podrá otorgarse suspensión cuando: i) Se solicite expresamente; ii) Se acredite perjuicio grave e irreparable; iii) Se otorgue caución suficiente.

En el caso de sanciones cuyo monto no supere DIEZ (10) UMSD, la interposición del recurso administrativo tendrá efecto suspensivo automático hasta la resolución definitiva en sede administrativa.

Para sanciones superiores a dicho monto, la suspensión podrá concederse con caución real o personal equivalente hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto de la multa impuesta.

En ningún caso se exigirá caución cuando se trate de personas físicas o establecimientos unipersonales cuya facturación mensual promedio no supere CINCO (5) SMVM.

k) Prescripción

La acción para sancionar prescribe a los tres (3) años de cometida la falta. La prescripción se interrumpe por la notificación de cargos.

ARTÍCULO 45.- Infracciones, Sanciones y Eximentes en Materia de Trazabilidad Digital de Medicamentos

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 20 (Registro Digital de Dispensación Trazable - RDDT) dará lugar a la aplicación del siguiente régimen específico de infracciones y sanciones:

a) Alcance del Régimen

Este régimen aplicará a:

1) Farmacias (públicas y privadas) obligadas a registrar dispensaciones en el RDDT.

2) Obras sociales, entidades de medicina prepaga, INSSJP-PAMI y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) obligadas a fiscalizar mediante el RDDT.

3) Profesionales prescriptores que emitan prescripciones electrónicas.

4) Establecimientos de salud que gestionen medicación institucional.

b) Vigencia Temporal

Las infracciones y sanciones previstas en el presente artículo serán aplicables únicamente una vez finalizado el período de transición y convivencia troquel físico/RDDT establecido en la Disposición Transitoria Undécima.

Solo serán exigibles respecto de las categorías de medicamentos y prestadores efectivamente incorporados al sistema conforme el cronograma de implementación progresiva definido por la Autoridad de Aplicación.

c) Tipificación de Infracciones

1) Infracciones Leves:

Constituyen infracciones leves:

i) Demora menor (hasta SETENTA Y DOS (72) horas) en el registro de dispensación en el RDDT, sin impacto en la fiscalización o en la seguridad del paciente.

ii) Errores formales en campos no críticos del registro (domicilio incompleto, teléfono erróneo) subsanables.

iii) Omisión no intencional de datos secundarios sin afectación de la trazabilidad esencial.

2) Infracciones Graves:

Constituyen infracciones graves:

i) Omisión de carga en RDDT: No registrar dispensación de medicamento en el RDDT dentro del plazo establecido (CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles desde la dispensación), cuando ya se encuentre en fase obligatoria para esa categoría de medicamento.

ii) Retraso sistemático en carga: Se entenderá por retraso sistemático el incumplimiento del plazo de carga establecido que, verificado en CINCO (5) o más ocasiones dentro de un período de TREINTA (30) días corridos, registre una demora superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles desde la dispensación y no resulte atribuible al Modo de Contingencia previsto en el artículo 22 debidamente activado y documentado en cada instancia.

iii) Carga de información falsa o adulterada: Registrar en el RDDT datos que no correspondan con la dispensación real (cantidad distinta, medicamento distinto, paciente distinto, fecha u hora adulterada).

iv) Dispensación sin verificación de identidad: Dispensar medicamento sin verificar fehacientemente la identidad del paciente conforme artículo 29, generando

riesgo de suplantación o fraude.

v) Aprobación de pago sin RDDT por financiadores: Obras sociales, prepagas, INSSJP-PAMI o ART que aprueben y paguen prestaciones farmacéuticas sin verificar la existencia de registro válido en el RDDT.

d) Eximente de Responsabilidad por Contingencia
No constituirá infracción sancionable el retraso o la falta de registro en el RDDT cuando obedezca a:

1) Falla de conectividad, siempre que:

i) Se haya utilizado el Modo de Contingencia previsto en el artículo 22.

ii) Se sincronice la información dentro de las DOCE (12) horas siguientes al restablecimiento de conectividad del servicio.

iii) Se conserve evidencia documental del impedimento técnico.

iv) El sistema registre automáticamente la indisponibilididad o interrupción del servicio.

En zonas rurales o de conectividad intermitente certificada conforme el artículo 63 inciso c), el plazo de sincronización podrá extenderse hasta VEINTICUATRO (24) horas posteriores al restablecimiento del servicio.

2) Caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditados.

3) Falla atribuible a la plataforma nacional, certificada por la Autoridad de Aplicación.

e) Régimen Sancionatorio Específico

1) Infracciones Leves:
Serán sancionadas con:

i) Apercibimiento escrito.

ii) Plazo de subsanación de QUINCE (15) días.

iii) Asistencia técnica obligatoria sin costo.

2) Infracciones Graves (Sector Privado y Seguridad Social):
Serán sancionadas con multa graduable conforme los siguientes parámetros:

i) Escala Base: De CINCUENTA (50) a DOSCIENTAS (200) Unidades de Multa Sanitaria Digital (UMSD).

ii) Criterios de Graduación: Magnitud del establecimiento o entidad; Reincidencia dentro de VEINTICUATRO (24) meses; Intencionalidad o negligencia grave acreditada; Perjuicio concreto causado. (En el caso de establecimientos unipersonales o de pequeña escala, cuya facturación anual se encuentre por debajo del límite que establezca la reglamentación, la multa podrá graduarse

hasta el mínimo legal previsto, garantizando el principio de proporcionalidad y razonabilidad).

iii) Procedimiento Previo Obligatorio:
- Apercibimiento fehaciente otorgando plazo de TREINTA (30) días para regularización.
- Ofrecimiento de asistencia técnica personalizada gratuita durante dicho plazo.
- Verificación posterior de regularización.
- Sustanciación de sumario administrativo conforme artículo 44 inciso i), únicamente en caso de incumplimiento persistente e injustificado.
- Resolución fundada imponiendo sanción graduada.

3) Sanciones Accesorias:
Adicionalmente podrá aplicarse:

i) Suspensión temporal (TREINTA (30) a NOVENTA (90) días) de la habilitación para operar en el RDDT.

ii) Publicación de la sanción en el Portal de Transparencia del Sistema C.U.R.A.

iii) Comunicación al colegio profesional correspondiente.

La suspensión temporal no podrá implicar desabastecimiento de pacientes ni interrupción de tratamientos esenciales. En todos los casos deberá garantizarse la continuidad asistencial mediante mecanismos alternativos que aseguren el derecho a la salud.

4) Régimen para Efectores y Farmacias Públicas:
En estricta concordancia con lo dispuesto en el Artículo 44 inciso e), a las farmacias y establecimientos de salud bajo dependencia del Estado (Nacional, Provincial o Municipal) no se les aplicarán multas dinerarias en UMSD. En caso de infracciones graves, serán pasibles de las medidas correctivas, planes de mejora obligatorios e intervenciones técnicas allí dispuestas, garantizando ininterrumpidamente la dispensa de medicamentos a los pacientes.

f) Destino de las Multas
El producido de las multas se integrará al Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD) conforme artículo 35.

g) Recursos
Contra la resolución sancionatoria procederán los recursos previstos en el artículo 44 incisos i) y j).

h) Prescripción

La acción para sancionar infracciones a la trazabilidad de medicamentos prescribe a los DOS (2) años de cometida la infracción. El plazo se interrumpe por notificación del apercibimiento o inicio de sumario.
Las sanciones previstas en el presente artículo tendrán alcance exclusivamente respecto de la operatoria dentro del Sistema C.U.R.A. y del Registro Digital de Dispensación Trazable, sin perjuicio de las competencias sancionatorias propias de las autoridades sanitarias jurisdiccionales conforme la legislación local aplicable.

ARTÍCULO 46.- Auditoría, control público y transparencia.

Auditorías Técnicas y de Seguridad Anuales.

El Sistema C.U.R.A. será objeto de auditorías técnicas y de seguridad informática anuales a cargo de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), la SIGEN y la AAIP, cuyos resultados deberán ser publicados en formato abierto en el portal oficial del Estado nacional. Los ciudadanos podrán verificar el estado del sistema y sus estadísticas generales sin acceso a datos personales a través de la interfaz web pública del sistema. El comité de evaluación de sugerencias establecido en el Artículo 6° deberá publicar anualmente un informe sobre las mejoras implementadas en respuesta a las sugerencias recibidas.

Auditoría Externa y Evaluación de Impacto.

Además de las auditorías técnicas previstas en el inciso a), corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) las siguientes atribuciones:

Auditoría Externa Anual: La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará anualmente una auditoría integral del Sistema C.U.R.A., examinando:

Transparencia y acceso a la información.

Eficiencia presupuestaria y ejecución financiera

Resguardo de derechos ciudadanos y protección de datos.

Cumplimiento de plazos y metas de implementación.

Evaluación de Gestión y Modernización: El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) colaborará técnicamente en la evaluación de impacto institucional, modernización administrativa y mejora de procesos, emitiendo informes no vinculantes sobre:

Calidad de implementación;

Capacitación y adopción profesional;

Mejores prácticas en gestión digital pública.

Evaluación de Impacto Bianual: Cada dos (2) años, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará una evaluación integral del impacto de la presente ley, midiendo:

Mejora en indicadores de salud pública. Eficiencia lograda en el sistema sanitario.

Eficiencia lograda en el sistema sanitario

Nivel de adopción ciudadana y profesional.

Reducción de duplicaciones y optimización de recursos.

Grado de interoperabilidad alcanzado.

Publicación y Rendición de Cuentas: Los informes de auditoría y evaluación serán de acceso público y se remitirán a las Comisiones de Salud de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.

Panel Federal de Transparencia y Gobernanza Pública.

Créase el Panel Federal de Transparencia y Gobernanza del Sistema C.U.R.A., de acceso público y gratuito a través del portal oficial, que mostrará en tiempo real indicadores agregados y anonimizados del desempeño del sistema.

Finalidad: Garantizar la transparencia, facilitar el control social y proveer datos para la mejora continua y la rendición de cuentas de los prestadores y jurisdicciones adherentes.

Contenido Mínimo Obligatorio: El Panel deberá incluir, como mínimo, los siguientes indicadores, actualizados en tiempo real y con desagregación jurisdiccional:

Eficiencia Operativa: Tiempos promedios de atención, porcentaje de recetas electrónicas emitidas, tasa de utilización de la Credencial de Emergencia.

Interoperabilidad y Ahorro: Número de estudios de laboratorio e imágenes evitados por duplicación, ahorro estimado en papel y procesos administrativos.

Calidad de Datos: Porcentaje de registros clínicos con metadatos completos y estandarizados.

Adopción del Sistema: Porcentaje de profesionales activos, farmacias y establecimientos utilizando el sistema.

Índice C.U.R.A. de Interoperabilidad: El índice público para cada prestador, establecido en el Artículo 7° inciso e).

Principios de Publicación: La información se publicará bajo licencia abierta, en formatos

digitales reutilizables, garantizando en todo momento la protección de los datos personales y el secreto estadístico.

Responsabilidad: La Autoridad de Aplicación, a través de la Unidad Ejecutora (UESC), será responsable del desarrollo, mantenimiento y actualización del Panel.

TÍTULO IX – INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 47.- Integración obligatoria del INSSJP–PAMI al Sistema C.U.R.A.

a) Obligación de Integración.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI), en su carácter de ente público no estatal integrante del subsistema nacional de seguridad social en salud, deberá integrarse de manera plena, progresiva y obligatoria al Sistema C.U.R.A., garantizando la interoperabilidad, trazabilidad y estandarización digital de sus procesos asistenciales y administrativos.

b) Alcance Funcional Mínimo Obligatorio.
La integración comprenderá, como mínimo, la adopción e implementación de los siguientes módulos y funcionalidades:

1) Historia Clínica Electrónica Interoperable.
   i) Incorporación de la historia clínica digital de sus afiliados al ecosistema C.U.R.A., conforme estándares técnicos nacionales.
   ii) Garantía de interoperabilidad con prestadores públicos y privados adheridos.
2) Prescripción Electrónica y Trazabilidad.
   i) Implementación de prescripción electrónica interoperable.
   ii) Integración obligatoria al Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT).
3) Sistema Federal de Gestión de Turnos.
   i) Integración al sistema unificado de búsqueda, asignación y gestión de turnos.
   ii) Visualización en tiempo real de disponibilidad de prestadores.
4) Derivaciones, Traslados y Auditoría.
   i) Digitalización y trazabilidad de derivaciones médicas y traslados.
   ii) Integración de procesos de auditoría médica y administrativa al sistema digital nacional.
5) Digitalización Administrativa Progresiva.

i) Eliminación progresiva de trámites presenciales innecesarios.

ii) Automatización de autorizaciones y validaciones prestacionales.

c) Plazo y Cronograma de Implementación.

1) Plazo Máximo.
La integración deberá encontrarse operativa en un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) meses contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.

2) Implementación por Fases.
La implementación se realizará conforme un cronograma progresivo aprobado por el Directorio del Instituto y comunicado al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., contemplando:

i) Prioridad en prestaciones críticas y medicamentos de alto impacto sanitario.

ii) Integración territorial gradual según capacidad operativa.

iii) Etapas piloto con evaluación técnica previa a la expansión nacional.

d) Respeto de la Autonomía Institucional.

1) Modalidad Operativa.
El Directorio del INSSJP–PAMI, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 19.032 y sus modificatorias, conservará autonomía para definir:

i) Modalidades operativas internas.

ii) Reingeniería de procesos administrativos.

iii) Estrategias tecnológicas complementarias.

iv) Organización territorial de la implementación.

La presente ley no podrá ser interpretada como restricción al ejercicio de la autonomía tecnológica del Instituto, ni como impedimento para el desarrollo de soluciones digitales propias que respondan a sus necesidades institucionales específicas.

2) Límite de la Autonomía.
La autonomía operativa no podrá afectar el cumplimiento sustancial de:

i) La interoperabilidad obligatoria con el Sistema C.U.R.A.

ii) La trazabilidad digital de las prestaciones y medicamentos.

iii) La protección de datos personales conforme a la normativa vigente.

iv) Los derechos de los afiliados establecidos en la presente ley.

e) Continuidad Asistencial y Protección de Afiliados.

1) Principio de No Interrupción.
La integración no podrá generar interrupciones en la atención médica, dispensación de medicamentos ni prestaciones esenciales.

2) Transición Ordenada.
Durante el período de implementación podrán coexistir temporalmente sistemas internos del Instituto, siempre que no impidan interoperabilidad con el Sistema C.U.R.A., no dupliquen cargas innecesarias y no comprometan la trazabilidad de medicamentos ni la seguridad del paciente.

f) Supervisión y Evaluación.
El proceso de integración será monitoreado por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., sin afectar la autarquía financiera del Instituto, y deberá incluir informes semestrales de avance.

g) Instrumento de implementación.
Las obligaciones de integración al Sistema C.U.R.A. establecidas en los Artículos 47 a 64 de la presente ley serán instrumentadas mediante un Convenio Marco de Integración Digital, celebrado entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Directorio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI), suscripto dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la reglamentación de esta ley.
Dicho convenio determinará los plazos, modalidades operativas, especificaciones técnicas y mecanismos de monitoreo conforme los lineamientos de los artículos mencionados, respetando la estructura orgánica y las competencias de gobierno del Directorio del INSSJP–PAMI establecidas por la Ley 19.032 y sus modificatorias. El Convenio no podrá desnaturalizar las obligaciones de integración establecidas en esta ley ni diferirlas por plazos que excedan los aquí previstos.

ARTÍCULO 48.- Integración funcional de PAMI en la Plataforma C.U.R.A.

a) Integración en Plataforma Única.

El Sistema C.U.R.A. constituirá el canal oficial de integración digital del INSSJP–PAMI con el ecosistema nacional de salud digital.

El INSSJP–PAMI podrá mantener y desarrollar sistemas internos y canales propios de gestión, siempre que garanticen interoperabilidad plena y certificada con el Sistema C.U.R.A. conforme el Artículo 15 y el régimen del presente artículo.

No podrán financiarse ni implementarse desarrollos tecnológicos que dupliquen funcionalidades sustancialmente equivalentes a módulos plenamente operativos del Sistema C.U.R.A., salvo que medie informe técnico fundado que acredite:

1) imposibilidad de integración;

2) necesidad operativa específica no cubierta por el sistema; o

3) mejora sustancial en eficiencia, seguridad o capacidad operativa.

Dicho informe deberá ser remitido a la SIGEN y a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema C.U.R.A.

b) Módulo PAMI dentro de C.U.R.A.

El Sistema C.U.R.A. incorporará un módulo específico de gestión para afiliados PAMI, que deberá garantizar:

1) Gestión Asistencial.
   i) Visualización y autogestión de turnos.
   ii) Consulta de historia clínica interoperable.

2) Gestión Farmacéutica.
   i) Visualización de recetas electrónicas vigentes.
   ii) Estado de dispensación y trazabilidad de medicamentos (RDDT).

3) Gestión Administrativa.
   i) Seguimiento de autorizaciones y derivaciones.
   ii) Estado de traslados y prestaciones especiales.

c) Identidad Digital Unificada.

La autenticación se realizará exclusivamente mediante la plataforma oficial de identidad digital del Estado Nacional (actualmente “Mi Argentina”) o la que en el futuro la sustituya o actualice, sin que ello impida al INSSJP-PAMI mantener sus propios mecanismos de autenticación para servicios o plataformas propias, conforme el inciso e).

d) Principio de Ventanilla Única Digital.

El entorno del Sistema C.U.R.A. será el principal punto de acceso y el canal oficial a través del cual el INSSJP-PAMI prestará a sus afiliados el acceso integrado a servicios digitales de

salud, garantizando experiencia unificada con el ecosistema nacional, trazabilidad completa y actualización en tiempo real.

El INSSJP-PAMI podrá habilitar canales propios complementarios, siempre que toda interacción quede registrada en el Sistema C.U.R.A. conforme inc. e).

e) Certificación de Interoperabilidad para Desarrollos Propios del INSSJP–PAMI

Todo sistema, plataforma, portal o aplicación digital desarrollado o adquirido por el INSSJP–PAMI con posterioridad a la vigencia de la presente ley, que tenga por objeto la gestión asistencial, farmacéutica o administrativa de sus afiliados, deberá:

1) Garantizar interoperabilidad plena con el Sistema C.U.R.A. mediante las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) seguras definidas por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. conforme el Artículo 15.
2) No implicar duplicación de registros identificatorios de pacientes de forma incompatible con el CURA-ID (Artículo 17 BIS).
3) Garantizar la transmisión de trazabilidad de medicamentos al RDDT (Artículo 20) conforme los estándares técnicos vigentes.
4) Obtener, previamente a su implementación, la Certificación de Interoperabilidad emitida por la Autoridad de Aplicación del Sistema C.U.R.A., la que se pronunciará en un plazo máximo de SESENTA (60) días hábiles desde la presentación de la documentación técnica completa. El vencimiento de dicho plazo sin pronunciamiento implicará aprobación tácita.

La certificación prevista en el presente inciso no exime del cumplimiento del principio de no duplicación establecido en el inciso a), ni sustituye el informe técnico fundado allí requerido cuando el desarrollo proyectado involucre funcionalidades sustancialmente equivalentes a módulos plenamente operativos del Sistema C.U.R.A.

La Certificación de Interoperabilidad verifica exclusivamente el cumplimiento de los estándares técnicos de integración y no constituye autorización ni aprobación del sistema propio del INSSJP-PAMI, cuya gestión, adquisición y mantenimiento permanecen bajo su exclusiva autonomía institucional conforme la Ley 19.032.

Los sistemas existentes del INSSJP-PAMI a la fecha de promulgación de la presente ley quedan alcanzados por el régimen de transición del Artículo 47 inc. e.2), sin requerir certificación retroactiva, debiendo adecuarse en el plazo del cronograma del Artículo 47 inc. c).

f) Accesibilidad y Atención Alternativa.

Se garantizarán canales presenciales o asistidos para afiliados que no posean conectividad o habilidades digitales suficientes, sin afectar el registro digital obligatorio de las prestaciones.

ARTÍCULO 49.- Adecuación del modelo prestacional y garantía de libre elección.

Establécese que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en el marco de su autonomía institucional conforme la Ley 19.032, deberá adecuar progresivamente su modelo de atención primaria a los principios de continuidad del cuidado, coordinación clínica digital e integración plena al Sistema C.U.R.A., garantizando en todos los casos la libertad de elección del afiliado.

a) Principios Rectores de la Adecuación:

1) Continuidad y longitudinalidad del cuidado.
2) Coordinación digital obligatoria a través del Sistema C.U.R.A.
3) Eliminación de barreras burocráticas innecesarias.
4) Respeto irrestricto a la libre elección del afiliado.

b) Garantías Obligatorias para el Afiliado:

1) Libertad plena para elegir y cambiar profesional referente o prestador dentro de la cartilla vigente, sin restricciones, penalidades ni períodos de carencia.
2) Eliminación de exigencias administrativas presenciales para obtención de recetas, correcciones, autorizaciones o derivaciones cuando estas puedan gestionarse digitalmente.
3) Implementación obligatoria de receta electrónica interoperable y teleconsulta como modalidad complementaria de atención.
4) Acceso digital inmediato a su historial clínico, derivaciones y estado de trámites a través del Sistema C.U.R.A. integrado a la plataforma oficial de identidad digital del Estado Nacional o la que en el futuro la sustituya o actualice.

c) Modalidad Operativa.

El Directorio de PAMI, en ejercicio de su autonomía institucional conforme Ley 19.032,

definirá el modelo operativo específico de atención primaria (médico referente, equipos interdisciplinarios u otros esquemas equivalentes), siempre que se respeten los principios y garantías establecidos en el presente artículo.

d) Prohibición de Restricciones.

Queda expresamente prohibido:

Imponer afiliación obligatoria a un profesional determinado sin posibilidad de cambio.

Establecer días específicos obligatorios para emisión de recetas o autorizaciones.

Exigir trámites presenciales cuando la gestión digital resulte técnicamente viable.

ARTÍCULO 50.- Aplicación del régimen de prescripción electrónica extendida.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) deberá garantizar la plena aplicación del régimen de videoconsulta y prescripción electrónica extendida previsto en el Artículo 19 QUINQUIES de la presente ley.

a) Garantías operativas.

1) Ningún afiliado deberá concurrir presencialmente para la mera renovación administrativa de tratamientos crónicos cuando el profesional tratante considere que puede instrumentarse mediante prescripción electrónica extendida.
2) Las dispensaciones deberán registrarse obligatoriamente en el Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT).
3) El sistema deberá impedir exigencias burocráticas adicionales no previstas en la presente ley.

b) Evaluación institucional.

PAMI deberá incluir en su Informe Anual indicadores específicos sobre:

1) Adherencia terapéutica en afiliados con prescripción extendida.
2) Reducción de consultas presenciales innecesarias.
3) Seguridad clínica y eventos adversos reportados.

ARTÍCULO 51.- Modernización integral de la gestión de medicamentos del INSSJP–PAMI.

Dispónese que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) deberá adoptar de manera obligatoria el módulo nacional de medicación digital del Sistema C.U.R.A., adecuando sus circuitos administrativos, contractuales y tecnológicos para garantizar una gestión farmacéutica completamente digital, interoperable y trazable.

a) Receta Electrónica Integrada.

La Receta Electrónica PAMI–C.U.R.A. constituirá el único instrumento válido de prescripción para medicamentos con cobertura del Instituto, conforme el régimen establecido en los Artículos 19 QUINQUIES y 20 de la presente ley.

Toda prescripción deberá emitirse con firma digital del profesional habilitado y registrarse automáticamente en el Sistema C.U.R.A.

b) Dispensación 100 % Digital.

El proceso de validación, autorización y dispensación de medicamentos en farmacias adheridas deberá realizarse de forma íntegramente digital, sin utilización de soportes físicos como requisito de facturación o auditoría.

La validación prestacional, cobertura y autorización quedarán registradas electrónicamente con sello de tiempo y firma digital correspondiente.

c) Eliminación del troquel físico.

El Instituto quedará plenamente alcanzado por el régimen de sustitución del troquel físico establecido en el Artículo 20.

En consecuencia, no podrá exigir troqueles físicos ni documentación en papel cuando la dispensación se encuentre debidamente registrada en el Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT) con efecto liberatorio.

d) Registro automático y trazabilidad.

Toda dispensa de medicamentos con cobertura PAMI deberá cargarse automáticamente en el Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT), integrado en tiempo real con el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos administrado por la ANMAT.

El registro digital constituirá prueba suficiente y preferente de la entrega del medicamento al afiliado.
En caso de indisponibilidad técnica del Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT) por causas atribuibles a la plataforma nacional, las farmacias podrán dispensar medicamentos correspondientes a tratamientos crónicos previamente registrados en el sistema, generando comprobante digital o físico de emergencia con identificación del afiliado, profesional prescriptor y medicamento dispensado, el cual tendrá plena validez legal y prestacional. La información deberá sincronizarse dentro de las VEINTICUATRO (24) horas posteriores al restablecimiento del servicio. La Autoridad de Aplicación llevará registro público de indisponibilidades certificadas.

e) Stock en tiempo real.

El Instituto deberá garantizar la interoperabilidad necesaria para que el afiliado pueda visualizar, a través del Portal del Paciente del Sistema C.U.R.A. o la plataforma digital que lo sustituya en el futuro, la disponibilidad de stock en farmacias adheridas.

La información de stock se limitará a datos operativos agregados, preservando la confidencialidad comercial y los estándares de seguridad establecidos por la reglamentación.

f) Adecuación contractual y administrativa.

El Instituto deberá:

1) Modificar sus convenios con farmacias y prestadores para incorporar como condición obligatoria el uso del RDDT.
2) Adaptar sus procesos de auditoría médica y administrativa al esquema de auditoría digital previsto en la presente ley.
3) Implementar progresivamente estas medidas conforme el cronograma general establecido en la Disposición Transitoria Undécima y los principios de eficiencia presupuestaria del Artículo 35.

ARTÍCULO 52.- Integración del INSSJP–PAMI al Módulo Nacional de Detección de Duplicaciones e Inconsistencias Prestacionales.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI)

deberá integrarse obligatoriamente al Módulo Nacional de Detección de Duplicaciones, Sobreactuación e Inconsistencias Prestacionales establecido en el Artículo 24 BIS de la presente ley.

a) Alcance de la Integración.

La integración comprenderá:

1) La interoperabilidad técnica plena entre los sistemas de auditoría y gestión del INSSJP–PAMI y el módulo nacional.
2) El envío automático y periódico de datos prestacionales necesarios para el análisis de duplicaciones, sobreactuación e inconsistencias, respetando los principios de minimización y protección de datos personales.
3) La recepción y tratamiento interno de las alertas generadas por el módulo, conforme los procedimientos de auditoría propios del Instituto.

b) Validación Humana Obligatoria.

Toda alerta generada respecto de prestaciones financiadas por el INSSJP–PAMI deberá ser evaluada por auditor médico humano antes de adoptar cualquier medida administrativa, contractual o disciplinaria.

En ningún caso el sistema automatizado podrá:

1) Rechazar automáticamente prestaciones.
2) Suspender pagos sin intervención humana.
3) Aplicar sanciones de manera autónoma.

b) Debido Proceso.

Cuando una alerta derive en observación o cuestionamiento de una prestación, el prestador involucrado deberá ser notificado fehacientemente y contará con un plazo no menor a VEINTE (20) días hábiles para presentar justificación clínica o administrativa, conforme la normativa aplicable al INSSJP–PAMI y los principios de debido proceso establecidos en la presente ley.

c) Autonomía Institucional.

El Directorio del INSSJP–PAMI definirá los protocolos operativos internos para la implementación del presente artículo, respetando sus facultades de administración conforme la Ley 19.032 y modificatorias, siempre que se garantice el cumplimiento de los principios de validación humana, transparencia y respeto de derechos establecidos en esta ley.

ARTÍCULO 53.- Gestión digital inteligente de traslados y derivaciones en el INSSJP–PAMI.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) deberá integrar sus procesos de traslado y derivación al Sistema C.U.R.A., garantizando coordinación digital, reducción de trámites y protección reforzada para afiliados en situación de vulnerabilidad.

a) Generación Automática para Afiliados Vulnerables.

Todo turno otorgado a un afiliado que registre en el Sistema C.U.R.A.:

1) Certificado de discapacidad vigente.
2) Movilidad reducida documentada.
3) Patología incapacitante registrada.
4) Indicación médica expresa de necesidad de traslado.

Generará automáticamente la pre-asignación digital de traslado, sin necesidad de trámite administrativo adicional por parte del afiliado.

b) Módulo de Gestión Digital.

El módulo permitirá:

1) Solicitud digital de traslados programados.
2) Derivaciones a especialistas o centros de mayor complejidad.
3) Coordinación automática entre turno médico y horario de transporte.
4) Trazabilidad del traslado efectuado.

c) Consentimiento del Afiliado.

Toda derivación o traslado programado requerirá consentimiento informado del afiliado,

quien podrá:

1) Aceptar la derivación sugerida.
2) Solicitar establecimiento alternativo dentro de la cartilla.
3) Rechazar la derivación, salvo en situaciones de urgencia o emergencia médica donde prevalecerá el criterio clínico del profesional tratante.

d) Optimización Asistencial.

El sistema podrá sugerir, sin carácter vinculante:

1) Establecimientos de destino considerando proximidad, disponibilidad y especialización.
2) Alternativas que eviten traslado físico cuando clínicamente adecuado, tales como:

    i) Interconsultas virtuales entre profesionales.
    ii) Evaluación remota de estudios diagnósticos.
    iii) Telediagnóstico asistido.

e) Accesibilidad y No Exclusión Digital.

La implementación de los módulos digitales de gestión no podrá implicar barrera alguna para afiliados que no cuenten con dispositivos, conectividad o habilidades digitales. PAMI deberá garantizar canales alternativos de gestión presencial o telefónica, así como mecanismos de representación digital por terceros debidamente autorizados, asegurando igualdad de acceso a las prestaciones.

La decisión final corresponderá siempre al profesional tratante.

f) Garantía de Traslado Necesario.

Cuando el traslado sea clínicamente necesario, el INSSJP–PAMI garantizará la provisión de transporte adecuado conforme:

1) Condición clínica del afiliado.
2) Grado de movilidad.
3) Nivel de riesgo asistencial durante el traslado.

El tipo de transporte será determinado conforme protocolos médicos y podrá incluir transporte común, vehículo adaptado o ambulancia con el nivel de complejidad que corresponda según indicación profesional.

El afiliado no abonará costo alguno cuando el traslado se encuentre autorizado conforme la normativa vigente.

En caso de indisponibilidad técnica del módulo digital de traslados por causas atribuibles al sistema nacional, el Instituto deberá garantizar la autorización por vía telefónica o presencial con posterior registro digital obligatorio dentro de las VEINTICUATRO (24) horas.

g) Prohibición de Denegación Encubierta.

La optimización digital de traslados no podrá utilizarse para:

1) Negar prestaciones médicamente indicadas.
2) Sustituir evaluación presencial cuando ésta sea clínicamente necesaria.
3) Imponer modalidades virtuales contra la voluntad del afiliado.

ARTÍCULO 54.- Integración del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) al Sistema Federal de Gestión de Turnos.

Dispónese la integración obligatoria del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) al Sistema Federal de Gestión de Turnos previsto en el Artículo 19 BIS de la presente ley.

a) Alcance de la Integración.

Las agendas de los prestadores propios y conveniados deberán integrarse progresivamente al sistema federal.

Los afiliados podrán buscar, solicitar, confirmar, cancelar o reprogramar turnos mediante los canales digitales oficiales del Sistema C.U.R.A.

b) Garantía de Canales Alternativos.

PAMI deberá mantener canales no digitales de acceso a turnos, incluyendo línea telefónica

con atención humana y gestión presencial.

Ningún afiliado podrá ser excluido o ver restringido su acceso a prestaciones por no utilizar herramientas digitales.

c) Implementación Progresiva.

1) La integración comenzará por establecimientos propios del Instituto.
2) Continuará con prestadores de mayor volumen asistencial.
3) Finalizará con consultorios individuales y pequeños prestadores.
4) El Directorio de PAMI establecerá el cronograma específico conforme criterios de conectividad, capacidad técnica y volumen de atención.

d) Asistencia Técnica.

PAMI deberá proveer capacitación y asistencia técnica gratuita a los prestadores para facilitar la integración de agendas, pudiendo estos:

1) Integrar sus sistemas mediante API seguras.
2) Utilizar la interfaz web oficial del Sistema C.U.R.A.

e) Excepciones Temporales.

Podrán otorgarse excepciones fundadas y temporales a:

1) Prestadores ubicados en zonas sin conectividad adecuada.
2) Profesionales próximos a jubilación con dificultades técnicas acreditadas.
3) Prestadores con volumen muy bajo de atención PAMI.

Las excepciones no podrán exceder de VEINTICUATRO (24) meses, renovables por única vez mediante resolución fundada.

ARTÍCULO 55.- Videoconsulta complementaria para afiliados del INSSJP–PAMI.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) implementará la modalidad de videoconsulta como complemento de la atención presencial, conforme lo dispuesto en el Artículo 19 QUINQUIES de la presente ley.

a) Alcance.

1) La videoconsulta estará disponible para seguimiento de patologías crónicas estabilizadas.

2) Renovación de tratamientos de mantenimiento cuando el profesional lo considere clínicamente procedente.

3) Revisión de estudios complementarios.

4) Interconsultas o asesoramientos que no requieran examen físico indispensable.

b) Autonomía Profesional.
El profesional tratante conserva plena autonomía para determinar la modalidad de atención más adecuada según criterio clínico.
Ningún profesional podrá ser obligado, sancionado ni evaluado negativamente por optar por atención presencial cuando lo considere necesario.

c) Derecho del Afiliado.
Todo afiliado conserva el derecho de optar por atención presencial, aun cuando su condición admita seguimiento por modalidad virtual.

d) Soporte y Accesibilidad.
PAMI deberá garantizar:

1) Plataforma tecnológica interoperable con el Sistema C.U.R.A.

2) Soporte técnico telefónico con asistencia humana.

3) Material explicativo accesible.

4) Asistencia presencial en centros de atención para afiliados con dificultades tecnológicas.

e) Implementación Progresiva.

El Directorio de PAMI establecerá el cronograma de implementación territorial y por especialidades, considerando criterios de conectividad, accesibilidad y seguridad asistencial.

ARTÍCULO 56.- Gestión digital integral de prótesis, órtesis e insumos especiales en el INSSJP–PAMI.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) deberá gestionar en forma íntegramente digital, a través del Sistema C.U.R.A., los trámites vinculados a la provisión de prótesis, órtesis e insumos médicos especiales.

a) Alcance.
La digitalización comprenderá:

1) Solicitud médica con firma digital.
2) Carga de indicación clínica y documentación respaldatoria.
3) Auditoría médica y administrativa.
4) Cotización y validación presupuestaria.
5) Autorización final.
6) Orden de provisión al proveedor.
7) Confirmación de entrega efectiva al afiliado.

b) Trazabilidad y Transparencia.
Cada etapa del trámite deberá:

1) Generar registro con sello de tiempo.
2) Identificar responsable interviniente.
3) Permitir seguimiento del estado en tiempo real por el afiliado.
4) Integrarse al Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría (Artículo 10).

c) Derecho del Afiliado.
El afiliado podrá visualizar en su perfil digital:

1) Estado actual del trámite.
2) Plazos estimados de resolución.
3) Observaciones o requerimientos pendientes.
4) Fecha estimada de entrega.

d) Contingencia.
En caso de indisponibilidad técnica del sistema, se aplicará el procedimiento de contingencia previsto en el Artículo 22, debiendo cargarse la información al sistema dentro de las DOCE (12) horas posteriores a su restablecimiento.

e) Implementación Progresiva.

El Directorio del INSSJP–PAMI establecerá cronograma de implementación territorial y por categoría de insumo, priorizando prótesis de alta complejidad y mayor impacto funcional.

ARTÍCULO 57.- Sistema de Notificaciones Inteligentes al Afiliado.

El INSSJP–PAMI deberá implementar un sistema de notificaciones automáticas integradas al Sistema C.U.R.A., destinadas a informar al afiliado sobre eventos relevantes vinculados a su atención y gestiones administrativas.

a) Eventos Mínimos Obligatorios.
El sistema notificará automáticamente cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

1) Un profesional o prestador deje de atender por PAMI.
2) Se produzcan modificaciones en su cobertura prestacional.
3) Una receta electrónica haya sido emitida o renovada.
4) Un turno haya sido confirmado, reprogramado o cancelado.
5) Un traslado haya sido autorizado o confirmado.
6) Una prótesis, órtesis o insumo especial haya sido aprobado.

b) Canales de Notificación.
Las notificaciones podrán realizarse mediante:

1) Aplicación móvil oficial integrada a Mi Argentina o la que la sustituya en el futuro.
2) Mensaje de texto (SMS).
3) Correo electrónico.
4) Llamado automatizado o comunicación telefónica asistida en casos de afiliados sin acceso digital.

c) Consentimiento y Preferencias.
El afiliado podrá configurar sus preferencias de notificación, sin que ello implique renuncia a recibir comunicaciones críticas vinculadas a su salud o derechos prestacionales.

d) Protección de Datos.

Las notificaciones deberán cumplir estrictamente con la Ley 25.326 y las disposiciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública, limitándose al contenido mínimo necesario para informar el evento sin revelar información clínica sensible en canales no seguros.

e) Principio de Accesibilidad.
PAMI deberá garantizar que los afiliados sin acceso o alfabetización digital puedan recibir notificaciones mediante canales alternativos accesibles, asegurando igualdad efectiva en el acceso a la información.

ARTÍCULO 58.- Programa Federal de Facilitadores Digitales PAMI.

El INSSJP–PAMI implementará el Programa Federal de Facilitadores Digitales, destinado a garantizar acompañamiento presencial y telefónico a afiliados con dificultades para utilizar las herramientas digitales del Sistema C.U.R.A.

a) Objeto.
El Programa tendrá por finalidad:

1) Reducir la brecha digital en personas mayores.
2) Asegurar igualdad real en el acceso a prestaciones digitales.
3) Facilitar la autogestión asistida de trámites, turnos y recetas electrónicas.

b) Funciones.
Los facilitadores digitales tendrán como funciones mínimas:

1) Asistir a afiliados en el uso del Portal del Paciente y/o aplicación móvil integrada a Mi Argentina o la que la sustituya en el futuro.
2) Gestionar turnos médicos digitales a solicitud del afiliado.
3) Orientar en la descarga y visualización de recetas electrónicas.
4) Brindar asistencia en trámites digitales vinculados a prótesis, traslados y autorizaciones.
5) Resolver incidencias técnicas básicas.

b) Despliegue Territorial.
El Programa deberá implementarse prioritariamente en:

1) 1. Agencias y oficinas de atención presencial de PAMI.

2) 2. Centros de jubilados que celebren convenios con el Instituto.

3) 3. Establecimientos de salud con alta concentración de afiliados.

La distribución territorial se definirá conforme criterios de densidad poblacional, perfil etario y nivel de conectividad de cada jurisdicción.

c) Canales Complementarios.
PAMI deberá mantener habilitado un número telefónico gratuito (0800) con atención humana para acompañamiento digital y gestión asistida de trámites, garantizando acceso para afiliados sin conectividad o sin dispositivos propios.

d) Capacitación y Protección de Datos.
Los facilitadores deberán recibir capacitación específica en:

1) Alfabetización digital adaptada a personas mayores.

2) Uso del Sistema C.U.R.A.

3) Protección de datos personales y confidencialidad.

4) Trato digno y accesible.

En ningún caso podrán acceder a información clínica sin autorización expresa del afiliado y dentro de los límites de su función de asistencia.

e) Evaluación.
El Programa será evaluado periódicamente por el Directorio de PAMI en función de:

1) Cantidad de afiliados asistidos.

2) Nivel de satisfacción.

3) Incremento en adopción digital.

Los resultados deberán incorporarse al Informe Anual previsto en el Artículo 43 SEXIES en lo pertinente.

ARTÍCULO 59.- Inclusión de afiliados no digitales y gestor delegado.

Los afiliados que no utilicen herramientas digitales, ya sea por edad, discapacidad, barreras tecnológicas o decisión personal, podrán designar un gestor delegado —familiar, conviviente o referente afectivo— autorizado a operar el Portal PAMI–C.U.R.A. en su nombre.

a) Designación formal.
La designación deberá realizarse mediante autorización expresa del afiliado, registrada en el Sistema C.U.R.A., pudiendo instrumentarse por vía digital o presencial ante dependencias del PAMI.

b) Alcance de la autorización.
El gestor delegado podrá gestionar turnos, consultar recetas, verificar estado de trámites, recibir notificaciones y realizar operaciones administrativas, sin que ello implique sustitución de la voluntad del afiliado en decisiones médicas.

c) Protección de datos.
El acceso del gestor delegado quedará sujeto a los mismos deberes de confidencialidad y protección de datos previstos en la presente ley. Toda operación realizada quedará registrada con trazabilidad digital.

d) Revocación.
El afiliado podrá revocar la autorización en cualquier momento, sin expresión de causa, por los mismos medios utilizados para su otorgamiento.

e) Garantía de no exclusión.
La designación de gestor delegado no será obligatoria ni condicionará el acceso a prestaciones. Ningún afiliado será excluido por no utilizar herramientas digitales.

ARTÍCULO 60.- Priorización sanitaria objetiva en el Sistema Federal de Turnos.

El Sistema Federal de Gestión de Turnos previsto en el Artículo 19 BIS podrá establecer mecanismos de priorización automática basados en criterios sanitarios objetivos y verificables, aplicables a todos los usuarios del Sistema C.U.R.A., incluyendo afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

a) Criterios de priorización.
La priorización podrá fundarse en:

1) Edad avanzada.
2) Condición de paciente crónico prioritario conforme Artículo 19 QUINQUIES.
3) Discapacidad o movilidad reducida registrada.

4) Patologías de riesgo o necesidad de seguimiento continuo.

5) Urgencia médica documentada.

6) Zonas críticas sanitarias conforme Artículo 43 QUATER.

b) No discriminación por financiador.
Queda prohibido establecer mecanismos de priorización automática exclusivamente por condición de afiliación a un financiador determinado. La aplicación de criterios sanitarios objetivos no se considerará discriminación indirecta por condición de afiliación cuando se funde exclusivamente en variables clínicas, epidemiológicas o de vulnerabilidad debidamente registradas en el sistema.

c) Transparencia algorítmica.
Los criterios de priorización deberán ser públicos, auditables y no discriminatorios, conforme las disposiciones del régimen de gobernanza algorítmica del Sistema C.U.R.A.

d) Finalidad sanitaria.
La priorización tendrá como única finalidad garantizar equidad en el acceso a la atención y no podrá utilizarse con fines comerciales, contractuales o de competencia entre financiadores.

ARTÍCULO 61.- Validación de identidad en las gestiones PAMI–C.U.R.A.

Toda gestión digital, presencial o remota realizada por afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en el marco del Sistema C.U.R.A. deberá ajustarse al régimen general de identificación y autenticación digital previsto en la presente ley.

a) Integración obligatoria.
PAMI utilizará exclusivamente los mecanismos de identidad digital interoperables definidos por la Autoridad de Aplicación del Sistema C.U.R.A., incluyendo el identificador único C.U.R.A.–ID y los sistemas oficiales de identidad digital del Estado Nacional.

b) Prohibición de sistemas paralelos.
Queda prohibida la creación o mantenimiento de sistemas de autenticación paralelos, redundantes o incompatibles que generen duplicación de registros o barreras de acceso para los afiliados.

c) Principios rectores.
Los mecanismos de validación de identidad deberán garantizar:

1) Seguridad por diseño.
2) Protección de datos personales.
3) Accesibilidad para personas mayores y con discapacidad.
4) Alternativas presenciales o asistidas para quienes no puedan utilizar medios digitales.

d) Actualización tecnológica.
La enumeración específica de tecnologías de autenticación será determinada por la reglamentación, a fin de permitir su actualización sin necesidad de modificación legislativa.

ARTÍCULO 62.- Despapelización progresiva e integral en el ámbito del PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) implementará un proceso progresivo de despapelización integral de sus trámites administrativos, prestaciones médicas, auditorías y procesos internos, en el marco del Sistema C.U.R.A.

a) Sustitución digital obligatoria.
Toda nueva gestión, autorización, auditoría, prescripción o trámite iniciado con posterioridad a la implementación correspondiente deberá realizarse en formato digital mediante el Sistema C.U.R.A., salvo las contingencias técnicas previstas en la presente ley.

b) Validez jurídica.
Los registros digitales generados en el Sistema C.U.R.A. tendrán pleno valor legal, probatorio y administrativo equivalente al soporte papel, conforme la normativa vigente sobre firma digital y documentos electrónicos.
La presente equiparación de validez jurídica alcanza exclusivamente a normas nacionales, reglamentaciones del Poder Ejecutivo Nacional y disposiciones del INSSJP–PAMI. Las normas provinciales que establezcan requisitos de soporte papel en el ámbito de su competencia continuarán vigentes hasta tanto cada jurisdicción adhiera expresamente al presente régimen conforme el mecanismo previsto en el Artículo 26.

c) Digitalización de archivos preexistentes.
PAMI desarrollará un plan de digitalización progresiva de archivos físicos existentes,

priorizando:

1) Historias clínicas activas.
2) Trámites administrativos en curso.
3) Expedientes con impacto prestacional o judicial vigente.

La digitalización deberá garantizar integridad, autenticidad y trazabilidad de la documentación.

d) Conservación y expurgo.
La eliminación o expurgo de documentación física solo podrá realizarse una vez:

1) Digitalizada con certificación de integridad.
2) Cumplidos los plazos legales de conservación aplicables.
3) Emitido acto administrativo fundado que autorice su destrucción.

e) Contingencias técnicas.
En caso de indisponibilidad del sistema, se aplicará el modo de contingencia digital previsto en la presente ley, con posterior sincronización obligatoria.

f) Gradualidad.
El proceso completo de despapelización deberá ejecutarse en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses desde el inicio de implementación, pudiendo el Directorio establecer cronogramas internos por fases operativas.

ARTÍCULO 63.- Régimen de Contingencia Digital en el ámbito del PAMI

En el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), las situaciones de indisponibilidad total o parcial del Sistema C.U.R.A. se regirán por el Modo de Contingencia Digital previsto en el Artículo 22 de la presente ley, con las siguientes particularidades:

a) Activación.
El modo de contingencia podrá activarse cuando se verifique:

1) Caída de conectividad del establecimiento prestador.
2) Interrupción del suministro eléctrico.

3) Indisponibilidad técnica certificada del Sistema C.U.R.A.

4) Fallas generalizadas en plataformas integradas de PAMI.

b) Registro local encriptado.
Toda prestación realizada durante la contingencia deberá registrarse en soporte digital local encriptado o en mecanismo alternativo autorizado, garantizando:

1) Identificación del profesional interviniente.

2) Identificación del afiliado.

3) Fecha y hora de la prestación.

4) Tipo de práctica o prescripción realizada.

c) Sincronización obligatoria.
Restablecido el servicio, la información deberá sincronizarse con el Sistema C.U.R.A. dentro de las doce (12) horas siguientes.
En zonas rurales o con conectividad intermitente acreditada, el plazo podrá extenderse hasta veinticuatro (24) horas.

d) Validez jurídica.
Las prestaciones realizadas durante el período de contingencia tendrán plena validez prestacional y administrativa, siempre que cumplan con el procedimiento establecido y sean posteriormente sincronizadas en término.

e) Auditoría posterior.
El Sistema generará registro automático de activaciones del modo de contingencia, quedando sujetas a auditoría posterior por parte de PAMI y la Autoridad de Aplicación, a fin de prevenir uso indebido o reiterado injustificado.

f) Prohibición de abuso.
La utilización sistemática del modo de contingencia sin causa técnica acreditable podrá constituir incumplimiento conforme el régimen sancionatorio aplicable.

ARTÍCULO 64.- Garantía de estabilidad laboral y reconversión funcional en el PAMI

La implementación del Sistema C.U.R.A. y la modernización digital del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) no constituirán causal de despido, cesantía ni reducción arbitraria de personal.

a) Principio de estabilidad.
El personal de PAMI conservará:

1) Su estabilidad laboral conforme el régimen jurídico aplicable.
2) La antigüedad adquirida.
3) Su categoría y nivel escalafonario.
4) Su remuneración básica y complementaria.

b) Reconversión funcional obligatoria.

Cuando la digitalización implique modificación o supresión de tareas administrativas presenciales, el Instituto deberá implementar un Programa de Reconversión Funcional destinado a reasignar al personal afectado a funciones compatibles con el nuevo entorno digital, tales como:

1) Facilitación digital y asistencia a afiliados.
2) Soporte técnico y administrativo remoto.
3) Auditoría digital y control de calidad de datos.
4) Acompañamiento presencial prioritario a afiliados vulnerables.
5) Otras funciones de valor agregado no automatizables.

c) Capacitación previa y gratuita.
Toda reconversión deberá estar precedida por capacitación específica:

1) Gratuita para el trabajador.
2) Impartida dentro de la jornada laboral.
3) Con certificación formal de competencias adquiridas.

d) Participación sindical.
Los planes de reconversión deberán ser informados y consultados con las representaciones sindicales correspondientes, conforme la normativa laboral vigente.

e) Prohibición de precarización.
Queda prohibido:

1) Reducir remuneraciones como consecuencia de la reconversión.
2) Degradar categoría o funciones en forma arbitraria.
3) Utilizar la digitalización como mecanismo indirecto de presión para renuncias o retiros forzados.

f) Facultades organizativas.
Lo dispuesto en el presente artículo no limita las facultades de reorganización administrativa del Instituto, siempre que se respeten los derechos laborales adquiridos y el régimen jurídico aplicable.

TÍTULO X - GOBERNANZA, ÉTICA Y MARCO PROGRESIVO DE IA

CAPÍTULO 1 - PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA DE CONTROL

ARTÍCULO 65.- Principios Rectores de la IA en Salud.

El desarrollo e implementación de módulos de IA en el Sistema C.U.R.A. se regirá estrictamente por:

a) Supervisión Humana Permanente: La IA funcionará como herramienta de asistencia y nunca sustituirá el juicio clínico profesional.
b) Progresividad: La implementación será gradual, comenzando por herramientas de bajo riesgo.
c) Validación Previa: Ningún algoritmo operará con pacientes reales sin certificación técnica y ética previa.
d) Modularidad: Los fallos en un módulo de IA no deberán afectar la operatividad del sistema clínico central.
e) Auditoría Continua: Se monitoreará el desempeño de los algoritmos post-implementación para detectar sesgos o errores.

ARTÍCULO 65 BIS.- Clasificación de Riesgo de los Módulos de IA.

Los módulos de Inteligencia Artificial que se integren al Sistema C.U.R.A. deberán clasificarse conforme a su nivel de impacto potencial en la seguridad del paciente y en la toma de decisiones clínicas, en las siguientes categorías:

a) Nivel I – Bajo Riesgo: Herramientas administrativas, organizativas o de soporte no clínico directo.

b) Nivel II – Riesgo Moderado: Sistemas de asistencia clínica no decisoria o de apoyo diagnóstico, cuya intervención requiera validación profesional obligatoria.

c) Nivel III – Alto Riesgo: Sistemas cuyos resultados impacten de manera directa en decisiones terapéuticas, priorización clínica, triage automatizado o gestión crítica de recursos asistenciales.

d) Evaluación de conformidad independiente para módulos Nivel III.

Los módulos de IA clasificados como Nivel III — Alto Riesgo deberán someterse, antes de la evaluación del Subcomité del Artículo 66, a una auditoría técnica externa realizada por un Organismo de Evaluación de Conformidad en IA Sanitaria (OECAIS), acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) conforme la norma ISO/IEC 17065 y los criterios técnicos específicos para la evaluación de sistemas de IA en salud que establezca la Autoridad de Aplicación mediante resolución fundada, con intervención del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial, conforme los siguientes requisitos:

1. Independencia orgánica, funcional y financiera respecto del desarrollador del módulo, del prestador que lo utilice y del Estado Nacional.

2. Capacidad técnica específica en validación de modelos de IA para uso clínico, acreditada mediante panel de expertos en inteligencia artificial, bioestadística y medicina clínica, según criterios objetivos fijados por la reglamentación.

3. Ausencia de conflicto de interés con el sistema evaluado, declarada bajo responsabilidad y verificada anualmente.

4. Cobertura de seguro de responsabilidad profesional adecuada a la naturaleza vinculante del dictamen.

La Autoridad de Aplicación mantendrá el Registro Público de OECAIS acreditados, actualizado semestralmente.

El dictamen del OECAIS tendrá naturaleza de pericia técnica obligatoria. El órgano decisor final será el Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial previsto en el Artículo 66, el cual no podrá autorizar un módulo Nivel III cuando el dictamen identifique riesgos críticos no mitigados, pero sí podrá rechazar un módulo que el OECAIS no haya objetado si detecta riesgos adicionales no evaluados.

Cuando el dictamen del OECAIS identifique riesgos críticos no mitigados, la autorización de despliegue quedará automáticamente suspendida hasta que el desarrollador acredite su mitigación técnica y obtenga dictamen complementario

favorable del OECAIS y resolución aprobatoria del Subcomité.

Los costos de la auditoría externa serán soportados por el solicitante de la certificación. La Autoridad de Aplicación fijará el arancel máximo para garantizar proporcionalidad y accesibilidad del proceso de certificación.

La reglamentación establecerá los requisitos técnicos, éticos y de validación proporcionales a cada nivel de riesgo, garantizando el principio de proporcionalidad y la seguridad del paciente.

ARTÍCULO 65 TER.- Sistemas de Inteligencia Artificial Prohibidos.

Queda prohibido el desarrollo, implementación o utilización en el Sistema C.U.R.A. de sistemas de inteligencia artificial que:

a) Sustituyan completamente el juicio clínico profesional, adoptando decisiones diagnósticas, terapéuticas o pronósticas de manera autónoma sin validación humana calificada obligatoria.

b) Realicen perfilamiento, segmentación o priorización de pacientes basados en características protegidas (edad, género, origen étnico, discapacidad, condición socioeconómica u otras) que generen discriminación en el acceso a servicios, calidad de atención o asignación de recursos.
Queda exceptuado el uso de variables científicamente justificadas con finalidad epidemiológica, preventiva o terapéutica, siempre que no produzcan trato arbitrario o exclusión indebida.

c) Denieguen o limiten automáticamente prestaciones sanitarias, autorizaciones o coberturas sin revisión humana obligatoria y fundamento clínico individualizado.

d) Realicen identificación biométrica masiva, vigilancia sanitaria poblacional o seguimiento no consentido con fines ajenos a la atención médica individual, investigación científica debidamente autorizada o salud pública.
No se considerará alcanzada por esta prohibición la autenticación biométrica individual basada en consentimiento expreso, utilizada exclusivamente para el acceso del titular a sus propios datos de salud.

e) Generen riesgos graves e incompatibles con los derechos fundamentales a la vida, salud, intimidad, dignidad y no discriminación, cuando del análisis de impacto previo realizado por el OECAIS surja que:

1) Existe probabilidad significativa de daño grave individual o colectivo; y

2) Dicho riesgo no pueda reducirse a un nivel residual aceptable mediante salvaguardas técnicas, organizativas o de supervisión humana conforme el estado del arte

La determinación del nivel de riesgo residual aceptable deberá fundarse en criterios técnicos objetivos, documentados y auditables, establecidos por reglamentación y publicados previamente.

La implementación o utilización de sistemas prohibidos conforme el presente artículo constituirá falta gravísima, dará lugar al retiro inmediato del módulo del RENIA-Salud y podrá generar responsabilidad administrativa, civil o penal conforme la legislación vigente.

ARTÍCULO 66.- Subcomité Técnico de Ética e Inteligencia Artificial en Salud.

El Subcomité Técnico de Ética e Inteligencia Artificial en Salud, creado en el Artículo 8 de la presente ley, actuará como órgano técnico especializado responsable de la evaluación ética, certificación técnica y supervisión continua de todos los módulos de inteligencia artificial implementados en el Sistema C.U.R.A.

a) Funciones indelegables:

1) Evaluación previa obligatoria.

Evaluar y autorizar técnicamente cada módulo de inteligencia artificial antes de su activación en entorno productivo, verificando el cumplimiento de:

i) Los principios del Artículo 65.

ii) Las prohibiciones del Artículo 65 TER.

iii) Los estándares de seguridad, privacidad y calidad de datos.

iv) La ausencia de sesgos discriminatorios clínicamente relevantes.

2) Protocolos de validación algorítmica.
Establecer los protocolos técnicos de validación, incluyendo:

i) Métricas de desempeño (precisión, sensibilidad, especificidad u otras pertinentes).

ii) Métodos de detección de sesgos.

iii) Requisitos mínimos de transparencia y explicabilidad.

iv) Umbrales técnicos de aceptación para puesta en producción.

3) Supervisión post-implementación.
Supervisar el desempeño de los módulos de IA en operación mediante el análisis de:

i) Reportes periódicos de desempeño.

ii) Eventos adversos asociados a su utilización.

iii) Indicadores de desviación técnica o clínica.

4) Monitoreo continuo obligatorio.
Establecer un sistema permanente de monitoreo técnico-ético que permita detectar desviaciones, degradación del rendimiento o riesgos emergentes.

5) Facultad de recomendación vinculante.
Recomendar a la Autoridad de Aplicación o al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.:

i) La suspensión preventiva de un módulo ante riesgo grave o inminente para la seguridad del paciente.

ii) El retiro definitivo cuando se verifiquen incumplimientos sustanciales o riesgos incompatibles con la presente ley.

En casos de urgencia, la suspensión preventiva inmediata sólo procederá cuando el Subcomité acredite mediante resolución técnica fundada la concurrencia simultánea de:

a) un riesgo cierto, actual y no meramente hipotético para la seguridad del paciente;

b) la imposibilidad de mitigación inmediata mediante ajustes parciales o limitaciones operativas del módulo; y

c) la notificación fehaciente al desarrollador con una antelación mínima de VEINTICUATRO (24) horas, salvo que se acredite riesgo de daño grave e irreversible que torne materialmente imposible dicha notificación previa.

La medida deberá ser revisada por el Consejo Nacional en el plazo máximo de QUINCE (15) días. Sin perjuicio de ello, el desarrollador podrá solicitar revisión judicial conforme la normativa vigente.

b) Articulación institucional.
El Subcomité actuará en coordinación con la Comisión Nacional de Bioética en los casos

que presenten dilemas bioéticos complejos, pudiendo requerir dictámenes consultivos no vinculantes.

c) Publicidad y transparencia.
El Subcomité deberá publicar semestralmente un informe agregado sobre:

1) Módulos evaluados.
2) Módulos aprobados o suspendidos.
3) Principales métricas técnicas de desempeño.

La información técnica sensible o protegida por secreto industrial podrá resguardarse conforme reglamentación.

CAPÍTULO 2 - REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PROGRESIVA

ARTÍCULO 67.- Registro Nacional de Módulos de Inteligencia Artificial en Salud (RENIA-Salud).

Créase el Registro Nacional de Módulos de Inteligencia Artificial en Salud (RENIA-Salud), de carácter obligatorio para toda herramienta o sistema de inteligencia artificial que pretenda integrarse al Sistema C.U.R.A.

a) Requisito previo obligatorio.
Ningún módulo de inteligencia artificial podrá ser implementado, activado en entorno productivo ni utilizado con datos reales de pacientes sin previa inscripción, certificación técnica y autorización expresa de despliegue en el RENIA-Salud.

b) Requisitos de inscripción y certificación.
Para su inscripción y autorización de despliegue, los módulos deberán demostrar:
1) Validación técnica y clínica en entornos controlados o simulados.
2) Evaluación de impacto ético favorable emitida por el Subcomité previsto en el Artículo 66.
3) Plan de capacitación obligatorio para los usuarios profesionales.
4) Protocolos de auditoría y monitoreo continuo post-implementación.

5) Mecanismos de "fallback" o retorno inmediato a operación manual segura ante malfuncionamiento, degradación de desempeño o suspensión preventiva.

c) Actualización obligatoria.
Toda modificación sustancial del modelo, incluyendo cambios en arquitectura, datos de entrenamiento, parámetros críticos, umbrales decisorios o finalidad clínica, requerirá nueva evaluación y actualización obligatoria en el RENIA-Salud antes de su despliegue.

d) Contenido mínimo del Registro.
El RENIA-Salud deberá contener como mínimo:

1) Nivel de riesgo asignado conforme Artículo 65 BIS.
2) Fecha de certificación inicial.
3) Versión del modelo autorizado.
4) Fecha de próxima revisión obligatoria.
5) Estado del módulo (activo, en revisión, suspendido o retirado).
6) Resumen público del dictamen ético y técnico.

e) Publicidad y confidencialidad.
El Registro será de acceso público respecto de la información esencial, garantizando transparencia del sistema. La información técnica sensible o protegida por secreto industrial podrá resguardarse conforme reglamentación, sin afectar el derecho ciudadano a conocer el nivel de riesgo y estado de cada módulo.

ARTÍCULO 67 BIS.- Repositorio Nacional de Datos Anonimizados para Investigación, Salud Pública e Innovación Tecnológica en Salud

Créase el Repositorio Nacional de Datos Anonimizados del Sistema C.U.R.A. (en adelante, el Repositorio), como infraestructura pública estratégica de datos sanitarios destinada exclusivamente a la investigación científica, la formulación de políticas públicas sanitarias, la vigilancia epidemiológica y el desarrollo tecnológico en salud con finalidad de interés público, bajo soberanía digital nacional y control institucional permanente del Estado.

El presente artículo regula tanto el régimen general del Repositorio como el Entorno Controlado de Innovación en Salud (Sandbox de IA), que constituye una modalidad restringida y supervisada de acceso a los datos del Repositorio con fines de desarrollo y validación de sistemas de inteligencia artificial.

SECCIÓN I — REPOSITORIO NACIONAL DE DATOS ANONIMIZADOS

a) Soberanía y residencia de datos.

El procesamiento y almacenamiento del Repositorio deberá realizarse prioritariamente en infraestructura radicada en territorio argentino o bajo jurisdicción nacional, utilizando como nodo principal los centros de datos de ARSAT S.E., conforme lo establecido en el Artículo 71 de la presente ley. Cuando la capacidad técnica disponible de ARSAT S.E. resulte insuficiente para garantizar los niveles de disponibilidad, seguridad y latencia requeridos, la Autoridad de Aplicación podrá habilitar, mediante resolución fundada y dictamen previo de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), el uso de infraestructura complementaria bajo jurisdicción nacional o que garantice equivalencia jurídica de protección conforme el Artículo 71. En todos los casos, las claves criptográficas maestras y los mecanismos de cifrado quedarán bajo control exclusivo del Estado Nacional, garantizando inmunidad soberana frente a requerimientos extraterritoriales.

b) Anonimización: proceso, estándares y reconocimiento de riesgo residual.

Los datos incluidos en el Repositorio deberán someterse obligatoriamente a procesos de anonimización mediante técnicas combinadas y auditables que reduzcan razonablemente el riesgo de identificación directa o indirecta de personas físicas. La anonimización deberá incluir, según el tipo de dato y el riesgo de reidentificación evaluado, al menos dos de las siguientes metodologías: supresión de identificadores directos, generalización de variables sensibles, agregación territorial proporcional al riesgo, k-anonymity, diversidad de atributos sensibles (l-diversity), privacidad diferencial u otras metodologías equivalentes reconocidas internacionalmente.

A los efectos operativos, y a fin de garantizar un umbral técnico de referencia verificable, se establecen los siguientes parámetros orientadores de protección:

Privacidad diferencial: el parámetro epsilon (ε) no excederá, como referencia inicial, el valor de 2,0 para conjuntos con variables individualizables, ni de 5,0 para estadísticas agregadas sin identificadores directos, conforme estándares del NIST SP 800-226 u organismo técnico de reconocido prestigio equivalente. El Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., previo dictamen del CSRNA y de la AAIP, podrá actualizar estos valores mediante resolución fundada cuando la evolución del estado del arte tecnológico, la disponibilidad de nuevas metodologías de protección o el resultado de evaluaciones periódicas de riesgo así lo justifiquen. Toda actualización que implique una relajación de los parámetros requerirá dictamen favorable de la AAIP.

K-anonymity: todo dataset con variables combinadas de diagnóstico, edad y localidad deberá garantizar k ≥ 5 como umbral mínimo de referencia. El CSRNA podrá exigir valores superiores en función del perfil de riesgo del proyecto específico o de las características del conjunto de datos. La reducción del valor de k

por debajo del umbral de referencia solo procederá mediante autorización expresa de la AAIP, fundada en evaluación técnica independiente que acredite la adecuación compensatoria de otras medidas de protección aplicadas.

Evaluación periódica del riesgo residual: la Autoridad de Aplicación realizará evaluaciones técnicas del riesgo de reidentificación con periodicidad no mayor a dos (2) años, o ante cualquier cambio metodológico sustancial o incorporación masiva de nuevos datos al Repositorio, pudiendo imponer técnicas adicionales o restricciones de acceso cuando el nivel de riesgo así lo requiera.

En ningún caso se presumirá la anonimización absoluta de los datos. La presencia de riesgo residual verificable implicará la aplicación de medidas de mitigación adicionales o, si fuere irreducible a nivel aceptable, la restricción del acceso al dato afectado.

c) Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) previa obligatoria.

Toda incorporación masiva de nuevos conjuntos de datos al Repositorio, así como todo cambio sustancial en las finalidades, los sistemas de acceso o los módulos de inteligencia artificial que lo utilicen, requerirá la realización previa de una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD). La EIPD deberá:

1) Describir sistemáticamente el tratamiento y sus finalidades.
2) Evaluar la necesidad y proporcionalidad del tratamiento respecto del objetivo perseguido.
3) Identificar y cuantificar los riesgos para los derechos y libertades de los titulares de datos.
4) Establecer las medidas previstas para mitigar dichos riesgos, incluyendo técnicas de anonimización seleccionadas.
5) Incluir análisis de alternativas técnicas menos intrusivas disponibles.

La EIPD será sometida a consulta previa del Comité de Supervisión del Repositorio Nacional de Datos Anonimizados (CSRNA) y de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que dispondrán de noventa (90) días para emitir dictamen. Vencido dicho plazo sin pronunciamiento, el silencio se considerará no objeción, habilitando a la Autoridad de Aplicación a continuar el proceso con las medidas de mitigación propuestas, dejando constancia de ello en el expediente. La Autoridad de Aplicación deberá publicar su respuesta motivada a las observaciones formuladas cuando se hubiere emitido dictamen expreso.

d) Finalidad exclusiva y prohibición de usos secundarios no autorizados.

Los datos del Repositorio no podrán utilizarse para fines comerciales ajenos a la salud pública, perfilamiento individual, discriminación en seguros, empleo o crédito, decisiones automatizadas individualizadas, scoring individual sanitario, fijación de primas de seguros de vida o salud, evaluación actuarial individual, segmentación discriminatoria de cobertura, ni

para cualquier mecanismo que implique discriminación basada en condiciones de salud, dentro o fuera del territorio nacional.

e) Prohibición de reidentificación.

Queda expresamente prohibido cualquier intento de reidentificación directa o indirecta, cruce con bases de datos externas o inferencia individual, constituyendo falta gravísima conforme el régimen sancionatorio de la presente ley. El intento de reidentificación implicará rescisión inmediata del acuerdo de acceso, inhabilitación permanente para participar del régimen y las sanciones administrativas y penales correspondientes.

f) Autorización formal, temporal y control institucional.

Todo acceso requerirá autorización expresa de la Autoridad de Aplicación, previo dictamen técnico del Comité de Supervisión del Repositorio (CSRNA) y evaluación de proporcionalidad, finalidad, riesgo de reidentificación y metodología aplicada. El acceso se concederá por proyecto específico, plazo determinado y finalidad declarada, sin que el otorgamiento de un acceso previo genere derecho preferente alguno sobre accesos futuros.

El dictamen del CSRNA tendrá carácter vinculante cuando identifique riesgos de reidentificación críticos no mitigados o cuando el proyecto involucre tratamiento de datos de categorías especialmente sensibles conforme la Ley N° 25.326. En los restantes supuestos, el dictamen tendrá carácter técnico consultivo de alta ponderación. Si la Autoridad de Aplicación decidiere apartarse de un dictamen consultivo desfavorable del CSRNA, deberá hacerlo mediante resolución fundada que especifique las medidas de mitigación adicionales adoptadas para compensar los riesgos señalados, la cual será publicada en el portal oficial del Sistema C.U.R.A. y comunicada a la AAIP dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

g) Acceso de entidades privadas.

Cuando el acceso sea solicitado por entidades privadas, el mismo quedará restringido a consorcios de investigación en salud que acrediten la participación efectiva, en carácter de co-ejecutor, de al menos una universidad nacional, organismo del sistema científico-tecnológico nacional (CONICET, INTA, INTI u organismos equivalentes) o institución hospitalaria pública nacional o provincial.

En estos casos, la Autoridad de Aplicación podrá establecer condiciones específicas de transferencia tecnológica, licenciamiento razonable, acceso preferencial para el sistema público o participación estatal en desarrollos estratégicos, conforme el interés público comprometido. No se considerarán entidades con finalidad de interés público a los efectos del presente inciso las personas jurídicas cuya actividad principal sea la prestación lucrativa de servicios de análisis de datos, seguros de salud, crédito o empleo.

h) Entornos de computación segura y régimen de extracción de resultados.

Todo procesamiento de datos del Repositorio por parte de terceros deberá realizarse dentro de entornos de computación segura habilitados por la Autoridad de Aplicación, bajo alguna de las siguientes modalidades técnicas:

1) Federated Learning: entrenamiento de modelos en el repositorio sin salida de datos; solo se extraen parámetros matemáticos del modelo resultante.
2) Secure Multi-Party Computation (SMPC): cómputo distribuido en el que ninguna parte accede a los datos brutos de las demás.
3) Trusted Execution Environment (TEE): procesamiento dentro de enclave seguro con verificación criptográfica de integridad.
4) Sala de datos segura (safe room) operada por la Autoridad de Aplicación: acceso presencial en entorno aislado sin conexión a redes externas, con supervisión técnica permanente.

Queda prohibida, como regla general, la descarga, exportación, transmisión o replicación de datasets del Repositorio, en forma total o parcial, hacia entornos externos al Sistema C.U.R.A.

Se admitirán, como excepción estricta y sujeta a autorización expresa previa, las siguientes categorías de resultados extraíbles del entorno seguro:

1) Parámetros matemáticos de modelos entrenados, estadísticas agregadas y resultados de análisis que, conforme certificación técnica emitida por el CSRNA, no permitan inferencia individual ni constituyan vector de reidentificación.
2) Datos sintéticos generados íntegramente mediante modelos estadísticos o de inteligencia artificial entrenados sobre los datos del Repositorio, que no contengan registros reales ni permitan su reconstrucción, previa certificación técnica independiente de su naturaleza sintética y ausencia de riesgo de reidentificación. La generación y extracción de datos sintéticos requerirá protocolo técnico aprobado por el CSRNA para cada proyecto.

En todos los casos de extracción autorizada, la Autoridad de Aplicación verificará técnicamente que los resultados a exportar no constituyan vectores de reidentificación antes de su liberación, dejando constancia documentada de dicha verificación.

i) Trazabilidad y transparencia.

Todo acceso, procesamiento o generación de resultados será registrado en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría. La Autoridad de Aplicación publicará anualmente un informe público indicando proyectos autorizados, finalidad, duración y resultados, preservando el secreto estadístico.

j) Garantías financieras para accedentes privados.

Como condición de acceso al Repositorio, toda entidad privada autorizada conforme el inciso g) deberá constituir las garantías que establezca la Autoridad de Aplicación mediante resolución fundada, conforme los siguientes criterios de proporcionalidad:

Las garantías se calibrarán en función del nivel de riesgo del proyecto evaluado por el

CSRNA, el tipo de entidad solicitante, el volumen y sensibilidad de los datos involucrados, y la finalidad comercial o no comercial del proyecto.

Para proyectos de mayor riesgo o con componente comercial, las garantías mínimas de referencia serán: seguro de responsabilidad civil por daños derivados de incidentes de reidentificación o violación de datos, con cobertura mínima equivalente a diez mil (10.000) Unidades de Multa Sanitaria Digital (UMSD); y garantía de cumplimiento equivalente a quinientas (500) UMSD, retenida durante el período de acceso y por dos (2) años posteriores a su cierre.

Para proyectos de investigación sin componente comercial, de menor escala o de riesgo bajo según evaluación del CSRNA, la Autoridad de Aplicación podrá reducir proporcionalmente los montos de referencia, no pudiendo en ningún caso exonerarlos completamente ni prescindir del requisito de cobertura mínima de responsabilidad civil.

En todos los casos, la entidad deberá designar un Responsable Técnico de Seguridad de Datos con título universitario en informática, seguridad de la información o ciencias de datos, que asumirá responsabilidad personal y solidaria con la entidad por el cumplimiento de las obligaciones del presente artículo.

La Autoridad de Aplicación publicará y mantendrá actualizada la tabla de garantías aplicables por categoría de proyecto, garantizando previsibilidad y proporcionalidad en su aplicación.

SECCIÓN II — ENTORNO CONTROLADO DE INNOVACIÓN EN SALUD (SANDBOX DE IA)

k) Creación, naturaleza y relación con el Repositorio.

Créase, dentro del Sistema C.U.R.A. y como modalidad restringida de acceso al Repositorio Nacional de Datos Anonimizados, el Entorno Controlado de Innovación en Salud (Sandbox de IA), destinado específicamente al desarrollo, entrenamiento, validación y prueba de sistemas de inteligencia artificial aplicados al ámbito sanitario, bajo condiciones reforzadas de protección de datos personales. El Sandbox no constituye un repositorio independiente sino un subrégimen de acceso supervisado a los datos del Repositorio, sujeto a las mismas garantías de soberanía, anonimización y prohibición general de extracción establecidas en la Sección I, más las garantías específicas del presente capítulo.

l) Evaluación de impacto previa y dictamen.

Todo proyecto que solicite acceso al Sandbox deberá contar con una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) propia y específica, conforme los estándares del inciso c). Cuando el acceso tenga fines comerciales o implique explotación económica posterior de los desarrollos obtenidos, la aprobación requerirá adicionalmente dictamen técnico previo del Comité de Supervisión del Repositorio (CSRNA) y de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), conforme el régimen del inciso f). El silencio de ambos organismos vencido el plazo de noventa (90) días habilitará a la Autoridad de Aplicación a continuar el proceso conforme lo establecido en dicho inciso.

m) Principios específicos del Sandbox.

El funcionamiento del Sandbox se regirá por los siguientes principios específicos, adicionales a los de la Sección I:

Soberanía de datos: los datos anonimizados utilizados permanecerán bajo jurisdicción argentina y no podrán ser descargados, transferidos ni reproducidos fuera del entorno técnico autorizado, con las excepciones previstas en el inciso h).

Bien público no transferible: los datasets anonimizados constituyen activo estratégico del Estado y no podrán ser objeto de cesión, venta, transferencia de titularidad ni exclusividad contractual.

Acceso controlado y auditado: el acceso se otorgará exclusivamente por proyecto aprobado, bajo entornos seguros, con registro integral de accesos, trazabilidad técnica y monitoreo permanente.

No exclusividad: la participación en el Sandbox no generará derecho exclusivo ni preferente sobre datos futuros ni sobre otros desarrollos del sistema.

Interoperabilidad obligatoria: todo desarrollo deberá cumplir estándares abiertos, documentar interfaces y permitir integración modular sin dependencia tecnológica exclusiva.

Arquitectura sustituible: ningún módulo crítico del Sistema C.U.R.A. podrá implementarse bajo condiciones que impidan su reemplazo razonable por otra solución interoperable.

n) Licencia estatal perpetua y explotación internacional.

Todo módulo validado en el Sandbox otorgará al Estado argentino licencia gratuita, perpetua, irrevocable y no exclusiva para su uso en el territorio nacional. Los desarrolladores podrán explotar comercialmente versiones derivadas fuera del territorio nacional, siempre que no impliquen transferencia de datos argentinos, no reproduzcan datasets anonimizados originales y no restrinjan el uso gratuito y permanente del módulo en la República Argentina.

o) Procedimiento de aprobación y convocatorias.

La Autoridad de Aplicación deberá resolver la admisión o rechazo de proyectos en un plazo máximo de noventa (90) días desde la presentación formal completa. El silencio administrativo vencido dicho plazo se considerará rechazo. El acceso se realizará mediante convocatorias públicas con criterios objetivos y evaluación técnica fundada, garantizando igualdad de oportunidades. La Autoridad de Aplicación publicará anualmente un Roadmap Oficial de Desarrollo Tecnológico con convocatorias temáticas estratégicas y módulos prioritarios.

p) Responsabilidad del Estado ante fallos de anonimización.

El Estado Nacional responderá conforme el régimen establecido en la Ley N° 26.944 cuando una eventual reidentificación resulte imputable a deficiencias técnicas del proceso de

anonimización bajo su control directo. La responsabilidad no se extenderá a conductas dolosas o fraudulentas de terceros que violen las condiciones técnicas y contractuales del Sandbox.

SECCIÓN III — COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL REPOSITORIO NACIONAL DE DATOS ANONIMIZADOS (CSRNA)

a) Creación y composición.

Créase el Comité de Supervisión del Repositorio Nacional de Datos Anonimizados (CSRNA) como órgano colegiado de supervisión independiente, con funciones de aprobación previa, monitoreo continuo y auditoría ex post de los accesos al Repositorio y al Sandbox.

El CSRNA estará integrado por:

Un representante de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), quien lo presidirá.

Un representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Un representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Un representante del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil con trayectoria acreditada en protección de datos de salud o derechos digitales, seleccionados por concurso público de antecedentes.

Los miembros del CSRNA no podrán tener relación contractual o societaria con ningún accedente al Repositorio durante su mandato ni en los dos (2) años posteriores a su egreso.

b) Atribuciones del CSRNA.

El CSRNA tendrá las siguientes atribuciones:

Dictaminar en forma previa sobre toda solicitud de acceso al Repositorio por parte de entidades privadas conforme el inciso g), con carácter vinculante en los supuestos previstos en el inciso f) y carácter consultivo de alta ponderación en los restantes.

Auditar sin previo aviso los entornos de computación segura habilitados conforme el inciso h).

Emitir recomendaciones públicas sobre el nivel de riesgo de reidentificación del Repositorio con periodicidad anual.

Certificar la aptitud de los resultados extraíbles conforme el inciso h), incluyendo la validación de datos sintéticos.

Recibir y resolver denuncias de presuntas violaciones a las disposiciones del presente artículo.

Solicitar a la Autoridad de Aplicación la suspensión cautelar de accesos en curso ante indicios de riesgo de reidentificación.

Revisar y recomendar actualización de los parámetros técnicos de referencia del inciso b) cuando la evolución tecnológica así lo justifique.

Los dictámenes del CSRNA serán públicos, con excepción de la información técnica cuya divulgación pudiera comprometer la seguridad del Repositorio, determinada por el propio Comité.

TÍTULO XI - ACCESIBILIDAD, DIFUSIÓN Y MEJORA CONTINUA

ARTÍCULO 68.- Accesibilidad Universal, Difusión Pública y Alfabetización Digital Sanitaria.

La Autoridad de Aplicación deberá garantizar la accesibilidad universal, la difusión pública permanente y la alfabetización digital sanitaria vinculada al Sistema C.U.R.A., conforme los siguientes lineamientos:

a) Lenguaje Claro y Comprensible.
Toda comunicación institucional vinculada al Sistema C.U.R.A., incluyendo derechos, funcionalidades, uso de datos, módulos de inteligencia artificial y canales de reclamo, deberá redactarse en lenguaje claro, evitando tecnicismos innecesarios.

b) Formatos Accesibles e Inclusivos.
La información deberá estar disponible, como mínimo, en:

1) Formato audiovisual con subtitulado y lengua de señas argentina.
2) Versión audio-descriptiva.
3) Texto compatible con lectores de pantalla.
4) Versión impresa simplificada disponible en establecimientos de salud públicos.
5) Versiones adaptadas para lectura fácil dirigidas a personas mayores.

c) Difusión de Derechos y Canales de Reclamo.
Deberá difundirse ampliamente:

1) La existencia de los canales de denuncia establecidos en el Artículo 6.
2) El formulario de sugerencias de mejora continua.
3) Los derechos de acceso, rectificación y protección de datos personales.
4) Los mecanismos de revisión humana de decisiones asistidas por IA.

d) Acceso Gratuito y Prioritario.
Se garantizará acceso gratuito al Sistema C.U.R.A., con prioridad operativa para personas con discapacidad, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad digital.

e) Programa Permanente de Alfabetización Digital Sanitaria.
La Autoridad de Aplicación, en coordinación con provincias y PAMI, implementará un programa permanente de alfabetización digital sanitaria destinado a:

1) Explicar el uso del sistema.
2) Informar sobre derechos en entornos digitales.
3) Promover uso responsable y seguro de herramientas tecnológicas en salud.

ARTÍCULO 69.- Actualización tecnológica, seguridad y mejora continua.

El Sistema C.U.R.A. deberá mantener un proceso permanente de actualización tecnológica, seguridad informática y mejora funcional conforme las siguientes reglas:

a) Actualizaciones periódicas obligatorias.
El sistema contará con al menos DOS (2) versiones estables anuales, que deberán incluir como mínimo:

1) Parches de seguridad y actualización de dependencias críticas.
2) Correcciones de vulnerabilidades detectadas.
3) Mejoras de usabilidad basadas en métricas objetivas y sugerencias verificadas de usuarios.
4) Adaptación a navegadores, dispositivos y sistemas operativos estándar del mercado.

b) Gestión de vulnerabilidades y ciberseguridad.
La Autoridad de Aplicación implementará:

1) Programa permanente de detección temprana de vulnerabilidades.
2) Auditorías externas de seguridad informática al menos una vez por año.
3) Procedimiento de respuesta ante incidentes con notificación obligatoria a la AAIP cuando corresponda.
4) Mecanismos de contingencia que aseguren continuidad operativa ante fallos críticos.

c) Incorporación progresiva de nuevas tecnologías.
Podrán incorporarse tecnologías emergentes que mejoren eficiencia, interoperabilidad o

seguridad, siempre que:

1) No interfieran con la operatividad clínica central.
2) No comprometan la integridad ni confidencialidad de los datos.
3) Sean previamente evaluadas en entornos controlados.
4) Cumplan el régimen de gobernanza previsto en el Título X cuando involucren inteligencia artificial.

d) Prioridad de estándares abiertos y soberanía tecnológica.
El Sistema C.U.R.A. priorizará el uso de:

1) Software de código abierto o con licencias auditables.
2) Estándares abiertos e interoperables.
3) Arquitecturas que eviten dependencia tecnológica exclusiva de proveedores privados.

e) Reinversión de ahorros tecnológicos.
Los ahorros derivados de la utilización de tecnologías abiertas o reducción de costos de licenciamiento deberán reinvertirse prioritariamente en:

1) Mejora de seguridad informática.
2) Optimización de infraestructura.
3) Desarrollo de nuevas funcionalidades de acceso ciudadano.

TÍTULO XII - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 70.- Regla de interpretación, orden público y prelación normativa.

Las disposiciones de la presente ley deberán interpretarse conforme los siguientes principios rectores:

a) In dubio pro paciente.
Ante duda interpretativa, deberá estarse a la solución más favorable a la protección de la salud, la dignidad, la autonomía y los derechos del paciente.

b) In dubio pro data sanitaria.
En caso de conflicto interpretativo en materia de tratamiento de datos personales de salud, prevalecerá la interpretación más favorable a la protección, confidencialidad y seguridad de dichos datos.
En materia sancionatoria, el principio establecido en el presente inciso se aplicará para

determinar la existencia de una eventual violación al deber de protección de datos personales. Una vez determinada dicha violación, las dudas relativas a la graduación o tipo de sanción se resolverán conforme los principios de razonabilidad, proporcionalidad y mínima intervención establecidos en el Artículo 44 de la presente ley y en la Ley 19.549.

c) Accesibilidad y no regresividad.
Ninguna interpretación podrá restringir el acceso efectivo al sistema de salud ni implicar retrocesos en derechos previamente reconocidos.

d) Soberanía y jurisdicción nacional.
El almacenamiento, procesamiento y gobernanza de los datos sanitarios regulados por esta ley deberán realizarse bajo jurisdicción argentina, sin perjuicio de los mecanismos de interoperabilidad internacional previstos en la presente norma.

e) Orden público y prelación.
La presente ley es de orden público. Sus disposiciones prevalecerán sobre normas administrativas, reglamentarias o contractuales que se le opongan, sin perjuicio de la vigencia de las leyes nacionales de mayor jerarquía en materia sanitaria, de protección de datos personales y derechos del paciente.

ARTÍCULO 71.- Soberanía tecnológica, residencia y control jurisdiccional de datos sanitarios.

a) Régimen Diferenciado de Residencia de Datos.

Establécese un régimen diferenciado de residencia física y soberanía para el almacenamiento primario y secundario de los datos generados y administrados por el Sistema C.U.R.A., conforme a su nivel de criticidad:

1) Categoría A (Datos Clínicos y Sensibles): Las bases de datos que contengan historias clínicas, datos genéticos, biométricos o identificatorios de pacientes (C.U.R.A.-ID vinculado) deberán alojarse, replicarse y procesarse física y exclusivamente en infraestructura radicada en el territorio de la República Argentina o en regiones de servicios de computación en la nube que garanticen residencia exclusiva en territorio argentino, bajo estricta jurisdicción nacional. Queda prohibida la transferencia internacional de estos datos, salvo en los casos excepcionales de cooperación sanitaria internacional o acceso IPS expresamente autorizados por la presente ley y con consentimiento específico del titular.

2) Categoría B (Datos Administrativos y de Gestión): Los datos operativos, de gestión de turnos, logísticos y de infraestructura no sensibles podrán alojarse en arquitecturas de nube híbrida, priorizando proveedores locales o regionales que garanticen el cumplimiento de los estándares de seguridad definidos por la Autoridad de

Aplicación.

3) Categoría C (Datos Públicos y Estadísticos): Los datos completamente anonimizados, las estadísticas agregadas de salud pública y los activos digitales estáticos (recursos web) podrán utilizar redes de distribución de contenido (CDN) globales para garantizar su alta disponibilidad, accesibilidad y velocidad, sin restricciones de residencia física.

b) Control Jurisdiccional y Criptográfico.

Para todas las categorías de datos, la infraestructura tecnológica y los acuerdos de servicios deberán asegurar:

1) Que toda relación contractual con proveedores tecnológicos establezca expresamente la aplicación exclusiva del derecho argentino y la jurisdicción de tribunales nacionales.

2) Que las claves criptográficas maestras y los mecanismos de cifrado de la Categoría A se encuentren bajo control exclusivo del Estado Nacional o del organismo público designado como Autoridad de Aplicación, garantizando la inmunidad soberana contra requerimientos extraterritoriales.

3) Que cualquier servicio de respaldo o contingencia de datos clínicos mantenga el mismo estándar de residencia territorial y jurisdicción nacional.

c) Respaldo y Contingencia Soberana.

La empresa pública ARSAT S.A., o el organismo que en el futuro la reemplace, actuará como nodo soberano estratégico de respaldo primario del Sistema C.U.R.A., garantizando continuidad operativa, infraestructura crítica y contingencia conforme lo establecido en el Artículo 12 TER.

A fin de asegurar resiliencia estructural y evitar puntos únicos de falla, la infraestructura de respaldo deberá operar en coordinación con al menos un proveedor adicional radicado en territorio argentino o bajo jurisdicción nacional, seleccionado conforme los procedimientos de contratación pública vigentes.

La arquitectura deberá garantizar redundancia geográfica, sincronización segura y recuperación operativa bajo estándares técnicos definidos por la reglamentación, preservando en todos los casos la residencia territorial y el control jurisdiccional argentino de los datos de Categoría A.

ARTÍCULO 72.- Reglamentación y límites a la potestad reglamentaria.

a) Plazos de Reglamentación Escalonada.
El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar la presente ley estableciendo los protocolos técnicos, estándares de interoperabilidad, seguridad, consentimiento informado digital, trazabilidad, gobernanza y protección de datos, conforme a estándares nacionales e internacionales adoptados por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.
A fin de garantizar la viabilidad técnica y el cumplimiento de la consulta pública obligatoria, la reglamentación se dictará conforme al siguiente esquema escalonado de plazos máximos, contados desde su publicación en el Boletín Oficial:

1) En un plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) días corridos: Gobernanza institucional, órganos de gobierno y derechos de los pacientes.
2) En un plazo máximo de DOSCIENTOS DIEZ (210) días corridos: Aspectos técnicos, estándares de interoperabilidad, seguridad informática, trazabilidad, y módulos de Inteligencia Artificial.
3) En un plazo máximo de DOSCIENTOS SETENTA (270) días corridos: Módulos de integración internacional, Resumen Internacional del Paciente (IPS) y Hub Global.

b) Respeto del contenido sustancial.
La reglamentación no podrá alterar el objeto, los principios rectores ni el contenido sustancial de los derechos, garantías y obligaciones establecidos en la presente ley.

c) Límites expresos.
El decreto reglamentario no podrá:

1) Alterar los plazos máximos establecidos por la ley, pudiendo únicamente fijar plazos menores.
2) Modificar la composición, competencias o funcionamiento de los órganos de gobierno creados por esta ley.
3) Establecer requisitos adicionales que restrinjan el ejercicio de derechos reconocidos a pacientes, profesionales o instituciones.
4) Delegar en otros organismos facultades que la presente ley reserve expresamente al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.
5) Reducir los estándares mínimos de protección de datos personales, seguridad informática y trazabilidad establecidos en la presente ley.

d) Consulta pública previa.
Los proyectos de reglamentación de cada fase deberán ser sometidos a consulta pública por un plazo no menor a TREINTA (30) días, garantizando la participación de provincias,

colegios profesionales, organizaciones de pacientes, sociedades científicas y ciudadanía en general. El plazo de consulta pública será adicional y no computable dentro de los plazos máximos escalonados establecidos en el primer apartado.

e) Remisión al Congreso.
Los decretos reglamentarios dictados serán remitidos a las comisiones competentes del Congreso Nacional dentro de los DIEZ (10) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 72 BIS.- Plazo de reglamentación, vigencia de la delegación legislativa y control parlamentario.

Delégase en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de reglamentar aspectos técnicos, operativos y de implementación del Sistema C.U.R.A., en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, conforme las bases, límites y condiciones establecidos en la presente ley.

a) Plazo de reglamentación

El Poder Ejecutivo Nacional deberá dictar la reglamentación de la presente ley dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde su promulgación. La reglamentación deberá abordar, como mínimo, las siguientes materias dentro de ese plazo: (1) cuantificación técnica del CIES y resolución conjunta SSS/SSN conforme el Artículo 35; (2) metodología de cuantificación de ahorros sistémicos conforme el Artículo 35; (3) costo estándar por efector conforme el Artículo 35 TER; (4) régimen del padrinazgo tecnológico y reglamentación AFIP del beneficio de deducción en Ganancias; (5) régimen del Sandbox Nacional de IA en Salud; (6) conformación y primer mapa de Zonas Críticas Sanitarias. Los ítems enumerados no admiten extensión del plazo.

Para los demás aspectos de implementación, la reglamentación se dictará conforme el siguiente esquema escalonado de plazos máximos, contados desde la promulgación:

1. En un plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) días corridos: gobernanza institucional, órganos de gobierno y derechos de los pacientes.
2. En un plazo máximo de DOSCIENTOS DIEZ (210) días corridos: aspectos técnicos, estándares de interoperabilidad, seguridad informática, trazabilidad y módulos de inteligencia artificial.
3. En un plazo máximo de DOSCIENTOS SETENTA (270) días corridos: módulos de integración internacional, Resumen Internacional del Paciente (IPS) y Hub Global.

Prórroga excepcional. Cuando circunstancias técnicas, institucionales o presupuestarias debidamente acreditadas impidan el cumplimiento de los plazos escalonados previstos en los numerales 1, 2 y 3 del presente inciso, el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, por única vez y por decreto fundado, una prórroga no superior a NOVENTA (90) días corridos por cada plazo incumplido. El decreto deberá: a) identificar con precisión la causa técnica, institucional o presupuestaria que justifica la prórroga; b) establecer el cronograma específico de regularización con hitos verificables; c) ser comunicado a la Comisión Bicameral prevista en

el inciso g) dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de su dictado. La prórroga no altera la naturaleza obligatoria de los plazos ni habilita nuevas extensiones. Vencida la prórroga sin que se haya dictado la reglamentación correspondiente, la Comisión Bicameral deberá informar el incumplimiento al plenario de ambas Cámaras dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes.

Los plazos escalonados son adicionales y no computan el plazo de consulta pública obligatoria previsto en el inciso h) del presente artículo. El incumplimiento de cualquiera de estos plazos —vencida la prórroga si hubiere sido ejercida— deberá ser comunicado por la Autoridad de Aplicación a la Comisión Bicameral prevista en el inciso g) dentro de los CINCO (5) días hábiles del vencimiento respectivo, con indicación de causas y cronograma de regularización.

b) Alcance de la delegación

La delegación se limita exclusivamente a:

1) la determinación operativa de parámetros técnicos de interoperabilidad definidos en la presente ley;
2) la actualización de estándares tecnológicos internacionales adoptados por la ley, en tanto dicha actualización no modifique derechos sustanciales;
3) la implementación progresiva del sistema en el territorio nacional conforme el cronograma establecido en el Artículo 14;
4) la determinación de la alícuota de la contribución CIES dentro de los límites fijados en el Artículo 35 de la presente ley;
5) la clasificación técnica de sistemas de inteligencia artificial conforme los criterios establecidos en el inciso c) del presente artículo.

En ningún caso la delegación podrá extenderse a:

i. la definición de derechos sustanciales no previstos en la ley;
ii. la modificación de obligaciones expresamente establecidas en el texto legal;
iii. la ampliación de los sujetos alcanzados por la presente ley;
iv. la fijación de bases de cálculo distintas a las previstas en el texto legal;
v. la creación de nuevas cargas tributarias, contribuciones o tasas no contempladas expresamente;
vi. la modificación de la composición, competencias o funcionamiento de los órganos de gobierno creados por la presente ley;
vii. la restricción de derechos reconocidos a pacientes, profesionales o instituciones.

c) Bases para la clasificación de sistemas de inteligencia artificial

La reglamentación deberá clasificar los sistemas de inteligencia artificial utilizados en el Sistema C.U.R.A. conforme los siguientes criterios objetivos, los cuales constituyen las bases de la delegación en esta materia:

1) grado de autonomía del sistema en la adopción de decisiones que afecten directa o indirectamente al paciente;

2) impacto potencial sobre la salud, la integridad, la autonomía o los derechos del paciente;

3) nivel de intervención o supervisión humana calificada requerida para validar los resultados del sistema;

4) posibilidad de explicación, auditabilidad y trazabilidad de los resultados generados;

5) riesgo de discriminación, sesgo sistemático o inequidad en los resultados, especialmente respecto de grupos vulnerables.

La clasificación deberá respetar el principio de mayor exigencia regulatoria a mayor nivel de riesgo, garantizando que los sistemas de mayor impacto potencial sobre la salud o la integridad del paciente queden sujetos al régimen más exigente de evaluación previa, supervisión continua y auditoría. La reglamentación podrá tomar como referencia técnica orientativa estándares de organismos internacionales de reconocido prestigio en la materia —tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)—, sin que dicha referencia implique la incorporación de normativa extranjera al ordenamiento jurídico argentino, ni la sujeción de la validez o interpretación de la presente ley a jurisdicción, tribunal o autoridad foránea.

d) Bases para la determinación de la alícuota del CIES

La determinación de la alícuota de la Contribución Solidaria para la Interoperabilidad Sanitaria dentro de los límites establecidos en el Artículo 35 deberá respetar:

1) los límites legales fijados en el Artículo 35: no inferior al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) ni superior al CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del gasto anual en prestaciones médicas de la entidad;

2) criterios de proporcionalidad, equidad y sostenibilidad del sistema sanitario;

3) la relación entre el costo efectivo del sistema y la capacidad contributiva de los sujetos alcanzados, certificada mediante informe técnico auditado por la SIGEN;

4) la prohibición de efectos confiscatorios, distorsivos o que afecten sustancialmente la continuidad de las prestaciones de salud.

Toda modificación de la alícuota deberá fundarse en variación documentada del costo real de prestación del Sistema C.U.R.A., acreditada mediante informe técnico de la UESC y dictamen previo de la SIGEN, publicados con una antelación mínima de CIENTO OCHENTA (180) días al inicio del ejercicio al que corresponda. La Comisión Bicameral prevista en el inciso g) deberá emitir dictamen de compatibilidad respecto de toda resolución de cuantificación del CIES con carácter previo a su entrada en vigencia, conforme el procedimiento previsto en el numeral 6 de dicho inciso.

e) Bases para la metodología de cuantificación de ahorros sistémicos

La metodología técnica de cuantificación de ahorros sistémicos deberá basarse exclusivamente en flujos reales verificados, auditados por la SIGEN y la AGN. Queda prohibida la utilización de proyecciones estimativas como base de afectación presupuestaria. La metodología deberá contemplar:

1) criterios objetivos, verificables y auditables;
2) atribución causal documentada entre la digitalización y la reducción efectiva de costos;
3) diferenciación entre ahorros directos cuantificables y ahorros indirectos estimados;
4) un factor de prudencia técnicamente fundado, cuyo valor mínimo será establecido por resolución conjunta de la SIGEN y la Autoridad de Aplicación dentro de los NOVENTA (90) días de la reglamentación de la presente ley, con auditoría anual de la AGN y revisión cada DOS (2) ejercicios fiscales conforme la evolución de los datos observados. El factor de prudencia no podrá ser eliminado ni reducido a cero por acto administrativo de alcance particular o general. Hasta tanto se dicte la resolución conjunta, se aplicará provisionalmente un factor no inferior al QUINCE POR CIENTO (15%), el cual perderá vigencia automáticamente en la fecha de publicación de la resolución correspondiente.

f) Vigencia de la delegación y procedimiento de renovación

Las normas dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades delegadas por la presente ley tendrán una vigencia de TRES (3) años a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Dentro de los NOVENTA (90) días hábiles previos al vencimiento de cada período de delegación, la Comisión Bicameral prevista en el inciso g) deberá pronunciarse expresamente mediante dictamen fundado sobre la renovación, modificación o caducidad de las normas delegadas.

La ausencia de pronunciamiento expreso de la Comisión Bicameral dentro del plazo precedente no producirá renovación automática ni prórroga tácita de la delegación. La voluntad de la Comisión deberá manifestarse en forma expresa, conforme el artículo 82 de la Constitución Nacional.

Vencido el plazo de vigencia de la delegación sin pronunciamiento expreso de renovación:

1) Las normas reglamentarias dictadas en ejercicio de las facultades delegadas mantendrán ultraactividad exclusivamente respecto de los derechos y situaciones jurídicas válidamente constituidos durante su vigencia, por un período adicional de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde el vencimiento. Esta ultraactividad tiene por única finalidad preservar situaciones consolidadas y evitar el vacío regulatorio abrupto; no constituye renovación de la delegación ni habilita el dictado de nuevas normas fundadas en ella para regular situaciones jurídicas nuevas.

2) Durante dicho período, el Poder Ejecutivo Nacional deberá presentar ante el Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley de renovación de las facultades delegadas o, alternativamente, un proyecto de incorporación definitiva al texto legislativo de las normas técnicas que requieran continuidad normativa.

3) Transcurrido el período de ultraactividad sin sanción legislativa expresa, las normas reglamentarias caducarán de pleno derecho para nuevas situaciones jurídicas. La caducidad no afectará los derechos adquiridos, los certificados, habilitaciones y actos administrativos firmes dictados durante la vigencia de las normas.

Ninguna norma reglamentaria que establezca o modifique una carga económica para los sujetos del Régimen A podrá entrar en vigencia sin previa comunicación a las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, con una antelación mínima de TREINTA (30) días hábiles.

g) Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Sistema C.U.R.A.

Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Sistema C.U.R.A., integrada por SEIS (6) Senadores y SEIS (6) Diputados designados por los Presidentes de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporcionalidad de la representación.

Naturaleza de los dictámenes. Los dictámenes de la Comisión Bicameral tienen carácter de control parlamentario republicano y no constituyen, por sí solos, condición de validez de las normas reglamentarias dictadas en ejercicio de la presente delegación, salvo en los supuestos en que la presente ley lo establezca expresamente. La falta de dictamen de la Comisión dentro de los plazos previstos no impide la entrada en vigencia de las normas reglamentarias, con excepción de aquellos casos en que la ley requiere dictamen previo vinculante o de compatibilidad como condición expresa de vigencia. En todos los casos, la norma reglamentaria dictada sin dictamen previo cuando éste es exigido expresamente quedará suspendida en sus efectos hasta la emisión del dictamen o el vencimiento del plazo establecido para ello, conforme las reglas del numeral 6 del presente inciso.

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

1) Revisar anualmente las normas reglamentarias dictadas en ejercicio de las facultades delegadas y emitir dictamen fundado sobre su compatibilidad con las bases de la delegación establecidas en la presente ley; dicho dictamen tiene carácter de control y no afecta la vigencia de las normas ya publicadas, sin perjuicio de las acciones parlamentarias y judiciales que correspondan;

2) Pronunciarse expresamente, con la antelación establecida en el inciso f), sobre la renovación, modificación o caducidad de la delegación, mediante dictamen fundado que deberá ser publicado en el Boletín Oficial;

3) Solicitar a la SIGEN y a la AGN los informes que estime necesarios sobre la ejecución del FIISD, el FFES y la Subcuenta de Proyección Internacional;

4) Convocar a las autoridades de la UESC y del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. a audiencias de rendición de cuentas con periodicidad no inferior a la semestral;

5) Informar anualmente al plenario de ambas Cámaras sobre el estado de implementación del sistema, el cumplimiento de las bases de la delegación y la ejecución presupuestaria;

6) Emitir dictamen de compatibilidad respecto de toda resolución de cuantificación del CIES, con carácter previo vinculante a su entrada en vigencia. La Comisión dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la comunicación de la resolución para emitir su dictamen. Vencido dicho plazo sin pronunciamiento, la resolución podrá entrar en vigencia sin que el silencio implique aprobación tácita ni convalide incompatibilidades con las bases de la delegación. Este supuesto constituye la única hipótesis en que el dictamen tiene carácter vinculante como condición expresa de vigencia;

7) Requerir al Poder Ejecutivo el replanteo de normas reglamentarias que, a criterio fundado de la Comisión, excedan las bases de la delegación; sin perjuicio del control judicial correspondiente y de que tal requerimiento no suspende por sí solo la vigencia de las normas cuestionadas.

La Comisión dictará su reglamento interno dentro de los SESENTA (60) días corridos desde su constitución. Sus dictámenes serán públicos y deberán publicarse en el Boletín Oficial y en el portal oficial del Sistema C.U.R.A. dentro de los CINCO (5) días hábiles de emitidos.

h) Consulta pública previa

Los proyectos de reglamentación de cada fase o materia deberán someterse a consulta pública por un plazo no menor a TREINTA (30) días, garantizando la participación de provincias, colegios profesionales, organizaciones de pacientes, sociedades científicas y ciudadanía en general. El plazo de consulta pública es adicional y no computable dentro de los plazos máximos escalonados establecidos en el inciso a).

i) Remisión al Congreso

Los decretos reglamentarios dictados en ejercicio de la presente delegación serán remitidos a las comisiones competentes del Congreso Nacional dentro de los DIEZ (10) días de su publicación en el Boletín Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, para su control por la Comisión Bicameral Permanente y por la

Comisión Bicameral creada en el inciso g) del presente artículo.

j) Principio de respeto del contenido sustancial

La reglamentación no podrá alterar el objeto, los principios rectores ni el contenido sustancial de los derechos, garantías y obligaciones establecidos en la presente ley. Las facultades reglamentarias deberán ejercerse respetando estrictamente las bases y objetivos definidos por esta ley, sin que puedan alterar la naturaleza, alcance ni los derechos y obligaciones definidos en el texto legal.

k) Principio de interpretación restrictiva

La delegación conferida por el presente artículo deberá interpretarse en forma restrictiva. El Poder Ejecutivo no podrá ampliar su alcance más allá de los límites expresamente establecidos. Ante duda interpretativa sobre si una materia se encuentra comprendida dentro del alcance de la delegación, se estará por la solución que preserve la competencia legislativa del Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 72 TER.- Evaluación del Sistema.

A los cinco (5) años de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá presentar al Honorable Congreso de la Nación un informe integral de evaluación del Sistema C.U.R.A., incluyendo su impacto sanitario, económico y tecnológico, pudiendo proponer las modificaciones legislativas que resulten necesarias para su actualización.

ARTÍCULO 73.- Adecuación normativa, derogaciones y armonización.

a) Modificación y Prevalencia Específica.

Establécese que las disposiciones de la presente ley complementan y prevalecen, en lo pertinente a la digitalización, interoperabilidad y gobernanza de datos, a los regímenes establecidos por las siguientes normas, las cuales mantendrán su vigencia en todo aquello que no se oponga a la presente:

1) Ley 26.529 (Derechos del Paciente): En cuanto a la definición, soporte y titularidad de la Historia Clínica, prevaleciendo el formato digital interoperable y el acceso en tiempo real aquí dispuestos.
2) Ley 27.553 (Recetas Electrónicas o Digitales): Cuyos mecanismos de fiscalización y plataformas se integrarán obligatoriamente al Sistema C.U.R.A. y al Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT).
3) Leyes 23.660 y 23.661 (Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud): En

lo relativo a las obligaciones de intercambio de información, auditoría digital y prohibición de cautividad de datos.

4) Ley 26.682 (Marco Regulatorio de Medicina Prepaga): Respecto de la prohibición de preexistencias basada en datos interoperables y la portabilidad de la información clínica.

Las modificaciones y prevalencias establecidas en el presente inciso se circunscriben a los aspectos expresamente identificados en cada caso. En ningún supuesto implican alteración de los derechos sustanciales de pacientes, obras sociales, entidades de medicina prepaga y profesionales reconocidos por las leyes nominadas en este inciso. Las disposiciones de dichas leyes que no guarden relación directa con la digitalización, interoperabilidad o gobernanza de datos sanitarios mantienen plena vigencia y no podrán ser interpretadas como derogadas por la presente ley.

b) Derogaciones expresas y cláusula de interpretación digital.

A los fines de la validez jurídica del Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT) y de la sustitución del soporte físico por registro digital con firma válida conforme la presente ley, deróganse expresamente, en lo pertinente y en cuanto resulten incompatibles con el régimen digital aquí establecido, las siguientes normas nacionales y toda otra norma de igual o inferior jerarquía que establezca exigencias equivalentes de soporte físico:

1) Resolución del Ministerio de Salud N° 435/2011, exclusivamente en lo relativo a exigencias de soporte físico o troquel como condición de validez o reintegro.

2) Disposiciones de la ANMAT N° 3683/2011, 1831/2012, 247/2013, 963/2013, 6301/2015 y 10564/2016, exclusivamente en los artículos que requieran corte de troquel, presentación física o soporte papel cuando el acto se encuentre debidamente registrado en el RDDT.

3) Normativa del Sistema Único de Reintegros (SUR) y del ex Administración de Programas Especiales (APE) que condicione el cobro, auditoría o validación prestacional a la presentación de documentación física cuando exista registro digital válido en el Sistema C.U.R.A.

4) Toda cláusula contractual de convenios marco celebrados por el INSSJP–PAMI, obras sociales u otros financiadores nacionales que exija, como condición de pago o auditoría futura, la presentación física de troqueles o documentación analógica, a partir de la certificación de operatividad plena del módulo correspondiente conforme el Artículo 35 TER.

La derogación operará exclusivamente hacia el futuro y no afectará:

i. derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia efectiva del módulo digital correspondiente;

ii. actos administrativos firmes dictados con anterioridad a dicha fecha;

iii. procedimientos de auditoría o reintegro iniciados válidamente bajo el régimen normativo previo.

A los efectos interpretativos, toda referencia normativa preexistente a “troquel”, “cupón”, “etiqueta de trazabilidad” o “comprobante físico” deberá entenderse, desde la operatividad certificada del módulo correspondiente, como referida al registro digital almacenado en el RDDT con firma digital o electrónica válida, prevaleciendo la validez digital sin necesidad de soporte material adicional.

La existencia de registro digital válido en el Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT) constituirá prueba suficiente de la dispensa y del acto prestacional correspondiente, no pudiendo exigirse documentación física adicional como condición de validez, auditoría, reintegro o pago.

Sustitución Digital Condicionada y Derogación Específica.

A partir de la certificación de operatividad plena del módulo correspondiente en cada jurisdicción, emitida por la Autoridad de Aplicación conforme el Artículo 35 TER, quedarán sin efecto en el ámbito nacional los requisitos específicos de presentación en soporte papel que resulten incompatibles con la disponibilidad digital del documento en el Sistema C.U.R.A. con firma digital o electrónica válida.

La Autoridad de Aplicación deberá publicar, dentro de los NOVENTA (90) días de dictada la reglamentación, un catálogo taxativo de normas nacionales, reglamentaciones y disposiciones administrativas alcanzadas por la presente sustitución digital.

Las normas provinciales o locales que establezcan exigencias de soporte papel continuarán vigentes en sus respectivas jurisdicciones hasta tanto cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiera expresamente al presente régimen conforme el Artículo 26.

En ningún caso la sustitución digital podrá generar indefensión, afectar el debido proceso ni impedir la verificación técnica cuando ésta resulte indispensable conforme la normativa aplicable.

5) Cláusula de Armonización.

Encomiéndase al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. la facultad de dictar "Dictámenes de Armonización Normativa" para resolver, en sede administrativa, las divergencias interpretativas que pudieran suscitarse entre la normativa preexistente y los nuevos estándares del Sistema C.U.R.A., debiendo primar siempre la interpretación más favorable a la interoperabilidad, la portabilidad del dato y la protección de la privacidad del paciente (in dubio pro data).

6) Orden Público Tecnológico.

Las disposiciones de la presente ley que establecen estándares de seguridad, privacidad desde el diseño y arquitectura de datos son de orden público y no podrán ser dejadas sin efecto por acuerdos entre partes ni por normas jurisdiccionales locales que establezcan estándares inferiores de seguridad, interoperabilidad o protección de datos

ARTÍCULO 74.- Principio de no regresividad y piso mínimo de protección.

Las asignaciones presupuestarias destinadas al funcionamiento del Sistema C.U.R.A., las estructuras orgánicas creadas por la presente ley y los estándares de protección de datos, accesibilidad, interoperabilidad y gobernanza aquí establecidos constituyen un piso mínimo de garantía institucional y de derechos.

a) Dicho piso no podrá ser reducido, suprimido ni desnaturalizado por normas de inferior jerarquía.

b) Cualquier modificación legislativa futura que implique alteración sustancial de las estructuras, competencias o estándares establecidos deberá respetar el principio de progresividad en materia de derecho a la salud, protección de datos personales y acceso equitativo al sistema sanitario.

c) Las decisiones presupuestarias anuales deberán asegurar recursos suficientes para el funcionamiento efectivo del Sistema C.U.R.A., conforme los objetivos y obligaciones establecidos en la presente ley.

El principio de no regresividad y progresividad establecido en el presente artículo se funda en las obligaciones internacionales de la República Argentina en materia de derecho a la salud, conforme el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Observación General N° 14 del Comité DESC de Naciones Unidas, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en 'Campodónico de Beviacqua' (Fallos 323:3229), 'Asociación Benghalensis' (Fallos 323:1339) y 'CEPIS' (Fallos 339:1077), normas e interpretaciones con jerarquía superior a la ley ordinaria en virtud del Artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. En consecuencia, cualquier norma futura que implique regresión en los estándares de derecho a la salud, protección de datos sanitarios o acceso equitativo al sistema aquí establecidos deberá ser interpretada y aplicada conforme el principio pro homine y el bloque convencional citado, sin perjuicio de la potestad legislativa del Congreso.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Publicación del Marco de Intercambio Federal.

Dentro de los ciento ochenta (180) días contados desde la reglamentación de la presente ley, la Autoridad de Aplicación deberá publicar:

a) La versión inicial (1.0) del Marco de Intercambio Federal, cuyo contenido mínimo deberá ajustarse a las bases establecidas en el Anexo Técnico Normativo de la presente ley, que incluye como piso infranqueable: el protocolo de interoperabilidad HL7 FHIR en la versión mínima vigente, los campos estructurados obligatorios del C.U.R.A.-ID, los mecanismos de consentimiento interjurisdiccional y los estándares de seguridad informática exigibles.

b) Los modelos de acuerdos interjurisdiccionales previstos en el Artículo 26.

c) El procedimiento de certificación técnica de prestadores y jurisdicciones adherentes.

La versión inicial deberá ser técnicamente suficiente para dar inicio al Programa Piloto Nacional previsto en la Disposición Transitoria Quinta.

El Marco de Intercambio Federal será actualizado progresivamente por el Comité de Gobernanza Técnica conforme se incorporen nuevos módulos, estándares o mejoras de interoperabilidad, garantizando compatibilidad retroactiva. Toda actualización deberá respetar las bases mínimas establecidas en el Anexo Técnico Normativo, pudiendo la reglamentación ampliar dichas bases pero no reducirlas.

En caso de incumplimiento del plazo establecido, la Autoridad de Aplicación deberá informar fundadamente al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. y al Honorable Congreso de la Nación dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores al vencimiento, detallando causas técnicas, institucionales o presupuestarias y el cronograma de regularización. El incumplimiento del plazo no suspenderá el avance de las demás fases que no dependan

técnicamente del Marco publicado.

SEGUNDA.- Entrada en vigencia.

La presente ley entrará en vigencia a los NOVENTA (90) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial.

La reglamentación general deberá dictarse dentro del plazo previsto en el Artículo 72 de la presente ley.

Sin perjuicio de su entrada en vigencia formal, las obligaciones operativas, técnicas, estructurales y prestacionales previstas en la presente ley se activarán de manera progresiva conforme:

a) Las fases de implementación establecidas en las Disposiciones Transitorias correspondientes.

b) La certificación técnica de cada módulo por parte de la Autoridad de Aplicación.

c) La verificación de disponibilidad de infraestructura mínima necesaria para su cumplimiento.

Ninguna obligación de carácter tecnológico, financiero, organizacional o prestacional podrá exigirse a prestadores, financiadores o jurisdicciones antes de encontrarse habilitada la fase respectiva y garantizadas las condiciones técnicas mínimas para su cumplimiento.

El incumplimiento de plazos aspiracionales de implementación no generará sanciones automáticas, debiendo la Autoridad de Aplicación informar fundadamente al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. y a las Comisiones competentes del Congreso sobre las causas del desvío y el cronograma ajustado.

SEGUNDA BIS.- Régimen Transitorio del Fondo de Servicio Universal (FSU)

La utilización de recursos del Fondo del Servicio Universal conforme lo dispuesto en el Artículo 12 TER requerirá reglamentación operativa específica por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la cual deberá dictarse dentro de los NOVENTA (90) días corridos contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación.

A los efectos de la presente disposición, la utilización del FSU para proyectos de conectividad sanitaria se encuadra exclusivamente en los destinos elegibles del Fondo conforme la Ley 27.078 y sus modificatorias. Toda aplicación de recursos del FSU a proyectos de conectividad de infraestructura sanitaria pública en zonas sin cobertura comercial adecuada deberá ajustarse a los criterios que establezca el ENACOM en coordinación con el Ministerio de Salud, sin alterar la finalidad esencial del Fondo ni la competencia institucional del ENACOM.

Dicha reglamentación tendrá carácter operativo y deberá respetar estrictamente el alcance legal establecido en el Artículo 12 TER, no pudiendo alterar, restringir ni desnaturalizar sus finalidades.

Vencido el plazo previsto sin que se haya dictado la reglamentación correspondiente, el Ministerio de Salud de la Nación, previa intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), podrá establecer lineamientos operativos transitorios estrictamente necesarios para la ejecución de proyectos de conectividad sanitaria en zonas críticas, los cuales:

a) Tendrán carácter provisional.

b) Se dictarán en coordinación técnica con ENACOM.

c) Serán notificados de manera inmediata a dicho organismo.

ENACOM podrá formular observaciones técnicas dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos desde la notificación.

Hasta tanto se dicte la reglamentación definitiva, los lineamientos operativos transitorios permitirán la ejecución de los proyectos estrictamente vinculados a la conectividad sanitaria prioritaria, sin afectar la competencia institucional del ENACOM ni alterar el régimen general del Fondo del Servicio Universal.

La implementación de proyectos financiados mediante el FSU deberá respetar los principios de transparencia, trazabilidad del gasto, control concurrente y auditoría

TERCERA.- Consolidación Técnica del C.U.R.A.-ID

Dentro de los primeros CIENTO OCHENTA (180) días contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, la Autoridad de Aplicación, en coordinación con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), deberá completar el proceso de validación, sincronización y consolidación técnica del Identificador Único de Paciente (C.U.R.A.-ID) generado conforme el Artículo 17.

A los efectos de la presente disposición, se entenderá por consolidación técnica:

a) La validación de integridad y unicidad del identificador respecto de los registros del RENAPER.

b) La detección y resolución progresiva de inconsistencias o duplicidades.

c) La implementación de mecanismos automáticos de actualización ante modificaciones registrales.

d) La definición de protocolos específicos para personas con documentación en trámite, extranjeros residentes, recién nacidos u otras situaciones especiales.

La certificación de consolidación técnica será emitida por la Autoridad de Aplicación con intervención técnica del RENAPER y quedará sujeta a auditoría posterior por los organismos competentes.

En caso de imposibilidad técnica debidamente fundada, el plazo podrá extenderse por única vez hasta NOVENTA (90) días adicionales, debiendo informarse al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. y a las comisiones competentes del Congreso.

Hasta tanto se complete la consolidación técnica, el Sistema podrá operar con identificadores válidamente generados, garantizando migración automática y sin pérdida de trazabilidad una vez finalizado el proceso. Los actos administrativos y clínicos realizados sobre un C.U.R.A.-ID provisional mantienen plena validez jurídica, garantizándose migración automática y sin solución de continuidad una vez emitida la certificación de consolidación técnica.

CUARTA.- Fase Cero - Lanzamiento Nacional de la Credencial C.U.R.A.

a) Generación del C.U.R.A.-ID como acto de identificación administrativa.

Desde la entrada en vigencia de la presente ley, el Sistema C.U.R.A. generará un Identificador Único de Paciente (C.U.R.A.-ID) para todas las personas inscriptas en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), conforme lo dispuesto en el Artículo 17°, sin perjuicio del proceso de consolidación técnica previsto en la Disposición Transitoria Tercera.

La generación del C.U.R.A.-ID constituye un acto administrativo de identificación sanitaria y no implica tratamiento de datos personales sensibles en los términos del artículo 2° de la Ley 25.326 hasta tanto el titular active su Credencial C.U.R.A. mediante consentimiento libre, expreso e informado conforme el artículo 5° de la Ley 25.326. El C.U.R.A.-ID generado opera como número de reserva interno del Sistema, sin asociación a datos clínicos ni sanitarios, hasta la activación voluntaria por su titular.

La Autoridad de Aplicación deberá instrumentar el mecanismo de activación con consentimiento informado dentro de los TREINTA (30) días de entrada en vigencia de la presente ley, debiendo dicho mecanismo:

1) Garantizar la provisión de información clara, accesible y completa al titular sobre el alcance, finalidad y consecuencias del tratamiento de datos.
2) Permitir la activación mediante acto positivo del titular, sin presumir consentimiento por

omisión.

3) Habilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme la Ley 25.326.

4) Garantizar que la no activación de la Credencial no generará consecuencias desfavorables para el titular en el acceso a prestaciones de salud.

b) Disponibilidad progresiva de la Credencial Digital.

Dentro de los NOVENTA (90) días de entrada en vigencia, la Credencial C.U.R.A. digital estará disponible a nivel nacional a través del portal web oficial del Sistema C.U.R.A. y de la aplicación "Mi Argentina" o la que en el futuro la reemplace, una vez que el titular haya prestado consentimiento informado conforme el inciso a).

La Autoridad de Aplicación podrá disponer un despliegue técnico gradual durante los primeros TREINTA (30) días de habilitación, a efectos de garantizar estabilidad operativa, seguridad informática y adecuada experiencia de usuario, sin afectar el derecho de acceso de los titulares.

c) Funcionalidades habilitadas durante la Fase Cero.

Durante esta etapa inicial, los ciudadanos que hayan activado su Credencial podrán:

1) Acceder utilizando las credenciales de identidad digital del Estado.

2) Visualizar y descargar su Credencial C.U.R.A. digital.

3) Gestionar y actualizar información no validada clínicamente (contactos de emergencia, alergias declaradas, medicación habitual informada y datos de contacto).

4) Ejercer los derechos previstos en la presente ley en materia de protección de datos personales.

d) Carga y validación de datos clínicos.

Los datos clínicos incorporados en la Credencial C.U.R.A. solo podrán adquirir carácter clínicamente validado cuando sean confirmados por profesional matriculado a través del módulo de Historia Clínica Digital Integral operativo en la respectiva jurisdicción.

Hasta tanto ello ocurra:

1) Los datos ingresados por el titular tendrán carácter exclusivamente auto-declarado.

2) Deberán identificarse de manera visible como "informados por el titular".

3) No sustituirán validación médica ni generarán responsabilidad profesional hasta su incorporación formal en la Historia Clínica Digital.

4) El Sistema deberá diferenciar visual y técnicamente entre datos auto-declarados y datos clínicamente validados, a fin de evitar confusión asistencial.

La disponibilidad pública de la Credencial C.U.R.A. no implicará validez clínica del C.U.R.A.-ID hasta tanto se emita la certificación de consolidación técnica prevista en la

Disposición Transitoria Tercera.

e) Convergencia con el Programa Piloto Nacional.

En las provincias del Programa Piloto Nacional se habilitará la validación profesional de datos clínicos y la integración plena con los módulos asistenciales.

En el resto del territorio nacional, durante la Fase Cero, la Credencial funcionará como documento digital de identificación sanitaria con funcionalidades básicas hasta la activación progresiva de los módulos clínicos.

QUINTA.- Programa Piloto Nacional.

a) Alcance inicial.

El Programa Piloto Nacional se implementará en un mínimo de TRES (3) y un máximo de CINCO (5) jurisdicciones, seleccionadas por el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. en coordinación con la Autoridad de Aplicación, considerando criterios de representatividad geográfica, diversidad demográfica y capacidad técnica instalada.

El piloto alcanzará inicialmente a laboratorios, farmacias y centros de vacunación, donde se probarán las funcionalidades básicas de carga, consulta y trazabilidad de resultados médicos.

b) Duración.

El período del Programa Piloto tendrá una duración máxima de VEINTICUATRO (24) meses contados desde su inicio formal, prorrogable por única vez por hasta DOCE (12) meses mediante resolución fundada de la Autoridad de Aplicación, con informe previo al Consejo Nacional.

c) Módulos obligatoriamente operativos durante el piloto.

Durante esta fase deberán estar plenamente operativos:

1) El Portal Web del Paciente, con acceso restringido a la sección "Mis Estudios".
2) El Portal Profesional, habilitando la visualización de resultados conforme Artículo 29.
3) El Portal de Laboratorios, para carga y consulta de estudios solicitados.
4) El Panel de Sugerencias y Reporte de Fallas.
5) El Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría.

d) Protocolos de Seguridad Obligatorios.

Será obligatorio probar y utilizar durante el piloto:

1) Verificación fehaciente de identidad conforme Artículo 29.
2) Controles de acceso diferenciados para cada perfil.
3) Operación con conectividad intermitente conforme Artículo 22.

4) Registro completo de accesos y modificaciones.

e) Régimen transitorio de aprendizaje.

Durante el Programa Piloto:

1) No se aplicarán sanciones por errores operativos no dolosos derivados de fallas técnicas o curva de aprendizaje.

2) Las irregularidades deberán documentarse y corregirse.

3) Serán sancionables exclusivamente las conductas dolosas o fraudulentas.

El régimen de aprendizaje previsto en el presente inciso e) se extenderá automáticamente a toda jurisdicción, prestador o profesional que se incorpore al Sistema dentro de los primeros VEINTICUATRO (24) meses de implementación nacional, independientemente de si su jurisdicción integra el Programa Piloto. Los mismos plazos y condiciones se aplicarán de manera proporcional al inicio de la operación de cada sujeto obligado, garantizando igualdad de trato en la curva de aprendizaje.

f) Pruebas técnicas obligatorias previas a la expansión.

Antes de autorizar la expansión territorial, la Autoridad de Aplicación deberá certificar formalmente:

1) Interoperabilidad funcional entre módulos.

2) Estabilidad operativa bajo carga real.

3) Seguridad informática validada mediante pruebas de penetración realizadas por auditor externo independiente.

4) Nivel adecuado de usabilidad y aceptación por parte de usuarios y profesionales.

g) Transparencia del piloto.

Los inconvenientes detectados, métricas de desempeño y mejoras implementadas deberán publicarse en el Portal Federal de Transparencia, preservando datos sensibles.

h) Objetivo del piloto.

El Programa Piloto tendrá por finalidad validar usabilidad, seguridad, aceptación de protocolos, robustez técnica y adecuación normativa antes de su expansión progresiva.

SEXTA.- Constitución y régimen de actuación del Subcomité de Usabilidad Clínica.

El Subcomité de Usabilidad Clínica establecido en el Artículo 8° deberá constituirse dentro de los SESENTA (60) días posteriores a la reglamentación de la presente ley.

Durante la fase piloto y las fases posteriores de implementación, será responsable de revisar y emitir dictamen técnico fundado sobre los prototipos, interfaces y flujos de interacción del Sistema C.U.R.A., en materia de:

a) Estándares mínimos de usabilidad.

b) Accesibilidad universal.

c) Seguridad clínica derivada del diseño de interfaz.

Procedimiento

La Autoridad de Aplicación deberá remitir los prototipos al Subcomité con una antelación mínima de TREINTA (30) días corridos previos a su despliegue.

El Subcomité deberá emitir dictamen dentro de QUINCE (15) días hábiles desde la recepción, prorrogables por única vez por DIEZ (10) días hábiles adicionales mediante resolución fundada.

El dictamen tendrá carácter de recomendación técnica obligatoria en cuanto a la definición de estándares mínimos, sin afectar la competencia decisoria final de la Autoridad de Aplicación.

La Autoridad de Aplicación podrá:

a) Incorporar íntegramente las observaciones formuladas; o

b) Apartarse fundadamente, debiendo justificar técnicamente las razones del apartamiento y las medidas alternativas adoptadas para garantizar los estándares mínimos exigibles.

En caso de apartamiento, el Subcomité podrá elevar informe al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., quien resolverá en un plazo máximo de QUINCE (15) días.

Vencido el plazo para dictaminar sin pronunciamiento, la Autoridad de Aplicación podrá continuar con el despliegue, sin perjuicio de recomendaciones posteriores de mejora.

La falta de constitución del Subcomité dentro del plazo establecido no impedirá el inicio del Programa Piloto, debiendo aplicarse transitoriamente estándares internacionales reconocidos en materia de accesibilidad y diseño seguro en sistemas sanitarios digitales.

SÉPTIMA.- Implementación por Tandas Provinciales y Régimen de Expansión Progresiva.

Determinación de Provincias por Etapa

El Consejo Federal de Salud (COFESA), en coordinación con la Autoridad de Aplicación, determinará mediante resolución conjunta las TRES (3) a CINCO (5) provincias que participarán en cada etapa de expansión, considerando criterios de representatividad regional, capacidad técnica instalada y compromiso institucional. Deberá incorporarse como criterio prioritario la situación sanitaria estructural de cada jurisdicción, garantizando que en las primeras tandas participen provincias con mayores déficits sanitarios verificables, incluyendo indicadores de mortalidad infantil, acceso a especialidades críticas e índice de desarrollo humano provincial, de modo de evitar que la implementación progresiva reproduzca o amplíe las brechas sanitarias territoriales preexistentes.

Implementación por Tandas

La implementación se realizará por tandas de TRES (3) a CINCO (5) provincias.

El inicio de una nueva tanda requerirá que la tanda precedente haya alcanzado el período mínimo de observación previsto en la presente disposición. Dicho período mínimo de SEIS (6) meses de operación efectiva y estable opera como plazo de acumulación de datos

estadísticos suficientes para la evaluación de los Criterios Técnicos de Habilitación definidos en la Disposición Transitoria Octava. Si los criterios técnicos se cumplen antes del vencimiento del período mínimo de observación, el Consejo Nacional deberá emitir la certificación correspondiente dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a la verificación del cumplimiento, sin necesidad de aguardar el vencimiento del plazo.

El avance de una provincia no quedará condicionado al cumplimiento de otras provincias.

Hito de Salida de Provincia

Se considerará que una provincia ha alcanzado el Hito de Salida cuando haya cumplido individualmente los Criterios Técnicos de Habilitación definidos para la fase correspondiente, conforme certificación del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

Duración por Provincia

Cada provincia dispondrá de un plazo estimado de SEIS (6) meses y máximo de NUEVE (9) meses desde su inicio formal para alcanzar el Hito de Salida.

Consecuencias del Incumplimiento Provincial

Si una provincia no alcanzare el Hito de Salida dentro del plazo máximo:

a) La Autoridad de Aplicación deberá elaborar un Plan de Asistencia Técnica Reforzada.

b) Podrá suspenderse la asignación de recursos específicos vinculados a la fase incumplida.

c) Las demás provincias continuarán su implementación sin interrupción.

La provincia podrá reanudar su proceso una vez subsanadas las observaciones técnicas.

Gatillo para Avance de Fase Funcional Superior

Para habilitar una fase funcional superior a nivel nacional, se requerirá que:

a) Provincias que representen al menos el SESENTA POR CIENTO (60%) del total de las jurisdicciones, o

b) Provincias que representen al menos el SETENTA POR CIENTO (70%) de la población nacional, hayan alcanzado el Hito de Salida de la fase anterior.

Excepción por Fuerza Mayor

En casos de fuerza mayor debidamente acreditados —desastres naturales, emergencias sanitarias declaradas, colapso de infraestructura crítica o ciberincidentes de alcance significativo— el Consejo Nacional podrá extender el plazo máximo de una provincia hasta DOCE (12) meses mediante resolución fundada.

Dicha extensión no podrá alterar los criterios técnicos de habilitación ni el principio de progresividad federal.

OCTAVA.- Criterios Técnicos de Habilitación para Avance de Fases.

El avance a cada fase sucesiva de implementación no estará sujeto únicamente al

cumplimiento de plazos, sino a la verificación fehaciente de Criterios Técnicos de Habilitación por parte del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. En caso de divergencia entre el cronograma estimado y el cumplimiento técnico efectivo, prevalecerá el criterio de estabilidad, seguridad y funcionalidad por sobre la estricta consecutividad temporal.

Para pasar de la FASE 1 (Piloto Nacional) a la FASE 2 (Expansión Provincial): El Consejo Nacional deberá certificar, mediante informe público, el cumplimiento de los siguientes criterios en las provincias piloto:

Una disponibilidad mensual del sistema igual o superior al 98% durante el último trimestre

Una tasa de integración exitosa de laboratorios de mediana y alta complejidad igual o superior al 85%

Una adopción activa del sistema por al menos el 40% del cuerpo médico, con una tendencia de crecimiento mensual sostenida

La ausencia de brechas de seguridad críticas o graves sin parchear por más de 72 horas

Para pasar de la FASE 2 (Módulo Clínico Ampliado) a la FASE 2 BIS (Integración PAMI): El Consejo Nacional deberá certificar:

La operatividad estable del módulo de receta electrónica integrada en al menos el 60% de las provincias de la FASE 2

La disponibilidad de la Credencial C.U.R.A. a nivel nacional

La interoperabilidad con los sistemas de identidad digital del Estado (Mi Argentina, ANSES, AFIP)

Para pasar de la FASE 2 BIS (Integración PAMI) a la FASE 3 (Historia Clínica Integral): El Consejo Nacional deberá certificar:

La implementación exitosa del Portal PAMI-C.U.R.A. en al menos el 80% de las jurisdicciones

La operatividad del módulo de gestión electrónica de medicamentos PAMI

La integración estable con los sistemas de RENAPER y ANSES

Para pasar de la FASE 4 (Historia Clínica Integral) a la FASE 5 (Internacional IPS): El Consejo Nacional deberá certificar:

La cobertura geográfica del 90% de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Una calidad de datos clínicos integrales igual o superior al 98%

La estabilidad comprobada del módulo de historia clínica integral durante al menos 6 meses consecutivos

Efecto del Incumplimiento: Si los criterios técnicos no se cumplen al finalizar el plazo estimado de la fase, ésta se extenderá hasta su cumplimiento, y el Consejo Nacional deberá publicar un plan correctivo detallado con cronograma de implementación.

Hito para la Implementación del Módulo de Stock Farmacéutico

Para habilitar la transición hacia las fases avanzadas del Módulo Clínico Ampliado y asegurar la disponibilidad efectiva del sistema de información farmacéutica, el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. deberá certificar:

a) Que, durante los primeros DOCE (12) meses desde la reglamentación de la ley, el módulo haya operado en modalidad voluntaria, permitiendo a las farmacias declarar stock de medicamentos esenciales y de alto uso poblacional sin obligación ni sanción.

b) Que, vencido dicho período, la Autoridad de Aplicación haya establecido un calendario escalonado de incorporación obligatoria, priorizando:

1) medicamentos esenciales del PMO;

2) medicamentos de alto uso;

3) medicación crítica y de urgencia;

4) insumos sujetos a trazabilidad nacional.

c) Que la obligatoriedad se implemente de manera progresiva, proporcional a la capacidad operativa de las farmacias, con interoperabilidad técnica verificada en entorno controlado.

La implementación obligatoria deberá contemplar criterios de proporcionalidad según volumen de facturación, localización geográfica, nivel de conectividad disponible y capacidad tecnológica declarada por el establecimiento.

d) Que existan reportes técnicos trimestrales que acrediten la estabilidad del módulo, su integración con el Sistema Federal de Turnos y el Portal del Paciente, y la ausencia de vulnerabilidades de seguridad críticas.

Efecto: La implementación obligatoria del módulo será condición habilitante para avanzar a la fase correspondiente del Módulo Clínico Ampliado, de conformidad con los criterios técnicos establecidos en esta Disposición.

Procedimiento de Certificación y Definiciones Operativas

a) Publicación de Indicadores. La Autoridad de Aplicación deberá publicar trimestralmente en el Portal Federal de Transparencia del Sistema C.U.R.A. los indicadores correspondientes a cada criterio técnico de habilitación, incluyendo metodología de cálculo, universo considerado y margen de error estadístico.

b) Auditoría Técnica Independiente. La certificación del cumplimiento de los criterios técnicos deberá contar con auditoría técnica independiente realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), universidad nacional con competencia técnica acreditada o entidad equivalente designada por el Consejo Nacional.

c) Límite Máximo de Extensión. Si transcurridos TREINTA Y SEIS (36) meses desde el inicio formal de una fase no se hubieran alcanzado los criterios técnicos de transición, el Consejo Nacional deberá:

1) Evaluar la razonabilidad técnica de los criterios fijados;

2) Proponer ajustes fundados cuando resulten materialmente inalcanzables;

3) Informar al Congreso Nacional las causas del incumplimiento y el plan de adecuación.

d) Definiciones Operativas. A los efectos de esta disposición se entenderá por:

1) Adopción activa del sistema: utilización efectiva por parte del profesional mediante al menos una acción asistencial significativa mensual (carga clínica, prescripción electrónica, consulta validada de datos o intervención documentada).
2) Tendencia de crecimiento sostenida: incremento mensual promedio no inferior al DOS POR CIENTO (2%) durante al menos tres (3) meses consecutivos.
3) Calidad de datos clínicos integrales: porcentaje de registros que cumplan simultáneamente con criterios de completitud de campos críticos, coherencia interna y validación profesional cuando corresponda.

e) Interpretación armónica de fases y expansión territorial. El avance de fases tecnológicas a nivel nacional no requerirá la adhesión o implementación simultánea en la totalidad de las jurisdicciones, sino el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos y la cobertura mínima territorial o poblacional prevista en la presente ley.

Ninguna jurisdicción individual podrá impedir el avance funcional del sistema en otras jurisdicciones que hayan cumplido los requisitos técnicos correspondientes.

En caso de divergencia entre cronograma estimado y cumplimiento técnico efectivo, prevalecerá el criterio de estabilidad, seguridad y funcionalidad por sobre la estricta consecutividad temporal.

NOVENA.- Protocolo de Estabilización y Retroceso Controlado.

Declaración de Estado de Observación Crítica: El Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. podrá declarar este estado, de oficio, a solicitud de la Autoridad de Aplicación, o por denuncia fundada de cualquier miembro del Consejo, para una jurisdicción cuyo desempeño en una fase avanzada incumpla reiteradamente los criterios técnicos de estabilidad, seguridad o interoperabilidad.

Se considerará incumplimiento reiterado cuando se verifique el incumplimiento de los criterios técnicos durante DOS (2) informes trimestrales consecutivos o en TRES (3) mediciones dentro de un período de SEIS (6) meses.

Periodo de Gracia y Asistencia: Declarado el estado, se dispondrá de un plazo de SESENTA días hábiles para que la jurisdicción, con el apoyo técnico de la Autoridad de Aplicación, implemente las medidas correctivas necesarias.

Suspensión Temporal de Fase Avanzada: Vencido el plazo sin que se hayan solucionado los problemas de fondo, el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., por mayoría simple, podrá disponer la suspensión temporal de la fase avanzada para dicha jurisdicción. Esta decisión será pública y fundada.

Ejecución del Retroceso Controlado: Una vez tomada la decisión de suspensión, la Autoridad de Aplicación ejecutará un retroceso controlado, que implicará:

a) La desactivación segura de los módulos de la fase avanzada para la jurisdicción
b) La reactivación automática de los módulos de la fase anterior que hayan demostrado

estabilidad

c) La conservación en un entorno seguro de los datos ya cargados en la fase avanzada

Los datos permanecerán accesibles en modo de consulta para los profesionales habilitados, sin posibilidad de nuevas cargas hasta la reactivación de la fase avanzada.

Reintegración: La jurisdicción podrá solicitar su reingreso a la fase avanzada una vez que demuestre ante el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. el cumplimiento sostenido de los criterios técnicos durante un período no menor a NOVENTA (90) días.

DÉCIMA.- Implementación del Protocolo para Pacientes No Identificados.

Dentro de los ciento ochenta (180) días desde la reglamentación, la Autoridad de Aplicación deberá implementar progresivamente el sistema previsto en el Artículo 29 BIS, comenzando por las jurisdicciones piloto.

UNDÉCIMA.- Implementación Progresiva del Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT)

a) Alcance. El Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT) se implementará progresivamente en cada jurisdicción que haya alcanzado el Hito de Salida de la Fase 2 (Expansión Provincial).

b) Hito previo obligatorio. Con carácter previo a su activación en cualquier jurisdicción, la Autoridad de Aplicación, en coordinación con la ANMAT, deberá:

1) Desarrollar, probar y validar técnicamente el módulo RDDT.
2) Publicar las especificaciones técnicas de integración.
3) Certificar su interoperabilidad con el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos.
4) Este hito será condición habilitante para toda implementación territorial.

c) Secuencia obligatoria por jurisdicción. Una vez certificada la jurisdicción en Fase 2, se activará la siguiente secuencia:

1) Implementación inicial (0 a 6 meses): Las farmacias deberán incorporar el RDDT como mecanismo operativo complementario.
2) Período de coexistencia (6 a 18 meses): Durante DOCE (12) meses contados desde la activación del RDDT en la jurisdicción: i) El troquel físico y el RDDT tendrán validez legal simultánea. ii) El RDDT deberá utilizarse en toda dispensación. iii) El troquel físico podrá mantenerse como respaldo transitorio. En caso de divergencia entre ambos registros durante el período de coexistencia, prevalecerá el registro digital RDDT como fuente primaria de validación.
3) Sustitución definitiva (a partir del mes 18): El RDDT se convertirá en el único mecanismo válido con fuerza liberatoria para la dispensación en la jurisdicción correspondiente,

quedando sin efecto la obligatoriedad del troquel físico, con las siguientes condiciones: i) La sustitución definitiva del troquel físico no operará en jurisdicciones donde la conectividad verificada no alcance el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del tiempo de disponibilidad mensual en el establecimiento. En tales casos, ambos sistemas mantendrán validez simultánea hasta que la Autoridad de Aplicación certifique la conectividad adecuada. ii) La sustitución no podrá generar responsabilidad profesional por fallas técnicas del RDDT no atribuibles al farmacéutico. iii) La Autoridad de Aplicación publicará trimestralmente el mapa de jurisdicciones habilitadas para sustitución definitiva.

d) Integración nacional. Durante el período de coexistencia, la Autoridad de Aplicación y la ANMAT deberán completar la integración plena y bidireccional entre el RDDT y el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos, garantizando consistencia, validación cruzada y prevención de duplicaciones.

e) Verificación. La ANMAT y la Autoridad de Aplicación certificarán el cumplimiento de cada etapa antes de habilitar el avance a la Fase siguiente.

f) Financiamiento y sostenibilidad. Las acciones técnicas, desarrollos e integraciones previstas en la presente disposición se ejecutarán conforme al régimen de financiamiento establecido en el Artículo 35 y 35 BIS de la presente ley, bajo el principio de máxima eficiencia presupuestaria y progresividad territorial, sin generar derecho subjetivo a compensación económica automática por parte de los sujetos obligados.

La sustitución definitiva del soporte físico y del troquel se implementará de manera progresiva por jurisdicción, conforme cronograma aprobado por la Autoridad de Aplicación y validación técnica certificada de interoperabilidad, estabilidad, seguridad y conectividad adecuada.

Hasta tanto se verifique operatividad plena y conectividad suficiente, podrá disponerse un régimen transitorio excepcional en jurisdicciones específicas por plazo determinado, sin afectar el principio general de digitalización obligatoria.

DUODÉCIMA.- Implementación Progresiva del Sistema Federal de Gestión de Turnos.

La implementación del Sistema Federal de Gestión de Turnos establecido en el Artículo 19 bis se realizará de forma progresiva, supeditando su obligatoriedad al cumplimiento de los siguientes hitos funcionales:

Hito de Habilitación del Sistema: La Autoridad de Aplicación deberá tener desarrollado, probado y publicado el Sistema Federal de Gestión de Turnos. Dicho sistema deberá incorporar de manera plenamente funcional todas las capacidades establecidas en el Artículo 19, incluyendo la búsqueda inteligente, la gestión en tiempo real y la autogestión ciudadana.

Este hito es previo y condición necesaria para cualquier implementación.

Hito de Implementación Voluntaria: Una vez que una jurisdicción o prestador individual alcance el Hito de Salida de la Fase 2 (Módulo Clínico Ampliado), el Sistema Federal de Gestión de Turnos estará a su disposición para su uso voluntario y de prueba.

Hito de Obligatoriedad para el Sector Público: El uso del sistema será obligatorio para el cien por ciento (100%) de los establecimientos de salud de gestión pública de una jurisdicción, una vez que dicha jurisdicción haya alcanzado y sido certificada en el Hito de Salida de la Fase 1 (Módulo de Emergencia y Estudios) y haya mantenido un funcionamiento estable del mismo durante al menos SEIS (6) meses; para esta certificación, el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A deberá verificar que al menos el 90% de los establecimientos públicos de la jurisdicción han cargado y mantienen actualizadas sus agendas en el sistema, y que la funcionalidad de autogestión ciudadana se encuentra operativa y estable.

A los efectos de la certificación, se considerará "uso estable" cuando:

a) Al menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) de las agendas de cada establecimiento público se encuentren cargadas en el sistema.

b) Las agendas se actualicen como mínimo semanalmente.

c) No se registren interrupciones técnicas superiores a CUARENTA Y OCHO (48) horas consecutivas sin causa de fuerza mayor.

Programa de Digitalización de Agendas Públicas.

La Autoridad de Aplicación deberá implementar un programa de apoyo técnico para establecimientos públicos que no cuenten con sistemas informatizados de gestión de turnos, incluyendo:

a) Interfaz web simplificada de carga manual.

b) Capacitación básica al personal administrativo.

c) Soporte técnico remoto inicial.

El financiamiento podrá realizarse con recursos del FIISD conforme artículo 35.

Hito de Obligatoriedad para el Sector Privado:

La obligatoriedad se extenderá a clínicas, sanatorios y obras sociales de medicina privada exclusivamente en aquellas jurisdicciones que hayan adherido expresamente al Sistema Federal de Turnos mediante convenio interjurisdiccional conforme el Artículo 26 de la presente ley. La sola verificación de los hitos funcionales no es suficiente para extender la obligatoriedad al sector privado sin la adhesión provincial previa.

En las jurisdicciones con adhesión provincial vigente, la obligatoriedad se activará una vez que se cumpla uno de los siguientes dos criterios:

a) Que haya transcurrido un plazo de DOCE (12) meses desde que se decretó la obligatoriedad para su sector público

b) Que al menos el OCHENTA POR CIENTO (80%) de los establecimientos públicos de la jurisdicción demuestren un uso estable y correcto del módulo de turnos durante al menos

SEIS (6) meses consecutivos

La obligatoriedad alcanzará a clínicas, sanatorios, centros médicos privados y obras sociales que cuenten con CINCO (5) o más profesionales matriculados.

No estarán alcanzados los consultorios individuales o agrupaciones de hasta CUATRO (4) profesionales, quienes podrán adherir voluntariamente.

Los establecimientos privados ubicados en zonas con conectividad certificada insuficiente conforme los parámetros de la presente ley quedarán exentos de la obligatoriedad hasta que la Autoridad de Aplicación certifique la conectividad adecuada, pudiendo adherir voluntariamente durante dicho período.

DÉCIMOTERCERA.- Régimen Transitorio de Implantación y Aprendizaje.

Establécese un "Régimen de Implantación y Aprendizaje" de alcance individual e intransferible para cada profesional, establecimiento, farmacia, laboratorio y demás sujeto obligado. Dicho régimen se activará para cada uno de ellos a partir de la fecha de su primera operación registrada en el Sistema C.U.R.A., con independencia de la fase de implementación alcanzada por la jurisdicción en que opera, y tendrá una vigencia de DIECIOCHO (18) meses contados desde dicha fecha.

Para los sujetos que se incorporen al Sistema durante la vigencia del Programa Piloto Nacional en su jurisdicción, el Régimen de Implantación y Aprendizaje previsto en la presente disposición comenzará a computarse desde la finalización del período piloto, aplicándose en lo que refiere a las conductas previstas en la Disposición Transitoria Quinta durante el desarrollo del piloto el régimen más favorable al sujeto obligado, sin acumulación de plazos entre ambos regímenes.

Durante este período, la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el Artículo 44 se regirá por las siguientes reglas especiales:

Faltas Leves y Graves - Sustitución de Sanciones:

Las conductas tipificadas como faltas leves y graves en el Artículo 44, incisos a) y b), no serán sancionadas con suspensión de acceso, apercibimiento formal o comunicación a colegios profesionales.

En su lugar, se aplicará de manera obligatoria un sistema de corrección y capacitación, que consistirá en:

a) Notificación Educativa: El sistema o la Autoridad de Aplicación notificará al profesional o prestador, detallando el error o incumplimiento de forma clara y pedagógica

b) Obligación de Capacitación Correctiva: El usuario deberá completar con éxito un módulo de capacitación específico y breve dentro del Sistema Federal de Capacitación, enfocado en la norma o procedimiento incumplido

c) Corrección del Registro: Se otorgará un plazo de SETENTA Y DOS (72) horas hábiles para

que el profesional o prestador subsane el error o complete la información omitida

El incumplimiento de esta obligación de corrección y capacitación se considerará falta grave y será sancionada conforme al régimen general del Artículo 44.

Faltas Gravísimas - Aplicación Inmediata:

Las conductas tipificadas como faltas gravísimas en el Artículo 44, inciso c) –en particular, el acceso sin matrícula, la suplantación de identidad, la alteración de registros de auditoría, la transferencia o comercialización de datos– SERÁN SANCIONADAS CON TODA SU SEVERIDAD DESDE EL PRIMER DÍA de incorporación al sistema de cada sujeto, sin gozar de este régimen transitorio.

Trazabilidad y Registro de Incidencias:

Todas las incidencias gestionadas bajo este régimen transitorio quedarán registradas en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría. Estos registros no constituirán un antecedente sancionatorio, pero podrán ser utilizados por la Autoridad de Aplicación para identificar necesidades de capacitación masiva, ajustar interfaces o clarificar procedimientos.

Finalización del Régimen Transitorio:

Cumplido el plazo de DIECIOCHO meses desde la primera operación registrada del sujeto en el Sistema, el régimen sancionatorio del Artículo 44 se aplicará en su integridad y de forma plena. La Autoridad de Aplicación comunicará este cambio con al menos TREINTA (30) días de antelación al sujeto afectado.

Reglas Complementarias del Régimen Transitorio

a) Reincidencia. La reiteración de una misma falta leve o grave dentro del período de NOVENTA (90) días posteriores a la capacitación correctiva dará lugar a una capacitación reforzada. A partir de la tercera reincidencia en la misma conducta dentro del plazo de DIECIOCHO (18) meses, podrá aplicarse el régimen sancionatorio del Artículo 44 con atenuación fundada.

b) Determinación de Dolo. La calificación de una conducta como dolosa requerirá:

1) Acto fundado de la Autoridad de Aplicación,

2) Derecho a descargo del usuario por DIEZ (10) días hábiles,

3) Resolución motivada,

4) Posibilidad de recurso ante el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A.

c) Cómputo del Plazo. El plazo de DIECIOCHO (18) meses se computará siempre desde la primera operación registrada del sujeto en el Sistema, con independencia de la fase jurisdiccional en que se produzca dicha incorporación.

d) Alcance. El régimen será aplicable tanto a profesionales individuales como a establecimientos, farmacias, laboratorios y demás sujetos obligados.

e) No generación de antecedentes. Las incidencias gestionadas bajo este régimen no constituirán antecedente sancionatorio formal ni serán comunicadas a colegios profesionales, sin perjuicio de su registro interno para fines estadísticos y de mejora del sistema.

DÉCIMOCUARTA.- Pruebas Obligatorias de Estrés e Interoperabilidad.

Antes de que cualquier tanda de provincias sea certificada para alcanzar un Hito de Salida y, por lo tanto, antes de autorizar el inicio de la implementación en una nueva tanda, la Autoridad de Aplicación, a través de la Unidad Ejecutora (UESC) y con la supervisión del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., deberá conducir y aprobar de manera obligatoria una batería de pruebas técnicas sobre la infraestructura desplegada. Dichas pruebas deberán incluir, como mínimo:

Pruebas de Carga y Estrés: Simulación de acceso y uso concurrente de un número de usuarios equivalente al 150% del total de profesionales de la salud de las provincias de la tanda en evaluación, durante un período sostenido de no menos de CUARENTA Y OCHO (48) horas continuas. El sistema debe mantener una disponibilidad superior al 99.5% y tiempos de respuestas inferiores a 3 segundos para consultas críticas.

Pruebas de Interoperabilidad Masiva: Simulación de la carga simultánea de estudios médicos y registros clínicos desde, al menos, CIEN (100) sistemas de prestadores diferentes de forma concurrente, verificando la integridad de los datos, la correcta asignación del C.U.R.A.-ID y el funcionamiento de la Capa de Intercambio Federada (CIF).

Pruebas de Resiliencia y Recuperación ante Desastres (DRP): Ejecución del Plan Nacional de Recuperación ante Desastres, simulando la caída de uno de los nodos de redundancia nacional. El sistema debe demostrar una conmutación automática a un nodo secundario en un tiempo no mayor a CINCO (5) minutos, sin pérdida de datos y con una interrupción del servicio no mayor a DIEZ (10) minutos para los usuarios finales.

Pruebas de Seguridad (Penetration Testing): Realización de tests de penetración por parte de un equipo especializado e independiente, destinados a identificar vulnerabilidades en las APIs, los repositorios y los mecanismos de autenticación. La corrección de las vulnerabilidades críticas y altas identificadas será condición sine qua non para el avance.

La Autoridad de Aplicación deberá publicar un informe público con los resultados de estas pruebas en el portal oficial del Sistema C.U.R.A. dentro de los QUINCE (15) días hábiles posteriores a su finalización. La certificación del Hito de Salida por parte del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. estará supeditada a la aprobación de estas pruebas y a la publicación del informe correspondiente.

Disposiciones Complementarias sobre Ejecución y Certificación

a) Las pruebas de carga, interoperabilidad y resiliencia serán ejecutadas por la Unidad Ejecutora (UESC) bajo supervisión técnica externa de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) o universidad nacional con especialización acreditada en sistemas críticos.

b) Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas obligatoriamente por equipo independiente especializado en ciberseguridad, conforme estándares internacionales reconocidos.

c) La clasificación de vulnerabilidades deberá ajustarse a estándares técnicos internacionales vigentes al momento de la prueba, debiendo corregirse previamente a la certificación aquellas

calificadas como críticas o de alta severidad.

d) En caso de no aprobación de las pruebas, la Autoridad de Aplicación deberá elaborar y publicar un plan correctivo con cronograma de subsanación. La certificación podrá repetirse una vez implementadas las mejoras, priorizando la estabilidad técnica por sobre la estricta consecutividad cronológica de las tandas.

e) La publicación de resultados no deberá comprometer la seguridad operativa del sistema. Los informes públicos podrán omitir detalles técnicos cuya divulgación pudiera generar riesgo de explotación hasta tanto se encuentren debidamente mitigados.

f) Los costos de ejecución de las pruebas serán financiados con recursos del Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD), conforme el Artículo 35 y 35 BIS.

DÉCIMOQUINTA.- Condición para el Despliegue del Resumen Internacional del Paciente (IPS) y Módulo de Atención Internacional.

a) Condición para el Despliegue del Resumen Internacional del Paciente (IPS). Una vez que el módulo de Historia Clínica Integral se encuentre implementado y operativo en al menos el noventa por ciento (90%) de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en jurisdicciones que representen al menos el ochenta y cinco por ciento (85%) de la población nacional, la Autoridad de Aplicación, con conformidad del Consejo Federal de Salud (COFESA), dispondrá de un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días para iniciar el despliegue en producción del módulo de Generación del Resumen Internacional del Paciente (IPS), conforme a lo establecido en el Artículo 18.

El Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. deberá verificar el cumplimiento de este hito y certificar la correcta implementación del estándar IPS.

b) Condición para el Despliegue del Módulo de Atención Internacional. El Módulo de Atención Internacional se implementará una vez cumplida la condición prevista en el inciso anterior.

La Autoridad de Aplicación dispondrá de NOVENTA (90) días para su implementación, debiendo incluir como mínimo:

1) Generación de códigos de acceso temporales desde el portal del paciente y la aplicación "Mi Argentina".
2) Portal público de ingreso de códigos.
3) Sistema de auditoría automática de accesos internacionales.
4) Integración segura con el generador de IPS.

c) Coordinación Internacional y Protección de Datos. La operatividad plena del Módulo de Atención Internacional requerirá la celebración de acuerdos bilaterales o multilaterales de reconocimiento mutuo del estándar IPS, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El acceso internacional se realizará exclusivamente mediante mecanismos de

autorización individual del titular, no implicará transferencia masiva de bases de datos ni alterará el principio de soberanía tecnológica y residencia de datos establecido en el Artículo 71 de la presente ley.

DÉCIMOSEXTA.- Condición para el Desarrollo del Repositorio para Investigación.

El desarrollo del Repositorio de Datos para Investigación establecido en el Artículo 67 BIS se iniciará una vez que el Módulo de Historia Clínica Integral se encuentre operativo y estable durante al menos SEIS (6) meses consecutivos sin incidentes críticos de seguridad o integridad de datos, en al menos el ochenta por ciento (80%) de las provincias adherentes.

El repositorio incluirá exclusivamente datos provenientes de jurisdicciones que hayan alcanzado dicha condición de estabilidad certificada.

La Autoridad de Aplicación, con acuerdo del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., dispondrá de un plazo no mayor a DOCE (12) meses desde el cumplimiento de la condición establecida para tener operativo el repositorio y su protocolo de acceso conforme al Artículo 67 BIS.

El financiamiento de su desarrollo y operación se realizará conforme a lo dispuesto en los Artículos 35 y 35 BIS de la presente ley.

DÉCIMOSÉPTIMA.- Reglamentación operativa del procedimiento de revisión y retiro de módulos de IA.

La Autoridad de Aplicación, a través del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial, deberá dictar la reglamentación técnica detallada del procedimiento de revisión periódica, suspensión preventiva y retiro definitivo ("sunset") de los módulos de inteligencia artificial previstos en el artículo 23 de la presente ley, dentro de un plazo no mayor a DOCE (12) meses contados desde la constitución efectiva del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial.

Dicha reglamentación deberá establecer, como mínimo y sin que la delegación pueda exceder estas bases:

a) Los umbrales objetivos de tasa de error clínico que activan la revisión obligatoria del módulo, diferenciados por nivel de riesgo conforme el Artículo 65 BIS.

b) Los criterios de obsolescencia tecnológica que habilitan el inicio del procedimiento de retiro, incluyendo la pérdida de compatibilidad con los estándares de interoperabilidad vigentes.

c) Los indicadores de riesgo clínico que determinan la suspensión preventiva cautelar, con plazo máximo de resolución.

d) El procedimiento mínimo de auditoría técnica previa al retiro definitivo, garantizando el derecho de descargo de los desarrolladores o proveedores del módulo.

e) El mecanismo de preservación de datos generados por módulos retirados y los plazos de

migración a sistemas alternativos.

Hasta tanto se dicte dicha reglamentación específica, resultarán aplicables de manera directa los principios y criterios establecidos en el artículo 23 y en el Título X de la presente ley.

DÉCIMOCTAVA.- Reglamentación de los Mecanismos de Participación y Gobernanza.

La Autoridad de Aplicación deberá dictar, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días posteriores a la promulgación de la presente ley, la reglamentación normativa necesaria para la implementación de los siguientes mecanismos:

a) Los procedimientos detallados de elección o designación de los representantes del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., en coordinación con el Consejo Federal de Salud (COFESA) y las entidades profesionales correspondientes.

b) El funcionamiento y estándares de transparencia del Portal Federal del Consejo Nacional.

c) Los protocolos de solicitud y convocatoria de sesiones extraordinarias.

d) Los mecanismos de notificación automática y alertas provinciales.

e) Los procedimientos de designación y funciones de los Enlaces Digitales Provinciales.

La implementación técnica y puesta en funcionamiento operativo de dichos mecanismos podrá realizarse de manera progresiva conforme al cronograma federal aprobado por el Consejo Nacional y a la disponibilidad presupuestaria prevista en el artículo 35 y concordantes.

DÉCIMONOVENA.- Integración Progresiva del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria

Objetivo Estratégico.

Establécese como objetivo estratégico la integración progresiva y modernización de las funciones del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), creado por el Decreto N° 1569/2011, dentro de la arquitectura del Sistema C.U.R.A., priorizando la automatización, la interoperabilidad federal, la detección temprana y la unificación de fuentes de información sanitaria.

Cronograma de Integración Funcional.

La integración se realizará de manera escalonada conforme el siguiente esquema:

Fase 1 (0-12 meses): Integración de las notificaciones de enfermedades de notificación obligatoria mediante el sistema de Alertas Sanitarias Tempranas previsto en el Artículo 6°.

Fase 2 (13-24 meses): Migración progresiva de los módulos de vigilancia epidemiológica al Sistema Nacional de Indicadores Predictivos previsto en el Artículo 24.

Fase 3 (25-36 meses): Unificación bajo la arquitectura del Sistema C.U.R.A. de los registros federales vinculados a vigilancia sanitaria, incluyendo ensayos clínicos, farmacovigilancia e

inmunizaciones.

Estrategia de Transición Operativa

Durante el período de integración:

a) El SNVS y el Sistema C.U.R.A. podrán coexistir funcionalmente, garantizando continuidad operativa.

b) El Sistema C.U.R.A. asumirá progresivamente el carácter de sistema primario de captura y procesamiento de datos.

c) No podrá disponerse la desactivación definitiva de funciones del SNVS hasta tanto el módulo correspondiente del Sistema C.U.R.A. se encuentre operativo, estable y certificado.

Transferencia Progresiva de Recursos

Los créditos presupuestarios, recursos humanos, técnicos y materiales asignados al SNVS serán transferidos progresivamente a la estructura operativa del Sistema C.U.R.A. en la medida en que las funciones respectivas sean absorbidas, conforme al régimen de administración financiera vigente y sin afectar la continuidad de las obligaciones sanitarias nacionales e internacionales.

La transferencia deberá:

a) Preservar la estabilidad laboral del personal conforme su régimen aplicable y realizarse exclusivamente mediante procedimientos voluntarios, reasignación con el consentimiento del agente o concursos abiertos, conforme el régimen del artículo 23 de la Ley 25.164. En ningún caso la transferencia implicará modificación del régimen jurídico aplicable al trabajador sin su consentimiento expreso.

b) Garantizar la continuidad de las funciones de vigilancia sanitaria.

c) Evitar duplicación estructural permanente de sistemas.

d) Instrumentarse previa celebración de un convenio de transición con las entidades sindicales representativas del personal comprendido, conforme los mecanismos de participación previstos en la normativa laboral vigente.

Consolidación Institucional

Una vez que los módulos de vigilancia del Sistema C.U.R.A. se encuentren operativos y estables en al menos el OCHENTA POR CIENTO (80%) del territorio nacional, y transcurrido un período adicional mínimo de SEIS (6) meses de funcionamiento continuo sin incidentes críticos, el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer la adecuación normativa necesaria para formalizar la integración total del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) dentro del Sistema C.U.R.A., evitando superposiciones regulatorias y administrativas.

Principio de No Duplicación Presupuestaria

La integración prevista en la presente disposición no implicará la creación de estructuras paralelas ni la generación automática de nuevas erogaciones, debiendo priorizarse la reasignación eficiente de recursos existentes conforme al Artículo 35 de la presente ley.

VIGÉSIMA.- Activación del Sistema de Asistencia Clínica Inteligente.

Condición de Activación

El Sistema de Asistencia Clínica Inteligente previsto en el Artículo 23 se activará una vez que se certifique el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad de datos y de infraestructura establecidos en dicho artículo.

Desarrollo Progresivo

Cumplida la condición de activación, la Autoridad de Aplicación, en coordinación con universidades nacionales y el sistema científico-tecnológico, desarrollará el sistema de manera progresiva en un plazo estimado de hasta TREINTA Y SEIS (36) meses, conforme las etapas técnicas definidas en la presente disposición.

El desarrollo se ejecutará conforme disponibilidad presupuestaria y prioridades sanitarias, de acuerdo con el Artículo 35.

Validación Obligatoria

Previo a su despliegue general, cada etapa deberá ser validada en al menos CINCO (5) hospitales públicos de distintas regiones del país y niveles de complejidad.

La validación deberá demostrar desempeño clínico adecuado conforme métricas técnicas que serán definidas reglamentariamente por el Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial, incluyendo criterios de precisión diagnóstica, sensibilidad para patologías críticas y análisis de sesgos poblacionales.

Implementación por Etapas Técnicas

El desarrollo se realizará mediante etapas sucesivas:

Etapa 6A: Sistema de apoyo al diagnóstico diferencial para patologías prevalentes.

Etapa 6B: Integración con resultados de laboratorio e imágenes diagnósticas.

Etapa 6C: Modelos predictivos avanzados basados en evolución clínica y comorbilidades.

Cada etapa requerirá certificación expresa del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial antes de su habilitación operativa.

Naturaleza Asistiva

El Sistema de Asistencia Clínica Inteligente tendrá carácter exclusivamente asistivo y no sustituirá en ningún caso el juicio clínico profesional, siendo el profesional de la salud el único responsable de la decisión final.

VIGESIMOPRIMERA.- Implementación Progresiva del Régimen Federal de Equidad Territorial

Condición de Activación

El Régimen Federal de Equidad Territorial se activará una vez que el Fondo Federal de Equidad Sanitaria (artículo 43 BIS) haya recibido financiamiento efectivo proveniente de las fuentes previstas en el artículo 35 de la presente ley, certificado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

El Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. dictará resolución formal declarando activado el Régimen dentro de los QUINCE (15) días hábiles de recibida dicha certificación.

La implementación se realizará de manera progresiva y proporcional a los recursos efectivamente disponibles en el Fondo, conforme el principio de sostenibilidad financiera establecido en el artículo 35 BIS.

Fase Inicial (0-12 meses post activación)

a) La Comisión Federal de Equidad Sanitaria (art. 43 TER) elaborará, certificará y publicará el primer Mapa Federal de Zonas Críticas Sanitarias conforme los criterios del artículo 43 QUATER.
b) Implementación inicial de bonos de radicación profesional e incentivos no monetarios básicos en escala gradual, priorizando las zonas con mayor criticidad.
c) Puesta en marcha del Sistema Federal de Indicadores de Equidad para establecer la línea de base de evaluación.

Fase de Consolidación (13-36 meses post activación)

a) Expansión progresiva de programas de rotación obligatoria en residencias y concurrencias de especialidades críticas.
b) Implementación gradual de telemedicina de apoyo y soporte logístico integral en Zonas Críticas Sanitarias.
c) Primera evaluación de impacto conforme artículo 43 SEXIES y ajuste de instrumentos según disponibilidad financiera y resultados obtenidos.

Evaluación Anual Obligatoria

El Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., a través de la Comisión Federal de Equidad Sanitaria, publicará anualmente el Informe de Evaluación de Impacto del Régimen de Equidad Territorial conforme el artículo 43 SEXIES.

VIGESIMOSEGUNDA.- Activación del Hub Global.

Condición de Activación.

La Fase 5 se activará una vez que el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. certifique el cumplimiento estable de la Fase 4 en al menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) del territorio nacional durante un período mínimo de DOCE (12) meses consecutivos.

Plazo de Desarrollo.

Cumplida la condición precedente, la Autoridad de Aplicación dispondrá de un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) meses para desarrollar y poner en operación la Plataforma de

Interoperabilidad Internacional del Sistema C.U.R.A.

Pruebas de Interoperabilidad Internacional.

Previo a su despliegue definitivo, deberán realizarse pruebas obligatorias de interoperabilidad con al menos DOS (2) sistemas de salud de países socios, verificando:

a) Intercambio seguro del Resumen Internacional del Paciente (IPS) conforme estándar HL7 FHIR vigente.

b) Trazabilidad completa de accesos transfronterizos.

c) Cumplimiento de los principios de protección de datos establecidos en la presente ley.

d) Disponibilidad técnica no inferior al 99% durante el período de prueba.

Las pruebas serán auditadas por el Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial en Salud, con intervención técnica de la Autoridad de Aplicación en materia de seguridad informática.

VIGESIMOTERCERA.- Garantía de Ejecución Presupuestaria.

Si transcurridos DIECIOCHO (18) meses desde la reglamentación no se hubiera efectivizado la reasignación presupuestaria prevista en el Artículo 35, inciso a), el Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. deberá elevar al Jefe de Gabinete de Ministros un informe técnico fundado recomendando la inclusión de una partida específica destinada al Sistema C.U.R.A. en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio siguiente. Dicho informe deberá detallar la metodología de cálculo de la partida recomendada, cuyo importe de referencia no deberá ser inferior al CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del presupuesto total vigente del Ministerio de Salud de la Nación correspondiente al ejercicio inmediato anterior, afectado exclusivamente al Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD).

El Jefe de Gabinete de Ministros deberá responder fundadamente al Consejo Nacional dentro de los TREINTA (30) días hábiles de recibido el informe. El Congreso de la Nación podrá considerar el informe del Consejo Nacional y la respuesta del Jefe de Gabinete en el marco del procedimiento de aprobación presupuestaria anual, conforme sus atribuciones constitucionales.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá certificar anualmente si la reasignación presupuestaria prevista en el Artículo 35, inciso a), ha sido efectivamente implementada, informando al Congreso de la Nación en caso contrario.

Una vez acreditada la efectiva reasignación estructural de recursos conforme el Artículo 35, inciso a), la obligación de elevar el informe prevista en la presente disposición cesará automáticamente, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo pueda mantener la partida como refuerzo complementario.

VIGÉSIMOCUARTA.- Implementación y Reporte del Ahorro PAMI–C.U.R.A.

Dentro de los DOCE (12) meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) deberá:

a) Establecer y documentar la línea de base de costos administrativos y operativos de los procesos que serán objeto de digitalización conforme al Sistema C.U.R.A., de acuerdo con lo previsto en el Artículo 35, inciso e).

b) Diseñar y adoptar una metodología objetiva y verificable de cuantificación de ahorros. Dicha metodología deberá basarse, como mínimo, en: i) la reducción verificable de costos de impresión, distribución y gestión de recetas físicas; ii) el ahorro en auditoría manual de prestaciones derivado de la dispensación electrónica trazable; iii) la reducción de costos por duplicación de prescripciones o prestaciones. La metodología será presentada a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que deberá aprobarla o formular observaciones fundadas dentro de los SESENTA (60) días de su presentación. Si la SIGEN no se pronunciare en plazo, la metodología se tendrá por aprobada. La metodología aprobada por la SIGEN será de aplicación obligatoria para el PAMI.

Dentro de los SEIS (6) meses posteriores a la certificación de implementación operativa integral del Sistema C.U.R.A. en el ámbito del PAMI, el Instituto deberá:

a) Cuantificar los ahorros netos derivados de la digitalización de sus procesos administrativos y prestacionales, conforme a la metodología aprobada por la SIGEN.

b) Informar dichos ahorros al Ministerio de Salud, a la Autoridad de Aplicación y a la SIGEN para su verificación.

c) Transferir al Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD) el porcentaje establecido en el Artículo 35, inciso e), sobre la base de los ahorros efectivamente verificados por la SIGEN.

d) Publicar anualmente los indicadores de eficiencia operativa y los montos transferidos en el Portal de Transparencia del Sistema C.U.R.A.

El ahorro anual deberá ser incremental, verificable y auditado digitalmente por la SIGEN.

La transferencia de recursos no podrá comprometer la sostenibilidad financiera ni la continuidad prestacional del Instituto, debiendo interpretarse conforme al régimen de administración financiera vigente.

A partir del primer reporte validado, las obligaciones de cuantificación, verificación, transferencia e información se repetirán anualmente conforme al Artículo 35, inciso e).

VIGÉSIMOQUINTA.- Cronograma de Fases de Implementación Tecnológica.

Alcance del Cronograma.

El presente cronograma establece las fases de desarrollo, validación, certificación y habilitación técnica de los módulos tecnológicos del Sistema C.U.R.A. a nivel nacional.

La implementación territorial progresiva en las distintas jurisdicciones se regirá adicionalmente por el mecanismo de tandas previsto en la Disposición Transitoria Séptima, pudiendo coexistir jurisdicciones en diferentes etapas durante el período de transición.

a) PRIMERA ETAPA (Años 1-2) – Sistema Base. Implementación y habilitación nacional de la Historia Clínica Electrónica Federal, Sistema Federal de Turnos, Trazabilidad de Medicamentos e Interoperabilidad básica FHIR. En esta etapa no se activarán módulos de IA clínica compleja.

b) SEGUNDA ETAPA (Años 2-3) – IA de Bajo Riesgo. Incorporación progresiva de módulos de optimización predictiva de turnos, herramientas de accesibilidad digital, limpieza y estandarización automática de datos y alertas epidemiológicas básicas.

c) TERCERA ETAPA (Años 3-5) – IA de Medio Riesgo. Implementación de soporte a la codificación clínica (SNOMED CT), predictores de demanda sanitaria territorial, herramientas de ayuda al diagnóstico por imágenes y sistemas de vigilancia avanzada.

d) CUARTA ETAPA (Años 5 en adelante) – IA de Alto Impacto. Evaluación para el eventual despliegue de sistemas de soporte a decisiones clínicas, personalización de tratamientos, predictores de riesgo individual y herramientas de investigación clínica asistida, conforme al régimen reforzado de control establecido en el Título X.

VIGÉSIMOSEXTA.- Protocolo de Escalamiento Ágil para Módulos de Inteligencia Artificial.

La implementación territorial de los módulos específicos de Inteligencia Artificial clasificados como Nivel I (Bajo Riesgo), Nivel II (Riesgo Moderado) o Nivel III (Alto Riesgo) conforme al Artículo 65 BIS de la presente ley se regirá por un Protocolo de Escalamiento Ágil.

Dicho protocolo será ejecutado por la Autoridad de Aplicación en coordinación con el Consejo Federal de Salud (COFESA) y requerirá aprobación vinculante del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial en Salud (Art. 66).

El presente protocolo será complementario y posterior a la validación técnica prevista en la Disposición Transitoria Vigésima.

a) Piloto Inicial Restringido. Cada nuevo módulo de IA se implementará inicialmente en TRES (3) provincias piloto, seleccionadas por el COFESA en función de: 1) Infraestructura tecnológica disponible; 2) Nivel de interoperabilidad alcanzado; 3) Capacidad de auditoría clínica; 4) Diversidad poblacional representativa.

b) Plazos de Prueba.

1) Módulos Nivel I (Bajo Riesgo): Período mínimo de prueba: TRES (3) meses.

2) Módulos Nivel II (Riesgo Moderado): Período mínimo de prueba: CUATRO (4) meses.

3) Módulos Nivel III (Alto Riesgo): Período mínimo de prueba: SEIS (6) meses con evaluación clínica obligatoria supervisada por el Subcomité.

En ningún caso el período podrá exceder SEIS (6) meses sin resolución fundada del Consejo

Nacional.

c) Escalamiento por Lotes. Una vez obtenida la certificación de seguridad y desempeño por parte del Subcomité de Ética e IA:

1) La expansión territorial se realizará en lotes sucesivos de hasta TRES (3) provincias por vez.

2) Cada lote deberá superar una validación operativa de: i) TREINTA (30) días para módulos Nivel I; ii) CUARENTA Y CINCO (45) días para módulos Nivel II; iii) SESENTA (60) días para módulos Nivel III.

3) El escalamiento podrá realizarse de manera secuencial o parcialmente superpuesta, siempre que el Subcomité certifique que no se compromete la seguridad del paciente.

d) Freno de Emergencia.

Ante reporte fundado de evento adverso grave potencialmente atribuible a un módulo de IA, la Autoridad de Aplicación deberá suspender preventivamente el despliegue del módulo dentro de las VEINTICUATRO (24) horas del reporte, sin necesidad de prueba de causalidad establecida. Corresponderá a la Autoridad de Aplicación, en el procedimiento posterior, demostrar que el evento adverso no es atribuible al módulo. El Subcomité de Ética e IA emitirá dictamen técnico de atribución causal dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la suspensión preventiva.

La suspensión preventiva deberá realizarse en los siguientes casos:

1) Evento adverso grave atribuible al módulo de IA.

2) Tasa de error clínico superior al doble del umbral aprobado en la validación inicial.

3) Vulneración grave de seguridad o exposición de datos sensibles.

4) Sesgo discriminatorio verificado que afecte derechos fundamentales.

5) Alteración o manipulación de registros de auditoría.

El reinicio del proceso solo podrá autorizarse mediante certificación expresa del Subcomité de Ética e IA, previa verificación técnica de corrección.

VIGÉSIMOCTAVA.- Condiciones para la Habilitación de Módulos de Inteligencia Artificial.

Cada módulo de Inteligencia Artificial requerirá, para su implementación efectiva en una jurisdicción determinada y con carácter previo al despliegue masivo, el cumplimiento acumulativo de las siguientes condiciones:

a) Aprobación Ética y Técnica. Aprobación expresa del Subcomité Técnico de Ética e Inteligencia Artificial en Salud (Art. 66), con inscripción activa en el Registro Nacional de Módulos de IA en Salud (RENIA-Salud), conforme lo establecido en el Título X de la presente ley.

b) Capacitación Certificada. Acreditación de capacitación certificada de al menos el OCHENTA POR CIENTO (80%) del personal directamente usuario del módulo en la jurisdicción de implementación.

Se entenderá por "personal directamente usuario" a los profesionales o agentes que operen el módulo o cuyas decisiones clínicas o administrativas se encuentren asistidas por el mismo.

La capacitación deberá:

1) Ser gratuita para el personal.
2) Estar incluida dentro del Sistema Federal de Capacitación Digital.
3) Incluir evaluación final de comprensión.
4) Realizarse dentro del horario laboral ordinario.

c) Validación Territorial Previa. Acreditación del cumplimiento del piloto inicial y del proceso de escalamiento ágil previstos en la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta.

d) Plan de Reversión Operativa. Existencia y aprobación previa por parte del Subcomité Técnico de Ética e Inteligencia Artificial en Salud de un Plan de Reversión que incluya:

1) Procedimiento técnico de desactivación inmediata del módulo.
2) Preservación segura de los datos generados.
3) Continuidad operativa alternativa manual o semiautomatizada.
4) Definición de los umbrales técnicos y clínicos que activan la reversión.
5) Responsable institucional designado para su ejecución.

VIGÉSIMONOVENA.- Interpretación armónica y progresiva de plazos.

Los plazos establecidos en las distintas disposiciones transitorias de la presente ley deberán interpretarse de manera armónica, sistémica y progresiva, atendiendo a la interdependencia técnica de los módulos y fases del Sistema C.U.R.A.

La prioridad será garantizar estabilidad operativa, seguridad informática, interoperabilidad y continuidad asistencial por sobre la estricta consecutividad cronológica de los plazos formales.

El eventual solapamiento, reordenamiento técnico o adecuación razonable de cronogramas, debidamente fundado por la Autoridad de Aplicación y comunicado al Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., no constituirá incumplimiento legal cuando responda a criterios de estabilidad, seguridad o progresividad federal.

DISPOSICIÓN FINAL

Este proyecto se presenta como iniciativa popular conforme al artículo 39 de la Constitución Nacional y a la Ley 24.747.

ARTÍCULO 75.- Forma.

Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

ANEXOS

ANEXO I TRAZABILIDAD DIGITAL DE MEDICAMENTOS — REGISTRO DIGITAL DE DISPENSACIÓN TRAZABLE (RDDT)

El presente Anexo desarrolla los requisitos técnicos, contenidos mínimos, mecanismos de verificación, régimen de contingencia y cláusulas de vigencia del Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT) establecido en el Artículo 20 de la presente ley, en consonancia con el régimen sancionatorio de los Artículos 44 y 45.

1. Contenido Mínimo del Registro (RDDT)

El Registro Digital de Dispensación Trazable deberá contener, como mínimo, los siguientes campos estructurados obligatorios:

a) Código unívoco de identificación del medicamento según estándar GS1 vigente (GTIN o equivalente internacional adoptado como estándar por la Autoridad de Aplicación), número de serie, lote y fecha de vencimiento.

b) Identificador del paciente titular conforme el C.U.R.A.-ID (Art. 17), o en su defecto el identificador jurisdiccional interoperable previsto en el Art. 3° BIS, cuando el paciente pertenezca a jurisdicción no adherente al Régimen B.

c) Identificación de la farmacia o entidad dispensadora, con código de habilitación vigente otorgado por autoridad jurisdiccional competente.

d) Identificación digital del profesional farmacéutico interviniente mediante firma digital o mecanismo de autenticación equivalente validado por la Autoridad de Aplicación, y número de matrícula activa.

e) Fecha y hora exacta de la dispensación. La geolocalización del acto dispensario es obligatoria exclusivamente en modalidades no presenciales (entrega a domicilio, envío postal u otras modalidades digitales). En la dispensación presencial en farmacia con domicilio declarado, basta con la identificación del establecimiento.

f) Código único de la prescripción electrónica o receta digital asociada, incluyendo la identificación del profesional prescriptor y la plataforma de emisión.

g) Estado de la dispensación: primera dispensación, dispensación fraccionada programada, dispensación de urgencia o contingencia.

2. Mecanismo de Verificación Automática de Dispensas (MVAD)

La ANMAT, en coordinación con la Autoridad de Aplicación (Art. 6°), implementará el Mecanismo de Verificación Automática de Dispensas (MVAD), que realizará las siguientes validaciones de manera inmediata e integrada al acto de dispensación:

a) Verificación de la correspondencia entre el medicamento dispensado y la prescripción electrónica asociada, incluyendo dosis, concentración y forma farmacéutica.

b) Validación del identificador único del medicamento (número de serie y lote) contra el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos administrado por ANMAT, conforme normativa vigente o la que en el futuro la sustituya.

c) Actualización automática del registro de stock de la farmacia dispensadora.

d) Habilitación de consultas auditoras para obras sociales, entidades de medicina prepaga y organismos de control, mediante técnicas de anonimización o seudonimización auditables (conforme definición del Anexo IV, punto 1), preservando la confidencialidad de los datos personales del paciente.

e) Verificación del esquema de dispensación fraccionada programada, impidiendo retiros anticipados o duplicaciones no autorizadas conforme el Art. 19 QUINQUIES.

Conservación: Los registros de auditoría del MVAD deberán conservarse por un plazo mínimo de DIEZ (10) años contados desde su generación, conforme el Art. 10 TER, inciso b).

En caso de divergencia técnica entre el MVAD y el criterio del profesional farmacéutico actuante, prevalecerá el criterio profesional debidamente fundado y documentado, sin perjuicio del registro de la alerta y su derivación al Subcomité de Seguridad y Protección de Datos (Art. 8°) para evaluación.

3. Régimen de Contingencia (Modo Offline)

En situaciones de caída total de conectividad, indisponibilidad técnica del sistema central o emergencia sanitaria declarada, las farmacias operarán bajo el siguiente protocolo:

a) Registro Local Seguro. Se registrará localmente, en formato digital cifrado, la siguiente información mínima:

   i. Identidad del paciente verificada por documento nacional de identidad físico (número de DNI y número de trámite) o por cotejo biométrico local si estuviera disponible.
   ii. Datos del medicamento: identificador del producto, lote, vencimiento y número de serie cuando corresponda.
   iii. Fecha y hora exacta de la transacción.
   iv. Identidad del profesional farmacéutico responsable y registro del motivo de contingencia (código de causa).

b) Sincronización obligatoria. Al restablecerse la conectividad, el sistema local deberá sincronizar automáticamente los registros pendientes con el nodo central del Sistema C.U.R.A. dentro de un plazo máximo de DOCE (12) horas. En zonas con conectividad estructuralmente limitada, la Autoridad de Aplicación establecerá plazos extendidos reglamentariamente, con un máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

c) Soporte digital preferente. El modo de contingencia prioriza el registro digital local en todo caso. La utilización de soporte papel se admite con carácter estrictamente excepcional únicamente cuando el registro digital local sea técnicamente imposible por falla del dispositivo terminal, debiendo el farmacéutico actuante informar el hecho a la Autoridad de Aplicación dentro de las VEINTICUATRO (24) horas y cargar retroactivamente el registro

digital en cuanto disponga de medios técnicos para hacerlo. El registro en papel no tendrá efecto liberatorio hasta tanto se produzca la carga digital retroactiva validada por el sistema.

Nota de aplicación: El modo de contingencia no suspende las obligaciones de trazabilidad: difiere su ejecución técnica en el sistema central hasta el restablecimiento de la conectividad. La infracción sancionable es la no sincronización dentro del plazo, no el uso transitorio del modo offline.

4. Sustitución del Soporte Físico y Efectos Jurídicos

A partir de la certificación de operatividad plena del módulo RDDT en cada jurisdicción, emitida por la Autoridad de Aplicación conforme el Artículo 35 TER de la presente ley, operarán los siguientes efectos:

a) La carga válida y completa de una dispensación en el RDDT del Sistema C.U.R.A. tendrá efecto liberatorio respecto de todas las obligaciones de presentación de soporte físico (troquel, etiqueta, comprobante en papel) que pudieran exigirse conforme normativa vigente a esa fecha.

b) Las obras sociales, entidades de medicina prepaga, INSSJP-PAMI, aseguradoras de riesgos del trabajo y demás financiadores no podrán rechazar la dispensación registrada válidamente en el RDDT ni condicionar el pago o reintegro a la presentación adicional de documentación física.

c) Queda prohibida, en el ámbito de los efectores con operatividad plena certificada, la solicitud, exigencia o archivo de: impresiones de recetas o comprobantes de dispensación; firmas manuscritas del paciente o del farmacéutico con carácter sustitutivo de la firma digital; adhesión física de troqueles o etiquetas; fotografías o escaneos de troqueles como mecanismo de auditoría.

d) La Autoridad de Aplicación publicará y mantendrá actualizado el catálogo de jurisdicciones y categorías de efectores con operatividad plena certificada, con actualización trimestral.

5. Cláusula de Interpretación (In Dubio Pro Digital)

En el ámbito territorial y para las categorías de efectores con operatividad plena del RDDT debidamente certificada conforme el Artículo 35 TER:

a) Toda referencia normativa preexistente que mencione "troquel", "cupón de dispensación", "etiqueta de trazabilidad" o "comprobante físico de dispensación" se interpretará de pleno derecho como referida al registro informático almacenado en el RDDT, prevaleciendo la validez digital sin necesidad de prueba física adicional.

b) En caso de discrepancia entre el registro digital en el RDDT y cualquier soporte físico preexistente, el registro digital validado por el MVAD con firma electrónica y sello de tiempo tendrá valor probatorio prevalente, salvo demostración fehaciente de error técnico o manipulación indebida mediante pericia informática.

c) La presente cláusula opera exclusivamente sobre actos de dispensación ocurridos con posterioridad a la certificación de operatividad plena del RDDT en la jurisdicción y categoría de efector correspondiente.

6. Régimen de Aplicación Jurisdiccional (Cláusula de Certificación)

Las obligaciones del presente Anexo aplicables a los efectores del Régimen A (Art. 1°, inc. g) son de cumplimiento directo e inmediato conforme el cronograma de la Disposición Transitoria Undécima.

Para los efectores dependientes de jurisdicciones no adherentes al Régimen B:

a) Las obligaciones técnicas de trazabilidad se rigen por el protocolo de portabilidad mínima del Artículo 3° BIS, no por el presente Anexo.

b) El Estado Nacional proveerá, sin costo y con carácter subsidiario, las herramientas técnicas mínimas necesarias para el cumplimiento del protocolo del Art. 3° BIS, incluyendo APIs estandarizadas compatibles con el RDDT.

c) La incorporación de estos efectores al régimen pleno del presente Anexo se producirá automáticamente al momento de la adhesión formal de la jurisdicción, sin requerir trámite adicional.

Referencia cruzada sancionatoria: Los incumplimientos al presente Anexo se tipifican y sancionan conforme el Artículo 45 de la presente ley, con aplicación subsidiaria del Art. 44. El tope máximo de multa aplicable a efectores privados es de QUINIENTAS (500) UMSD por ejercicio fiscal, conforme Art. 44 inciso d). Las sanciones a efectores públicos se rigen exclusivamente por las medidas correctivas del Art. 44 inciso e).

ANEXO II - COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FINANCIAMIENTO EXTERNO

Artículos de referencia: Arts. 35, 40, 41, 42, 71, 72 BIS y Disposición Transitoria vigésimoprimera

El presente Anexo establece el marco de principios, prohibiciones y procedimientos aplicables a los acuerdos de cooperación técnica internacional y al financiamiento externo del Sistema C.U.R.A. Sus disposiciones son complementarias y no modifican las competencias del Poder Ejecutivo Nacional en materia de política exterior ni de celebración de tratados internacionales conforme la Constitución Nacional.

1. Principios Rectores

Toda cooperación técnica internacional o financiamiento externo vinculado al Sistema C.U.R.A. se regirá por los siguientes principios, que tienen carácter prevalente en la interpretación y negociación de los instrumentos correspondientes:

a) Soberanía sanitaria digital. La República Argentina conserva la titularidad exclusiva y el control jurisdiccional pleno sobre los datos sanitarios de su población, con independencia del origen o modalidad del financiamiento recibido. Ningún acuerdo internacional podrá transferir este control a un sujeto de derecho privado o a una persona jurídica extranjera o internacional (Art. 71).

b) Intransferibilidad de datos identificables. Queda prohibida la transferencia internacional de datos personales de salud de carácter identificable o seudonimizado sin consentimiento expreso del titular o sin que el país destinatario cuente con un nivel adecuado de protección

reconocido por la Agencia de Acceso a la Información Pública, conforme el Art. 12 de la Ley 25.326 y el Art. 18 inciso j) de la presente ley.

c) Prevalencia del interés público sanitario. El interés público en la continuidad, calidad y accesibilidad del sistema sanitario argentino prevalece sobre cualquier interés comercial, financiero o estratégico del financiador, contraparte o cooperante externo.

d) Transparencia y publicidad. Todo convenio, acuerdo, protocolo o memorando de entendimiento vinculado al Sistema C.U.R.A. que involucre cooperación técnica internacional o financiamiento externo deberá ser publicado íntegramente en el portal oficial del Sistema C.U.R.A. dentro de los TREINTA (30) días de su suscripción, salvo cláusulas de confidencialidad de información técnica sensible que deberán identificarse específicamente.

e) No condicionamiento del acceso ciudadano. Ningún acuerdo de financiamiento externo podrá condicionar el acceso de los ciudadanos argentinos al Sistema C.U.R.A. ni a las prestaciones sanitarias que de él dependen al pago de aranceles, cargos de usuario o cualquier otra contraprestación derivada de compromisos asumidos con el financiador.

2. Prioridades de Aplicación del Financiamiento Externo

Los recursos obtenidos de organismos multilaterales (BID, CAF, BM, OPS/OMS u otros de similares características), de cooperación bilateral o de fondos multilaterales específicos se destinarán con carácter preferente a:

a) Infraestructura de conectividad en zonas críticas sanitarias sin acceso a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), conforme el mapa de Zonas Críticas Sanitarias del Art. 43 QUATER y la asignación complementaria del Art. 12 TER.

b) Desarrollo y operación del Repositorio Nacional de Datos Anonimizados (Art. 67 BIS), su infraestructura de computación segura y los procesos de anonimización irreversible certificada.

c) Programas de capacitación, alfabetización digital y formación de facilitadores digitales sanitarios (Arts. 34, 58 y 68).

d) Proyectos de investigación y desarrollo en salud digital ejecutados por universidades nacionales o institutos de investigación públicos argentinos, con protección de la propiedad intelectual de los resultados a favor del Estado Nacional (Art. 37 BIS).

e) Implementación del Hub de Interoperabilidad Sanitaria Global y el Resumen Internacional del Paciente (IPS) en la FASE 5 del Art. 14, exclusivamente después de la consolidación de la cobertura nacional.

3. Prohibiciones Expresas en la Negociación

No se suscribirán acuerdos de cooperación internacional o financiamiento externo que contengan alguna de las siguientes cláusulas o condiciones, las cuales se tendrán por no escritas en caso de haber sido incorporadas por error:

a) Renuncia a la jurisdicción argentina o sometimiento obligatorio a arbitraje internacional, tribunales extranjeros o foros de solución de controversias distintos de los establecidos en el ordenamiento jurídico argentino, para controversias derivadas del tratamiento de datos de salud o del funcionamiento del Sistema C.U.R.A.

b) Otorgamiento al financiador o cooperante de derechos de propiedad intelectual, exclusividad tecnológica o acceso preferente sobre los módulos de software, algoritmos, bases de datos o desarrollos del Sistema C.U.R.A., sean identificables o anonimizados.

c) Condiciones de repago vinculadas a la explotación comercial de datos sanitarios, a la imposición de aranceles a usuarios del sistema, o a la modificación de políticas de salud pública nacionales como condición de desembolso.

d) Cláusulas de confidencialidad que impidan la publicación del instrumento en los términos del principio 1.d) del presente Anexo, o que restrinjan el control parlamentario previsto en el Art. 72 BIS.

e) Obligaciones de adquisición preferente de bienes o servicios tecnológicos al financiador o a empresas vinculadas al mismo, que restrinjan la libre concurrencia en los procesos de contratación pública del Estado Nacional.

4. Procedimiento de Aprobación

Los acuerdos de cooperación internacional o financiamiento externo vinculados al Sistema C.U.R.A. se someterán al siguiente procedimiento de aprobación, diferenciado según el monto y la sensibilidad del objeto:

Clasificación de Convenios de Cooperación y Financiamiento

Los convenios celebrados en el marco del presente régimen se clasificarán conforme las siguientes categorías:

a) Cooperación técnica sin fondos.

Comprende acuerdos de asistencia técnica, intercambio de expertos, formación o cooperación académica que no impliquen transferencia de fondos ni transferencia de datos personales o datos sanitarios identificables.

Su aprobación requerirá resolución del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., con publicación en el portal oficial.

b) Financiamiento ordinario.

Comprende convenios cuyo monto sea inferior al umbral que establezca la reglamentación, el cual deberá expresarse en Salarios Mínimos Vitales y Móviles vigentes al momento de la suscripción.

Requerirá aprobación del Ministerio de Salud de la Nación, dictamen previo del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A., publicación en el portal oficial y remisión a la Comisión Bicameral prevista en el Artículo 72 BIS dentro de los DIEZ (10) días de su suscripción.

c) Financiamiento significativo.

Comprende convenios cuyo monto sea igual o superior al umbral reglamentario referido en el

inciso anterior, o aquellos que involucren transferencia de tecnología sensible o acceso a datos sanitarios anonimizados.

Requerirá aprobación del Ministerio de Salud de la Nación, dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral prevista en el Artículo 72 BIS, intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y publicación íntegra en el portal oficial.

El umbral que define la categoría de "financiamiento significativo" será establecido por la reglamentación dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días desde la promulgación de la ley y se actualizará anualmente por resolución conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía de la Nación.

5. Propiedad Intelectual y Datos Generados en Cooperación

Los desarrollos tecnológicos, modelos de datos, algoritmos, protocolos y productos de investigación generados en el marco de convenios de cooperación internacional:

a) Serán de propiedad del Estado Nacional Argentino, sin perjuicio de las licencias de uso que puedan acordarse a favor del cooperante en condiciones de reciprocidad y no exclusividad.
b) No podrán ser registrados como propiedad intelectual del cooperante en ningún país, salvo acuerdo expreso aprobado conforme el procedimiento del punto 4 del presente Anexo.
c) Los datos sanitarios utilizados en investigaciones realizadas en cooperación internacional se emplearán exclusivamente en formato anonimizado conforme la definición del Anexo IV, punto 1, y bajo protocolo de uso específico aprobado por la AAIP y el Subcomité de Seguridad y Protección de Datos (Art. 8°).

6. Supervisión y Rendición de Cuentas

a) La Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema C.U.R.A. (Art. 72 BIS) recibirá información semestral sobre todos los acuerdos de cooperación internacional y financiamiento externo vigentes, con indicación de montos, objetos, estado de ejecución y cumplimiento de los principios del presente Anexo.
b) La Auditoría General de la Nación incluirá en su informe anual de seguimiento del Sistema C.U.R.A. (Art. 14) una sección específica sobre la ejecución de los acuerdos de financiamiento externo.
c) Cualquier ciudadano podrá solicitar al Defensor del Pueblo de la Nación la revisión de un acuerdo internacional que considere violatorio de los principios del presente Anexo.

ANEXO III - CLASIFICACIÓN DE RIESGO Y GOBERNANZA DE MÓDULOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SALUD

Artículos de referencia: Arts. 1° inc. f), 14, 23, 65, 65 BIS, 65 TER, 66, 67 y 67 BIS

El presente Anexo desarrolla los criterios de clasificación de riesgo, los requisitos de evaluación de conformidad, el procedimiento de acreditación de organismos evaluadores y los

estándares mínimos de documentación técnica obligatoria para los módulos de Inteligencia Artificial que se integren al Sistema C.U.R.A., en desarrollo del marco establecido en el Título X de la presente ley.

1. Clasificación de Riesgo de Módulos de IA

A los efectos de la evaluación ética, validación técnica y autorización en el RENIA-Salud (Art. 67), los módulos de IA se clasifican en las siguientes categorías:

Clasificación de Niveles de Riesgo de Módulos de Inteligencia Artificial

A los efectos de la clasificación establecida en el Artículo 65 BIS, los módulos de Inteligencia Artificial se encuadrarán en las siguientes categorías, con indicación de su fase mínima de activación:

a) NIVEL I – Bajo Riesgo.

Comprende herramientas destinadas a funciones administrativas, organizativas o de soporte sin incidencia directa en decisiones clínicas ni en la asignación de recursos asistenciales.

Se incluyen, a título orientativo, sistemas de optimización logística, gestión de agendas, limpieza y estandarización automática de datos, asistentes de accesibilidad y traductores de lenguaje técnico para pacientes.

Estos módulos podrán activarse a partir de la FASE 2 conforme el Artículo 14.

b) NIVEL II – Riesgo Moderado.

Comprende sistemas de soporte clínico no decisorio cuya intervención requiera validación profesional obligatoria antes de generar efecto sobre la atención del paciente.

Se incluyen, a título orientativo, herramientas de soporte a la codificación clínica, predictores de demanda de turnos, alertas de interacciones medicamentosas, sistemas de vigilancia epidemiológica y herramientas de prescripción asistida.

Estos módulos podrán activarse a partir de la FASE 2 o FASE 3 según la modalidad y alcance definidos por la reglamentación.

c) NIVEL III – Alto Riesgo.

Comprende sistemas cuyos resultados impacten directamente en decisiones terapéuticas, diagnósticas, de priorización clínica, triage automatizado o gestión crítica de recursos asistenciales.

Se incluyen, a título orientativo, sistemas de soporte a decisiones clínicas (CDSS), asistencia al diagnóstico por imágenes, predictores de riesgo individual de salud y sistemas de personalización terapéutica.

Estos módulos sólo podrán activarse a partir de la FASE 4 y deberán contar con piloto certificado y evaluación de conformidad independiente conforme el Artículo 65 BIS.

La clasificación inicial la realiza el solicitante de la certificación mediante declaración responsable; el Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial (Art. 8°, punto 3) puede reclasificar el módulo en cualquier momento del proceso de evaluación o durante el monitoreo post-implementación, con resolución fundada y notificación al desarrollador.

2. Requisitos de Evaluación por Nivel

Los módulos de Inteligencia Artificial clasificados conforme el Artículo 65 BIS deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos según su nivel de riesgo:

a) Nivel I – Bajo Riesgo

Los módulos clasificados como Nivel I deberán cumplir con:

1. Declaración responsable del desarrollador, de carácter obligatorio.
2. Model card mínimo en formato simplificado conforme lo establecido en el punto 5 del presente Anexo.
3. Notificación técnica al Subcomité Técnico de Ética e Inteligencia Artificial en Salud conforme el Artículo 66.
4. Auditoría externa por OECAIS: no requerida.
5. Evaluación de Impacto Ético en Salud (EIES): no requerida.
6. Piloto controlado certificado: no requerido.
7. Plan de monitoreo post implementación de carácter básico.
8. Mecanismo obligatorio de fallback a operación manual.
9. Registro obligatorio en el RENIA-Salud conforme el Artículo 67.

b) Nivel II – Riesgo Moderado

Los módulos clasificados como Nivel II deberán cumplir con:

1. Declaración responsable del desarrollador, obligatoria.
2. Model card mínimo en formato estándar.

3. Evaluación técnica obligatoria del Subcomité conforme el Artículo 66.
4. Auditoría externa por OECAIS: recomendada cuando el impacto clínico lo justifique conforme reglamentación.
5. Evaluación de Impacto Ético en Salud (EIES): obligatoria.
6. Piloto controlado certificado: recomendado.
7. Plan de monitoreo post implementación de carácter estándar.
8. Mecanismo obligatorio de fallback a operación manual.
9. Registro obligatorio en el RENIA-Salud.

c) Nivel III – Alto Riesgo

Los módulos clasificados como Nivel III deberán cumplir con:

1. Declaración responsable del desarrollador, obligatoria.
2. Model card mínimo en formato completo.
3. Evaluación técnica obligatoria del Subcomité conforme el Artículo 66.
4. Auditoría externa obligatoria realizada por un OECAIS habilitado.
5. Evaluación de Impacto Ético en Salud (EIES) obligatoria.
6. Piloto controlado certificado obligatorio previo a su despliegue productivo.
7. Plan de monitoreo post implementación reforzado, con métricas periódicas de desempeño y seguridad.
8. Mecanismo obligatorio de fallback a operación manual.
9. Registro obligatorio en el RENIA-Salud.

3. Sistemas Prohibidos (Art. 65 TER — Síntesis Operativa)

A los efectos de la evaluación por el Subcomité y por los OECAIS, se considerarán automáticamente incompatibles con el Sistema C.U.R.A. los módulos que en cualquier modalidad de operación:

a) Adopten decisiones diagnósticas, terapéuticas o de pronóstico de manera autónoma sin validación humana calificada obligatoria, independientemente del nivel de confianza estadística del sistema.

b) Realicen perfilamiento de pacientes basado en variables protegidas (edad, género, origen étnico, discapacidad, condición socioeconómica u otras) con efectos sobre el acceso a servicios o la asignación de recursos, salvo cuando exista justificación epidemiológica o clínica científicamente acreditada y sin producir trato arbitrario.

c) Denieguen o limiten prestaciones sanitarias, autorizaciones de tratamiento o coberturas de manera automática y sin revisión humana obligatoria e individualizada.

d) Realicen identificación biométrica o vigilancia sanitaria masiva no consentida con fines ajenos a la atención individual del paciente.

e) Presenten riesgos graves e incompatibles con los derechos fundamentales a la vida, salud, intimidad o dignidad que, conforme el dictamen del OECAIS, no puedan reducirse a nivel residual aceptable mediante salvaguardas técnicas u organizativas.

4. Acreditación de Organismos de Evaluación de Conformidad en IA Sanitaria (OECAIS)

Los organismos habilitados para realizar la auditoría técnica externa de módulos Nivel III (Art. 65 BIS, inciso d) deberán estar acreditados conforme el siguiente procedimiento:

a) Sistema de acreditación. La acreditación de los OECAIS se realizará por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) conforme los requisitos de la norma ISO/IEC 17065 (organismos de certificación de productos, procesos y servicios) y los criterios técnicos específicos para la evaluación de sistemas de IA en salud que establezca la Autoridad de Aplicación mediante resolución fundada, en coordinación con el Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial.

b) Requisitos mínimos de los OECAIS. Sin perjuicio de los criterios del OAA, los OECAIS deberán acreditar:

   i. Independencia orgánica, funcional y financiera respecto del desarrollador del módulo, del prestador que lo utilice y del Estado Nacional.
   ii. Capacidad técnica específica en validación de modelos de IA para uso clínico, acreditada mediante panel de expertos en inteligencia artificial, bioestadística y medicina clínica.
   iii. Ausencia de conflicto de interés con el sistema evaluado, declarada bajo responsabilidad y verificada por el OAA.
   iv. Cobertura de seguro de responsabilidad profesional adecuada a la naturaleza y valor del dictamen emitido.

c) Registro público. La Autoridad de Aplicación mantendrá un Registro Público de OECAIS Habilitados, actualizado semestralmente, accesible en el portal oficial del Sistema C.U.R.A. El registro indicará el alcance de acreditación de cada OECAIS.

d) Efectos del dictamen. El dictamen del OECAIS tiene naturaleza de pericia técnica obligatoria con efectos vinculantes en lo relativo a la identificación de riesgos críticos no mitigados (conforme definición del Anexo IV, punto 5). El órgano decisor final es el Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial (Art. 66), quien no puede autorizar un módulo Nivel III cuando el OECAIS identifique riesgos críticos no mitigados, pero sí puede rechazar un módulo que el OECAIS no haya objetado si detecta riesgos adicionales no evaluados.

e) Costos. Los costos de la auditoría del OECAIS son soportados por el solicitante de la certificación. La Autoridad de Aplicación fijará aranceles máximos para garantizar la proporcionalidad y accesibilidad del proceso de certificación.

5. Model Card Mínimo Obligatorio (Módulos Nivel III)

Todo módulo de IA clasificado como Nivel III deberá presentar, como parte del expediente de certificación ante el RENIA-Salud, un documento de descripción técnica estandarizado (Model Card) que incluya como mínimo:

1. Identificación del módulo: Nombre, versión, desarrollador, fecha de última actualización, nivel de riesgo declarado y clasificación de dispositivo médico (si aplica según normativa ANMAT vigente).
2. Finalidad clínica declarada: Descripción precisa del propósito del módulo, la población a la que va dirigido, las condiciones o patologías sobre las que opera y los límites explícitos de su aplicación.
3. Datos de entrenamiento: Descripción de las fuentes de datos utilizadas para entrenamiento y validación (sin revelar datos personales), diversidad poblacional, período temporal, potenciales sesgos identificados y medidas de mitigación adoptadas.
4. Desempeño técnico: Métricas de desempeño en población de validación: precisión, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, tasa de falsos positivos y negativos, y curva ROC cuando aplique. Comparación con estándar clínico de referencia.
5. Explicabilidad: Descripción del mecanismo de generación de alertas o sugerencias del modelo, nivel de explicabilidad técnica (local o global), información que el sistema presenta al profesional para justificar cada salida y mecanismo para que el profesional comprenda la base de la alerta.
6. Límites y contraindicaciones: Condiciones en las que el módulo no debe utilizarse, poblaciones en las que no ha sido validado y situaciones en las que el sistema recomienda explícitamente priorizar el criterio clínico sobre su salida.
7. Protocolo de monitoreo: Plan de supervisión post-implementación: indicadores de desviación de rendimiento, frecuencia de auditoría, umbrales de alerta para re-evaluación y responsable técnico de seguimiento.
8. Mecanismo de fallback: Descripción del mecanismo de retorno inmediato a operación manual segura ante malfuncionamiento, degradación del desempeño o suspensión preventiva (Art. 67 inc. b) punto 5).

La Autoridad de Aplicación, a propuesta del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial, podrá establecer mediante resolución el formato estándar del Model Card, los módulos Nivel I y II con versión simplificada del mismo, y actualizarlo conforme evolucionen los estándares internacionales, sin necesidad de modificación legislativa.

6. Actualización del Marco de Clasificación

La clasificación de módulos, los criterios de evaluación y los requisitos del Model Card son

de carácter técnico y podrán actualizarse por resolución fundada del Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. (Art. 7°) con intervención del Subcomité de Ética e Inteligencia Artificial, con el único límite de no reducir los estándares de protección del paciente establecidos en el Título X de la presente ley.

A los efectos de la actualización, se tomará como referencia técnica de mínima el estado del arte de los marcos regulatorios internacionales de IA de mayor rigor vigentes al momento de la revisión, en particular el Reglamento (UE) de Inteligencia Artificial, las guías de la OMS sobre ética en IA sanitaria y los estándares del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST AI RMF) o los que en el futuro los sustituyan.

La referencia a marcos regulatorios, estándares o guías técnicas internacionales en el presente Anexo tendrá carácter orientativo y técnico mínimo, no implicando incorporación normativa automática ni sujeción a jurisdicción extranjera. La interpretación y aplicación de tales estándares se realizará conforme el derecho argentino y bajo control de la Autoridad de Aplicación.

ANEXO IV - GLOSARIO DE DEFINICIONES JURÍDICO-TÉCNICAS

Artículos de referencia: Todos los títulos y artículos de la ley que utilizan los términos aquí definidos

El presente Anexo establece las definiciones jurídicamente vinculantes de los términos de mayor riesgo interpretativo utilizados en el articulado principal y en los Anexos I, II y III de la presente ley. Las definiciones aquí contenidas prevalecen sobre cualquier otra interpretación en el ámbito de aplicación de esta ley.

Criterio de inclusión: Se incluyen exclusivamente términos que (i) no tienen definición legal en otra norma del ordenamiento argentino, o (ii) cuyo significado técnico difiere sustancialmente del uso común del término, o (iii) cuya ambigüedad ha generado o puede generar controversia interpretativa o litigio.

Definiciones

1. Anonimización Irreversible

Artículos de referencia: Arts. 67 BIS; Anexos II y III

Proceso técnico mediante el cual se eliminan o transforman irreversiblemente los identificadores directos e indirectos de los datos personales, de modo tal que no sea razonablemente posible la re-identificación del titular por ningún medio disponible con el estado del arte tecnológico vigente al momento del proceso, ni mediante la combinación con otros conjuntos de datos accesibles. La anonimización irreversible debe ser certificada mediante auditoría técnica independiente con periodicidad mínima anual, conforme metodología validada por la AAIP. Los datos correctamente anonimizados conforme este

estándar dejan de ser considerados datos personales a los efectos de la Ley 25.326 y de la presente ley. La seudonimización (sustitución de identificadores por seudónimos reversibles mediante clave) no constituye anonimización irreversible.

2. Break-Glass (Acceso de Emergencia)

Artículos de referencia: Arts. 19, 22, 30, 44 inc. b), punto 3-ii

Mecanismo técnico excepcional que habilita a un profesional de la salud habilitado a acceder a la historia clínica digital completa de un paciente sin contar con consentimiento activo previo del titular, en situaciones de emergencia vital donde el paciente se encuentre inconsciente, incapacitado o en riesgo de muerte inminente y no pueda prestar consentimiento por ningún medio. Su activación genera de manera automática e inmediata un registro inalterable en el Módulo Nacional de Trazabilidad y Auditoría (Art. 10) con identificación del profesional actuante, fecha y hora, establecimiento y diagnóstico de emergencia fundante. El uso indebido del mecanismo break-glass —entendido como su activación sin situación de emergencia real— constituye falta gravísima conforme el Art. 44 inciso b) punto 3-ii.

Nota de aplicación: La activación del break-glass no suspende ningún derecho del paciente; solo difiere temporalmente el momento del consentimiento informado.

3. Interoperabilidad Plena

Artículos de referencia: Arts. 3°, 11, 14, 15; Anexo I

Estado de integración técnica y semántica alcanzado por un efector de salud cuando cumple simultáneamente: (i) integración operativa completa a la plataforma del Sistema C.U.R.A. con capacidad de lectura y escritura en tiempo real; (ii) adopción de los estándares terminológicos del CMBD (Art. 16); (iii) superación de la última auditoría técnica periódica prevista en el Art. 11 sin observaciones pendientes de subsanación; y (iv) certificación emitida por la Autoridad de Aplicación conforme el Art. 35 TER. La interoperabilidad plena se distingue de la interoperabilidad mínima (Art. 3° BIS), que requiere únicamente la capacidad de generar y transmitir el Resumen Clínico Federal conforme el Art. 3° TER.

4. Riesgo Crítico No Mitigado

Artículos de referencia: Arts. 65 TER, 65 BIS; Anexo III, punto 4-d

Condición de un módulo de IA en la que el dictamen técnico del OECAIS certifica la concurrencia de: (i) probabilidad significativa de daño grave, individual o colectivo, para la seguridad o integridad de los pacientes; y (ii) imposibilidad técnica de reducir ese riesgo a nivel residual aceptable mediante las salvaguardas técnicas, organizativas o de supervisión humana disponibles conforme el estado del arte al momento de la evaluación. La determinación de "probabilidad significativa" y "daño grave" se realizará conforme los criterios técnicos objetivos y documentados establecidos por la reglamentación. La existencia de un riesgo crítico no mitigado determina la suspensión automática de la autorización de despliegue del módulo hasta acreditación de su mitigación efectiva.

5. Supervisión Humana Significativa

Artículos de referencia: Art. 1° inc. f) punto 6; Art. 23; Art. 65 inc. a)

Modalidad de control del ejercicio del juicio clínico profesional en el que: (i) el profesional de la salud recibe y comprende efectivamente la salida del sistema de IA antes de tomar cualquier decisión clínica; (ii) el profesional tiene plena capacidad técnica, tiempo suficiente y autoridad para rechazar, modificar o no actuar conforme la salida del sistema; (iii) la decisión final es adoptada por el profesional bajo su responsabilidad exclusiva; y (iv) el rechazo de la sugerencia del sistema no genera obstáculos técnicos ni administrativos para el profesional actuante. No constituye supervisión humana significativa: (a) la mera visualización de la salida del sistema sin posibilidad real de modificarla; (b) la validación rutinaria bajo presión de tiempo que impida el análisis clínico adecuado; ni (c) cualquier esquema en el que el rechazo de la sugerencia del sistema genere carga adicional que desincentive el ejercicio del juicio profesional independiente.

6. Modo Restringido del C.U.R.A.-ID

Artículos de referencia: Art. 17; Ley 25.326 Art. 16

Estado técnico-jurídico del Identificador Único de Paciente (C.U.R.A.-ID) solicitado voluntariamente por su titular, en el que: (i) el identificador se conserva en el registro de infraestructura del sistema con valor pseudonimizado a efectos de continuidad asistencial archivística; (ii) no puede utilizarse para nuevos intercambios activos de información clínica entre efectores; (iii) el acceso a los datos históricos vinculados queda restringido a los supuestos de emergencia vital (break-glass, definición punto 2) y a los datos mínimos del Resumen Clínico Federal del Art. 3° TER; y (iv) el modo es reversible a solicitud del titular en cualquier momento, con efecto inmediato. El modo restringido satisface el derecho de restricción del tratamiento previsto en el Art. 16 de la Ley 25.326 sin implicar supresión del identificador como elemento de infraestructura pública sanitaria.

Nota de aplicación: La reglamentación establecerá el procedimiento de solicitud del modo restringido, que deberá ser simple, gratuito y accesible mediante el portal oficial del Sistema C.U.R.A. y en los centros de atención ciudadana.

7. Datos de Salud de Acceso Libre (DSAL)

Artículos de referencia: Arts. 18, 19, 32

Categoría de datos de la historia clínica digital que el titular ha autorizado expresamente para su acceso por cualquier profesional habilitado del Sistema C.U.R.A., sin restricción de especialidad o efector. Se distingue de los datos de acceso controlado (accesibles solo por el equipo tratante habitual) y de los datos de acceso de emergencia (accesibles únicamente mediante break-glass). El titular puede modificar la categorización de sus datos en cualquier momento mediante el portal del Sistema C.U.R.A., con efecto dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes.

8. Certificación de Operatividad Plena

Artículos de referencia: Arts. 35 TER, 44 inc. d); Anexo I, puntos 4 y 5

Acto administrativo emitido por la Autoridad de Aplicación que declara que una jurisdicción o categoría de efectores ha alcanzado el nivel de integración técnica y funcional al Sistema C.U.R.A. suficiente para que las obligaciones legales de exclusividad digital (sustitución del soporte físico) sean exigibles en ese ámbito. La certificación solo puede emitirse después de verificarse: (i) integración operativa de al menos el OCHENTA POR CIENTO (80%) de los efectores del Régimen A de la categoría evaluada; (ii) funcionamiento estable del MVAD por un período mínimo de SEIS (6) meses; y (iii) tasa de incidencias técnicas inferior al CINCO POR CIENTO (5%) mensual promedio en el último trimestre.
Excepcionalmente, cuando una jurisdicción acredite cumplimiento sustancial de los requisitos establecidos y demuestre que las incidencias remanentes no comprometen la seguridad del paciente ni la integridad del sistema, la Autoridad de Aplicación podrá emitir certificación condicionada mediante resolución fundada, estableciendo un plan de adecuación con plazo máximo de noventa (90) días para alcanzar los estándares plenos.

9. Habilitación Complementaria Digital (HCD)

Artículos de referencia: Art. 19 SEPTIES inc. b) (conforme texto propuesto en Auditoría Jurídica)

Autorización de ejercicio funcional digital emitida por la autoridad competente de una jurisdicción receptora que habilita a un profesional de salud mental —matriculado en otra jurisdicción— a brindar teleconsultas a pacientes residentes en la jurisdicción receptora a través del Sistema C.U.R.A. La HCD: (i) no sustituye la matrícula de origen; (ii) se circunscribe exclusivamente a actos de teleconsulta realizados a través del Sistema C.U.R.A.; (iii) no habilita ejercicio presencial ni establece actividad permanente en la jurisdicción receptora; y (iv) puede ser revocada por la jurisdicción receptora ante sanciones disciplinarias firmes, con notificación a la jurisdicción de matrícula.

10. Ahorro Sistémico Neto (ASN)

Artículos de referencia: Art. 35; Arts. 43 BIS y 43 SEXIES

Reducción efectiva de erogaciones del sistema de salud atribuible causalmente a la implementación del Sistema C.U.R.A., calculada conforme la metodología que establezca la reglamentación mediante los organismos de control previstos en el Art. 35. El ASN se computa sobre la base de: (i) eliminación de estudios diagnósticos duplicados verificada por trazabilidad de imágenes; (ii) reducción de errores de medicación cuantificada por el MVAD; (iii) optimización de la gestión de stock de medicamentos; y (iv) reducción de fraude en prestaciones verificada por auditoría digital. El ASN no incluye proyecciones ni ahorros futuros hipotéticos: es una medición ex-post de flujos reales, auditable por la SIGEN y la AGN.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El presente proyecto tiene por finalidad reconstruir integralmente el sistema de salud argentino mediante una arquitectura sanitaria digital única, interoperable, auditable y federal, que garantice continuidad asistencial, equidad territorial y eficiencia presupuestaria. La Ley C.U.R.A. (Consolidación Unificada del Registro y Atención) propone un modelo moderno, seguro y centrado en la persona, capaz de articular los subsistemas públicos, privados y de la seguridad social bajo estándares digitales comunes y mecanismos de gobernanza cooperativa.

I. Diagnóstico estructural

El sistema sanitario argentino presenta una fragmentación histórica derivada de la coexistencia de múltiples subsistemas con escasa integración tecnológica. La falta de interoperabilidad real genera:

- duplicación de estudios y prácticas,
- pérdida de información clínica relevante,
- auditorías manuales y burocracia en soporte papel,
- errores de medicación evitables,
- demoras diagnósticas,
- dificultades en la vigilancia epidemiológica,
- y profundas desigualdades territoriales.

Esta fragmentación no responde a una falta de recursos, sino a una arquitectura desarticulada que impide aprovecharlos con eficiencia. La ausencia de trazabilidad integral y de intercambio estructurado de información produce costos evitables que afectan tanto la calidad asistencial como la sostenibilidad del sistema.

La Ley C.U.R.A. aborda este problema estructural mediante la creación de una infraestructura sanitaria digital común que no sustituye a los subsistemas existentes, sino que los integra bajo estándares interoperables y reglas claras de gobernanza.

II. Fundamento constitucional y jurídico

El proyecto se inscribe en las competencias del Congreso Nacional conforme:

- Artículo 42 de la Constitución Nacional (protección de la salud y derechos de usuarios),
- Artículo 75 incisos 18 y 19 (progreso y bienestar general),
- Artículo 75 inciso 22 (derecho a la salud reconocido en tratados internacionales),
- Artículo 75 inciso 23 (igualdad real de oportunidades).

Asimismo, respeta el esquema federal del Artículo 121 y 125 CN, estableciendo un régimen de adhesión progresiva que preserva las competencias provinciales y promueve un federalismo cooperativo.

En materia de protección de datos personales, la ley se integra armónicamente con la Ley 25.326 y fortalece sus principios mediante:

- seudonimización criptográfica del identificador único,
- segmentación por categorías sensibles,
- mecanismos de consentimiento informado digital,
- registro de accesos y auditoría permanente,
- y protocolo de acceso de emergencia (“break-glass”) con trazabilidad obligatoria.

La arquitectura normativa garantiza que la modernización tecnológica no implique regresión de derechos, sino su fortalecimiento.

III. Arquitectura sanitaria digital

El corazón del sistema es el Identificador Único de Paciente (C.U.R.A.-ID), vinculado al RENAPER y diseñado bajo criterios de seudonimización y control del titular. Este identificador permite asegurar continuidad asistencial en cualquier punto del país sin crear bases paralelas ni vulnerar la privacidad.

El sistema incorpora:

- Historia Clínica Digital Interoperable,
- Registro Digital de Dispensación Trazable (RDDT),
- módulos de emergencia, laboratorio, imágenes y vacunación,
- sistema federal de turnos,
- trazabilidad integral de medicamentos,
- y monitoreo auditable en tiempo real.

La sustitución del soporte papel se realiza de manera progresiva, certificada por jurisdicción y categoría de efector, evitando inseguridad jurídica o imposiciones intempestivas.

El modelo incluye mecanismos de contingencia offline, garantizando continuidad operativa aun en situaciones de conectividad limitada.

IV. Soberanía tecnológica y residencia de datos

La infraestructura tecnológica se apoya prioritariamente en capacidades estatales y en proveedores bajo jurisdicción argentina, estableciendo un régimen diferenciado de residencia de datos según su criticidad:

- Categoría A: datos clínicos y sensibles con residencia exclusiva en territorio nacional.
- Categoría B: datos administrativos con arquitectura híbrida controlada.
- Categoría C: datos estadísticos anonimizados sin restricciones de CDN.

El control criptográfico y jurisdiccional se mantiene bajo autoridad nacional, reforzando la inmunidad frente a requerimientos extraterritoriales.

Esta configuración no es aislacionista: habilita interoperabilidad internacional segura mediante el Resumen Internacional del Paciente (IPS) y el Hub Global C.U.R.A., respetando soberanía y legislación argentina.

V. Integración del INSSJP–PAMI

La ley establece la integración digital del INSSJP–PAMI al ecosistema C.U.R.A. mediante convenio marco, respetando su autarquía conforme Ley 19.032 y preservando las

competencias de su Directorio.

La integración incluye:

- receta electrónica interoperable,
- trazabilidad digital completa,
- portal integrado,
- eliminación progresiva del troquel físico,
- medición anual del Ahorro Sistémico Neto (ASN),
- auditoría por SIGEN y AGN.

Por primera vez se exige cuantificación verificable de los ahorros generados por la digitalización, constituyendo un mecanismo objetivo de eficiencia y transparencia.

VI. Equidad territorial y acompañamiento humano

La transformación digital no excluye: incorpora un modelo de accesibilidad y acompañamiento humano, especialmente orientado a personas mayores o con barreras digitales.

Se prevén:

- programas de facilitadores digitales,
- reconversión funcional del personal administrativo,
- capacitación obligatoria,
- estabilidad laboral garantizada.

El Régimen Federal de Equidad Territorial introduce incentivos para zonas sanitarias críticas, fortaleciendo la telemedicina estructural y corrigiendo asimetrías históricas en distribución de profesionales e infraestructura.

En materia de salud mental y psiquiatría, la Ley C.U.R.A. introduce una solución estructural a uno de los problemas más críticos del sistema público: la demora excesiva para obtener turnos. Mediante la integración federal de agendas y la habilitación de la teleconsulta interjurisdiccional voluntaria, el sistema permite que un paciente pueda acceder virtualmente

a profesionales disponibles en cualquier provincia adherida, sin perder garantías de matriculación, responsabilidad disciplinaria ni competencia provincial. Esto amplía la oferta real de atención sin necesidad de crear nuevos cargos ni estructuras físicas, reduce listas de espera y mejora la accesibilidad efectiva, especialmente en zonas con déficit de especialistas. La modalidad virtual no sustituye la presencialidad cuando esta sea clínicamente necesaria, pero elimina barreras territoriales que hoy generan demoras de meses para una primera consulta psicológica o psiquiátrica.

VII. Inteligencia artificial y ética sanitaria

La ley establece un marco de gobernanza ética de IA en salud basado en:

- clasificación de riesgo (niveles I, II y III),
- auditoría técnica independiente para sistemas de alto riesgo,
- registro obligatorio en RENIA-Salud,
- supervisión humana significativa,
- prohibición de decisiones autónomas sin validación clínica,
- y prohibición de sistemas discriminatorios o de vigilancia masiva no consentida.

Se crea un entorno controlado de experimentación (Sandbox) con datos anonimizados, bajo reglas estrictas de soberanía tecnológica y control público.

El Repositorio Nacional de Datos Anonimizados se limita a fines de interés público sanitario y se somete a auditorías técnicas y control institucional reforzado.

VIII. Financiamiento y sostenibilidad

El esquema de financiamiento combina:

- Fondo de Inversión Inicial para la Salud Digital (FIISD),
- reasignación estratégica de partidas existentes,
- ahorro operativo generado por digitalización,
- contribución estructural de PAMI,
- financiamiento internacional bajo lineamientos de soberanía y control parlamentario.

La ley se enmarca en los compromisos institucionales asumidos en materia de equilibrio fiscal, modernización del Estado y fortalecimiento del federalismo cooperativo.

Lejos de generar gasto estructural permanente, el sistema se diseña como una contribución estructural a la sostenibilidad fiscal y eficiencia del gasto público, atacando causas reales del despilfarro: duplicación de estudios, fraude prestacional y burocracia analógica.

IX. Federalismo cooperativo

El régimen prevé adhesión provincial progresiva, certificaciones técnicas, hitos de implementación y armonización normativa. No impone un modelo centralizado, sino que propone un estándar común de interoperabilidad que respeta las autonomías locales y promueve integración voluntaria bajo reglas claras.

El Consejo Nacional del Sistema C.U.R.A. funciona como órgano de coordinación interjurisdiccional y garante del equilibrio institucional.

X. Proyección internacional y generación de divisas

La dimensión internacional del Sistema C.U.R.A. no se limita a la interoperabilidad clínica, sino que configura una política activa de desarrollo económico. El modelo de Hub de Interoperabilidad Sanitaria Global posiciona a la Argentina como proveedor de infraestructura pública digital en salud para países con sistemas fragmentados o en proceso de modernización. A través de un framework exportable, adaptable a realidades locales y respetuoso de la soberanía de cada Estado, la República Argentina puede ofrecer asesoría, licenciamiento tecnológico, servicios de nube soberana y capacitación especializada, generando un nuevo sector exportador basado en conocimiento, tecnología y gobernanza sanitaria. Esta proyección permite transformar la inversión nacional en salud digital en una fuente genuina de divisas, fortaleciendo la balanza de pagos y consolidando una contribución estructural a la sostenibilidad fiscal y eficiencia del gasto público, sin comprometer la prioridad absoluta del sistema nacional.

XI. Conclusión

La Ley C.U.R.A. no es simplemente una reforma tecnológica: es una reorganización estructural del sistema sanitario argentino orientada a:

- garantizar continuidad asistencial,
- reducir inequidades territoriales,
- fortalecer la protección de datos personales,
- mejorar la calidad clínica,
- transparentar la gestión,
- y ordenar el gasto público.

Propone reemplazar un modelo fragmentado, analógico y opaco por una red sanitaria federal, interoperable, auditable y centrada en la persona.

La Ley C.U.R.A. se inscribe entre los modelos más avanzados de gobernanza sanitaria digital a nivel internacional. Integra estándares de interoperabilidad clínica consolidados en la Unión Europea, mecanismos de protección de datos comparables con los marcos más exigentes en materia de privacidad, y sistemas de trazabilidad y auditoría digital que superan esquemas actualmente vigentes en la región. Al mismo tiempo, adapta estas mejores prácticas a la realidad institucional, federal y presupuestaria argentina, evitando soluciones importadas sin contextualización. El resultado es una arquitectura sanitaria moderna, soberana y escalable, que coloca a la Argentina en condiciones de liderazgo regional en salud digital, combinando innovación tecnológica, protección de derechos y responsabilidad fiscal.

FIRMAS